

目 录

上篇 总 论

第一章	精、神与精神活动的物质基础	3
第一节	中医对精和神的认识	3
一、	精	3
二、	神	4
第二节	五脏与精神活动的关系	5
第三节	脑髓与精神活动的关系	7
第四节	气血与精神活动的关系	8
一、	气	8
二、	血	9
第五节	经络与精神活动的关系	9
第二章	精神病的病因病机	11
第一节	外因(六淫)	12
一、	风	12
二、	暑	13
三、	火	13
四、	发热性谵妄	14
第二节	内因(七情)	16
一、	喜	17
二、	怒	17
三、	忧	17
四、	思	18
五、	悲	18
六、	恐	18

七、惊	18
第三节 不内外因	19
一、中毒	19
二、颅脑外伤	21
三、其它	21
第四节 痰与精神病的关系	21
第五节 遗传与精神病的关系	22
第六节 素质与精神病的关系	22
一、太阳之人	23
二、少阳之人	23
三、太阴之人	23
四、少阴之人	24
五、阴阳和平之人	24
第三章 精神病症状学	25
第一节 中医精神病症状的分类	25
一、狂症	25
二、癫症	26
三、痴呆	27
四、癫痫	28
第二节 现代医学关于精神病症状的分类	30
一、认识过程障碍	30
二、情感过程障碍	41
三、意向行为过程障碍	43
四、精神病症候群	45
五、定向力与自知力	48
第四章 精神病诊断学	50
第一节 四诊	50
一、问诊	50

二、望诊	55
三、闻诊	58
四、切诊	60
第二节 八纲辨证	63
一、表里	63
二、寒热	63
三、虚实	65
四、阴阳	66
第三节 脏象辨证	67
一、心的生理和病理	67
二、肝的生理和病理	68
三、脾的生理和病理	70
四、肺的生理和病理	71
五、肾的生理和病理	71
第五章 精神病治疗学	74
第一节 五脏辨证施治	74
一、心的辨证论治	74
二、肝的辨证论治	80
三、脾的辨证论治	85
四、肺的辨证论治	88
五、肾的辨证论治	90
第二节 治疗精神病的几种法则	94
一、芳香开窍法	94
二、化痰开窍法	95
三、豁痰开窍法	96
四、清热解毒法	97
五、清热泻火法	99
六、重镇安神法	99

七、	养心安神法	100
八、	平肝法	100
九、	滋阴补肾法	102
十、	助阳补肾法	102
第三节	心理治疗	103
一、	古代医家运用心理疗法点滴	105
二、	心理治疗要点	107

下篇 各 论

第一章	传染病性精神病	113
第一节	病因病机	113
第二节	临床表现	115
一、	意识障碍症候群	115
二、	神经衰弱症候群	116
三、	智力减退和记忆障碍症候群	117
四、	性格障碍症候群	117
第三节	流行性感胃引起的精神障碍	117
一、	临床表现	117
二、	病例介绍	118
第四节	肺炎引起的精神障碍	119
一、	临床表现	119
二、	病例介绍	120
第五节	伤寒引起的精神障碍	122
一、	临床表现	122
二、	病例介绍	123
第六节	传染性肝炎引起的精神障碍	124
一、	临床表现	124
二、	病例介绍	127

第七节	细菌性痢疾引起的精神障碍	126
一、	临床表现	126
二、	病例介绍	127
第八节	脑膜炎引起的精神障碍	128
一、	临床表现	128
二、	病例介绍	128
第九节	流行性乙型脑炎引起的精神障碍	132
一、	关于乙脑的分型	133
二、	乙脑的主要症状	133
三、	治疗乙脑的法则	134
四、	不同症状乙脑的治疗方法	135
五、	病例介绍	139
六、	治疗体会	143
七、	附方	144
第二章	神经性梅毒	149
第一节	脑梅毒	150
一、	脑梅毒的类型及其临床表现	150
二、	病例介绍	151
第二节	麻痹性痴呆	153
一、	临床表现	153
二、	临床分型	155
三、	临床诊断	156
四、	病例介绍	157
五、	治疗体会	158
第三章	中毒性精神病	159
第一节	病因病机	159
第二节	铅中毒	160
一、	临床表现	160

二、	临床治疗	161
三、	病例介绍	162
第三节	汞中毒	163
一、	临床表现	163
二、	临床治疗	164
三、	病例介绍	165
第四节	一氧化碳中毒	167
一、	临床表现	167
二、	临床治疗	167
三、	病例介绍	168
第五节	酒精中毒	175
一、	临床类型及表现	176
二、	临床诊断与治疗	179
三、	病例介绍	180
第六节	治疗体会	182
第四章	脑外伤性精神障碍	184
第一节	中医对于颅脑外伤的认识	184
一、	脑的生理和功能	185
二、	脑和经络的关系	186
第二节	病因病机	188
第三节	脑外伤精神障碍的类型及临床表现	189
一、	脑外伤急性期的精神障碍	190
二、	脑外伤后遗症引起的精神障碍	192
第四节	诊断与鉴别诊断	194
一、	诊断	194
二、	鉴别诊断	194
第五节	临床治疗	195
一、	脑外伤急性期患者的治疗	195

二、	脑外伤后遗症患者的治疗	199
三、	病例介绍	200
第六节	治疗体会	215
第五章	躯体疾病所致和精神障碍	217
第一节	心脏病所致精神障碍的症状及治疗	218
一、	症状及治疗方法	218
二、	病例介绍	218
第二节	肝脏病所致精神障碍的症状及治疗	220
一、	症状及治疗方法	220
二、	病例介绍	221
第三节	肾脏病所致精神障碍的症状及治疗	225
一、	症状及治疗方法	225
二、	病例介绍	225
第四节	糖尿病所致精神障碍的症状及治疗	228
一、	症状及治疗方法	228
二、	病例介绍	228
第五节	甲状腺机能亢进所致精神障碍的症状及治疗	230
一、	症状及治疗方法	230
二、	病例介绍	231
第六节	肾上腺皮质机能减退所致精神障碍的症状及治疗	232
一、	症状及治疗方法	232
二、	病例介绍	233
第七节	肾上腺皮质机能亢进所致精神障碍的症状及治疗	235
一、	症状及治疗方法	235
二、	病例介绍	235
第六章	脑血管疾病所致和精神障碍	238
第一节	高血压精神障碍的症状及治疗	238
一、	病因病机	239

二、	临床表现	240
三、	中医有关高血压精神障碍的学说	241
四、	高血压精神障碍的分型及治疗	244
五、	治疗体会	250
第二节	脑动脉硬化症精神障碍的症状及治疗	251
一、	病因病机	251
二、	临床表现	251
三、	预防与治疗	253
四、	病例介绍	254
五、	治疗体会	262
第七章	精神分裂症	265
第一节	中医的有关论述	265
一、	关于症状的论述	265
二、	关于病因病机的论述	266
第二节	临床表现	267
一、	思维障碍	268
二、	情感障碍	268
三、	意向障碍	269
四、	感知障碍	269
第三节	临床分型与治疗	270
一、	单纯型的临床表现及治疗	271
二、	青春型的临床表现及治疗	274
三、	紧张型的临床表现及治疗	280
四、	妄想型的临床表现及治疗	282
第八章	躁狂忧郁性精神病	293
第一节	病因病机	293
一、	遗传因素	293
二、	素质基础	294

三、	间脑功能紊乱	294
四、	单胺物质代谢紊乱	294
五、	精神和躯体因素	295
第二节	中医对躁狂忧郁性精神病的认识	295
第三节	临床表现	297
一、	躁狂症患者的精神症状	297
二、	忧郁症患者的精神症状	298
三、	混合型患者的精神症状	299
四、	躁狂忧郁性精神病患者的躯体症状	300
第四节	临床分型治疗	301
一、	躁狂忧郁症的治疗	301
二、	躁狂症的治疗	305
三、	忧郁症的治疗	308
第九章	癫痫所致的精神障碍	313
第一节	原发性癫痫的辨证治疗	314
一、	病因病机	314
二、	临床表现、病程及预后	315
三、	鉴别诊断	320
四、	临床治疗	321
第二节	局限性癫痫的辨证治疗	326
一、	病因病机	327
二、	临床治疗	328
三、	治疗体会	330
第十章	更年期精神病	331
第一节	病因病机	332
一、	肾气虚衰	332
二、	冲任失调	333
三、	脾失健运	333

四、	肝失柔润	334
第二节	临床表现	334
一、	更年期综合症	334
二、	更年期忧郁症	334
三、	更年期妄想症	335
第三节	临床治疗	336
一、	治疗方法	336
二、	病例介绍	337
三、	治疗体会	341
第十一章	老年性精神病	342
第一节	病因病机	342
第二节	临床表现	343
第三节	诊断与鉴别诊断	345
一、	诊断	345
二、	鉴别诊断	345
第四节	临床治疗	346
一、	治疗方法	346
二、	病例介绍	346
三、	治疗体会	348
第十二章	心因性反应症	352
第一节	病因病机	352
第二节	临床表现	353
一、	急性心因性反应症	353
二、	持久性心因性反应症	354
第三节	诊断与鉴别诊断	355
一、	诊断	355
二、	鉴别诊断	355
第四节	临床治疗	356

一、	心理治疗法	356
二、	药物治疗法	357
三、	病例介绍	357
第十三章	神经官能症	363
第一节	神经衰弱	364
一、	病因病机	364
二、	临床表现	366
三、	诊断与鉴别诊断	367
四、	临床治疗	368
第二节	癔病(歇斯底里)	380
一、	病因病机	381
二、	临床表现	381
三、	诊断与鉴别诊断	385
四、	临床治疗	386
五、	小儿癔病治验	395
第三节	强迫性神经官能症	396
一、	病因病机	397
二、	临床表现	397
三、	诊断与鉴别诊断	398
四、	临床治疗	399
参考文献		407

上 篇

总 论

第一章 精、神与精神活动的 物质基础

第一节 中医对精和神的认识

精神一词，是现代医学的一个名词。中医则对精与神有自己独特的理解，其要义如下：

一、精

精有两种意义。首先，精是先天生命的物质基础。当人的生命开始孕育于母体的时候，最先生成的就是精，所谓先天之精。在这个基础上，脑髓、骨骼、筋、脉、皮肉、毛发等形体组织逐渐生长发育乃至形成。这种精是人类生殖繁衍的根本物质，没有它生命就无从谈起。

其次，精又是后天营养的主要物质，即水谷之精微，所谓后天之精。人在出生以后，生长发育、生活劳动全需依赖于它成为人体生命活动的基本物质。当机体发育到成熟时期，这种物质又能转化成生殖之精。因此，先天之精与后天之精是互相促进、互相依存的。没有先天之精，就不可能有后天之精，而先天之精又必须依赖后天之精以给养。在整个生命活动过程中，精不断地消耗而又不断得到水谷精微的补充，如此生生不息，如环无端。所以，精不仅是生命起源的物质

基础，而且也是生命活动的物质基础。总之，无论那种精，都对人类的繁衍和生长发育起着重大作用。

二、神

神是思维意识、精神活动的全部体现。它的起源和生命一样。随着父母之精的结合而蕴育。《灵枢·本神篇》说：“故生之来谓之精，两精相搏谓之神……”。待到既生之后，又赖水谷精微之营养，体形逐渐发育和成长，而神在此基础上得以滋养充实，从而主宰思维意识和精神活动。所以《灵枢·平人绝谷篇》又说：“神者，水谷之精气也”。

古人认为：神对于人体来说，一刻也不能分离。生命存在一天，神就存在一天，即《内经》之所谓“形与神俱”。在人的生命活动的全部过程，一切思维意识活动无一不是神在发挥作用。例如目之能视，耳之能听，口之能言，肢体之运动，等等，都是神的种种表现形式。一个正常人的精神活动，应当表现为精神充沛、思维意识健康。

以上简述的是精与神在人体中的独立作用。具体到精与神的关系，中医认为精为物质基础，而神为功能活动。物质基础越充分，功能活动越有力；反之，功能活动越有力，又会产生充分的物质而为功能之所需。目光有神，语言清晰，声音宏亮，举止轻快，此为精神正常；反之，目光暗然，语言无力或失常（谵言、妄语），妄见、妄闻（幻视、幻听），甚至昏不知人、寻衣摸床等等，都是精神失常的表现。因为精与神存在着互相依存的密切关系，过度地损伤精，便会使神失于滋养，如肾虚所表现的精神不振就是证据；反之，过度地消耗神，也会导致精力衰退。可见任何机体的功能活动，都不能离

开物质基础而单独进行，精神活动也不例外。现代医学通过实验证实：精神活动是受大脑支配的。但中医则认为精神活动是与五脏、脑髓、气血、经络有关。因此，在讨论精与神的功能活动时，仍需从这几方面入手。

第二节 五脏与精神活动的关系

中医认为，精神活动乃由神、魂、魄、意、志所谓五神所构成。而五神的来源是与五脏密切关联的。如《素问·宣明五气篇》指出：“心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志，是谓五脏所藏”。这些简单的论述，说明精神活动并不是脱离物质基础而孤立存在的，这一点是符合朴素唯物主义的。有人以为，神、魂、魄、意、志等带有迷信色彩，而我们认为这是古人对于精神活动的简单概括，不应仅从字面上去理解。

古之医家经过探索，对于人类精神活动的起源以及各种精神活动之间的相互关系提出下述见解，即“故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄，所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智”（《灵枢·本神篇》）。从这些描述中，更可看出古人不仅认为精神活动起源于精，是最早的物质基础，而且由此推衍出思、虑、智等一系列的思维活动，扩大了精神活动的范围。所谓魂，与神一样，也是一种无形的动力，它随着神的意志起着往来传达的作用，如目之能视，耳之能听，口之能言，肢体之能动作，等等。魄，是见诸于形体的一种活动形式，也是

协助神、魂出入的一种发挥，如“气魄、魄力”等。至于“心有所忆谓之意，意之所存谓之志”，是人类精神活动更高级而复杂的表现，也就是人类通过感官对于客观世界认识不断深化，从思考到分析，从分析到综合，以达到意愿目的的一系列活动过程。

古人为了便于掌握精神活动的规律，使之有助于医疗参考，还有机地把精神活动功能分配于每一个脏器，因而有十二官能之说。如《素问·灵兰秘典论》指出：“心者，君主之官也，神明出焉；肺者，相傅之官，治节出焉；肝者，将军之官，谋虑出焉；胆者，中正之官，决断出焉；膻中者，臣使之官，喜乐出焉；脾胃者，仓廪之官，五味出焉；……肾者，作强之官，伎巧出焉”。从这些描述中更可看出，古人进一步肯定了精神活动与五脏的密切关系。所谓“心者，君主之官也，神明出焉”，是喻心为最高主宰，统帅其它脏腑的功能活动，对于一切客观事物的反映都是通过心的功能而表达的（如大脑皮层高级中枢精神活动）。肺主治节，有协助心神保持正常活动的作用。肝主谋虑，协助心神思谋考虑，但要靠胆的功能来决断。膻中（心包络）为心之外围，有保卫心之功能，使之不受外邪侵犯，并有代心用事的作用。脾胃如仓廪，主纳五谷。五味入口，经过脾的运化，提取精微以营养五脏和精神，所以称脾胃为后天之母。肾主作强，主伎巧；所谓作强，是指人的精力充沛强劲多力；伎巧是指精细灵巧。正因为五脏功能的活动都是在心的统帅之下进行的，故有“主明则下安，……主不明，则十二官危”之说法。因此，精神活动与内脏器官的功能是统一的整体，内脏功能正常，是精神健康的物质基础；反之，精神健康，对于内脏功能也会产

生良好作用。正如《灵枢·本脏篇》所说：“志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪矣。”所以，中医对于任何疾病(包括精神病在内)都以五脏辨证为基础，就是这种思想指导。这种精神与脏腑统一的观点，也符合朴素的唯物主义。

第三节 脑髓与精神活动的关系

关于脑的功能活动，古人记载的较少。如《灵枢·海论篇》曾指出：“脑为髓之海……髓海有余，则轻劲多力，自过其度；髓海不足，则脑转耳鸣，胫痠眩冒，目无所见，懈怠安卧。”从这一段记载里，可以知道脑的内容是髓的汇集产物。而脑髓是怎样产生的？《灵枢·经脉篇》指出：“人始生，先成精，精成而脑髓生……”这说明脑髓与神一样是来源于先天之精。而髓来源于肾，因为肾藏精、生髓，所以肾足髓就足，髓足就强劲多力，精神充沛，胜任各种劳动。肾虚则髓不足，髓不足则头晕、耳鸣、目不能视、腰膝痠楚、倦怠喜卧。由此可见，肾精的虚实标志着脑髓的充实和不足。《难经·二十八难》说：“督脉者，起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入属于脑……”。督脉起于尾骶，而上于脑，它起着输送精髓与监督诸阳经的作用，故有“督为诸阳之总督”的说法。它相当于现代医学脊椎中枢神经的作用。因此，可以认为督脉的功能与脑脊液的循环和脊椎中枢神经活动有着密切的关系。《素问·五脏生成篇》中也明确提出“诸髓者皆属于脑。”故上至脑，下至尾骶，皆精髓升降之路。这既说明脑是髓的汇集之所，也说明髓的循环通道的范围。上至脑，下至尾骶，这是督脉的一条通道。明代李时珍提出：“脑为元神之府”。清代王

清任也说“灵机记性不在心在脑”。他指出脑髓不足直接影响记忆。“小儿无记性者，脑髓未满，高年无记性者，脑髓渐空”。这些认识都说明脑的功能活动为精神活动的基础。脑髓虽来源于先天之精，但仍需后天水谷精微的滋养。所以五脏六腑之精足，肾就能藏精生髓，以供脑之使用；五脏六腑之精不足，则肾精不足以养脑，直接影响着脑和精神的的活动。诸凡精力不足的患者，都应考虑到脑髓之是否充足，这对于临床具有现实意义。

第四节 气血与精神活动的关系

气血是维持人体生命活动的物质基础，它随着经脉的运行以供人体各个器官的功能活动之需，人的生命存在一天，这种活动形式就循环往复地进行着。尽管精神活动起源于脑和心，但均赖气血的濡养。所以，气血又是精神活动最基本的物质。

一、气

气是无形之物，来源于先天，在母腹中受于父母之精化生而成，即所谓元气。既生之后，肺吸人之清气（天地自然之气）与饮食经脾胃运化所产生的水谷精微之气相结合，即先天之气与后天之气相结合，谓之真气，也即人体之正气。真气充沛于人体各部，无所不至，内温脏腑，外煦肌体，以维持机体正常的生理活动。所以说，真气既是人体生命活动的物质基础，又是促进物质产生的动力。正气之盛衰，直接影响着人体和精神的的健康，即所谓“邪之所凑，其气必虚。”

“正气存内，邪不可干。”

二、血

血是有形的循环于脉中的液体，赖气的推动，运载水谷之精微，营养全身各部，如环无端，循环不息。所谓“气为血之帅”，“气行血自行，气滞血亦滞。”而气之所以能行，又赖于血的营养，故又有“血为气之母”的说法。由此可见气血之间有着互相依存的密切关系。

血是经过肝、心、脾、肺、肾的作用化生而成。五脏如有障碍，可破坏血的化生，或者由于失血而使血液减少。由于血液消耗，可造成某个脏器血虚，如思虑伤神，就是耗伤心血而使心血虚；脉道涩滞运行不畅，可造成血瘀。血液的盛衰也直接影响着精神活动，如失血过多，可造成精神昏迷；血液不足，可出现精神衰退；瘀血留滞，可造成精神异常；如气血一时供应不足，轻则可致精神昏迷，重则可致人死亡。

第五节 经络与精神活动的关系

经络的存在已属客观事实。经络学说也是中医学基础理论的核心之一。中医各科在临床诊断治疗上，无论是针灸还是用药，都不能离开经络学说的理论指导。古人认为，经络是人体上下内外气血运行的通道。内而五脏六腑，外而四肢百骸、皮肤肌肉，无不通过它的联络而进行有机的整体活动。气血是维持正常生理活动的重要物质，但它必须依靠经络始能循环输布。因为经络遍布全身，无处不到，所以气血

才能运行全身无处不有。

经络是脏腑之间的联络工具，它能内而协调脏腑之间的平衡，外而适应客观环境的变化。当机体受到外邪侵袭而发生病变时，经络首先受邪而后传脏腑。当脏腑发生疾病时，又可通过经络反映于体表而呈现其本脏的症状。所以，经络既是气血运行的通道，又是疾病传变的道路。由于经络能贯通人体内外上下，所以病邪同样可以凭借这种道路由表传里，由内传外，由上而下，由下而上地传变。

各经自有其独特的症候群，在临床诊断上，根据病人的自觉症状与医生的他觉症状，视其部位与表现便知与某经有关。即可明确诊断是某一经或数经的病变。精神病的病因、病理也同其它病变一样，与脏腑经络有密切的联系。当某一脏腑或某一经络发生变化时，都会反映出各自不同的症状。如《灵枢·经脉篇》有“胃足阳明之脉……是动则病洒洒振寒，善伸、数欠、颜黑，病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊，心动，欲独闭户窗而处，甚至欲上高而歌，弃衣而走，贲响腹胀，是为肝厥。”《灵枢·邪气脏腑病形篇》又有“心脉急甚者为瘈瘲，缓甚，为狂笑……”《丹溪心法》有“手少阴心经见证……淫淫，善笑，善恐，善忘，……眩仆，身热而腹痛。”再如《灵枢·经脉篇》有“膀胱足太阳之脉……是动则病冲头痛，目似脱，项似拔，脊痛腰似折……狂癫疾……”。

以上是古人通过临床实践所认识到的经络与精神活动的关系。值得重视的是各条经络均汇集于头部，头顶中央的“百会”即因此而得名。督脉为一身经络之总督，贯脊上入于脑，更加强脑与诸经络的联系。由此看来经络不但与精神活动有密切的关系，而且是精神活动中不可分割的一部分。

第二章 精神病的病因病机

中医的病因学说，一般把病因分为三种，即内因（七情过激）、外因（六淫侵袭）、不内外因（房室、金刃、跌仆损伤、外力冲击、中毒等）。《三因极一·病症方论》说：“然六淫天之常气，冒之则先自经络流入，内合于脏腑，为外所因。七情人之常性，动之则先自脏腑郁发，外形于肢体，为内所因。其如饮食饥饱，叫呼伤气，尽神度量，疲极筋力，阴阳违逆，乃至虎狼毒虫，金疮痿折，疰忤附着，畏压溺等，有背常理，为不内外因。”故有“千般灾难不越三条”之说。所谓不内外因，实质上也是一种外因。因此，有些医家把不内外因也划入外因范围。

上述有关精神病病因的分类仍不尽完善。因为精神病的情况比较特殊，仅从内因、外因或三因的角度区分，其界限往往不易划清。即以七情来说，一般认为是属于内因的范畴。其实，它们并不是自行发生的，而是必须通过外界刺激诱发，所谓“精神创伤”或称“精神因素”。如果说七情与六淫的侵害有什么不同的话，那仅是侵犯的形式不同，一则由于自然气候，一则由于情绪因素，其诱发因素都是来自客观。因为人是社会的人，生活环境、社会地位、思想性格各不相同，对于外界各种刺激的反应和耐受程度也会各不相同。例如，在相同的外因刺激下，有的人会情绪激动，有的人情绪低落，而致不同程度的病。有的人却可能若无其事。由此可

见，人们的性格(素质)以及人们对待外界因素的态度，是产生七情的基本条件。而七情则是人们对客观事物的情感反应，这种反应如果过激，即转变成致病因素，破坏机体内环境的平衡，使阴阳失调，气机紊乱。由此而产生的病灶无论位于什么脏腑和经络，都会引起相应的精神症状。

本章仍以三因学说为基础，把与精神病发病密切有关的各因素，如中毒、颅脑外伤等力求给予较系统的论述。

第一节 外因(六淫)

在正常情况下，风、寒、暑、湿、燥、火是自然界气候的应有变化，它并不致病，故称之为六气。但是，在失常(太过或不及)的情况下，它们是能够致病的，所以称为六淫。六淫当中与精神障碍有关的，主要有风、暑、火三种。

一、风

古人说：“风为百病之长”，是致病最广泛的因素。它不仅可单独使人发病，而且还可与其它五淫合而致病，如风寒、暑风、风湿、风燥、风火等，这些都是属于外风的范畴。受风之后，多表现为头痛、头晕、体痛、恶风(风寒)，昏迷、抽搐(暑风)，身重、骨节疼痛(风湿)，咳嗽、口干、舌燥(风燥)，齿颊肿痛、暴发火眼(风火)等症状。

还有一种内风症，多因痰火炽盛，风痰上扰，阴虚阳亢，肝风内动所致。是症多表现为昏厥、痉挛、眩晕、麻木、口眼喎斜、角弓反张等症状。亦能产生多种神经精神症状。

二、暑

暑的致病范围也很广，其表现症状也是多种多样。例如头痛，身热，口渴，心烦，脉洪而虚等，这是暑的本病。除此之外，还有以下几种类型：

（一）阴暑

其症为皮肤蒸热，恶寒，头重或腹痛吐泻等。

（二）中暑

其症为猝然昏倒，昏不知人，冷汗自出，手足发冷，或吐或泻，或喘满口渴等。

（三）伏暑

其症似疟疾，寒热往来，脘闷口渴，午后较甚，入暮更重，天明得汗则减。

（四）暑风

其症较为严重，面赤身热，大汗口渴，唇焦舌燥，神昏谵语，痉厥抽搐，角弓反张等。此症多见于乙脑高热昏迷期。

三、火

火是热极的表现，为害最烈。火性炎上，最易伤津。诸凡一切伤津的症状，多是由火所引起。除其自身热极以外，还可与其它五气化合，演出各种病变。例如，风火相煽可出现两目直视，四肢抽搐，角弓反张等症。温热病后期，火灼津伤液，唇焦舌燥，神昏谵语，就是郁热化火所致。伤寒（为寒所伤）后期，舌绛心烦，咽痛不寐，就是寒邪化火所致。它如肺热灼津，咳嗽吐血等症，就是燥气化火所致。中暑烦

心，面赤身热，大汗，口渴不止，甚至昏迷，就是由于暑邪化火所引起。此外，还有“五志化火”，如大怒气逆则火起于肝；醉饱逾度则火起于胃；房事无节则火起于肾；悲哀恻哀则火起于肺等，这些证候虽属内因，但均由外因刺激所致。除五气化火与五志化火以外，尚有虚火与实火之别。例如高热神昏，气粗口渴，大便秘结，小便赤涩，多为实火所致。心悸虚烦，骨蒸劳热，手足心热，两颊潮红，则多属于虚火。

四、发热性谵妄

这是由六淫之邪所引起的，多属于急性传染病诱发的精神症状。此类精神症状，起病急，发展快为其特征。中医对此早有记载，如后汉张仲景在《伤寒论》中对发热性精神症状作了详细论述。清代叶香岩、吴鞠通等对热性谵妄，又进一步有所发挥。兹将伤寒和温病中发热性谵妄略述如下。

（一）伤寒发热性谵妄

伤寒以六经为纲，按病程的不同阶段可概括为太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病等六种证候群。伤寒病中出现谵妄症状较多的是太阳、阳明、少阳三经。

“太阳之为病，脉浮、头项强痛面恶寒。”此为急性热病的初期阶段，患者一般不出现谵妄。但到太阳表邪不解，内传于腑，热与血结之于膀胱，谓之膀胱蓄血，患者便可出现如狂或发狂及少腹满硬、小便自利的症状。太阳病若误治，患者也可出现精神症状，如“发汗、吐下后，虚烦不得眠；若剧者，必反复颠倒，心中懊恼”。“伤寒八九日，下之，胸满、烦惊、小便不利、谵语、一身尽重，不可转侧者……”。

“伤寒，腹满、谵语、寸口脉浮而紧，此肝乘脾也……”。“太阳病二日，反燥，凡熨其背而大汗出，大热入胃，胃中水竭，躁烦必发谵语……”。“伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳，必惊狂……”等。

阳明病为太阳病表证未解而传里化热，病情较重。此时胃家实热，出现高热，口渴，大便燥结，脉洪大，甚则谵妄。例如：“阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞅，鞅则谵语……”。“阳明病，谵语、有潮热、反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也……”。“阳明病，下血、谵语者，此为热入血室。”

“三阳合病，腹满、身重、难以转侧、口不仁、面垢、谵语、遗尿”。

“二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足絷絷汗出，大便难而谵语者”。阳明经所发高热、烦躁、谵语等症，一般多属热性病的极期阶段。

“伤寒，脉弦细、头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语。”它如“妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。”说明伤寒化热，俱可引起发热性谵妄。

（二）温病发热性谵妄

温病为感受四时不同的温热邪气所引起，较之伤寒更易于发热。所以在疾病的发展过程中易于伤阴耗液及动血出血。按病状的特点分为卫分病、气分病、营分病、血分病等四个类型，这是疾病发展变化的四个不同阶段和疾病轻重浅深的程度。

1. 卫分病

这是指温热病的初起，温邪在表、病情较轻，仅有发热、微恶寒、头痛、咳嗽、口微渴等表证，一般并不出现谵妄。

2. 气分病

这是卫分病邪入里化热，表现全身壮热、口渴、大汗出、脉洪大，为急性传染病的高热阶段，此期也可出现精神症状，但不多见。

3. 营分病

此期身热夜甚，心烦躁扰，或神昏谵语，斑疹隐隐，口反不渴。由于邪热入营，心神被扰，所以病人突出表现谵妄和神识不清，为病情深入。急性传染病的谵妄多在此期出现。

4. 血分病

此为营分病的进一步发展，是热性病的最危重阶段。此期表现高热、神昏谵妄、皮肤出现紫黑色斑疹，或有衄血、吐血、便血等出血现象。常见于出血性的急性传染病。

温病，并不都是按照上述次序顺传的，例如热入心包，此证不是按卫、气、营、血的次序顺传，而是病在卫分或气分阶段径传心包。所谓“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”，其特征以精神神经症状为主，高热、神昏谵妄、抽搐均为热邪内闭所致。此病多见于急性传染病，如“乙脑”、“流脑”等。

第二节 内因(七情)

七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志表现。这些表现虽然是心理活动的表达，但都是与外界事物接触产生

的，也就是各种事物作用于人的心理活动的表现。这些表现如果是正常的适度的，对人体就没有什么损伤。如果超越一定的限度而不能节制，所谓七情过激，就会因此而影响正常的精神活动，即七情所伤。如“过喜伤心”，“过怒伤肝”等。这些七情过激的因素，对于人体内脏都可引起功能失调，而导致疾病。因此，七情变化的影响，在精神病的病因上有着极其重要的意义。兹分述如下：

一、喜

喜是心情愉快的表现，也是意气顺畅的正常表现。如果喜乐无极，超越常度，则心气将会由徐缓而变为涣散，使心气耗散而伤神，因而出现心虚不眠、惊悸、烦躁。肾气乘虚上犯，形成恐惧不安。所谓“喜伤心”。

二、怒

怒是发脾气的表现。肝主怒，肝气旺盛的人，一旦遇不合己意的事，就往往气愤不平，怒则气上，怒气暴发。肝藏血，因发怒而损伤肝血，致阴血亏损不能濡肝而肝失所养，则肝火愈旺，更易动怒，而肝血益伤，所谓“怒伤肝”。

三、忧

忧是情绪低落的表现，或者称为忧愁。忧愁是情志沉郁的状态，如果长期闷闷不舒，气机活动就会受到影响。肺主气，气机闭塞，就会出现胸满心悸，气不畅出，所谓“忧伤肺”。

四、思

思是集中精神，运用智慧考虑问题。也就是反复思考的意思。思考问题全靠精神的支持。因此，如果思考过度，精神活动就要受到一定的影响。心藏神，久思则神会受到损耗。脾为心之子，思则气结，母气不行，病及其子，所谓“思伤脾”就是这个意思。

五、悲

悲是精神抑郁、内心痛楚的表现。如遭遇不幸、生活困苦、疾病缠身、劳动条件恶劣等都是悲愁的根源。悲伤过度会损伤内脏。反之，如内脏活动发生障碍久久不愈，又可产生悲伤。因此，过悲和久悲都可伤肺。

六、恐

恐是惧怕的意思，是精神极度紧张所引起的胆怯表现。如突然的事故，惊险的遭遇，生活的剧变等等，都是引起恐惧的原因。形成恐惧的因素虽多，但是能够影响机体的还是肾气先虚。恐则气下，精血不足，因而志怯神伤而惊恐乘之。所谓“肾藏志”，“心藏神”，心肾不足则志怯神懦而善恐。“恐则伤肾”。

七、惊

惊与恐相类似，是猝然遇到异常变故而引起精神突然紧张的表现。如陡临危难，突遇险恶，目睹异物，耳闻巨响等，都可产生惊骇之感。惊的致病，虽然由于意外事变而致

心神气乱，但是还必须有心气先虚于内的因素。否则，虽猝然遇险境、危难，也能镇静自若，所谓“猝然临之而不惊”，亦不致产生惊骇或惊病。肝主惊，惊伤肝。“惊则心无所依，神无所归，虑无所定，故气乱矣”。

第三节 不内外因

一、中 毒

中毒有急性和慢性之别，中毒造成的精神病的严重程度，一方面决定于毒物的性质以及患者吸入量的大小，另一方面也决定于患者机体对毒物的耐受力 and 当时的躯体状态。但是，不论急性的或慢性的中毒，都可导致大脑高级神经活动机能失调，而产生暂时性或较持久的精神障碍。严重的还可造成死亡。现将笔者临床所见和有记载的几种中毒所致精神病的症状分述如下：

（一）汞中毒

汞中毒古籍中记载颇多，如明代李时珍说：“水银乃至阴之精，稟沉着之性，凡火锻炼，则飞腾灵变，得人气熏蒸，则入骨钻筋，绝阳蚀脑，阴毒之物无似之者”。又说：“人服水银病拘挛”。

汞中毒的临床特征，表现为一种特殊的胆怯，并且出现全身震颤、口角流涎以及中枢性和周围性麻痹。

（二）铅中毒

明代李时珍曾有详细观察记载：“铅生山穴石间，人挟油灯入至数里，随矿脉上下曲折砍取之。其气毒人，若连月

不出，则皮肤萎黄，腹胀不能食，多致疾而死”。

从以上这段描述可知连续接触铅会中毒致病甚者死亡。但对铅中毒侵犯脑及神经系统的描述则少见。临床常见铅中毒患者有类似汞中毒的病象。但应特别注意铅中毒对周围神经系统的损害，以及血管的硬化性改变。

（三）一氧化碳中毒

这是最常见的一种气体中毒。古人对任何能伤人的毒气都称之为“浊气”。浊气从呼吸道吸入，使人正常吸入的自然界清气（氧气）断绝，浊气入体蒙闭清窍，故患者开始头昏、头痛、恶心、呕吐；如果患者继续留在毒气环境中，往往可意识不清、昏迷，甚至死亡。

一氧化碳中毒，多由煤炉或灯用煤气所致，中毒的特点是意识模糊、幻觉以及明显的记忆力障碍。

（四）酒精中毒

酒精中毒较为常见。我国古代就有“恶酒”的记载。晋代巢元方提出：“酒者……其气慄悍而有火毒，入于胃则酒胀气逆，上逆于胸，内蒸于肝胆，故令肝浮胆横，而狂悖交怒，失于常性，故云恶酒也”。

一次大量饮酒，可引起暂时性的精神紊乱，若不过度严重，可自然恢复，而无后遗症。慢性酒精中毒，是由于长期饮酒过量，以酒代饭，因而产生营养障碍，可出现肝、肾严重病变及代谢障碍，后果不良。在慢性中毒的基础上，还可引起急性发作的精神障碍，常见的是震颤性谵妄，严重者可致酒精中毒性假性麻痹。

二、颅脑外伤

金刃、跌仆、外力冲击造成的颅脑外伤最容易引起精神症状。因为无论是脑震荡还是脑挫伤及脑干损伤，势必造成脑络和督脉的损伤。头为诸阳之会，督脉为诸阳脉之总督，在脑络和督脉损伤这一病变的基础上，经络传导阻滞，神明无由传达，因而出现昏迷及各种谵妄状态。严重的脑震荡和脑挫伤患者，不仅脑络损伤，脑血管也受到不同程度的损伤，以致造成血瘀（脑膜下血肿）和水肿，而出现昏迷和谵妄。由于挫伤后的脑组织有瘢痕形成，还可引起外伤性癫痫发作。受气浪猛烈冲击的人，可发生听觉和语言机能障碍，以致产生耳聋和失语症。

三、其 它

起居失常、劳逸不当，常可引起神经衰弱。饮食失节，常可引起胃肠功能紊乱。手淫及房室无度，可引起肾气亏损，导致性神经官能症。

第四节 痰与精神病的关系

痰为多种精神病的原因之一，故在此特别提出而予以重视。

痰，是人体脏腑功能活动失调的病理产物。它多由于气机不畅体液循环受阻而产生。具体到脏腑，痰的产生多与脾失健运，肺失清肃有关。故有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”一说。水液不能正常运化，水湿留聚成饮，饮因气滞而

粘凝成痰，形成对人体有害的物质。痰可能留滞于脏腑，也可能流窜于经络，并能与其它病邪结合而产生多种疾病。仅就与精神病有关的列举如下：

如痰火凝结，可致精神病中各种狂妄症。气郁痰结，可致精神病中的癫症和痴呆（如精神分裂症，脑动脉硬化性痴呆）。风动痰升，可致癫痫发作、卒中，以及各种瘈瘲、痉挛、抽搐等症。痰蒙心窍，可致神识昏迷，不省人事（急性传染病热邪逆传心包，邪入营血，中毒及颅脑外伤等昏迷除外）。痰窜经络，可致肢体麻木不仁。气滞痰凝，可致成瘰瘤（如甲状腺肿瘤）、梅核气（瘰病球）。痰停于胃，清气不升则眩晕，浊气不降则恶心、呕吐（胃神经官能症）。

第五节 遗传与精神病的关系

遗传因素在精神病的病因中占有一定的地位，因为很多精神病患者是有精神病家族史的。但是否可以说有精神病史的家族，其后代就一定会得精神病呢？这要视每个人的后天条件而定。有的人尽管有精神病遗传因子，如果在出生之后，不遇异常的精神刺激因素，也可能终生不患本病；假如不幸而遇到刺激因素，就易于导致本病。因此，既不可过分夸大遗传因素的作用，而使人精神产生负担，又必须提醒人们（有家属患此病者）正确对待这种先天因素。

第六节 素质与精神病的关系

素质是性格特征与体质类型的总合。自然界任何物质都

有其自身的特征，而这种特征也称做特性。做为人类来说，这种特性又称素质。一个人的素质，一般说是来自先天，所以又称做天性或者秉性。其实，除先天因素之外，一个人素质的形成，不能不受后天因素如生活环境、发育时期的躯体因素的影响。人的素质，就象人的面孔一样，各不相同。尽管人们的素质千差万别各不相同，但我国古代的医学家早已把它们归纳起来分作五种类型。这种分型方法，最早见于《灵枢·通天论》。现将有关人的素质分型简要介绍如下：

一、太阳之人

“太阳之人居处于于，好言大事，无能而虚说，志发于四野，举措不顾是非，为事如常自用，事虽败而常无悔，此太阳之人也。”这种类型的人，处处表现自以为是，没有本事却好说大话和好高骛远；举止行为放荡不羁，不顾是非，恣意妄行，做错了事也不知改悔。

二、少阳之人

“少阳之人，谄谄好自贵，有小小官，则高自宜，好为外交而不内附，此少阳之人也。”这类人妄自尊大，居非要职，却自认为是显贵。好交游和炫耀自己，而不能安心理内务、干实事。

三、太阴之人

“太阴之人，贪而不仁，下齐湛湛，好内而恶出，心抑而不发，不务于时，动而后之，此太阴之人也。”这类人阴险，贪得无厌，见利忘义，貌似谦和忠厚，却贪财而慳吝；

从不表露自己的观点，办什么事情都怕担风险，总是叫别人打头阵。

四、少阴之人

“少阴之人，小贪而贼心，见人有亡，常若有得，好伤好害；见人有荣，乃反愠怒，心疾而无恩，此少阴之人也。”此类人好贪小利，多猜忌；见别人遇到不幸的事，他幸灾乐祸；见别人有荣幸的事，他忌妒甚至发怒；有贼害之心而对人寡恩。

五、阴阳和平之人

“阴阳和平之人，居处安静，无为惧惧，无为欣欣，婉然从物，或予不爭，与时变化，尊则谦谦，谭而不治，是谓至治。”这种人心胸开朗，能随寓而安，既不患得患失，又不沾沾自喜，心安而无所惧，无私而无所畏；不追求物质享受，不爭名逐利；能顺应时代而前进，虽居高位而谦逊；以理服人而不是以力服人，具有很好地治理才能。

以上五种类型的人，以日常所见，阴阳和平的人占绝大多数。其他四种类型的人，只是少数，但这少数人的素质，便是形成精神病的内在因素。当然也应看到，每个人的素质并不是固定不变的；在生活过程中，由于受外界的影响，人的素质也是能够改变的。有些人特有的素质虽然有利于精神病的发生，但是在良好的客观条件影响之下，人的素质改变了，发生精神病的素质也就消失了。

第三章 精神病症状学

关于精神病的症状，中医与西医各有其不同的理论根据，因而也各有其不同的描述。中医关于精神病症状的命名和描述，一般都比较简古。为便于不懂医古文的同志和西医学习中医治疗精神病的方法，本书关于精神病的名称及其症状的描述，将尽量采取中西医对照的方法。为此，在这一章里将分别介绍中医和西医关于精神病症状的不同分类方法。

第一节 中医精神病症状的分类

中医对精神病的症状有很多描述，这些描述都是从临床实践体验中总结出来的，尽管精神病患者的症状表现千奇百怪、多种多样，但归纳起来不外乎四类，即狂、癫、痴呆、癔病等。现将这四类精神病的典型症状分述如下：

一、狂 症

《灵枢·癫狂篇》说：“狂始生，先自悲也，喜忘，苦怒，善恐……狂始发，少卧不饥，自高贤也，自辨智也，自尊贵也，善骂詈，日夜不休”。又说“狂言，惊善笑，好歌乐，妄行不休”。“狂者多食，善见鬼神，善笑而不发于外”。“狂，目妄见，耳妄闻，善呼”。金代成无己说：“阳明之病，恶人与火，闻木音则惕然而惊，心欲动，独闭户牖而处，甚

则欲上高而歌，弃衣而走，踰垣上屋，其所上之处，皆非素所能者……遂发狂也”。元代李杲说：“狂言者，大开目与人语，语所未尝见之事，即为狂言也。明代李梴说：“狂者凶狂也，轻则自高自是，好歌好舞，甚则弃衣而走，踰垣上屋，又甚则披头大叫，不避水火，且好杀人”。以上这些描述说明，狂症是精神运动性兴奋，但它又并非一种躁狂性兴奋，而是包括多种症状。如自高贤、自辨智、自尊贵、善骂詈、苦怒、善笑、好歌乐，这是一组情感过程的障碍，是情感高涨和夸大妄想的表现。如善见鬼神、目妄见、耳妄闻，是一组感知觉障碍的幻觉、幻视、幻听。如少卧不饥、妄行不休，是一组意向行为障碍，是意向增强的表现。如凶狂、踰垣上屋、不避水火、伤人毁物，是紧张性兴奋的一类兴奋状态。

中医所说的狂症，一般常见于躁狂忧郁性精神病的躁狂状态，精神分裂症，癔病，乃至中毒性精神病等等。

二、癲 症

汉代华佗在《中藏经》中说：“有能歌笑者，有能悲泣者，有能奔走者，有能呻吟者，有自委曲者，有自高贤者，有寤而不寐者，有不能言而声味者……”。唐代孙思邈在《千金方》中说：“凡诸百邪之病，源起多途，其有种种形相，示表癲邪之端而见其病，或有默默而不声，或复多言而漫说，或歌或哭，或吟或笑，或眠坐沟渠，噉食粪秽，或裸形露体，或昼夜游走，或嗔骂无度……”。明代李梴在《医学入门》中说：“癲者异常也；平日能言，癲则沉默；平日不言，癲则呻吟，甚则僵仆直视，心常不乐”。清代陈士铎在《石室秘篆》中说：

“如人病花癲，妇人……见男子抱住不肯放。此乃思慕男子不可得，忽然得病，如暴风疾雨，罔识羞耻，见男子则为情人也。”以上各家对癲的描述，包括多种精神病症状。如癲则沉默，心常不乐，是意向行为障碍的意向减退表现。甚则僵仆直视，是木僵状态的表现。如多言漫说，或默默不声，都属于思维障碍，前者象思想奔逸，病人变得非常健谈，语流增快，高谈阔论，滔滔不绝；后者很象缄默症，病人沉默不语，对任何人的询问概不回答，即使再三追问亦毫无反应。如眠坐沟渠，噉食粪秽，或裸形露体，很象意向缺乏，个人生活变得极端懒散，不讲究卫生，连最基本的清洁也置之不顾。如昼夜游走，嗔骂无度，是意向增强的躁狂状态。如花癲见异性抱住不肯放，罔识羞耻，为青春型兴奋，病人低级意向增强，性的色彩浓厚，突出地反映出知、情、意三者之间的不配合，与周围环境也不协调，为精神分裂症的典型表现。有能歌笑者，有能悲泣者，这是情感过程障碍中的情感高涨表现，病人忽而喜笑颜开，歌唱不休，忽而悲哀动中，伤心流泪。有自委曲者，是自责妄想的表现。寤而不寐，是精神兴奋性增高的表现，可见于各种精神病。有不能言而声昧者，属于意向减退。

三、痴 呆

明代张介宾在《景岳全书》中指出：“痴呆证，凡平素无痰而或以郁结，或以不遂，或以思虑，或以疑貳，或以惊恐而渐至痴呆，言辞颠倒，举动不经，或多汗，或善愁，其证则千奇万怪，无所不致……然此证有可愈者，有不可愈者……”。清代陈士铎在《石室秘纂》中说：“呆病如痴而默默

不言，如饥而悠悠如失也，意欲癫而不能，心欲狂而不敢，有时睡数日不醒，有时坐数日不眠，有时将己身衣服密密缝完，有时将他人物件深深藏掩，与人言则无语而神游，背人言则低声而泣诉，与之食则厌薄而不吞，不与食则吞炭而若快。”以上所描述的痴呆属于智能障碍。所谓智能，包括一般常识和记忆、计算、分析、综合、批判、理解、抽象、概括、判断、推理以及进而从事创造活动等等的能力。智能障碍病人主要表现为不同程度和不同性质的痴呆状态。

所谓痴呆，是指一种在精神障碍基础上产生的综合性智能障碍。一般病人的意识是清晰的，但其思维活动却变得很不完善，记忆力和计算力有所削弱，理解能力也减退，对周围的事物不能正确地进行分析和综合，主次不分，标本不辨，对复杂的现象常不能分析、判断，以致不能正常地工作、学习和劳动。

中医所描述的痴呆症状多属于后天性痴呆，包括大脑有器质性损伤的真性痴呆和由于强烈的精神创伤所致的假性痴呆。真性痴呆包括老年性痴呆、麻痹性痴呆、脑动脉硬化性精神病、外伤性痴呆。假性痴呆包括反应性精神病及癔病。

四、癲 癇

宋代严用和在《济生方》中说：“癲癇发则旋晕颠倒，口眼相引，目睛上摇，手足搐搦，背脊强直，食顷乃醒。”元代朱震亨在《丹溪心法》中说：“癲症有五……无非痰涎壅塞，迷闷孔窍，发则头旋颠倒，手足搐搦，口眼相引，胸背强直，叫吼吐沫，食顷乃苏。”以上描述的癲癇发作，是一时性的发作，多为癲癇大发作。明代楼英在《医学纲目》中说：“癲

痫，……邪气逆上则头中气乱，头中气乱则脉道闭塞，孔窍不通，故不闻声，目不识人，而昏眩无知，仆倒于地也。”明代张三锡在《医学准绳六要》中说：“大抵癫痫之发，由肾中阴火上逆，而肝从之，故作搐搦，搐搦则偏身之脂液促迫，而气上逆，吐出于口也。然肾间动气，乃生气之原，肾伤则志不足，故神躁扰，火逆上，攻动其痰而厥也。或经脉引入外邪，内伤深入，伤其生气之原，邪正混乱，天枢不发，卫气固留于阴而不行，不行则阴气蓄满，郁极乃发，发则命门之相火自下逆上，填塞其窍，惟迫出其如羊鸣者一二声而已。偏身之脂液，脾之涎沫，皆迫而上胸臆，流出于口，五脏六腑十二经脉皆不胜其冲逆，故卒倒而不知人也。食顷，火气退散乃醒。若生气未复，则余邪渐炽而复作也”。

上面各家所称痫症有五，或称五痫。元代朱震享有马痫、牛痫、鸡痫、猪痫、羊痫之分，都是以发作时状似五畜之声而命名。明代李梴有肝痫、心痫、脾痫、肺痫、肾痫之别，是以发作时的面色青、赤、黄、白、黑而命名。这些因像因声分痫法，无何重要意义。但癫痫发作开始都吼叫一声（民间俗称羊角疯），这一声吼叫可能由两种原因促成：一是患者意识到癫痫将要发作，来不及呼唤别人而惊叫；二是发作之始喉肌和胸肌痉挛迫使患者不得不喊叫一声，随之意识丧失而跌倒，四肢痉挛而抽搐。

以上这些讨论均为癫痫大发作的形式，未涉及到其它形式的发作和精神等体征。精神体征包括朦胧状态、癫痫样木僵状态和特殊状态。

上面分述了中医对精神病的症状分类，描述了古人临床观察到的狂、癫、痴呆、痫。各家对各类症状的不同描述，

虽然不能全面概括，但是，它对于学习和研究中医精神病症状学还是有其参考价值的。

第二节 现代医学关于精神病症状的分类

现代医学把正常人的精神活动主要归纳为三个过程，即认识过程，情感过程和意向过程，简称为知、情、意。人发生精神病，也就是这三个过程中的某个过程发生了障碍。因此，将精神病的症状也归纳为三个系统，即认识过程的障碍、情感过程的障碍和意向过程的障碍。精神病患者的症状，有的表现为某一个过程的障碍，而较多的是几个症状或几组症状结合出现，这些症状之间有内在的联系，其形式也相当固定，并各有其独特的特征，习惯上称之为症候群。因此，这一章将按照认识过程障碍、情感过程障碍、意向行为过程障碍、精神病症候群和定向力与自知力的顺序，分别介绍其症状。

一、认识过程障碍

(一) 感知觉障碍

1. 错觉

错觉就是把一种真实事物或现象感知为另一种事物或现象。如把绳子看作蛇，把挂着的衣服看成人等。

错觉以错视和错听较为常见。尤其是在意识障碍时更容易出现。它们往往和思维情感障碍等有一定的联系，多见于传染病性精神病、中毒性精神病和精神分裂症等。患者不能主动纠正错觉，因此它持续时间较长。

2. 幻觉

幻觉是一种虚假的感觉，患者所感知某种事物是客观并不存在的。有的幻觉是十分荒谬的，但病人却坚信这是通过他的感官所获得的亲身感受。由于感受的器官不同，幻觉可分为幻听、幻视、幻嗅、幻味、幻触和内感受器的幻觉等。

(1) 幻听。幻听是最为常见的幻觉，它不仅影响病人的思维和情感，往往还能支配病人的意志行为。病人可从各处听到各种不同性质的声音，如谈话、咒骂、呼喊、唱歌、无线电广播、射击、爆炸等等，其中以语言幻听较多见。语言幻听的内容，多半是使病人感到不愉快的批评、斥责、讽刺、嘲笑、威胁或侮辱，病人因难于忍受而哭泣、苦恼、愤怒，甚至引起兴奋而出现自伤、伤人的情况。有时患者所听到的是对他表示同情、关怀、赞美的话，病人可表现为独自微笑和洋洋自得。有时患者听到命令性质的语言，迫使病人遵照幻听的指示做出危害社会秩序的事。

(2) 幻视。幻视也极为常见，其内容丰富多样，形象常清晰、生动、鲜明、具体，与实际事物极为类似；但有时映象较模糊，就象一些图片似的。比较常见的是现实性的形象，尤其是在意识障碍下，常见到一些荒谬离奇的人物。病人对这些幻觉的态度也有所不同，有的好象自己是一个旁观者，有时却正式参与其中，因而病人所表现的情感体验和行为举动有显著的差别。

(3) 幻嗅。病人可闻到一些多半是使他感到不愉快的气味，如肉类、果品、蔬菜、蛋类、尸体的腐臭味或烧焦物品的气味，以及粪便味、血腥气、化学药品气味等等。这些幻嗅可单独出现，但常与其它的幻觉和妄想结合在一起。

(4) 幻味。幻味较为少见。病人可从食物和饮料中尝到某种特殊的、不愉快的味道。它也常和其它幻觉或妄想共同出现。

(5) 幻触和内感受器幻觉。这两种幻觉可和其它精神障碍同时出现。有时病人感到有一股电流不断在刺激他的皮肤、肢体和肠胃。有的病人感到皮肤下面有虫子在爬动，有的病人感到腹中有到处串走的奇怪疼痛，因而认为自己患了不治之症。

(6) 思维鸣响。这是一种特殊形式的幻听，它一般都是伴随着病人的思想活动而出现的。当病人想要做什么，就听到重复的声音，其内容和他所想的基一致。病人感到重复的声音是有人在重复他的思想，有时病人认为自己的思想已被别人测知，因而就在他所听到的言语中反映出来。

(7) 机能性幻听。这类幻听的特点，是当病人听到外界某些真实的声音的同时，又出现另一种与此无关的声音。这种幻听，是在病人听觉器官处在外界声音刺激之下而引起机能活动的状态时所出现的。它并不与外界真实的声音刺激融合在一起，而是同时被感知。当外界的声音消失时，这种幻听也随之消失。

按照幻觉的完善程度，一般可分为完全性幻觉和不完全性幻觉两种。上面所说绝大部分都属于完全性幻觉，也称之为真性幻觉。不完全性幻觉除感知成分外，还有表象、思维等成分，它不象真性幻觉那样鲜明具体，是一种存在于主观空间内的感觉。如思维鸣响的病人，当他想到什么，就听到一种与他思想一致的声音，因而感到自己的思想是听得见的。视心症的病人，当他想到什么，就有相应的形象出现在眼

前，故此也叫思维显形。另外，读心症、精神性幻觉、强迫性幻觉也属于不完全性幻觉的范畴。这种幻觉一般多见于精神分裂症，而且是它的特殊症状。

在临床中善于发现患者的幻觉，并证实它的存在，对确定疾病的性质有很重要的意义。由于一般患者缺乏自知力或受幻觉和妄想的影响，往往不能自觉地反映其幻觉体验，甚至隐瞒自己有幻觉。因此，医生必须注意观察病人，通过他们的姿态、表情、情感、反应、语言内容、举止行为等发现和证实他有幻觉存在。

3. 感知觉综合障碍

病人所感知的事物是客观确实存在的，但对其某些属性如大小、长短、形状、轻重、颜色、位置、距离等等却产生一种与该事物的实际情况不相符合的歪曲的感觉。例如病人把别人的脸看成长的或歪斜的，把小的东西看成很大（视物显大症），或把大的东西看成小的（视物显小症），把远物看得很近，近物看得很远。或感到自己的身体很轻，手臂变得很长。精神分裂症初期的病人，常不断照镜子，因为他看到自己的脸变得非常难看，以致气得砸破镜子（窥镜症）。对此病人虽然感到奇怪，但仍不能意识到它们是不正常的现象。这些症状对早期诊断有很大意义。

（二）思维障碍

人们平时思考问题，就是思维活动的一种表现。思维还常常通过语言、文字而表达出来。当思维过程发生障碍时，就必然在病人的言语和文字中反映出来。

一般常见的思维障碍有联想障碍和逻辑障碍两类。

1. 联想障碍

(1) 思想奔逸。这是一种在兴奋状态下思维联想的障碍，主要是指思维量的增多和转变的迅速而言。病人思维活动显著增加，联想迅速，新的概念接二连三地涌现出来，内容十分丰富。病人变得非常健谈，口若悬河，滔滔不绝；写文章大有“下笔千言，一挥而就”之势。但是，这种病人无论说话或写文章都比较肤浅，概念与概念之间的联系也不够紧密，主题极易变动，常常是一件事情未谈完就转移到另一个话题上去；而主题常常是随着周围环境的变化而转移的（随境转移）。病人的语言中常有某些词句的意义相联（意联）或某些词句中同音押韵的字词相联（音联）的现象。病人在高度的兴奋状态下，言语或文字常不很连贯或有片断的遗漏。这类症状常见于躁狂忧郁症的躁狂状态患者。

(2) 病理性赘述。病人言语明显增多，能表达其主要意思，但非常噜嗦，夹杂许多不必要的描述、解释。病人对许多事物缺乏明确的概念，分析和理解都有困难，不能作出正确地选择和判断。这种病理性赘述多见于老年性精神病痴呆、脑动脉硬化性精神病、麻痹性痴呆、癫痫等大脑器质性损害所致的精神病的患者。

(3) 思维迟缓（抑制思维）。它与思想奔逸恰恰相反，病人思维活动显著变慢，联想困难，思路阻滞。因此，病人的语言显著减少，反应迟钝，对于一些简单的询问也往往需要再三重复和催促才能回答，语流缓慢而不流畅，写封短信也很困难。病人常诉说自己的脑子变笨了。

这类症状常见于躁狂抑郁性精神病的抑郁状态患者。

(4) 思维贫乏。这类症状与思维迟缓在表面上颇有类似之处，但本质则有所不同，它主要是概念的产生显著减少，

以致思维活动内容空洞，概念和词汇贫乏，反应迟缓，言语简短。常答以“没什么”，“不知道”。平时不主动讲话，觉得脑子空虚，没有想什么事，也没有什么可说的。

这类症状经常与情感淡漠、意向缺乏同时出现，为精神分裂症单纯型或精神分裂症晚期阶段的主要表现之一。

(5) 缄默症。病人沉默不语，对任何人的询问概不答复，即使再三追问也毫无反应。常见于精神分裂症紧张型患者。

(6) 破裂性思维。这是在没有意识障碍情况下所产生的思维紊乱状态。病人联想破裂，思维内容缺乏内在联系和应有的逻辑规律，说话前言不搭后语，答非所问，人们无法理解其用意所在。

这类症状主要见于精神分裂症患者。

(7) 思维不连贯。这是在严重意识障碍情况下产生的一种状态。病人的语言缺乏主题，句与句，甚至单独的词与词之间无任何词义上的联系，整个语言零星片断、杂乱无章。

这类症状多见于传染性或中毒性精神病、外伤性谵妄、发热性谵妄患者。

2. 逻辑障碍

(1) 妄想。这是一种病人在病理基础上对于周围事物产生的歪曲的信念、错误的判断和推理，有的信念、判断和推理非常荒谬，但病人却坚信不疑，别人很难给予纠正。

妄想常见于精神分裂症、心因性妄想症、更年期妄想症、躁狂忧郁性精神病，以及器质性精神病患者。

妄想的表现形式不一，根据其内容的不同可区分为很多种，最常见的有以下几种。

甲、关系妄想 病人将周围环境与他无关的人物、现象或其它变动，错误地认为都和他有着密切的关系并且是针对他的。例如有人咳嗽、吐痰、关门、说笑，甚至收音机广播、报纸登载的新闻，都被认为是针对他的。

乙、被害妄想 病人无中生有地坚信他周围有某些人甚至是他的家属在打击、陷害他，或在饭里放毒，或者跟踪监视等等。这是一类最常见的妄想，多数先从怀疑开始，进而形成关系妄想，以后又逐渐发展为被害妄想。多见于精神分裂症或中毒性精神病患者。

丙、自罪妄想 病人毫无根据地或根据一些微不足道的琐事，认为自己犯了严重的错误和罪行，甚至认为自己给人民、国家造成不可弥补的损失，罪大恶极，不可饶恕，因而等待判刑，拒食，或者自杀。多见于精神分裂症和忧郁症。

丁、夸大妄想 病人认为自己才华盖世，聪明绝顶，是当今最伟大的人物，因而表现出得意洋洋、盛气凌人，经常以命令的口吻对待别人。

戊、疑病妄想 病人坚信自己患了严重的疾病，并且已经不可救活。这类病人发展到晚期阶段还可出现虚无妄想，认为自己的某些内脏已坏死或脱落而不复存在。多见于更年期精神病、精神分裂症患者。

己、嫉妒妄想 病人始终认为自己的爱人对他(她)不忠实，另有外遇，甚至能说出第三者的特征。多见于更年期精神病和精神分裂症患者。

庚、钟情妄想 病人坚信自己为某异性所眷恋，即使遭到对方严词斥责或殴打，也毫不置疑，甚至终日追求，纠缠不休。多见于精神分裂症患者。

辛、影响妄想及物理影响妄想 病人坚信自己的所有精神活动及行动都受到某些人或某种仪器的影响和控制，以致自己的思想、行为完全不能自主。多见于精神分裂症患者。

(2) 象征性思维(概念混乱)。病人以某种形象性的事物、信号或标记作为一种象征来代替某些特殊的、抽象的概念。但是这种病理性象征，如果不经病人自己的解释是无法理解的。病人常将抽象的概念与具体事物混为一谈。多见于精神分裂症特殊状态患者。

(3) 读心症(内心被揭露感)。病人坚信自己内心所想的事已经被别人知道或揭露出来，尽管他也说不出是怎样被人探查到的，但根据他的推论确实已经尽人皆知，甚至闹得满城风雨。多见于精神分裂症患者。

(4) 强迫性思维(强迫观念)。病人对自己的某些思想活动或观念，即使清楚地意识到是不必要的、不合理的和毫无实际意义的，但自己却无法控制，无法摆脱，纵然竭尽全力加以抵制也无济于事，因而感到非常痛苦。这类强迫观念的表现形式不一，其中以强迫性怀疑、强迫性穷思竭虑较为多见。

(5) 逻辑倒错。患者的推理毫无根据或恰恰相反。如病人认为他的母亲要害死他，那是由于他母亲太爱他的缘故，等等。这是精神分裂症患者的特殊症状。

(6) 语词新作。病人常自造一些文字或符号，或把几个字拼在一起代表一句话等等。这也是精神分裂症患者的特殊症状。

3. 语言文字障碍

(1) 模仿语言。病人似鹦鹉学舌，别人说什么，他也说什么，同时伴有模仿动作。是精神分裂症患者的特殊症状。

但在器质性脑病出现意识障碍时也可出现。

(2) 失语及失音。失语多见于脑器质性病变患者。失音并不是由于发音器官损伤造成的，病人仍可开口、吞咽或发出嘶哑之声。多见于癔病患者。

(3) 近似回答症。病人答问总是近似正确，给人以故意开玩笑的感觉。多见于癔病患者。

(三) 记忆障碍

记忆是一种在感知觉和思维基础上建立起来的精神活动。一切复杂的高级心理活动都必须以记忆作为基础。

记忆一般通过四个主要环节构成，即识记、保存、认知和再生；通俗地说，就是记住、不忘、认得和想起来。这四者既相互关联又密切组合。人们对于事物的识记和保存，形成关于事物的经验，而认知和再生则不但可以证明过去的经验是否已保存下来，而且还能使过去所保存的经验更为巩固。这种表现在认知和再生过程中的过去经验的反映，就叫做记忆。

一般常见的记忆障碍有以下几种：

1. 记忆减退

这是指病人对上述四个环节的保持能力较病前或一般的正常人有不同程度的减退，即所谓“记不住事”或“想不起来”。它有近记忆减退和远记忆减退之分。这类症状常见于神经衰弱患者，也可见于中毒性精神病、脑动脉硬化等一些大脑器质性病变的病人。

2. 遗忘症

这是一种再生能力的障碍。遗忘可与躯体某些疾病(如颅脑外伤)同时发生，病人对疾病发生后的某一段时间内所

发生的事件不能回忆(顺行性遗忘),有的则对疾病发生以前某一阶段中的事件不能回忆(逆行性遗忘),还有的遗忘过去经历中的一段时间内的事件(阶段性遗忘)。

遗忘症常见于颅脑外伤性精神病、老年性精神病、一氧化碳中毒和癔病患者。

3. 错构

这是一类表现为记忆错误的障碍。病人将过去确实发生的事情的时间、地点、情节记错,虽经别人提醒、纠正,病人仍坚信他所记的是真实的。这类症状可见于老年性精神病、脑血管硬化性精神病患者。

4. 虚构

这是指病人把过去从未发生的事说成是确有其事。病人以虚构的事实来充填他所遗忘的那段时间的经过。虚构可见于颅脑外伤性精神病、中毒性精神病、麻痹性痴呆等患者,亦可见于精神分裂症患者。

(四) 智能障碍

智能是指人们学习、工作、劳动和生活的能力,它来自于先天和后天两方面。智能不仅与感知(实践)、思维(理论)有极为密切的关系,而且与知识经验的储存和积累紧密相关。因此,智能包括人们的一般常识、记忆、计算、分析综合、批判理解、抽象概括、推理判断以及进而从事创造活动等能力。

当智能发生障碍时,临床上主要表现为不同程度和不同性质的痴呆状态。

1. 真性痴呆

这类痴呆主要由于大脑器质性病变所引起,因而它不仅

表现为学习、工作和生活能力的降低，而且在情感和意向活动方面也往往有轻重不同的失调。一般来说，这类痴呆多不易恢复或不能完全恢复正常，并且多呈现出进行性的改变。由于病变的性质和其损害的范围与程度不一，临床上可区分为以下几种类型。

(1) 先天性痴呆。这是指大脑在未发育成熟时受到各种有害因素损伤，以致智能的发展停留或被限制在某种低级的阶段。病人不能进行与其年龄相适应的学习和工作，随着年龄的增长，痴呆现象也逐渐明显。这类痴呆，可根据其程度的不同区分为白痴、痴愚和愚笨(低能)。

(2) 后天性痴呆。这是指病人的大脑发育已基本成熟，智能亦发育正常，但以后由于各种有害因素侵犯大脑，引起器质性损害，因而造成智能不同程度的缺损。常见于脑炎后遗症、老年性痴呆、脑动脉硬化性精神病及麻痹性痴呆患者。

2. 假性痴呆

这类痴呆主要由于强烈的精神创伤而产生，临床表现与真性痴呆颇相类似，但其本质则迥然不同。病人对一些非常简单的问题不能正确解答或解答得很荒谬，例如不知道自己的姓名、年龄、一周有几天，但他在生活中却能解决比这些复杂得多的问题，如下象棋能战胜对方，生活也都能自理，待人接物一如常人。因此给人一种机灵、做作或开玩笑的印象。这类痴呆患者经过适当治疗，在短期内可以完全恢复正常。常见于反应性精神病或癔病患者。

由于大脑损伤的病理变化的严重程度以及病变所涉及的范围大小不同，痴呆又分为两类：一类是全而性(普遍性)痴

呆。在这类病人中，大脑的病变主要呈现为弥散性的损害，可侵犯到大脑所有的部位(如老年性痴呆、麻痹性痴呆等)，以致在这类痴呆中，既涉及智能活动的各个方面，也可能影响病人的全部精神活动，甚至还经常出现人格的改变。另一类是局限性(病灶性)痴呆。这类痴呆由于病变所侵犯的只是某些限定的区域，如大脑血管的周围组织等，因而使智能产生部分的障碍，如记忆减退、理解力的降低、思考困难等等，但其人格的基本特征一般仍保持良好，也具有一定的批判能力和自知能力。这类痴呆常见于脑动脉硬化性精神病、外伤性痴呆患者。

二、情感过程障碍

(一) 情感高涨

病人的情感活动显著增强，表现得轻松愉快，喜笑颜开，兴高采烈，说话时眉飞色舞，表情生动活泼，对一切都感到非常乐观，对任何事都感兴趣，自负自信。但这种情感并不稳定，病人容易激惹，稍有不遂即勃然大怒，遇悲哀事就会伤心流泪，不过这些变化转瞬即逝，很快就恢复原状。这类症状是躁狂忧郁性精神病躁狂状态的一种典型表现。

(二) 情感欣快

这类症状在表面上与情感高涨颇相似，病人总是乐呵呵的，表现出十分满意和幸福愉快的神态，但其面部却明显地给人一种呆傻、愚蠢、单调、刻板的感觉，有时有幼稚行为。多见于器质性精神病如脑动脉硬化性精神病、老年性精神病、麻痹性痴呆等患者。

(三) 情感低落

它与情感高涨恰恰相反，病人情绪低沉，整日愁眉苦脸，忧心忡忡，唉声叹气或低声饮泣；重则忧郁沮丧，悲观失望，生趣索然，大有度日如年、生不如死之感。外界一切不仅引不起他的兴趣，反而徒增其悲哀的消极情绪，病人常自责自罪，甚至出现自杀企图。这类症状为躁狂忧郁性精神病忧郁状态患者的典型症状之一，也可见于反应性忧郁症和更年期忧郁症患者。

（四）焦虑

病人在缺乏明显的客观因素或充分根据的情况下，对本身健康或其它问题感到忧郁，焦急，紧张，恐惧，顾虑重重，认为病情严重或问题无法解决，以致搔首顿足，坐立不安，若大祸之将临，惶惶不可终日，即使多方解释，也不能消除他的焦虑。这类症状常伴有植物神经功能紊乱和疑病观念，常见于更年期忧郁症患者，也可见于神经衰弱患者。

（五）情感脆弱

一般在细微的外界刺激下，病人情绪容易波动，情感反应迅速而强烈，常因细故伤心流泪或兴奋激动而无法克制，常见于癔病、神经衰弱或脑动脉硬化性精神病患者。

（六）情感淡漠

病人对外界任何刺激均缺乏相应的情感反应，对能引起正常人悲伤或喜悦的事情，他都无动于衷，漠不关心。面部表情淡漠呆板，内心体验日益贫乏。这是精神分裂症患者经常出现的症状，也可见于严重的痴呆病人。

（七）情感倒错

病人的情感活动和正常人相反，该哭的却笑，该笑的却哭。还有一种叫表情倒错，即内心体验和表情截然相反，如

有的病人会很愉快地诉说自己的不幸遭遇和痛苦往事。此类症状常见于精神分裂症青春型患者。

(八) 强迫性情绪(恐怖症)

这是一种带有强迫性质的、不以病人的意志愿望为转移而又不由自主的恐惧情绪。病人对过去并不感到可怕的情况却产生一种紧张恐怖的心情,自己也知道是不必要的,甚至也能意识到这种恐怖感是不正常的,但却不能控制。因而感到非常痛苦。恐惧的内容很多,如:怕脏、怕感染、怕尖锐物件、怕空旷的广场、高地和深渊,怕脸红、怕死亡等等。这类症状常见于强迫性神经官能症、神经衰弱或精神分裂症早期患者。

三、意向行为过程障碍

(一) 意向增强

这是指患者意向活动增多,但不同疾病的患者其意向增强的表现有所不同。在躁狂状态时,病人对其周围一切事物都感兴趣,什么事都介入或干涉,不能保持片刻的安静,但随着外界环境的变化而不断改变其行为,所以常是有始无终,一事无成。在精神分裂症患者,有的由于受妄想的支配,可表现为不断地到处控告;有的则表现在食、性等低级意向的增强。

(二) 意向减退

正和上述现象相反,病人的意向活动显著减少,对周围一切兴趣索然,意志消沉,不愿参加活动,什么也不想料理,因而经常独处一隅。语言也相对的减少,甚至缄默不语,如坚持向他提问,或小声回答,或以表情及手势做出反

应。尽管这样，病人和周围人的关系仍是协调的，并无脱离或不配合的表现。病人对这些变化还能意识到，而且基本上并不缺乏一定的意向要求，但总感到自己做不了或不想做，因此，病人的活动就较正常时明显地减退。这类症状常见于躁狂忧郁性精神病忧郁状态的患者。

（三）意向缺乏

这是较之意向减退更为严重的一种症状，病人对任何活动既缺乏明显的动机，又没有什么确切的企图和要求，不关心事业，也不要求工作和学习，行为被动，不遵守纪律，生活懒散，不讲卫生，与周围环境不能协调一致，但病人不能意识到它是不正常的。这类症状常与思维贫乏、情感淡漠同时出现，而构成精神分裂症中常见的基本症状之一。一般多见于单纯型或晚期阶段以及器质性精神病痴呆状态患者。

（四）意向倒错

病人的意向与常情相违背，以致病人的某些活动使人感到难以理解。例如有的病人吃肥皂、脏土、大小便、草木、虫类等等。这种行为多在某些幻觉和妄想的支配下产生，病人常对此做出一些荒谬的解释。这类症状多见于精神分裂症青春型或妄想型患者。

（五）违拗症

病人经常对别人提出的要求表示拒绝或反抗，有时不做任何反应，有时则做些恰恰相反的动作。例如医生要病人张嘴进行舌诊时，病人却反而紧紧闭着嘴。可见于精神分裂症紧张型患者。

（六）木僵

病人的意识一般是清醒的，但却在一个相当长的时间内

停止运动，僵持在那里，面无表情，不言不语，不吃不喝，不排大小便，口角流涎，对任何刺激都无反应，即使针刺或以手在他眼前作欲击状，也不眨眼或躲避。但在深夜可稍有活动或低声应答。严重时病人的肢体可任人摆布，即使摆在一个极不舒服的姿势，也可保持很久不动(腊样屈曲)。这种状态常可突然转为兴奋而中止，有时也可自动缓解。多见于精神分裂症紧张型。

(七) 强迫性动作

这类症状和强迫性思维、强迫性情绪具有共同的特性。虽然病人自己知道这些动作是不正常的，但却无法控制。因此，病人感到非常痛苦，迫切要求治疗。这类症状是强迫性神经官能症的主要特征之一，也可见于精神分裂症早期患者。

四、精神病症候群

(一) 幻觉妄想状态

这一组症状常见于精神分裂症和反应性精神病患者。病人具有丰富的幻觉和妄想，而且两者密切结合，互相影响，经常作为一个整体表现出来。例如病人有关系妄想或被害妄想，同时还有幻听，病人既可由于这些幻听的作用更加坚定他的妄想观念，又可因这些妄想而反过来强化幻听，从而加重病情。

(二) 躁狂状态(精神运动性兴奋、躁狂性兴奋)

这一组症状的特点是思想奔逸，情感高涨，意向增强；三者互相配合，同时又与其周围环境协调一致，从而形成一个完整的兴奋活动，因而病人的言行均易为人所理解。病人

意识清晰，定向力大致完整，但自知力有所缺欠。这类症候群构成躁狂忧郁性精神病躁狂状态的特征性表现。

（三）青春性兴奋

具有这一组症状的病人语言增多，语无伦次（破裂思维）而内容极为荒谬，常伴有离奇片断的幻觉和妄想。病人哭笑无常，变化莫测，情感倒错，不可理解。病人的行为举动不仅杂乱冲动，而且离奇荒谬、幼稚愚蠢，常有低级意向（食、性）增强的表现。临床的突出表现是知、情、意之间既不配合，又与周围环境不协调，这是它与躁狂状态相区别的特点，它是精神分裂症的典型表现之一。

（四）紧张性兴奋

这组症状的特征，主要表现为病人突然出现强烈而冲动的兴奋活动，既无明显的原因，亦无确切的指向或目的。行为动作杂乱、单调、刻板、生硬，甚至极为粗暴，如伤人、毁物等，具有一定的破坏性或攻击性。患者语句简短，内容贫乏、单调、杂乱、刻板、连贯性较差，表情呆滞、生硬，由于知、情、意三者之间的不配合以及与环境的不协调，这类兴奋状态也是令人不可理解的，并且一般持续时间不长。多见于精神分裂症患者。

（五）紧张性症候群

这是精神分裂症紧张型的一种特征性症状。它是由木僵状态和紧张性兴奋所组成，二者常先后交替出现，但一般以木僵状态持续时间较久，甚至可长达数月至数年，而紧张性兴奋则较为短暂。具有这类症候群的患者，除有违拗现象之外，还经常出现刻板语言及刻板动作。此外还可见模仿语言及动作。

（六）忧郁状态（精神运动性抑郁）

这个症候群的特点是思维迟缓、情感低落、意向减退，是躁狂忧郁性精神病忧郁状态的典型表现。

（七）强迫状态

这组症状，主要包括强迫思维、强迫情绪及强迫性动作。它们经常同时出现，相互作用而构成一组非常顽固的症状，在病人整个精神活动中占居主要地位。如病人怀疑自己的手沾染了某种细菌，因而非常恐惧，反复不断地洗手。对有些事，即使患者也知道不对或不可能，并努力要摆脱某些思想、情绪、动作和行为对他的支配，但往往适得其反，愈演愈烈，因而感到非常痛苦。这类症候群主要见于强迫性神经官能症患者。精神分裂症早期患者虽也可见到此类症候群，但病人缺乏自知力，也没有和它进行斗争的表现。

（八）意识障碍症候群

在精神病临床中所谓“意识”，主要是指整个精神活动的状态而言。它不仅包括精神活动的内容、范围、清晰程度，以及对内、外环境的认识，而且还与精神活动的其它组成部分有一定的联系。因此，对于意识状态的辨认，以及在意识发生障碍的情况下所出现的各种精神症状的识别，对临床诊断与治疗都有极为重要的意义。

1. 朦胧状态

这类状态的特点在于意识领域的缩小或狭窄。在一定范围内，病人对某些外界刺激或事物能做出相应的反应，甚至其外表行为也相当正常；但在其它方面则不能正确地定向，出现感知困难，常对周围环境中的某些个别现象给予歪曲的评价。有的可以出现片断的幻觉和妄想，病人的情感和行为

往往受体验的支配，因而可能产生一些粗暴的或危险的动作和行为。这种状态常常是发作性的，持续时间一般不长；当意识恢复正常后，对其病中所发生的事情和体验，几乎完全不能回忆。这类症候群常见于癔病、癫痫性精神病、反应性精神病、脑外伤性或中毒性精神病患者。

2. 谵妄状态

这类意识障碍的特点，是经常出现大量的错觉和幻觉，内容丰富多变，其中以幻视更为多见，所看到的往往是一些生动而逼真的恐怖场面(如大火、神鬼、猛兽)，因而病人显得非常恐惧、紧张或兴奋，哭泣、行为冲动、突然喊叫、逃跑、挣扎、躲藏或打人毁物。思维紊乱，言语极不连贯，并可有片断的妄想。对环境定向一般都有缺损，但自我定向依然存在。这类状态多在晚间或体温增高时加重。患者清醒后，对病中所发生的情况和体验仅有片断回忆，有的完全不能回忆。常见于传染性的、中毒性的或颅脑外伤性精神病患者。

五、定向力与自知力

为精神病患者作临床诊断时，除必须注意检查患者有无上述各项症状之外，还应注意检查患者的定向力和自知力。

(一) 定向力

定向力是指人们对时间、地点、周围人物(对环境的定向)以及对自己本身的特征(包括姓名、年龄、职业等自我定向)几个方面的识别和判断的能力。精神活动失调的人，常可发生定向的错误，不能正确地对这些情况加以辨认，在意识障碍下尤其如此。精神分裂症病人，由于妄想观念的作

用,对某一个人的辨认可能同时出现两种迥然不同的判断,例如病人对医生,既承认是医生,同时又认为是法官。这类定向障碍称之为双重定向障碍。定向力障碍常见于脑器质性病变、痴呆患者及精神分裂症患者。

(二) 自知力

自知力是指病人对其本身所患疾病的识辨和判断的能力。一般正常人都能正确地意识到自己是否有病,并且还能确切地叙述自己患病的经过和当时的身体状况,以求取得及时的治疗。精神病患者多不能认识自己有病,更不知道疾病的严重程度,因此坚决否认有病,并拒绝就医或住院治疗。这种自知力的丧失,在临床上既可作为病人是否有病的客观指标之一,另外根据其完整的程度以及变化的过程,又往往可作为判断疾病是否痊愈的标准。

第四章 精神病诊断学

中医诊断疾病，是从病人的整体情况出发，运用辨证的理论和方法，以识别病证、推断病情的。因本书是专门论述有关精神病的诊断和治疗方法的，所以本章将只介绍与诊断精神病关系密切的四诊、八纲及脏腑辨证，至于经络辨证、三焦辨证、卫气营血辨证，就不在此一一赘述。

第一节 四 诊

四诊是指望、闻、问、切。因为诊治精神病首先要询问病史和现状，临床惯例是先问陪诊者，记好病历，然后再看患者，因此将问诊列于首位。

一、问 诊

问诊是中医诊断疾病的重要环节，就是要有目的地询问病史，收集资料，为辨证打下基础。但是，对于精神病患者的问诊，与对其他疾病患者的问诊又有所不同。关于精神病患者的问诊，应该包括下列几项内容：

（一）问病前性格

患者病前性格与辨证有密切关系。根据笔者临床体会，如患者病前的性格孤僻，沉默寡言，心量狭窄，胆小怕事，多思善虑，他就不易暴露思想。对于这样的患者，一要耐心

地做思想工作，二可结合起病原因，参考四诊，分析其病情。心量狭窄、沉默寡言者容易患肝气郁结；胆小怕事、多思善虑者容易耗伤心脾。如患者的性格倔强，好说，稍不如意就发脾气，就容易暴露思想，好做思想工作。这样的病人容易暴怒伤肝或心肝火盛。

（二）问思想状况

主要问病前的思想状况、兴趣爱好、思想问题和病后对待疾病的态度。

（三）问工作和家庭情况

要问清患者有无工作，做何种工作（是体力劳动还是脑力劳动，是轻体力劳动还是重体力劳动，是否需要精神高度集中），工作中劳逸结合如何，工作表现如何，是否热爱本职工作，在工作中与同志的关系如何，工作中有无困难，工作中是否接触毒物。

关于家庭情况，要问清患者在家庭中的地位，和家庭成员的关系，婚姻状况，以及家属中有无遗传病史。

（四）问起病原因

要详细了解有无明显的发病原因，包括精神因素、传染病、中毒、以及外伤史等。

（五）问病程

问清患者发病的时间、经过。按一般情况，新病多属实证，治疗收效较快。久病多属虚证，治疗收效较慢。

（六）问治疗经过

要问清发病后经哪里的医生作过何种治疗，疗效如何，症状有无改变等。

（七）问既往史

患者既往有无精神病史及其它病史，此次患病与既往有无关系，包括躯体有何疾患和平时健康水平。

(八) 九问

除上面要问的基本情况之外，还要有的放矢地进行“九问”即：

1. 问寒热

问病人有无怕冷、发烧情况。除外感病，包括传染病引起的精神障碍，多在高热时病邪传里，邪入心包的神昏谵语；邪入阳明的有发热性谵妄状态。

久病午后潮热，手足心热，为阴虚。平素怕冷，四肢逆冷为阳虚。

2. 问汗

外感病人有汗为表虚，无汗为表实。人睡后汗出，醒来汗止，为阴虚盗汗。白昼岑岑汗出，或稍动就汗出不止，伴有心悸、虚弱感为阳虚自汗。

3. 问饮食

多食善饥为胃有实火(甲状腺机能亢进和糖尿病“中消”的病人)。食欲减退为脾胃虚弱。能食但食后不消化，为胃强脾弱。食后胃痛加重，为实症。食后胃痛减轻，为虚症。拒食的原因很多，可能由于自罪、迫害等妄想，或怀疑妄想等所致。

口渴引饮，多饮能消为上消(如糖尿病“上消”、神经性烦渴症)。喜凉饮为胃热。喜热饮为胃寒。口淡不渴为脾阳虚。口干不欲饮水为阴虚(服安坦和阿托品等药物引起的口干例外)。口渴不欲饮水，或饮后不适，为湿盛。饮水则吐为停饮。

4. 问二便

大便稀溏为脾虚寒。黎明即泻为肾阳不足。暴泻，肛门灼热为湿热。大便不干，便时不爽为湿滞。先干后稀为脾虚。大便数日不解为胃肠实热。久病者及老人便秘，便下如羊粪为津液亏损。妊娠或产后便秘为血虚。

小便黄少为实热。尿混浊为湿盛。尿黄少，溺时尿道涩痛为膀胱湿热。小便频而量多为下消（糖尿病“下消”，尿崩症）。小便清长，为虚寒。小便频数，尿后余沥不尽，为肾气不固。

5. 问头身

头痛是精神病尤其是神经官能症最常见的症状。要问头痛的部位、性质和程度。由于疾病的性质不同，头痛的表现也有所不同。偏头痛，疼痛剧烈，时痛时止，多为肝胆风热。头顶胀痛（要检查有无颅压增高和高血压），多为肝阳上亢。头痛伴有眩晕，多为阴虚肝阳上亢。头痛绵绵不止，多为血虚。头痛不重，伴有眩晕，血压偏低，多为气虚清阳不升。头痛如裹，为湿盛。有脑外伤史者头痛如刺，多为瘀血。有中毒史者头痛，为毒邪犯脑。由失眠引起的头痛，按失眠辨证。

身痛：恶寒发热，全身痠痛，为外感。久病身痠痛，为血虚。身倦怠无力，为气虚。身串痛无定处，为肝气阻滞经络。全身关节痛，阴雨天加重，为风湿痹症（风湿性关节炎）。肢震颤，或瘫软，为血不荣筋。持久性肢麻木，为气血不足。如触电样放射性麻，为肝风内动。四肢痠痲、痉挛、抽搐（瘧病发作），多属于肝风内动。

6. 问胸腹

阵发性心前区痛(心绞痛)，为心阳气不足，或兼血滞。两胁痛，为肝郁不舒。两胁刺痛为瘀血。脘胁串痛，为肝胃不和。阵发性气上冲心，为奔豚症(瘕病)。脘腹痛喜按、喜暖，多为虚寒。痛处拒按，为实症。发作性腹痛，痛时有硬块，为虫积。

7. 问耳聋

耳突然暴聋(瘕病听力障碍)，为大怒伤肝。久聋(耳背)，为肾气虚。气压性脑挫伤引起的耳聋，为窍络阻塞。

耳鸣：耳鸣如风响，声音剧烈，多为肝火上逆。耳鸣如蝉鸣，伴有眩晕，多为肝肾阴虚。由中毒引起的耳鸣，为毒邪犯脑。

8. 问月经

对女性病人应该问月经。神经官能症、精神分裂症、躁狂抑郁症、更年期症候群，多影响月经，或症状在经期加重。经期提前，色红，质稠，量多，为血热。经期错后，色紫黑有块，腹痛喜暖，为寒凝血滞；色紫黑有块，经行不畅，少腹胀痛拒按，为气滞血瘀；瘦人量少色淡，为血虚；胖人量少，色淡如痰液，为痰湿。月经无定期，或前或后，为肝郁血虚。更年期经期紊乱，为冲任失调。经闭不行，精神狂妄，昼轻夜重，舌有瘀斑，脉涩有力者，为瘀血。肾上腺皮质机能亢进闭经，为相火盛。肾上腺皮质机能减退闭经，为肾阳不足。

9. 问睡眠

嗜睡，久病体弱者为脾虚。体实、嗜睡无它症状者为胆热。

失眠：闭目静卧，不能入睡，闻声则心悸，为心血虚。

闭目蹇卧，不能入睡(平卧则气不接)，时时怔忡，为心气不足。卧后思虑多想，不能入睡，为心脾两虚。夜间烦躁，不能安卧，时时起床行走，为心肝火盛。失眠自汗出，为营卫不和。欲睡突然清醒，再无睡意，为心肾不交。将入睡突然瘈瘲(全身一抽动)而醒，为肝血虚。眠后多梦惊醒，为肝不舍魂。眠后遗精而醒，为肾阴不足，精关不固。

二、望 诊

中医的望诊，是通过外观的一些现象，来认识病的实质，也是四诊重要的一个环节。望诊包括观察病人的精神状态、形体、面色、舌象等。

(一) 望精神状态

主要应当观察病人的意识、感情、意向等有无障碍。

1. 深度昏迷

神识昏迷，不省人事，鼻有鼾声为深度昏迷。如急性传染病的危重阶段，为热邪蒙闭清窍。如脑血管意外病人，为瘀血阻塞清窍。颅脑损伤病人，为脑络受损，瘀血阻塞窍络。急性气体中毒，为浊气蒙闭清窍。卒中痰声漉漉，为痰蒙清窍。

2. 中度昏迷

神志不清，无昏迷鼾声，但强呼数声似乎能应者为中度昏迷。

3. 谵妄状态

神昏谵语为一种谵妄状态，如发热性谵妄，急性传染病的邪入心包。精神病的谵妄状态，为痰火蒙闭清窍。

4. 兴奋状态

精神兴奋，两目炯炯有神，坐立不安(兼有运动兴奋)属火、属实，为狂症。

5. 抑郁状态

精神呆板，感情淡漠，懒言少动等为抑郁状态，多属虚症，或为夹痰或为癲症。有的患者精神呆滞，面无表情，不说不动，为痴呆(根据不同原因辨证)。

6. 紧张状态

精神紧张、恐惧，有强迫状态，多为心神不足。或为肝胆失调。

7. 情感障碍

情感高涨，表情愉快，好说好动，为心肝火盛。感情易冲动，不易接触，或有伤人毁物的行为，多为肝郁化火。病人僵仆不动，呈木僵状态，多为痰火蒙闭清窍。感情脆弱，表情抑郁，多为肝郁不舒。

(二) 望形态

观察病人的形体状态。如形体结实，挺胸阔步，为实症。形体瘦弱，缓步行走无力，多为虚症。老年或有外伤史者，行走呈前趋步态，多为肾虚脑海不足(大脑萎缩)。半身不遂，为中风后遗症。突然下肢瘫软，不能站立(癱病运动障碍)，为肝郁血不荣筋。四肢震颤、痉挛，多为肝风内动。

(三) 望色泽

主要是观察病人的面部颜色和光泽。面色红赤，多为实热症。两颧潮红，为阴虚内热。面红如妆，为虚阳上越。面色苍白，为血虚。面色晄白，为气虚。面色萎黄，为脾胃虚。面色黄染，为黄疸。面色黑暗，为肾阳虚(如爱迪森氏

症)。面色青晦，为肝风内动之征象。

(四) 望舌

即观察舌质与舌苔的变化。中医认为“舌为心之苗”。为了观察脏腑病变的情况，将舌分为几个部分，一般认为舌尖属心肺，舌中心属脾胃，舌边属肝胆，舌根属肾。看舌质可辨脏腑虚实。望舌苔可察病邪的深浅及胃气的强弱。重点观察舌质、舌苔的颜色，舌体的胖瘦，舌苔的薄、厚、燥、腻、老、嫩及分布的情况。要望舌的纹裂。望舌是中医诊断疾病非常重要的方法，在某种情况下判断病情，舌诊更重于切诊。

正常舌的情况：开口伸舌无阻，舌质淡红，舌苔薄而略白，舌体不胖不瘦，津液滋润。

1. 舌质

舌质能反映疾病的虚实、寒热以及气血的盛衰。舌质淡，为气血虚。舌质红，为热症。若舌质红无苔，为阴虚，或热伤津液。舌质绛（深红色），为热入营血（急性传染病意识障碍的病人多见此舌）。舌质紫红，为热甚。舌质紫暗或有瘀斑，为血瘀。舌质青色，为寒、为痛。舌尖红，甚则起刺，为心有热。舌中心红为脾热。舌边红为肝胆热。舌边尖起红刺，为心肝并热。

2. 舌苔

苔白滑，为寒症。舌白腻，为湿、为饮。苔白腻而厚，为痰结。苔黄，为内热。苔黄燥起刺，为里热盛。苔黄腻，为湿热。苔黄腻而厚，为痰火。苔黑滑润，为里寒。苔黑燥起芒刺，为热炽伤津（高热谵语病人可见此苔）。苔花剥（一块有苔一块无苔），为阴虚热盛。白膜苔（如白膜连在舌质上，非苔类），为阳虚。

3. 舌体

舌体胖嫩，边有软性齿痕(舌虚胖，印迹不明显)，为脾虚。舌体胖大，边有硬性齿痕(舌胀大，印迹棱角清楚)，为实症。舌体瘦，为虚症。舌体干瘪，为久病津液耗损。

4. 纹裂

舌中心沟裂，为肝郁。舌碎裂(舌碎裂且深，用力时不明显)，为津液伤。舌龟裂(似龟背纹裂，块大且有规则)为肾虚。地图舌(舌有裂纹而不规则)为气血虚。

三、闻 诊

对精神病人，闻诊不但要听患者说话声音之轻重高低，更主要的是测验病人的感知、记忆、思维、定向力、智能等多方面功能有无障碍。对于闻诊所得到的各种症状，可以归纳下列几类：

(一) 兴奋状态

语言繁多，语流增快，高谈阔论，出口成章，口若悬河，滔滔不绝，语声高亢，为实症、火症(属狂)，常见于躁狂状态的精神病。

(二) 抑郁状态

语言减少，对一般简单的询问反应迟钝，再三催问才能回答，回答时吞吞吐吐，语流缓慢，词句简单，为虚症或夹痰症(属癫症)，常见于抑郁状态的精神病。

(三) 思维贫乏

语言简短，词汇贫乏，平时不主动讲话，提问时反应迟缓，说话时以手拍头，为心肾不足。常见于精神分裂症单纯型，或脑器质性精神病痴呆状态。

(四) 幻觉状态

窃窃私语，低声泣诉，或独自发笑，为心气不足或夹痰。多见于精神病有幻觉的病人(主要是幻听)。

(五) 木僵状态

沉默不语，对任何询问概不回答，即使再三追问亦毫无反应，为痰火蒙闭清窍。常见于精神分裂症紧张型。

(六) 情绪不稳定状态

喜笑不休，为心火盛。时哭时笑，为心火上灼肺金。多见于癔病感情暴发。

(七) 遗忘症

患者对疾病发生前后的经过不能回忆，作不出答复，为肾气虚衰，或为邪蒙清窍。常见于老年精神病、颅脑外伤性精神病、一氧化碳中毒后遗症。

(八) 智能测验

患者不能回答一般常识性问题，记忆力、计算力、分析综合力和批判理解力都降低，为脑海不足。多见于先天性大脑发育不全、脑炎后遗症、老年性痴呆、脑动脉硬化性精神病、麻痹性痴呆等。

(九) 定向力测验

患者对时间、地点、人物均不能辨认，回答不出自己的年龄、姓名、职业，多为痰蒙清窍。多见于精神病有意识障碍的病人。

(十) 其它

嗳声叹气，多为肝郁不舒。呃逆频作，为肝气横逆，胃降失和。呵欠时作，为心肾不交。呼吸气粗，多为实症。呼吸微弱，多为虚症。

四、切 诊

切诊是中医诊断疾病的重要方法之一，但必须与其它三诊结合，把全部诊得材料加以分析、归纳，然后才能作出正确的判断。在某种情况下，还要舍脉从证，或舍证从脉地灵活掌握。

成人的正常脉象是一息(医生的一呼一吸)四、五至(一分钟七十次左右)，不浮不沉，不大不小，均匀和缓。

异常脉象又称“病脉”，有 28 种之多，此外尚有绝脉数种。现仅将临床常见脉象分述如下：

(一) 单纯脉

1. 浮脉

轻取即能感到脉搏跳动清楚，重按反觉不清楚，多为外邪袭表。

2. 沉脉

脉轻取中取均不明显，重按才能感到脉搏清楚，多属里症，有力为里实，无力为里虚。

3. 迟脉

脉搏跳动缓慢，一呼一吸不足四至(每分钟不足60次)，多属寒症。

4. 数脉

脉跳动快，一呼一吸超过五至(每分钟80次以上)，多属热症。常见于狂躁病人。

5. 滑脉

脉搏充盈流利(如按珠)，多属痰湿，妊娠三月也可见此脉。

6. 涩脉

脉流滞涩不畅(流走困难),无力为血少,有力为血瘀。常见于颅脑外伤病人。

7. 弦脉

脉搏动弹指,(如按弓弦),多属肝经病脉。如肝郁不舒,肝阳上亢,肝风内动等。

8. 弱脉

沉而无力,多属久病气虚。

9. 细脉

脉细如丝,多属阴血不足。

10. 洪脉

脉形大,来势较盛(如洪水),有力为热盛,无力为虚阳上越。

11. 虚脉

浮中沉取均无力,多为气血两虚。

12. 实脉

浮中沉取均有力,多为实症。

13. 结脉

脉律不整,有不规则的间歇,多为心气不足。多见于有心脏疾患的病人。

14. 促脉

脉律不整,至数多(每分钟100次以上),有间歇,多为心阴虚。常见于心脏神经官能症,偶见于甲状腺机能亢进引起的精神病患者。

15. 代脉

脉律不整,有规则的间歇,多为心气衰败(心力衰竭时

多见此脉)。

(二) 复合脉

临床独见一脉者较少，常为二、三种脉同时出现，谓之复合脉。

1. 浮之兼脉

浮数为表热，主外感发热。浮迟为表寒，主外感风寒。浮弦为风胜，神经性头痛、颜面神经麻痹多见此脉。浮滑为表湿，暑湿症多见此脉。浮大无力为气虚，热性病后恢复期及久病多见此脉。

2. 沉之兼脉

沉数为里热，躁狂性精神病患者多见此脉。沉迟为里寒，多见于腹痛恶冷的病人。沉弦为肝郁，多见于抑郁症及神经官能症的病人。沉滑为湿、饮、痰，多见于浮肿、滑泻、痰蒙清窍、意识障碍的精神病人。沉弦滑为气郁痰结，精神分裂症妄想型的病人及癔病球病人多见此脉。沉细为阴血虚，多见于热性病热邪伤阴的病人，亦可见于神经衰弱和一部分躁狂抑郁性精神病的抑郁症、精神分裂症的妄想型病人。沉细数为阴虚内热，多见于慢性病，如结核病和部分神经官能症病人。沉细弦为肝阴血不足，多见于神经衰弱和部分强迫性神经官能症(恐怖症)患者。沉涩无力为血少，见于久病和失血病人。沉涩有力为瘀血，常见于颅脑外伤精神病(瘀血阻滞清窍)病人。沉缓为阳气不足，多见于老年精神病。

3. 弦之兼脉

弦数脉为肝热化火，多见于躁狂忧郁性精神病躁狂状态、癫痫发作、癔病暴聋和癔病失明等病人。弦大有力为肝

阳上亢，多见于高血压、颅内压增高等病人。

4. 滑之兼脉

滑数为痰火，多见于精神分裂症紧张型病人。

第二节 八 纲 辨 证

八纲，即表里、寒热、虚实、阴阳，它是临床诊断确定疾病性质的基本纲领。因为疾病在临床表现上是错综复杂的，通过四诊所收集来的资料，需要运用八纲加以综合分析，以便找出疾病的主要矛盾，做出确切的诊断。

一、表 里

表里是指病位的深浅，如皮肤、肌肉等为表，五脏六腑为里。

(一) 表证

表证指一切外感病。怕冷，发热，头痛，鼻塞，身痠痛为其主证。舌苔薄白，脉浮，怕冷重，发热轻，口不渴，为表寒证，治宜辛温解表。发热重，恶寒轻，口渴，为表热证，治宜辛凉解表。

(二) 里证

里证指五脏六腑之病，其病或由表传里，累及脏腑；或为七情所伤；或为脏腑自身的病变（具体内容放到脏腑辨证里谈）。

二、寒 热

寒热是两种不同性质的病证，在一般情况下是容易鉴别

的。有时病情发展到严重阶段，也可以出现一些假象，如热证见寒象，寒证见热象，这是临床应该注意的。

（一）寒证

1. 表寒证

外寒侵袭机体，引起的怕冷、头痛、身痛、舌苔薄白、脉浮迟为表寒，治宜温散。

2. 里寒证

饮食寒冷引起的脘腹痛、喜暖、舌淡苔白、脉沉迟，为里寒，治宜温化。

3. 虚寒证

由于机体阳气不足，自身的功能活动减退而引起的怕冷、四肢凉、喜热食热饮、小便清长、大便溏薄、舌淡苔白、脉迟无力，为虚寒证，治宜温补。

（二）热证

1. 表热证

由表邪引起，温热病初起即表现为表热证。如发热，口渴，脉浮数，治宜辛凉解表。

2. 里热证

如风、寒、暑、湿之邪都可转化为里热，治宜清热祛邪。如温热病邪入心包，引起神昏谵语，治宜清热开窍。如风寒入里化热，引起壮热、口渴，也可有谵语、舌红苔黄、脉洪大，为热在阳明经，治宜辛凉重剂，清阳明经热。如大便燥而不解，神昏谵语，舌苔黄燥或起芒刺，脉沉实，为阳明腑实证，治宜咸寒通下。

3. 阳盛热证

由机体的机能亢进引起的热为阳盛热证，如口渴，目

赤，尿黄少，大便干，脉实数，治宜清热降火。

4. 五志化火热证

五志化火引起的烦躁不安，口渴喜凉饮，尿短赤，大便干，舌红苔黄，脉弦数，其治疗方法可根据不同情况宜清或宜泻。

5. 真热假寒证

真热假寒：身热四肢冷，怕热不欲穿衣盖被，口渴多饮，舌苔黑燥，脉虽细而沉取有力，证似寒象，实属内热炽盛，外现假寒。

6. 真寒假热证

真寒假热：身凉面浮红发热，口渴不能饮，反欲盖衣被，舌苔黑而滑润，脉洪大沉取无力，证似热象，实为阴寒内盛，外现假热。

三、虚 实

虚，是指正气虚(机体机能减退)；实，是指邪气盛。

(一) 虚证

虚证多系久病致使生理功能减退，或机体有形物质不足所产生的证候。如面色苍白，精神萎靡，或嗜睡懒言，体倦乏力，声低，心悸气短，自汗盗汗，舌少苔或无苔，脉细弱无力。治疗宜采用补法。辨证时还须结合具体脏腑、阴阳、气血。

(二) 实证

实证是由病邪引起的机体机能亢进，即邪气实。如精神兴奋(包括运动兴奋)，声高气昂，面色红，舌苔厚，脉有力。除具体到脏腑、阴阳、气血偏盛不同外，尚有痰饮、瘀

血等病邪。治疗宜祛邪(泻法)。

另外，虚证和实证并不一定是单纯存在的，尚有虚实夹杂的症候。在治疗上应根据具体情况，分别采取先补后攻、先攻后补或攻补兼施等不同治疗方法。

四、阴 阳

阴阳是八纲中的总纲，上面所述表里、寒热、虚实，都是在疾病发展过程中所表现的既对立而又统一的矛盾现象，而这些矛盾现象归纳起来不外阴阳两个方面。表证、热证、实证是属于阳证的范畴。里证、寒证、虚证是属于阴证的范畴。

在精神病的病因机理上，阴阳的平衡最为重要。古人有“阴平阳秘，精神乃治”的说法。人的正常精神活动，必须保持阴阳相对的平衡，如果在精神活动过程中，由于某种因素造成阴阳不平衡，就会产生不正常的病理现象。所以出现“重阳者狂，重阴者癫”和“邪入于阳则狂，入于阴则癫”。

(一) 阳证

阳证，精神兴奋，情感高涨，声高气昂，多语多动，面色红，舌红苔黄，脉数有力。

亡阳，精神萎靡或嗜睡，冷汗出，四肢逆冷，面色苍白，口不渴或喜热饮，舌淡，脉微欲绝，多见于休克的病人，或久病衰竭危重的病人。实际上亡阳多在亡阴之后，先有阴液的物质损伤，在亡阴的基础上阳的功能也衰竭，而出现亡阳。治疗宜急救回阳。

(二) 阴证

阴证，精神萎靡，情感低落，气短懒言，体倦少动，面

色暗淡，舌淡苔少，脉沉细无力。

亡阴，烦躁，口干喜凉饮，舌干无津，脉洪数无力。暴病见于失血或脱水的病人。久病见于热邪耗伤津液，急性传染病的后期。无论暴病或久病都是使机体阴的有形物质损伤。治疗宜补充阴液。

第三节 脏象辨证

诊断精神病，除急性传染病引起的精神障碍外，仍以脏腑辨证为根据。当然，主要是五脏。古人把一切精神活动分配给五脏，故有“五神脏”之称，即心、肝、脾、肺、肾。但每一脏的生理活动和病理变化，并不是孤立的，而是互相联系和互相影响的。所以，一脏有病可影响它脏，因而有五行生克学说，说明它们之间互相依存和互相制约的关系。

一、心的生理和病理

(一) 心主神明

人的精神、意识、思维等活动都是由心来主管(同大脑皮质高级神经中枢相类似)。在正常情况下，神明通达，精神沛然，其它脏腑亦能各安其职。如果心的功能发生障碍，轻则出现失眠、烦乱、善惊、多疑，重则出现意识障碍，胡言乱语，喜笑不休(心主喜，其声笑)或昏迷等。

(二) 心主血脉，其华在面

全身血液的运行，主要靠心力的推动，才能内充脏腑，外泽皮肤。所以，血液充盈，运行正常，面色就红润光泽。如果心气不足，血液运行发生障碍，血脉失于通畅，则血瘀

而脉涩，而色紫绀。心血不足则脉细无力，面色苍白。心力衰竭则出现结代脉。

（三）心开窍于舌

心的疾病，可以从舌体反映出来，故有舌为心之苗之说。心热舌尖红。心火盛时舌尖起红刺或舌有溃疡。心血不足时舌质淡。心血瘀滞则舌质紫暗或有瘀斑。痰迷心窍时，轻则语言不利，重则舌强不语。

（四）心主汗

汗为心之液。由于心主神明，当精神过度紧张时往往出汗增多。心阳虚时、卫外不固，轻则自汗出，甚则大汗淋漓。心阴虚时，阳无所附，汗液外泄，眠则盗汗出。

此外，心包络是心的外围，有保护心的作用，凡外邪侵犯心的时候，往往是心包代心受邪。如高热病时出现的精神障碍、神昏谵语等，就是热入心包的表现。

二、肝的生理和病理

（一）肝主谋虑

肝有深谋远虑抵御外侮的功能。肝虽主谋虑，但需要胆的功能帮助决断。若肝和胆的功能失调，往往多虑而不能决断。临床上常见于妄想和强迫性神经官能症的病人。

（二）肝藏血

肝有贮藏血液和调节血量的作用。当人处于安静状态时（休息和睡眠），血液归到肝里贮藏；人活动的时候，肝内的血液又输送到全身，供给各组织的功能活动需要。如肝血不足，或受到精神因素的影响，都能使肝藏血的功能失常。临床表现为恐惧，如人将捕之等症状，多见于精神分裂症、

迫害妄想的病人。暴怒伤肝，可以引起肝不藏血的出血症。

（三）肝主风

风善行而多变，也是因为肝主动、主升的特性所致。动即是风动，升即是阳亢。在阴液和血液不足以濡养肝，或为精神因素耗伤肝血，或为热极耗伤阴液的情况下，都可引起阴虚阳亢，肝风内动。临床表现为瘈瘲，痉挛，抽搐，震颤，身上有触电样的麻感，或突然晕倒，口眼喎斜等症状。

（四）肝性喜条达

条达就是畅达无束、心情舒畅。如精神因素使其抑郁不舒，引起肝气郁结，临床表现胸闷气不畅出，两胁胀满等。由于气郁不畅影响体液循环，聚而成痰，即谓气郁痰结，轻则咽喉阻塞，为梅核气(瘰病中的瘰病球)；重则表现精神症状，如癲症(精神分裂症妄想型中多见)；如气郁化火挟痰上扰，则成为狂症(躁狂状态)。

（五）肝主筋，其华在爪

肝主管全身筋的活动，从而支配肌肉、关节的屈伸运动。筋的活动全赖血液的濡养。若肝血不足，筋失荣养，临床表现肢体屈伸不利(如瘰病的运动障碍)，或四肢拘急。爪甲为筋之余，肝血不足时，指甲变为枯、脆、软、薄。

（六）肝开窍于目

肝与视觉有密切关系。肝血虚时目干涩，视力模糊，弱视，甚则可有幻视。暴怒伤肝，可出现暴盲(瘰病视力障碍)。高热病人热邪伤肝阴时，也可出现幻视。肝火盛可有目赤肿痛。

三、脾的生理和病理

(一) 脾主思

凡思考问题，回忆往事，古人认为与脾有关。由于脾主思，对一些临床有思维障碍的病人，应该考虑与脾病的关系。长期过度的思考，或长期意志不遂，都可引起脾的功能障碍。临床表现为思维障碍，健忘，注意力不集中等，多见于神经官能症及一部分精神分裂症的病人。

(二) 脾主运化

脾主管消化和运输营养。人的饮食入胃经过腐熟后，由脾进一步消化产生精微(营养物质)，经过再吸收，由脾气的力量将营养运送到全身，内滋脏腑，外养四肢百骸，所以称脾为后天之本。如果脾的运化功能不足，就不能很好地消化食物，吸收营养和把营养输送到全身。临床表现为食后不消化，腹胀，便溏，精神疲倦，肢体乏力，肌肉消瘦，甚则肌肉萎缩，唇淡无华，脉沉缓无力。

(三) 脾统血

脾有统摄血液正常运行的作用。如脾的功能失调，脾气不能统摄血液，使血不循经，临床可见到各种不同程度的出血症。

(四) 脾恶湿

脾有运化水湿的作用，但全赖脾气的充足。如脾气不足，水湿就不能运化，而致停留。水湿停留在肠内不能吸收，则大便溏泻，临床见于慢性肠炎，胃肠神经官能症。水湿停留于皮下，则出现浮肿，临床见于营养不良性浮肿及代谢障碍性浮肿。水湿也是痰的来源(湿痰)，它能造成多种精

神障碍。

四、肺的生理和病理

（一）肺主忧和悲

七情中的忧和悲，都能损伤肺气。由于持久的心境忧虑和暂时的感情过激（悲哀恻衷），都会影响肺的功能，而出现肺气虚的症状，临床可见心慌、气短、出汗等，也可见到突然失音（瘖病语言障碍）。

（二）肺主气，司呼吸

肺主一身之气，即真气。而真气之来源，一是吸入自然界之清气（氧气），二是饮食所化生的精微（谷气），二者相合成为人体生命之主宰。如肺气不足，临床表现为体倦乏力，气短，自汗等气虚症状。肺司呼吸，吸入自然界之清气，呼出体内代谢所产生的浊气，全赖气道通畅，呼吸均匀，如病邪引起气道不畅，临床可出现咳、喘等症状。

（三）肺合皮毛，主声音

肺主人身之表皮和毛孔之开合。人体依靠肺气的卫护，抵抗外邪的侵犯，如卫外之气不固，毛孔开放，自汗出，外邪就容易侵犯。所以有“肺为娇脏”之说。如风寒犯肺，临床表现咳嗽、鼻塞、声重、流涕。肺气闭塞，则声音嘶哑或失音。

（四）肺开窍于鼻

鼻为肺之门户，呼吸气出入之所。肺主管嗅觉，肺有病时嗅觉异常，鼻塞不通，鼻翼扇动，呼吸困难。

五、肾的生理和病理

（一）肾主技巧

古人称“肾为作强之官，技巧出焉”。所谓作强，是指精力充沛，轻劲多力。因肾贮藏五脏六腑之精，肾气的盛衰直接关系到精力的强弱。精力充足就轻劲多力，劳动不倦。精力不足就胫膝痿软，头晕目眩，倦怠嗜卧，不能耐劳。所谓技巧是指人的精细灵巧。因为肾生精髓上注于脑，因此脑髓的充盈与不足，对于人的智能与技巧起着重要作用。肾精不足时，临床表现记忆衰退，思维迟钝，智能降低，动作迟缓。如大脑发育不全、老年性精神病、颅脑外伤性精神病等。

（二）肾藏精

肾藏精包括两个方面，一个是藏五脏六腑之精，由饮食水谷所化的精微，用以充脑补髓。一个是肾本身的精，叫肾精，它与人的生殖、生长、发育、衰老有重要关系。肾精不足时，临床表现男性精薄稀少，女性无月经，男女原发性不孕症，先天发育不全及早衰。

（三）肾主命门

命门为肾之元阳，又称命门火，是人生命活动的原动力。脾之所以能消化运转，全靠命门火的帮助。如命门火衰，临床表现五更泄泻，性机能减退，阳萎早泄。相火（命门邪火）过盛时，表现性机能亢进，阳强或睡梦遗精。

（四）肾主水

肾有调节体液平衡的作用，这主要依靠肾关的开合。肾阳主开，肾阴主合，阴阳平衡，开合适宜，根据体内情况，保持尿的排泄正常。如开多合少，临床表现多尿（糖尿病，尿崩症）。合多开少，临床表现尿少，淋漓不尽。尿量过少，水液蓄积，因而产生浮肿。

（五）肾主纳气

肺虽主呼吸，但肾主纳吸入之气。如肾虚不能纳气，临床表现呼多吸少的虚喘症，多见于老年人。

（六）肾开窍于耳

听力的聪慧，靠肾气的健强。肾气虚时，临床表现为听力逐渐减退，耳鸣、耳聋。

（七）肾主骨

肾主骨，其华在发；齿为骨之余。肾不足时，表现骨软无力，牙齿不坚固，发易脱落、枯白。

第五章 精神病治疗学

中医理论体系的特点之一是辨证施治，治疗精神病也不例外。除治疗由急性传染病、颅脑外伤、中毒等引起的精神障碍之外，原则上都以五脏辨证施治为主。因为任何证候的显现，都脱离不开五脏。因此，本章重点介绍五脏辨证施治，同时介绍笔者治疗精神病运用的一些法则。

第一节 五脏辨证施治

一、心的辨证论治

(一) 心阴虚

〔症状表现〕心悸，心烦，易惊，健忘，失眠（入睡困难、眠后多梦），盗汗，口干，颧红。

〔舌 脉〕舌质红，无苔。脉细数。

〔病机分析〕心阴不足时，相对的心阳偏亢，故有心悸、心烦；心藏神，神不内守，故失眠多梦，健忘；阴不敛阳，故有盗汗出；心阴不足，阴虚火亢，故见颧红、口干；舌红无苔，脉细数，均为阴虚内热之象。

〔治疗法则〕补养心阴

〔方 药〕生地黄 杭白芍 紫丹参 元 参
麦门冬 生甘草 百 合 首乌藤

生龙骨 生牡蛎

(二) 心阴虚，心火亢

〔症状表现〕烦躁不安，不得安卧，夜间游走，坐立不宁，易激动，口渴喜冷饮。

〔舌 脉〕舌红，舌尖起红刺，脉细数。

〔病机分析〕心阴虚，心火上炎，不得下交于肾水，形成心肾不交之势。心神被扰，故烦躁不宁，不得安卧，情绪易激动；火热伤津液，故口渴思冷饮；舌红尖起红刺，脉细数，皆为阴虚火亢之象。上症见于神经官能症、躁狂症及其它精神病的焦虑状态。

〔治疗法则〕养心阴、降心火。

〔方 药〕黄 连 黄 芩 生白芍 阿 胶

鸡子黄 生梔仁 淡豆豉

(三) 心血虚

〔症状表现〕面色苍白，精神倦怠，心悸，易惊，多疑，健忘，失眠时能闭目安卧，但不易入睡，眠后多梦易惊醒。

〔舌 脉〕舌质淡、少苔，脉细无力。

〔病机分析〕心血不足，不能上荣于面，故面色苍白无华；心血虚，不足以养心神，心神不安，故心悸、易惊、多疑、健忘、失眠；由于心血虚不能荣养心神，神因虚而不安，故失眠时多能闭目安卧，但不能入睡，睡后神不安舍则多梦易醒。舌淡，脉细无力，皆血虚之象。本病多见于病后虚弱症、神经官能症及心脏病的病人。

〔治疗法则〕养血安神。

〔方 药〕当 归 熟 地 炙首乌 杭白芍

炒枣仁 茯 神 远 志 甘 草
五味子

或成药养血安神丸、补心丹等。

(四) 心阳虚

〔症状表现〕精神萎靡，怔忡，失眠，自汗，怕冷。

〔舌 脉〕舌质淡、苔白，脉缓无力。

〔病机分析〕心阳不振，则精神萎靡，怔忡；心阳虚神无所主，则不眠；阳虚卫外不固，则自汗怕冷；舌淡苔白，脉缓无力，皆心阳不足之象。多见于久病体虚、神经官能症、心脏病病人。

〔治疗法则〕温心阳，安心神。

〔方 药〕桂 枝 炒白芍 甘 草 生 姜
大 枣 茯 神 炒枣仁 远 志

1. 心阳不足，阳气不通、心脉痹而不宣，出现心前区憋闷；或气血运行不畅为心前区痛；舌质淡，苔白滑，脉弦无力。此症多见于心脏神经官能症或冠心病。

〔治疗法则〕宣痹通阳。

〔方 药〕栝 蒌 薤 白 半 夏 炒枳壳
远 志 菖 蒲

兼有血滞者，加郁金、桃仁、红花、川芎。

2. 心阳虚脱，面色晄白，神识昏瞢，四肢厥冷，大汗淋漓。舌质淡，脉微欲绝。心阳虚脱时，阳不系阴，心液随之外泄，故大汗淋漓；神失所主，故神识昏瞢；阳气不达于四肢，故四肢厥冷，脉微欲绝。本症见于心力衰竭及休克等病症。

〔治疗法则〕急救回阳。

〔方 药〕人 参 炙附片

(五) 心气虚

〔症状表现〕心悸，气短，自汗出，动则症状加重。失眠时喜踈卧，或以物顶胸。

〔舌 脉〕舌质淡，舌体松软，脉弱或结代。

〔病机分析〕心气不足，鼓动力弱，故心悸气短，脉弱；气来不匀，则脉结代；卫外之气不固，则自汗出；活动后耗伤心气，故症状加重；心气不继，则喜踈卧，或以物顶胸则舒适；心气不足，神无所附，故失眠。舌质淡，舌体松软为心气虚之象。

〔治疗法则〕补益心气。

〔方 药〕党 参(或人参) 炙黄芪 茯 神
远 志 炒枣仁 柏子仁 炙甘草

如出现脉结代时，加五味子，麦冬。

(六) 心火亢

〔症状表现〕哭笑失常，言语错乱。如癔病情感暴发。

〔舌 脉〕舌红、苔黄，脉数。

〔病机分析〕心主喜，其声笑，心为火脏心火亢盛则笑不休；心火上灼肺，肺主悲，其声哭，故哭笑失常；心主言，心火亢则语言错乱。舌红、苔黄，脉数，皆心火亢之象。

〔治疗法则〕降心火，清肺金。

〔方 药〕生甘草 淮小麦 大 枣 麦 冬
百 合

(七) 痰火扰心

〔症状表现〕精神错乱，躁动不安，胡言乱语，哭笑无常，甚则狂暴动怒、打人毁物。

〔舌 脉〕舌质红、苔黄腻，脉滑数有力。

〔病机分析〕郁怒伤肝，肝火暴盛，火与痰结，痰火炽盛，上蒙清窍，内扰心神，故精神错乱，狂躁多动，打人毁物；舌红苔黄，脉数，均为火热内炽之象；苔腻、脉滑，为痰浊内阻之征。多见于反应性精神病、躁狂性精神病、癔病和精神分裂症等。

〔治疗法则〕泻火，涤痰，镇心。

〔方 药〕黄 连 黄 芩 生 梔 仁 莲 子 心
胆 星 天 竺 黄 远 志 菖 蒲
朱砂末

或加牛黄清心丸。体壮者，加礞石滚痰丸。

（八）痰迷心窍

〔症状表现〕意识朦胧，时吐痰涎，甚则昏迷，或出现癫痫妄想。

〔舌 脉〕舌苔腻、脉滑有力。

〔病机分析〕心主神，心窍为痰浊所阻，则神识障碍，痰涎壅盛，则吐痰涎；舌苔腻，脉滑有力，皆为痰盛之象。多见于脑血管意外引起的昏迷或精神分裂症妄想型。

〔治疗法则〕化痰开窍。

〔方 药〕橘 红 法 半 夏 茯 苓 枳 壳
竹 茹 郁 金 菖 蒲 远 志
胆 星 栝 楼 重者加苏合香丸。

（九）心肝火盛

〔症状表现〕精神狂妄，易于激动，不易接触，妄想，失眠；失眠时多为烦躁不能安卧，头胀痛。

〔舌 脉〕舌边尖红，脉弦数。

〔病机分析〕心肝火盛，又称木火燔心，乃心肝二火合邪扰及神明，故精神狂妄；肝主怒，主谋虑，肝火盛，故易激动，难以接触，妄自谋虑而成为妄想；心神被扰，故烦躁不得安卧；肝火上扰则头痛。舌尖边红，脉弦数，均为心肝火盛之象。多见于躁狂症和一部分精神分裂症。

〔治疗法则〕清心泻肝，重镇宁神

〔方 药〕珍珠母 朱砂末 丹 参 元 参
黄 连 黄 芩 龙胆草 生梔仁
生 地

（十）心脾两虚

〔症状表现〕精神不振，体倦乏力，喜卧少动，失眠时为思虑多想不能入睡，记忆力减退。

〔舌 脉〕舌质淡，舌体胖软，脉细弱。

〔病机分析〕心主神，脾主四肢，心脾两虚，故精神不振，四肢倦怠，喜卧少动；脾主思，故多思虑而不能入睡，脾藏意，脾虚意不存，则记忆减退。舌淡，舌体胖软，脉细弱，均为心脾两虚之象。多见于忧郁症、精神分裂症、神经官能症。

〔治疗法则〕养心补脾。

〔方 药〕党 参 炙黄芪 生白术 茯 神
远 志 炙甘草 炒枣仁 当 归
龙眼肉

（十一）心肾不交

〔症状表现〕心悸，烦躁，失眠，失眠多为将要入睡时突然清醒再不能入睡，头晕，耳鸣，健忘，男性可有遗精。

〔舌 脉〕舌质红、无苔，脉细数。

〔病机分析〕心主火，肾主水，在正常情况下心火下交于肾，肾水上济于心，谓之心肾相交。若心阴虚，心火偏亢，不能下交于肾，即出现心肾不交的症状，如心悸、烦躁。失眠的特点，为将要入睡时即心火将要与肾水相济，心火又上亢，故突然清醒再不能入睡。头晕，耳鸣，健忘，为肾阴不足之征。男子遗精，乃肾阴虚精关不固所致。多见于神经官能症及一些虚弱症。

〔治疗法则〕交通心肾。

〔方 药〕生龙骨 生牡蛎 丹 参 元 参
远 志 菖 蒲 生 地 莲子心
夜交藤

或成药交泰丸。

二、肝的辨证论治

（一）肝阴虚及肝血虚

〔症状表现〕头晕，目眩，目干涩，视物不清，善恐（恐惧症），虚烦失眠，夜梦惊恐，常因瘈瘲（全身突然一抽动）而惊醒。

〔舌 脉〕舌质淡，脉沉细弦而无力。

〔病机分析〕肝之阴血不足，不能荣筋养目，故目干涩、视物不清；入卧则血归于肝，肝血虚则不能荣筋，故瘈瘲而醒；肝血虚则令人恐；阴血虚不能上充于脑，故头晕、目眩。舌淡、脉沉细弦而无力，皆肝阴血虚之象。多见于贫血和神经官能症及一部分眼科疾患。

〔治疗法则〕养血（阴）柔肝。

〔方 药〕生 地 枸杞子 女贞子 当 归

白芍 炙首乌 阿胶 桑椹
甘菊花

(二) 肝阳上亢

〔症状表现〕头晕胀痛，巅顶沉重，项强不利，面热，目胀，头重脚轻，口燥咽干，烦躁易怒。

〔舌脉〕舌质红，脉弦有力。

〔病机分析〕肝阳上扰，则头晕胀痛，巅顶沉重；肝阳亢于上，阴虚于下，故头重脚轻，面热目胀；阳亢为热，则口燥咽干；肝主怒，肝失柔养，故烦躁易怒。舌红，脉弦有力，皆为肝阳上亢之象。本症见于高血压病、神经官能症、更年期综合症。

〔治疗法则〕平肝潜阳。

〔方药〕生石决明 珍珠母 灵磁石 龟板
生地 丹皮 炒山栀 生白芍
桑叶 杭菊 夏枯草

(三) 肝风内动

〔症状表现〕轻则眩晕、肢麻、震颤，重则昏倒、痉挛、抽搐、口眼喎斜。

〔舌脉〕舌质红，脉弦细数。

〔病机分析〕肝风内动常见三种情况：一是热极生风，多见于热性病高烧阶段，出现四肢抽搐，角弓反张，如乙脑、流脑等。二是阴虚阳亢，化火生风，表现昏厥、抽搐、口眼喎斜，多见于脑血管意外症。三是肝阴不足，血虚生风，出现肢体麻木、头摇、震颤，多见于动脉硬化、神经官能症、巴金森氏征。无论何者所致，皆因风火相煽，上升巅顶，横窜经络，或血虚筋脉失养所导致。

〔治疗法则〕平肝熄风。

〔方药〕生石决明 白蒺藜 天麻 钩藤

杭菊花 全蝎 僵蚕 羚羊角粉

血虚生风者加白芍、生地、阿胶。阴虚阳亢生风者加生龙骨，生龟板。

（四）肝气郁结

〔症状表现〕精神抑郁，胸膈满闷，气不畅出，常因生气憋闷而失眠，胸胁串痛；妇女可有月经不调，或提前或错后。

〔舌脉〕舌质淡红，舌中心沟裂，脉沉弦。

〔病机分析〕多因情志不舒，郁怒伤肝所致。肝经经脉过两胁，故两胁串痛；气郁不舒，则胸膈憋闷，气不畅出；肝脉与冲脉相连，冲主月经，肝气郁结导致冲脉失调，故月经紊乱。舌有沟裂，脉弦，均为肝郁之象。多见于神经官能症、月经不调等症。

〔治疗法则〕舒肝解郁。

〔方药〕醋柴胡 香附 青皮 川楝子

郁金 枳壳 合欢皮 香橼

杭芍

或成药舒肝丸、逍遥丸。

（五）肝郁痰结

〔症状表现〕咽中如核阻塞，咯之不出，咽之不下，俗称梅核气。若痰阻神明时，也可出现精神症状（癫症）。

〔舌脉〕舌苔白腻，脉弦滑。

〔病机分析〕情志不舒，气怒伤肝，肝气上窜于咽喉，与痰相结，则咽中似有物梗阻，随情绪变化而增减。若痰阻神

明，则出现精神症状。舌苔白腻，脉弦滑，均为肝郁痰结之象。可见于瘰病(瘰病球)及反应性精神病。

〔治疗法则〕解郁化痰。

〔方 药〕苏 梗 川厚朴 乌 药 半 夏
陈 皮 茯 苓

若痰阻神明时，可用祛痰开窍法：

橘 红 法半夏 茯 苓 枳 壳
竹 茹 郁 金 菖 蒲 远 志
胆 星

(六) 肝气横逆

〔症状表现〕脘胁并痛，呃逆不止，呕吐吞酸，或呕吐绿水。

〔舌 脉〕舌质淡红、苔白，脉沉弦。

〔病机分析〕肝气横逆，侵犯脾胃，胃降失和，则呃逆呕吐吞酸，脘胁作痛。可见于植物神经机能障碍、迁延性肝炎。

〔治疗法则〕平肝降逆。

〔方 药〕旋覆花 代赭石 法半夏 生甘草
陈 皮 枳 壳 苏子梗 佛手片
沉香末

吞酸加黄连，吴茱萸。

(七) 肝经火盛

〔症状表现〕头痛眩晕，目赤，耳暴聋，口苦，急躁易怒，小便赤，大便干。

〔舌 脉〕舌边红，脉弦数。

〔病机分析〕肝气郁而化火，肝火上攻于头，故头痛眩

晕，胆经绕耳，下络于肝，肝火循经上壅于耳，故耳聋突然发作；肝火盛则急躁易怒，口苦，尿赤便干。舌边红，脉弦数，均为肝火盛之征。可见于癔病性听力障碍，高血压病，急性结膜炎。

〔治疗法则〕泻肝清火。

〔方药〕龙胆草 炒山栀 黄芩 柴胡
生地 当归 木通 生甘草
车前子 川军

若肝火扰心，烦躁失眠或出现精神兴奋状态，可按上方加重镇安神药如琥珀末、朱砂末。

（八）肝胆火逆、风痰上扰

〔症状表现〕癫痫发作，抽搐、口吐白沫，目直视。

〔舌脉〕舌边红，苔白腻，脉弦滑数。

〔病机分析〕肝胆火逆，风火相煽，风动痰涌，痰阻窍络，神明无主，神昏抽搐，口吐涎沫。舌边红为肝胆火盛，舌苔白腻为痰盛，脉弦滑数为肝胆火盛痰扰。见于癫痫大发作。

〔治疗法则〕平肝熄风，清火化痰。

〔方药〕生石决明 白蒺藜 龙胆草 炒山栀
黄连 黄芩 茯神 远志
钩藤 天麻 天竺黄 竹沥水

（九）肝胆失调

〔症状表现〕犹疑不决，判断无力。

〔舌脉〕舌质淡红、少苔，脉弦细。

〔病机分析〕肝主谋虑，胆主决断，肝胆失调，多谋而不决，怀疑无判断。最典型的是强迫性神经官能症和强迫怀

疑。

〔治疗法则〕调和肝胆。

〔方药〕珍珠母 生地 白芍 龙胆草
柴胡 炒山栀 合欢花 竹茹
枳壳

三、脾的辨证论治

（一）脾阳和脾气虚

〔症状表现〕面色萎黄，眼睑浮肿，甚则眼睑下垂。精神倦怠，肢软无力，嗜卧。感情淡漠，意向减退或缺失，饮食减少，食后不消，大便溏，肢冷。

〔舌脉〕唇淡无华，舌淡苔白；舌体软胖，边有齿痕。脉沉缓无力。

〔病机分析〕脾主运化，全靠脾阳之温煦，脾阳气虚，水谷精微不能运化，故饮食减少，食后不消，大便溏；脾为后天之本，水谷精微化生之源，脾阳气虚，不能运化吸收营养以补充身体，故精神倦怠，肢软无力，嗜卧；脾主意，脾虚则意向减退；眼睑属脾，虚则眼睑浮肿，甚则眼睑下垂；脾主肌肉，虚则肌肉无力不能支持身体的运动；脾之华在唇，唇淡无华，舌体软胖，脉沉缓无力，均为脾阳气虚之征。多见于躁狂忧郁症的忧郁状态、精神分裂症单纯型、胃肠功能紊乱、重症肌无力等病。

〔治疗法则〕补气健脾。

〔方药〕炙黄芪 党参 焦白术 茯苓
炙甘草 益智仁 白豆蔻 炒扁豆

（二）脾气下陷

〔症状表现〕气短，懒言，气不接续，下腹坠胀，久泻脱肛及内脏下垂等症。

〔舌 脉〕舌质淡，脉虚。

〔病机分析〕脾气太虚，清阳之气不得上升反而下陷，中气不接，故气短懒言；内脏皆以中气上升而各安其位，中气下陷则内脏下垂。

〔治疗法则〕升补中气。

〔方 药〕炙黄芪 党 参 白 术 甘 草
陈 皮 当 归 柴 胡 升 麻

久泻者加补骨脂、诃子肉。胃下垂者加白檀香。

（三）脾虚湿困

〔症状表现〕头沉如裹，体重乏力，口粘不渴，饮食减少，嗜睡，胸满，腹胀，大便溏或滞而不爽，小便不利，水湿停留，可产生浮肿或腹胀。

〔舌 脉〕舌质淡，苔白腻，脉软无力。

〔病机分析〕脾虚不能运化水湿，以致水湿停于体内。湿阻于上，则头重如裹；湿困于体，则体重乏力；湿阻清阳，则神疲嗜睡；湿阻于中，则口粘不渴，饮食减少，脘满腹胀；湿注于下，则便溏或滞而不爽；湿阻气化，则小便不利；水湿充溢肌肤，则浮肿。舌淡，苔白腻，脉软无力，皆为湿象。多见于慢性肠炎、浮肿、肝硬化。

〔治疗法则〕健脾利湿。

〔方 药〕苍 术 川厚朴 陈 皮 茯 苓
法半夏 白蔻仁 薏苡仁 泽 泻
大腹皮 藿 香 佩 兰

（四）脾阴虚

〔症状表现〕面色苍白，精神萎靡，懒言，少动，嗜卧，记忆减退，因思虑多而致失眠，不愿与人接触，妇女可有闭经。

〔舌 脉〕唇淡，舌质淡，脉细。

〔病机分析〕脾主思，思伤脾，脾血虚，面色苍白，唇淡，舌淡；血虚不能养神，精神萎靡不振，懒言，少动嗜卧，记忆减退；因思伤脾，故思虑多而影响睡眠；因神不足，则不愿与人接触；血虚则经闭。见于神经官能症、贫血。

〔治疗法则〕补脾养血。

〔方 药〕党 参 茯 苓 炙甘草 当 归
杭白芍 炙首乌 远志肉 龙眼肉

（五）脾不统血

〔症状表现〕见有脾气虚的症候，兼见各种出血，如妇女月经过多，便血，尿血，皮下出血。

〔舌 脉〕舌质淡，脉细弱。

〔病机分析〕脾气虚不能统摄血液，血不归经而溢于外。见于功能性子宫出血、血小板减少性紫癜、过敏性紫癜等。

〔治疗法则〕补脾摄血。

〔方 药〕炙黄芪 党 参 白 术 炙甘草
阿 胶 炒白芍 乌贼骨 炒地榆
蒲黄炭

（六）脾胃不和

〔症状表现〕食欲不振，食后不消，噎气吞酸，脘腹作胀，矢气多，大便溏；病久则倦怠无力，肌肉消瘦，面色萎黄。

〔病机分析〕胃主受纳，脾主运化，胃气主降，脾气主

升，脾胃调和，才能完成水谷精微之运化，供身体之消化吸收。胃虚则食欲不振，饮食减少；胃降失和，则噎气吞酸；脾虚则运化失常，食后不消，脘腹作胀，矢气多，便溏；病久则营养缺乏，出现体倦无力，面色萎黄，肌肉消瘦。可见于胃肠功能紊乱、慢性胃炎、慢性肠炎、慢性肝炎、肝硬化等。

〔舌 脉〕舌质淡，脉缓无力。

〔治疗法则〕健脾和胃。

〔方 药〕党 参 焦白术 茯 苓 炙甘草
陈 皮 半夏曲 砂 仁 木 香
炒扁豆 焦神曲

四、肺的辨证论治

（一）悲伤肺

〔症状表现〕由于强烈的悲伤，突然失音，神识无障碍，但不能言语，自觉胸中憋闷，能以手势和书写代替语言。

〔舌 脉〕舌无明显变化，脉多沉而不扬。

〔病机分析〕肺主悲，悲伤肺，强烈的悲哀而致肺气暴伤；肺主声音，肺气伤不能发声音而成暴瘖。可见于癔病性语言障碍。

〔治疗法则〕宣气开窍。

〔方 药〕桔 梗 枳 壳 郁 金 苏 梗
菖 蒲 射 干 玉蝴蝶

（二）肺阴虚

〔症状表现〕咳嗽无痰，午后颧红潮热，盗汗，手足心热，咽干声哑，甚则痰中带血，形体消瘦。

〔舌 脉〕舌红无苔，脉细数。

〔病机分析〕本证为阴虚内热。肺阴虚，故干咳无痰；虚火灼伤肺络，则痰中带血；虚火内炽，故午后颧红潮热，盗汗，手足心热；津液被灼，咽失滋润，则咽干声哑；病久耗伤阴液，则形体消瘦。舌红无苔，脉细数，均为阴虚内热之象。可见于肺结核、慢性支气管炎。

〔治疗法则〕滋阴润肺。

〔方 药〕沙 参 麦 冬 天 冬 生 地
百 合 川 贝 母 地 骨 皮 青 蒿
鳖 甲

（三）忧伤肺

〔症状表现〕气短，心慌，易出汗，面色晄白，体倦乏力，咳嗽无力，咳声低微，痰多清稀，精神淡漠。

〔舌 脉〕舌质淡，苔薄白，脉弱。

〔病机分析〕长期忧愁不解，肺气渐伤。肺主气，肺气伤，故咳嗽无力，咳声低微；气虚津液不得输布，化而为痰，故痰多清稀；肺主治节，肺气伤不能助心治节，则气短、心慌；肺气虚弱，卫外之气不固，则汗自出；气虚神不足，则精神淡漠。舌淡、脉弱，均为气虚之征。可见于神经官能症、肺结核、慢性气管炎。

〔治疗法则〕补益肺气。

〔方 药〕白 人 参 麦 冬 五 味 子 甘 草
炙 黄 芪 怀 山 药 白 果 远 志 肉

另外，如风寒袭肺，肺热咳喘，痰浊阻肺等，与精神病无关者从略。

五、腎的辨證論治

(一) 腎陰虛

〔症狀表現〕頭目眩暈，視力減退，耳鳴耳聾，腰膝痠軟無力，遺精或精少，不孕，午後颧紅，口干，潮熱盜汗。

〔舌 脈〕舌質紅、無苔，脈沉細數。

〔病機分析〕腎陰虛不能上養清竅，則耳鳴耳聾，視力減退；陰虛陽亢，則頭目眩暈；腰為腎之府，腎主腰膝，腎虛則腰膝痠軟無力，腎陰虛精關不固，則遺精；陰虛精虧，精室空虛，故精少不孕；陰虛生內熱，故颧紅、口干、潮熱；陰虛不斂陽，則盜汗出。舌紅無苔，脈沉細數，均為陰虛虛熱之征。可見性神經官能症等。

〔治療法則〕滋補腎陰。

〔方 藥〕熟地 山芋肉 枸杞子 女貞子
炙龜板 山 藥 丹 皮 茯 苓
甘菊花

或用成藥六味地黃丸。

(二) 腎陰虧損

〔症狀表現〕下肢痿軟不能站立，自覺兩足熱難忍，雖冬月足露于外不能着被。可成痿癱。

〔舌 脈〕舌體瘦，舌紅無苔，脈沉細。

〔病機分析〕腎藏精而生髓，腎精虧損，不能生髓，髓空骨軟，故下肢痿軟不能站立；陰精虧于下，熱自內生，故自覺足熱難忍，但外摸之不熱。可見于脊髓炎。

〔治療法則〕填精益髓。

〔方 药〕猪脊髓 熟地 炙龟板 鹿角胶
沙苑蒺藜 枸杞子 紫河车 怀牛膝

（三）肾精不足、脑海空虚

〔症状表现〕智能障碍或低下，包括理解力、计算力、分析能力、综合能力、批判力，创造力等，尤以记忆障碍为最显著，精神呆板。

〔舌 脉〕舌质淡，脉细弱。

〔病机分析〕肾藏精而生髓，脑为髓之海，肾精足，脑髓充，肾精不足，脑海空虚。肾为作强之官，主技巧，脑不足，技巧不能，则智能低下，记忆障碍。可见于老年性精神病、颅脑外伤后遗症、脑动脉硬化性精神病。

〔治疗法则〕补肾健脑。

〔方 药〕生龙骨 炙龟板 远志 菖蒲
巴戟天 肉苁蓉 补骨脂 熟地黄

（四）肾阳虚

〔症状表现〕面色晄白或晦暗，精神萎靡，腰膝痠软，怕冷，男子性欲减退、阳痿早泄，女子经闭不孕，尿频淋漓不尽，大便溏，甚则浮肿，毛发脱落。

〔舌 脉〕舌质淡，舌体虚胖，脉弱。

〔病机分析〕腰为肾之府，督脉贯脊属肾，而督诸阳，肾阳虚则腰脊痠软；命火衰微，故男子阳痿，性欲减退；阳虚精关不固，男则早泄，女子则经闭不孕；阳虚肾关开合不利，尿虽频而淋漓不尽；水液不能外排，则浮肿；命门火衰，不能温脾以助水谷之运化，则便溏；肾阳虚，阳气不能外达，故形寒怕冷；肾之华在发，肾虚则毛发脱落。舌淡、虚胖、脉弱，均为肾阳虚之征象。

〔治疗法则〕补肾助阳。

〔方 药〕仙 茅 仙灵脾 巴戟天 肉苁蓉
狗 脊 川续断 菟丝子 鹿角霜
甚则加附子、肉桂，或金匱肾气丸。

（五）肾阴阳两虚

〔症状表现〕精神呆板，耳聋，肢体不灵活，步态不整，口角流涎，语言困难。

〔舌 脉〕舌有龟裂，或有白膜苔。脉细弱。

〔病机分析〕肾为作强之官，技巧出焉。所谓作强者，轻劲多力；技巧者，精细灵巧。肾阴阳皆虚，功能失司，故精神呆板，肢体不灵活，步态不整；肾虚不能上养清窍，则耳聋不聪；肾气不得上贯舌下廉泉，则语言困难，口角流涎。舌有龟裂为肾阴虚，白膜苔为肾阳虚，脉细弱为阴阳两虚。可见于老年性痴呆、脑动脉硬化脑软化精神病。

〔治疗法则〕滋肾助阳。

〔方 药〕熟 地 巴戟天 肉苁蓉 肉 桂
炙附片 麦 冬 五味子 远 志
菖 蒲 山芋肉 石 斛

（六）肾阴亏，虚阳上越

〔症状表现〕头晕目眩，上重下轻，足若踏棉，面红如妆，肢冷，口干不欲饮，小便清长，大便溏。

〔舌 脉〕舌红少苔，脉洪大无力。

〔病机分析〕肾阴亏损于下，阴不敛阳，虚阳浮越于上，则头目眩晕，上重下轻，足软若踏棉；虚阳浮于上，面虽红如妆，但口干不欲饮，乃假热之象；阳虚不能外达，则肢冷；阳虚命火不足，则小便清长，大便溏泻。舌红少苔为阴

虚，脉洪大无力乃虚阳上越之征象。可见于高血压卒中之前，卒中见此为脱证危象。

〔治疗法则〕滋肾阴纳虚阳(导龙归海法)

〔方药〕生龙骨 生牡蛎 熟地 山芋肉
茯苓 山药 炙龟板 肉桂
炙附片

(七) 肾不纳气

〔症状表现〕喘促，自觉提气不升，吸气不降，呼多吸少，动则加重，气不衔接，肢冷。

〔舌脉〕舌质淡、苔白，脉微弱。

〔病机分析〕多因久病伤肾或年老体弱，肾气虚衰所致。肺主呼气，肾主纳气，肾虚纳气困难，故呼多吸少而气喘；动则耗伤肾气，故气喘加重；肾阳气不足，故肢冷。可见于肺气肿、肺原性心脏病及久病体弱的病人。

〔治疗法则〕补肾纳气。

〔方药〕补骨脂 胡桃 五味子 白果
蛤蚧

或成药黑锡丹、督气丸。

(八) 肾阴虚，相火盛

〔症状表现〕性欲亢进，阴茎易勃起，梦遗滑精。

〔舌脉〕舌红无苔，脉洪数。

〔病机分析〕肾阴虚，相火亢盛，性欲亢进，阳强；肾阴虚不能上交于心，相火扰动心火，则神动于中，精驰于下，故有梦遗滑精。舌红无苔为阴虚，脉洪数为相火盛。可见于神经官能症、精神分裂症青春型等。

〔治疗法则〕益肾阴，泻相火。

〔方 药〕生 地 山芋肉 山 药 茯 苓
丹 皮 泽 泻 知 母 黄 柏
或成药知柏地黄丸。

第二节 治疗精神病的几种法则

一、芳香开窍法。

用以治疗邪蒙清窍。适用于意识障碍或神识昏迷的病人。

（一）表邪未解，热邪蒙闭清窍

〔症状表现〕恶寒，发热，无汗，口渴，神识不清，牙关紧闭，四肢厥逆，体温在40℃以上，白血球在10,000以上，如急性传染病初期高热阶段。

〔舌 脉〕舌质红，苔白微黄，脉数。

〔治疗法则〕辛凉重剂透表，芳香开窍。

〔方 药〕生石膏 知 母 银 花 连 翘
杭 菊 薄 荷 辛 薹 鲜芦根
鲜葛蒲 鲜荷叶 鲜藿香 鲜佩兰
局方至宝丹

（二）邪入营分或心包

〔症状表现〕神昏谵语，烦躁不安，夜晚加重。如急性传染病中期高热阶段。

〔舌 脉〕舌红少津或舌绛而干，脉数。

〔治疗法则〕清热凉营，芳香开窍。

〔方 药〕犀角末 生 地 元 参 连心麦冬
丹 参 连翘心 银 花 竹叶心

黄 连 鲜菖蒲 郁 金

安宫牛黄丸

(三) 浊气蒙闭清窍

〔症状表现〕化学气体中毒急性期表现为头昏，头痛，恶心呕吐，重则昏迷；其后遗症为神识不清，动作古怪，表情茫然，反应迟钝，语言不清或失语，呈现痴呆症状群，逐渐发生麻痹性震颤(巴金森氏症)。

〔舌 脉〕急性期舌无变化，后遗症呈痴呆状态时伸舌不合作。脉多沉略数。

〔治疗法则〕芳香化浊开窍。

〔方 药〕藿 香 佩 兰 苍 术 辛 薷

荷 叶 杭 菊 远 志 菖 蒲

苏合香丸或十香返生丹

有震颤者，加平肝熄风药，如石决明，白蒺藜，钩藤等。

二、化痰开窍法

(一) 脑络受损伤，瘀血阻塞窍络

〔症状表现〕急性脑外伤性昏迷，多见于脑挫伤时。意识丧失可在受伤后立即出现，也可清醒后经过一个短时期才出现。意识障碍表现不同，可有意识混浊、昏迷或谵妄等。一般意识模糊历时较久，还可反复发生，往往不能很快就恢复，为促使病人早日清醒，并防止后遗症，应及时治疗。

〔舌 脉〕急性期舌多无变化，脉多数。

〔治疗法则〕疗伤损，止血化瘀，通络开窍。

〔方 药〕血竭末 三七末 乳 香 没 药

菴蔚子 泽 兰 骨碎补 川续断

归 尾 赤 芍 酒地龙 麝 香

或加成药七厘散。患者深度昏迷时，可采用鼻饲法。

〔二〕脑出血，瘀血阻塞窍络

〔症状表现〕突然剧烈头痛，眩晕，呕吐，偏瘫，短时间意识模糊而进入昏迷状态，呼吸深重，带有鼾声，眼球游动，口角歪斜。

〔舌 脉〕牙关紧闭，开口困难，舌质红，苔薄白。脉沉弦。

〔治疗法则〕化瘀血，通脑络，开窍清脑。

〔方 药〕琥珀末 三七末 没 药 乳 香
归 尾 赤 芍 南红花 桃仁泥
郁 金 葛 蒲 鸡血藤 酒地龙

〔三〕脑血栓、瘀血阻塞窍络

〔症状表现〕常于静止或睡眠时出现偏瘫，舌强失语，或口眼喎斜，饮水作呛，口角流涎，大便干，小便频，或失禁。

〔治疗法则〕补气化瘀通络。

〔方 药〕生黄芪 归 尾 赤 芍 川 芎
桃仁泥 南红花 酒地龙 鸡血藤
牛 膝

三、脑痰开窍法

〔一〕风痰蒙闭清窍

〔症状表现〕平素有高血压症，眩晕，突然神识不清，语言不利，如脑血管痉挛。

〔舌 脉〕舌质淡红，舌苔白腻，脉弦数。

〔治疗法则〕平肝熄风，豁痰开窍。

〔方 药〕生石决明 白蒺藜 钩 藤 天 麻
法半夏 远 志 菖 蒲 郁 金
胆南星 天竺黄 牛黄清心丸

（二）湿痰蒙闭清窍

〔症状表现〕精神障碍，妄想，如精神分裂症或其它痴呆状态。

〔舌 脉〕舌质淡红，舌苔白腻，脉滑。

〔治疗法则〕化痰开窍。

〔方 药〕橘 红 法半夏 茯 苓 枳 壳
竹 茹 胆南星 郁 金 菖 蒲
远 志 黄 连

（三）痰火蒙闭清窍

〔症状表现〕紧张性兴奋，病人突然出现强烈而冲动的兴奋活动，行为动作杂乱，甚则伤人毁物。常见于精神分裂症、躁狂症等。

〔舌 脉〕舌质红，舌苔黄，脉滑数。

〔治疗法则〕清火化痰开窍。

〔方 药〕黄 连 黄 芩 生栀子 胆南星
天竺黄 远 志 菖 蒲 郁 金
礞石滚痰丸

四、清热解毒法

（一）梅毒犯脑

〔症状表现〕年龄在50~60岁，早年有梅毒史，现有神经衰弱症候群。或精神迟钝，暂时失语，也可出现癫痫样发

作。也有的表现痴呆状态，康瓦氏试验阳性。

〔舌 脉〕舌质红，苔黄，或无苔。

〔治疗法则〕解毒驱梅清脑。

〔方 药〕土茯苓 金银花 连 翘 桔 梗
生甘草 槐 米 皂 角 露蜂房

（二）汞毒犯脑

〔症状表现〕长期接触汞，现症有神经衰弱症候群。头晕，头痛，失眠，多梦，记忆衰退，疲乏无力。或有精神症状，易兴奋，烦躁不安，易怒、胆怯，或有肢颤。

〔舌 脉〕涎水增多，口干，舌体肿胀，或口唇有溃疡，齿龈肿胀。脉不稳。

〔治疗法则〕解汞毒清脑络

〔方 药〕土茯苓 金银花 连 翘 甜桔梗
生甘草 豆 豉

外以黄酱擦牙龈。

（三）酒毒犯脑

〔症状表现〕由于长期饮酒，引起中枢神经系统严重病变，个性改变，智能减退，自私，孤僻，不修边幅，玩忽职守，兴趣范围狭窄，不关心别人，记忆减退，判断力差。有的病人在慢性酒精中毒的基础上急性发作精神障碍和震颤性谵妄。

〔舌 脉〕舌体胖，舌苔黄腻，脉滑数。

〔治疗法则〕解酒毒清脑络

〔方 药〕葛 花 枳椇子 黄 连 黄 芩
连 翘 生甘草 知 母 天花粉
辛 薹

五、清热泻火法

(一) 肝火盛

〔症状表现〕情绪易激动，烦躁，口干，大便干，小便赤。突然耳暴聋，如癔病性听力障碍。或突然暴盲，或视野缩小，如癔病性视力障碍。

〔治 则〕清泻肝火

〔方 药〕龙胆草 黄 芩 炒山栀 柴 胡
生 地 当 归 生甘草 木 通
泽 泻 车前子 川 军

耳聋者加菖蒲。目盲者加石决明、白蒺藜、杭菊花。

(二) 心肝火盛

〔症状表现〕精神狂妄，易激动，妄想，行为暴戾，不易接触，烦躁不能安卧。

〔舌 脉〕舌边尖红，脉弦数。

〔治疗法则〕清心泻肝，宁神。

〔方 药〕珍珠母 丹 参 元 参 黄 连
生 地 龙胆草 生栀子 黄 芩
朱砂末

六、重镇安神法(用于实证之心神不宁)

〔症状表现〕躁动不安，狂妄不羁。

〔舌 脉〕舌质红，舌苔黄，脉洪大有力。

〔方 药〕生铁落 珍珠母 生龙齿 丹 参
元 参 黄 连 磁朱丸

七、养心安神法

(一) 心血虚，心神不安

〔症状表现〕心悸，善惊，多疑，健忘，失眠，懒言，不愿与人接触。

〔舌 脉〕面色苍白，舌质淡、苔少，脉沉细。

〔治疗法则〕养心血，安心神。

〔方 药〕当 归 熟 地 炙首乌 杭 芍
炙甘草 远 志 炒枣仁 五味子
干桑椹

(二) 心气虚，心神不安

〔症状表现〕心悸，气短，自汗出，倦卧懒言，失眠。

〔舌 脉〕舌质淡，舌体松软，脉弱。

〔治疗法则〕养心气，安心神。

〔方 药〕党 参 炙黄芪 茯 神 炒枣仁
柏子仁 炙甘草 远 志 五味子
麦 冬

八、平肝法

(一) 肝阳上亢

〔症状表现〕声高气昂，情绪易激动，头痛，头胀，可有失眠，伴有高血压病。

〔舌 脉〕舌质红，舌体胖、苔白，脉弦。

〔治疗法则〕平肝潜阳。

〔方 药〕生石决明(珍珠母) 炙龟板

生 地 丹 皮 炒山梔 生牡蛎
夏枯草 苦丁茶 桑 叶 杭菊花

(二) 肝风内动

〔症状表现〕眩晕，肢麻，瘈瘲，痉 挛，抽 搐，甚则昏倒或口眼喎斜。

〔舌 脉〕舌边红，舌苔薄，脉弦数。

〔治疗法则〕平肝熄风。

〔方 药〕生石决明 白蒺藜 天 麻 钩 藤
杭菊花 僵 蚕 杭白芍 丹 皮

重者，加羚羊角粉。口眼喎斜者加全蝎。

(三) 肝气上逆

〔症状表现〕呃逆频作，呕吐，胸闷，不能进饮食，易怒，失眠，大便干(如植物神经机能障碍)。

〔舌 脉〕舌质淡红，苔白，脉沉弦。

〔治疗法则〕平肝降逆。

〔方 药〕旋覆花 代赭石 法半夏 生甘草
陈 皮 竹 茹 枳 壳 苏 子
苏 梗 沉香末

(四) 肝气郁结

〔症状表现〕精神抑郁，胸闷，咽塞，气不畅出，易怒，善哭泣，胸胁胀痛。

〔舌 脉〕舌质淡红，舌中心沟裂，苔白，脉沉弦。

〔治疗法则〕平肝解郁。

〔方 药〕醋柴胡 香 附 枳 壳 郁 金
川楝子 陈 皮 川厚朴 合欢皮

木 香

或成药舒肝丸

九、滋阴补肾法

(一) 肾阴虚，浮阳外越

〔症状表现〕头目眩晕，耳鸣，腰膝痿软无力，尿频，遗精，潮热盗汗，颧红，精神倦怠，遗忘。

〔舌 脉〕舌质红，无苔，脉沉细。

〔治疗法则〕滋肾阴，敛浮阳。

〔方 药〕生龙骨 生牡蛎 生地 山萸肉(枸杞子)
山 药 丹 皮 茯 苓 炙鳖甲
地骨皮 莲 须 五味子

(二) 肾阴亏损，虚阳上越

〔症状表现〕头目眩转，如坐舟车，足若踏棉，面红如妆，口干思热饮，尿频清长，大便溏，肢冷，精神恍惚，可伴有高血压病。

〔舌 脉〕舌质红而有龟裂，无苔；脉关上洪大，沉取无力，关后弱。

〔治疗法则〕填补肾阴，潜纳虚阳。

〔方 药〕生龙骨 生牡蛎 熟 地 炙龟板
山萸肉 枸杞子 丹 皮 山 药
茯 苓 炙附片 肉 桂

十、助阳补肾法

(一) 肾阳不足，精关不固

〔症状表现〕精神萎靡，腰膝痿软，肢冷，性欲减退，

阳萎早泄，尿频淋漓不尽，大便溏。

〔治疗法则〕补肾助阳，固精。

〔方 药〕煅龙骨 煅牡蛎 熟地 山萸肉
山药 茯苓 淫羊藿 巴戟天
川续断 菟丝子 肉桂 鹿角胶

(二) 肾阳不足，阴精亏损，冲任失调

〔症状表现〕精神焦虑不安，敏感，喜静，怕声，怕光，烦躁易怒，注意力不集中，性机能减退，女性月经紊乱或停止。失眠，头晕，头痛，食欲不佳，腹胀，便秘，心跳，易汗出，阵阵颜面潮红。可有高血压病。如更年期症候群。

〔舌 脉〕舌质淡，苔白，脉沉细。

〔治疗法则〕补肾阳，益肾精，调冲任。

〔方 药〕仙茅 仙灵脾 巴戟天 肉苁蓉
当归 知母 黄柏 炒枣仁
首乌藤

第三节 心理治疗

心理治疗，是医生在充分掌握患者过去与现在的心理与病理状态，在适当的时机，以有针对性的语言作用于患者的高级神经，从而改善患者的精神状态和机体状态，以达到治疗目的的一种疗法。

这种治疗方法，被我国历代医学家所重视。如《素问·宝命全形论》说：“一曰治神，二曰知养身，三曰知毒药为真，四曰制砭石小大，五曰知府脏血气之诊。五法俱立，各有所先。”由这段经文可以看出，古人治病时把调治精神一法

放在首要地位，强调必须先治神。这里所说的神，指的是魂、神、意、魄、志，统称为“五神”，为肝、心、脾、肺、肾所主。按杨上善注云：“人无悲哀动中，则魂不伤，肝得无病……无怵惕思虑，则神不伤，心得无病……无忧愁不解，则意不伤，脾得无病……无喜乐不极，则魄不伤，肺得无病……无盛怒者，则志不伤，肾得无病……是以五过不起于心，则神清性明；五神各安其脏，则寿延遐算也。”这说明良好的心理因素和积极的心理状态，对于身体或精神的疾病可以起到治疗和有助于康复的效用。《素问·汤液醪醴论》指出：“精神不进，志意不治，故病不可愈。”按全元起本云：“精神进，志意定，故病可愈。”《太素》云：“精神越，志意散，故病不可愈。”这说明心理活动直接影响着疾病的病程和预后。

《黄帝内经》这部医学经典巨著，不但对人体的生理、病理、治疗和预防作了系统的原则性的论述，而且对心理因素在人体多种疾病的发生、发展和转归过程中的作用，也给予高度的重视。《内经》不但为中医临床学奠定了理论基础，也给古代医学心理学奠定了基础。

中医把七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊看成是人类情志活动的七种表现。情志活动本来是人体对外界环境的一种心理反应。如果在人体正常的情况下，偶有情志波动本不会致病。若情志波动超过机体耐受的极限，就会使机体内脏活动不协调，从而发生病变。如《素问·举痛论》所说：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下……惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣。……思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结矣。”这些论点不但是后世

病因学的嚆矢，也是精神病理学的先导。

又如《素问·阴阳应象大论》说：“怒伤肝，悲胜怒”；“喜伤心，恐胜喜”；“思伤脾，怒胜思”；“忧伤肺，喜胜忧”；“恐伤肾，思胜恐”；就是利用一方面的精神抑制和兴奋来调节另一方面的精神兴奋和抑制。这些富有哲理的论述，成为后世心理治疗的依据。

一、古代医家运用心理疗法点滴

《灵枢·师传篇》指出：“入国问俗，入家问讳，上堂问礼，临病人问所便。……且夫王公大人血食之君，骄恣纵欲，轻人而无能禁之，禁之则逆其志，顺之则加其病，便之奈何？治之何先？岐伯曰：‘人之情，莫不恶死而乐生。告之以其败，语之以其善，导之以其所便，开之以其所苦，虽有无道之人，恶有不听者乎！’”这一段见之于《内经》的话，说明早在两千年前，中医就十分重视心理治疗方法，并且具有很高的水平。

金元四大家之一的张子和在《儒门事亲》中说：“悲可以治怒，以恻怛苦楚之言感之。喜可以治悲，以谑浪褒狎之言娱之。恐可以治喜，以恐惧死亡之言怖之。怒可以治思，以污辱欺罔之言触之。思可以治恐，以虑彼志此之言夺之。凡此五者，必诡诈谲怪，无所不至，然后可以动人耳目，易人听视。若胸中无才器之人，亦不能用此五法也。”他不仅提出心理治疗的“五法”，而且根据自己的临床实践，把七情疗法加以整理归纳，推广论述，使之更加具体化。下面选录医案数则，以示古今中医临床运用“五法”之巧妙。

（一）喜伤心，恐胜喜（《洄溪医案》）

某殿撰，新以状元及第，告假而归。至淮上而有病。求某某名医，医曰：“疾不可为也，七日必死，可速归，疾行犹可抵里。”殿撰嗒然气沮，兼程而还。越七日无恙。其仆进曰：“医有一柬，嘱归而呈之”。殿撰拆视，曰：“公自及第后，大喜伤心，非药力所能愈，故仆以死恐之，所以治病也，今无妨矣”。殿撰大佩服。

(二) 思伤脾，怒胜思(《朱丹溪传》)

一女子病不食，而北卧者且半载，医告术穷。丹溪先生诊之，肝脉弦出寸。曰：“思男子不得，气结于脾。”故叩之，则许嫁夫入广者五年。先生谓其父曰：“其病惟怒可解，盖怒则结于脾之气散，今唯触之使怒。”先生入而掌女面者三，责以不当有外思，女号哭而大怒，一怒而进食。先生复潜谓其父曰：“思气虽解，然必得喜，则庶不再结”。乃诈以夫有书，旦夕归。后夫果至，而病不作。

(三) 忧伤肺，喜胜忧(《儒门事亲》)

一妇饥不欲食，默然不乐，时或詈骂，治久不效。张载人视之曰：“此难以药治也”。使二妓各涂脂粉作伶者状，妇大乐；次日又令二妓作角觝(较力之戏)，妇又大乐；又使食子旁，且夸其所食之美，妇为所动，亦索食，与之不使过量。数日病减而食增，疾竟愈矣。

(四) 怒伤肝，悲胜怒案

笔者幼时，先父治一妇人，因与妯娌口角，后患呃逆不止已三月。呃逆时全身随之上耸，不能进食，致骨瘦如柴，经医治不效。先父得知病情后，示意其夫谎告其爱子溺于荷塘，妇闻知悲痛欲绝。少顷，其夫领其子至前说：“已救起。”妇抱其子悲喜交加，涕泪俱下，但未闻其有呃逆之声。先父

又以平肝镇逆之剂服之，病随愈。

（五）惊者平之案（《儒门事亲》）

卫德新之妻，旅中宿于楼上，夜值盗劫人烧舍，惊堕床下。自后每闻有响，则惊倒不知人。家人辈蹑足而行，莫敢冒触有声，岁余不痊。诸医作心病治之，人参、珍珠及定志丸，皆无效。张载人见而断之曰：“惊从外人，为自不知故也，恐从内出，自知也”。乃命二侍女执其两手，按于高椅之上，当面前，下置一小几，载人曰：“娘子当视此”，一木猛击之，其妇大惊。载人曰：“我以木击几，何以惊乎？”伺少定又击之，惊也缓。又斯须，连击三五次。又以杖击门，又暗遣人击背后之窗。徐徐惊定而笑曰：“是何治法”？载人曰：“内经曰：惊者平之，平者常也，平常见之必无惊”。是夜使人击其门窗，自夕达曙，一二日虽闻雷亦不惊。

上述举例是很不全面的，意在说明治疗精神病仅靠针药往往难以奏效。有人认为，针灸药石虽能治有形之疾，不能治无形之七情是不无道理的。对于七情所致之疾，治以七情疗法而辅以针药，既能提高疗效，又能消除病原。

二、心理治疗要点

（一）要尽力取得患者的信任

精神病患者的症状是多种多样、千差万别的，但多数人有一个共同特点，即多疑或拒医。因此，要对精神病患者进行心理治疗，医生必须具有全心全意为病人服务的思想，不论病人的意识、个性如何特殊，情感如何冲动，行为如何粗暴，都要以平等的身份、真挚的感情、诚恳的态度接待、体贴他们，以获得患者的信任，并以水滴石穿的耐心劝解来诱导

他们倾吐内心的感受。这是心理治疗成功的第一要素。

（二）要善于体察多类患者的思想感情

人患精神病有其内在因素，但许多精神病患者发病，往往是由有关家庭、社会的生活、工作中的事引起的，而且诱发精神病的家庭、社会因素又是千奇百怪，错综复杂的。因此，医生要想真正做到辨证论治，还必须熟悉社会上各种各样的人，要了解各地的风俗人情，各阶层人的生活习惯、精神面貌、文化素养，不同年龄、不同行业人的工作方式和特点。只有广泛深入地了解社会、了解人，才能够比较容易地与各种各样的患者交谈，才能同患者有共同语言，才有利于患者暴露真实思想。

（三）要从患者最易动心处入手

医生对精神病患者进行心理治疗的方法，切忌主观、片面、想当然和千篇一律，而必须因人而异。特别是开头，应当从最容易使患者动心之处入手，打破患者与医生之间的隔阂。假如患者是一位古典文学爱好者，就可引用历史故事或某首古诗和寓言来劝慰他。如患者是位没有文化的老工人，可以用机器作比喻，说明人有病不一定是部件损坏，多数是部件在功效上出了毛病，排除故障，机器又会照样转动。如果患者是位老农民，可以和他谈种庄稼，用水涝淹庄稼比喻人体的湿盛，天旱缺雨比喻人体的津液亏，将祛湿比作排涝，把滋阴增液比作灌溉等等。总之，对精神病人进行心理治疗，要采取一把钥匙开一把锁的方法。

（四）要采取灵活的方式

对精神病患者进行心理治疗，主要应该采取医生与患者单独对话的方式，因为有些患者不愿意在陪诊者（一般是

家属)和生人面前吐露真情。但是,为了使患者能够对精神病的病因、症状、治疗方法有个基本的认识,以便于解除患者不必要的顾虑和误解,以便于患者与医生的合作,也可以适当地采取集体讲座的形式。一般是选择同样病种的病人30~40人,把他们集合在一起,先由医生用通俗的语言讲解某种精神病是由哪些原因所引起的,为什么会产生各种症状,除采用药物治疗方法之外,还需要患者注意哪些事项,等等。然后请几位经过治疗、病情已经好转的病人发言,座谈交流配合医生治疗的经验体会。这种方法能够减轻病人的精神负担而增强其战胜疾病的信心。

下篇

总 论

~~401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412~~

第一章 传染病性精神病

传染病性精神病，是由各种传染病引起的精神障碍。临床常见的易于引起精神障碍的传染病有两类：一类是病变不在脑的，多见于流行性感冒、肺炎、伤寒、传染性肝炎、细菌性痢疾等。一类是病变在脑的，常见于脑膜炎、脑炎等传染病。

关于传染病所引起的精神障碍，如谵言妄语，神智昏迷，意识不清，惊厥抽搐，幻觉遗忘等，尽管与精神病症状近似，但在体征上与精神病并不相同。因为传染病性精神病多因高烧所引起，而真正的精神病，却不因高烧也可发作。所以，高烧是其主因。一旦高烧消退，其精神症状即可随之减弱或消失。至于因毒邪稽留而出现的后遗症，乃是由于高烧伤津，正气衰弱，神智不充，躯体缺乏抗邪能力，虽然高烧已退，实际余邪未尽，因而遗有各种精神障碍。

传染病性精神病的发作，在时间上多为朝轻暮重，而真正的精神病则随时都可发作。

第一节 病因病机

传染病为什么能导致精神障碍？这需要从中医对于传染病的病因认识谈起。

中医认为传染病的病因，首先在于“岁时”，就是说在本年

度里何气主令，就会流行某些传染病。其次，归咎于“六淫”，即风、寒、暑、湿、燥、火等不正之气。例如，春为“风气”当令，风就是主要传染病因（多流行风温）。春末夏初，阳气弛张，温盛为热，“热气”当令，热就是致病因素（多流行温热）。正夏之时，“暑气”当令，暑为主要致病因素（多流行暑温、暑风）。长夏初秋，湿中生热，“湿热”又为主要致病因素（多流行湿温）。迨至秋深，“燥气”当令，燥又为主要致病因素（多流行秋燥）。立冬之后，气候应当寒冷而反温者，又是冬温流行的因素。这里所举的这些因素，都是不正常的气候表现。在正常的情况下，“六气”是不致病的。

以上是中医对于传染病诱发因素的认识。至于传染病为什么能引起精神障碍，古人在这方面也作了描述。例如张仲景在《伤寒论》说：“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂……”就是说，太阳病的表邪尚未解除，而热邪随太阳经侵入膀胱，热结膀胱，病人烦躁不宁，因而出现类似发狂的病象。再如“妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室”。妇女感染伤寒以后，适值经血来潮，热邪乘虚入于血室，致使血瘀作烧，白天尚清醒，晚间阴虚热盛则谵语，并有幻视，见奇形怪状。

从上述证候来看，精神障碍都是热邪瘀结所致。关于温热病引起的精神障碍，古人认为有以下几种：

其一为邪入心包。心包为心之外围，心包受邪，神明无由传达，因而出现精神障碍的种种症状。

其二为汗出过多。温热之邪，最能伤津，汗出过多，势必重伤津液。汗为心之液，心液不足，则心神无以内守，因而出现神智昏迷等状态。

其三为阴虚风动。热邪伤津，阴血不足，肝失所养，则肝阳上越，肝风内动，因而出现昏晕惊厥；血不荣筋，则出现抽搐等症状。

其四为热入营分。营气通于心，邪热入营则身热夜甚，心烦躁扰，甚则神昏谵语。

其五为热入血分。血分热盛，迫血妄行，故皮肤出现紫黑斑疹及各种出血现象；热扰心神，故轻则躁扰，重则谵妄。

第二节 临床表现

一、意识障碍症候群

意识障碍为传染病性精神病中最常见的临床征象。约3/4的病人在病程中出现意识障碍，短的仅数小时，最长的可达一月以上。可自轻度的意识恍惚到严重的谵妄或昏迷。常见的意识障碍有以下两种状态。

（一）谵妄状态

患者兴奋不宁，紧张恐惧，狂呼乱叫，不住扭动，甚至冲动毁物，行为缺乏目的性；或循衣摸床，定向缺乏，思维不连贯，应答不切题，拒食；或有丰富的视听幻觉，内容多属迫害、恐惧性质，病人可有攻击或逃避假想的敌人而产生伤人或自伤行为，过后对发病过程大多遗忘。病人白天比较安静，昏昏沉沉，或者喃喃自语，对周围事物反应迟钝；夜间不能入睡，吵闹不安，严重时可转入昏迷。有的病人又可出现精神错乱状态，其症状较谵妄状态更为严重和持久，不但有环境定向障碍，而且自我定向也缺失，大小便不能自理，

病人持续兴奋骚动，容易导致衰竭、死亡。

（二）意识模糊状态

患者的意识障碍较轻，昏倦欲睡，注意力涣散，反应迟钝，言语减少，对简单的问题还能作出正确的反应或对答，但对较复杂的问题则不能作出相应的反应。表情迷惘，情感淡漠或不稳定，动作呆滞、刻板，有时甚至不能自己料理日常生活。有片断的模糊视、听幻觉，也可能有片断的妄想，定向也有一定的障碍，近事记忆缺失，事后部分遗忘。

意识障碍多数发生于高热期，并与体温升降相平行。少数病人发生于热退后，极个别的在发热出现前发生。有些感染后意识障碍的患者具有波动性和间歇清醒两个特征，他们的精神症状时轻时重，昼轻夜重便是这种波动性的典型例子。近半数的病人可出现维持数分钟至数小时的清醒期，此时病人意识清晰，精神症状消失，部分病人还可对疾病有一定批判能力，但过后又重现意识障碍。这种间歇清醒期可在整个病程中发生一次或数次。多数病人在意识障碍消失后，精神症状完全缓解，部分病人出现感染后神经衰弱症候群。

二、神经衰弱症候群

此种症候群比较常见，多在急性传染病的末期或恢复期出现。病人乏力，头昏，头痛，易激怒，情绪不稳或焦虑忧郁，容易流泪或激动，常埋怨别人对他不关心、不体贴，对声光过敏，睡眠浅而多恶梦，注意力不集中，记忆力减退，伴有消化不良、肢体疼痛和较多的躯体方面的主诉，临床颇似神经衰弱。

三、智力减退和记忆障碍症候群

此种情况是不多见的。儿童在严重感染特别是累及中枢神经系统时，可影响大脑的发育，产生智力缺损，但这种缺损有时是可逆的。老年人感染后常发生记忆障碍，主要是近记忆缺损。有些患者还可出现遗忘症候群，如情绪欣快，有记忆障碍，虚构，错构，有时还有定向错误。这种情况以原先有肺功能不全继发肺部感染的患者较为常见。感染后的遗忘症一般还是能够消失的。

四、性格障碍症候群

性格障碍多见于儿童，多数系中枢神经系统感染的后遗症，但其它严重的全身感染也会引发。患儿变得不安静，喜恶作剧、偷窃、说谎、贪食，不知羞耻，不听劝导，但智能却没有明显的变化。

第三节 流行性感冒引起的精神障碍

一、临床表现

流行性感冒是流感病毒引起的呼吸道传染病，它所引起的精神障碍大致可分为两类。

(一) 忧郁衰弱型

此型较为多见，可发生于发热期或热退后，以情绪忧郁和神经衰弱症状最为突出。患者忧郁寡欢，沉默少言，呆滞少动，疑病沮丧，对前途失去信心，可发生忧郁性木僵、违拗，不愿

进食，甚而自杀。幻觉及妄想不明显。

(二) 意识障碍型

此型并不多见，如有发生，则可能伴有继发感染，特别是在肺炎和脑膜炎患者中易出现。其临床表现为谵妄、意识模糊或嗜睡，可伴有抽搐和惊厥。

二、病例介绍

王× 女性 15岁 中学生 初诊日期为1962年3月10日。

〔问诊〕患者于四天前突然发高烧，鼻塞流涕，头痛，咽痛。当时学校有很多同样患者。校医室给复方阿司匹林，患者当晚服后有汗出，热也减轻，次日晨仍上学，至中午病势加重，不能坚持学习。下午去××医院，经检查体温 39.4°C ，诊断为流行性感，注射青霉素，嘱卧床休息，多喝水。自昨日患者口渴，饮水多，拒食，精神有谵妄状态，有时突然似受惊而喊叫，不知说些什么，不能正确答问，对探病的同学似乎不认识。忽而坐起不穿鞋下床乱走，两天来未大便。体温 39.2°C 。

〔望诊〕急性病容，面红，精神呈混浊状态。舌质红，舌尖红刺，苔薄黄；咽红。

〔闻诊〕不能正确回答提问。

〔切诊〕脉洪数。

〔辨证〕外感风热，表邪入里，热结阳明，邪扰神明。

〔立法〕清里热，安神明。方用清解汤。

〔处方〕生石膏 30克 知母 10克 生甘草 3克
板兰根 10克 贯仲 10克 杏仁泥 10克
牛蒡子 10克 芦根 30克 川军 3克

紫雪丹 6 克 (分两次冲服)

二诊：1962 年 3 月 12 日。前方服用两剂，自昨日热势已退，体温 36.2°C ，大便已通，精神转清醒，昨日黎明大便一次，便后即要进食，喝米粥一碗。今日稍感咽痛，仍有咳嗽数声，仅感体倦。今日就诊精神已正常，舌质红，舌苔薄，脉滑。仍以前方加减。

〔处方〕 前 胡 6 克 杏仁泥 10 克 牛蒡子 10 克
贯 仲 10 克 大青叶 10 克 板兰根 10 克
鲜芦根 30 克 两剂

〔病例分析〕本例为风热外感，表邪未能及时解除，很快即化热入里，故病人口渴多饮，为热在阳明胃经，继之出现便结、谵妄，乃阳明胃经之热传及阳明腑大肠，热邪与肠中滞热相结则大便不通，里热盛故身热面赤，舌苔黄。热扰心神，则精神谵妄。本证为热邪初入阳明大肠，尚未致燥结，故舌苔虽黄尚薄而不燥，尚有口渴；脉洪数而未见沉实，说明热邪在胃经之势尚未完全传入腑大肠，热邪初入与肠中滞热相结未坚，未成腑实证，故方中还需用白虎汤清胃经之热，配清热解毒药以治流感，仅用少量川军配紫雪丹清肠中热以安神，不用大承气汤泻肠中滞热。药后热退神清，便通，欲进食。二诊仅以理肺清热解毒药，以清余邪，症状消失。

第四节 肺炎引起的精神障碍

一、临床表现

各类肺炎均可能引起精神障碍。精神症状通常因高热、

毒血症及细菌血行播散至脑膜而引起。

肺炎引起的精神障碍，以意识障碍最为多见，轻的嗜睡，重的昏迷，程度不等，但多数为谵妄状态。患者有定向障碍，思维不连贯，兴奋不安，伴有错觉和幻觉。意识障碍一般为时不长，如在数天之内肺炎被控制，它也随之好转。

少数病例在体温下降后可出现紧张症候群和躁狂症候群。体格检查可于肺部发现啰音或实变征等肺炎体征。神经系统方面，有的可见惊厥和抽搐，少数病人可见视神经乳头水肿和脑膜刺激征。血象，白血球总数增加，中性粒细胞增多，有时于白细胞中可见中毒颗粒。在并发脑膜炎患者的脑脊液中可见细胞及蛋白质增高，但有些患者却没有任何变化，是一种虚型脑膜炎。胸部透视不但有助于确定炎症部位，而且对确定病原体的种类也能提供线索。

二、病例介绍

张×× 男性 4岁 初诊日期为1961年3月20日。

〔问诊〕患儿于三天前发热，寒战，咳嗽，喉中痰鸣、喘憋，烦躁不安。当晚，经其父母单位医务室注射青霉素，口服磺胺片。次日晨起去儿童医院就诊，查体温 39°C ，经透视检查，诊断为急性肺炎，经治疗症状稍有好转。自昨夜体温回升至 39.5°C ，咳喘气憋，喉中痰鸣，鼻翼扇动，烦躁不宁，意识不清，时有四肢痲痹。

〔望诊〕意识模糊不清，鼻翼扇动，胸高抬肩，舌质红，苔少，唇青紫。

〔闻诊〕气喘，喉中痰鸣。

〔切诊〕脉滑数。

〔辨证〕内有蕴热，外感表邪，内外之邪并结于肺，且有邪热内陷之势。

〔立法〕清肺热，化痰定喘，加清心开窍之品，以防邪热内陷。方用麻杏石甘汤加味。

〔处方〕麻黄3克 生石膏15克 甘草2克
杏仁泥6克 炒葶苈4.5克 栝蒌10克
代蛤粉6克 羚羊粉0.6克（分两次冲）
紫雪散1.6克（分两次冲）

二诊：1961年3月21日。患儿服药后，当晚咳喘气憋即轻，随即安睡，醒后神智清醒，知道要小便。今日就诊除有些衰弱症状外，精神已正常，体温 37.2°C ，仅有时咳嗽数声，未闻气喘痰鸣。已进饮食，二便正常。

〔病例分析〕本例患儿本为稚阳之体，肺素有蕴热，复感风热表邪，卫气被郁，肺失宣降，故见发热寒战、咳喘等表证，待表邪与内热并结于肺，邪热灼津，炼液为痰，痰热内阻，肺气不利，故出现咳嗽、喘急、痰鸣、鼻翼扇动等症状。又因邪热炽盛有内陷心包之势，热极生风，故出现意识不清，四肢时有痲疯等症，恐为惊厥之兆。急治以麻杏石甘汤宣肺定喘，羚羊粉清热熄风，以防惊厥抽搐；给紫雪丹清热开窍醒神，以防邪热内陷。药后热退，喘平，神智清醒，症状消失。

第五节 伤寒引起的精神障碍

一、临床表现

伤寒是由伤寒杆菌引起的肠道传染病。很早以前，人们

便注意到伤寒引起的精神障碍，并把它列为诊断伤寒的特殊征象之一。近年来，由于早期诊断和治疗，伤寒的临床征象有了变化，典型的所谓伤寒热型的体温阶梯形变化已很少看到，精神障碍的发生率也大为降低。伤寒引起的精神障碍，一般认为是由细菌毒素引起的，临床表现大致可分为以下三类：

（一）意识障碍型

此型大多发生于高热期，病人表现为意识模糊或谵妄状态，并可互相转化。病人表情淡漠，注意力涣散，反应迟钝，喃喃自语，迷迷糊糊，伴有阵发性惊恐的视听幻觉；有时情绪紧张恐惧，兴奋不安，狂奔乱跑，可有片断的牵连观念和迫害妄想，过后又转为意识模糊状态。上述表现，在病程中可有多次交替出现。

（二）幻觉妄想型

约有1/3的病人在热退后出现幻觉妄想，所谓“热后型”。有的是意识模糊幻觉妄想体验的继续，有的却是没有发生过意识障碍。病人猜疑重重，认为有人在监视他，迫害他，不肯进食和服药，感到医生和家属也要毒害他。有牵连观念的很为多见，妄想的内容和对象多变，和幻觉有一定联系，听幻觉、视幻觉都可发生。病程往往较长，易与精神分裂症的幻觉妄想型相混淆。

（三）类躁狂型

此型可发生在谵妄出现之前，或躯体疾病好转时。患者情绪欣快，兴奋多言，得意洋洋，忙忙碌碌，类似轻躁狂。但思潮澎湃、思维奔逸的症状不突出。其特点是情绪不稳，容易疲乏，病程也较短暂。

二、病例介绍

屈×× 男性 38岁 司机 会诊日期为1958年8月21日。

〔问诊〕患者两周前头痛、恶寒、发热，体温40℃，经化验检查后诊断为伤寒，收住院治疗。两周来体温持续在38℃左右。近三、四天来，反应迟钝，表情淡漠，对周围事物无所要求，耳聋，问话多不回答。腹胀，大便泻如水状，一日三次。大汗出不止。胸腹及背部出有白痞。

〔望诊〕精神不振，表情淡漠，舌质淡、舌苔白腻。

〔闻诊〕耳聋，提问不答。

〔切诊〕脉缓无力。

〔辨证〕外感湿温，表邪入里，湿阻清阳，内困脾胃。

〔立法〕化湿健脾，宣通清窍。方用三仁汤加减。

〔处方〕生苡仁15克 白蔻仁10克 杏仁泥10克

白通草6克 川厚朴6克 白茯苓15克

滑石块10克 石菖蒲6克 鲜荷叶30克

二诊：1958年8月23日。前方服用两剂，精神已爽，汗出亦止，白痞渐消，体温36.8℃，泻下止，今日未大便，耳聋减轻，能回答提问，自昨日能食粥一碗。舌质淡，舌苔稍白腻。脉缓较前有力。前方去厚朴，加扁豆衣10克。

〔病例分析〕本例为外感湿温，初感时为邪在表，故恶寒、发热、头痛；继则邪传入里，湿阻气机，故脘腹胀；湿困脾胃，故不食，便下如水；湿邪内郁汗出而生白痞。湿阻清阳，清阳不得上升，故精神不振，表情淡漠，反应迟钝。清窍不宜则耳聋无所闻。舌苔白腻，脉缓均为湿象。治以化

湿健脾，湿化而清阳升，神识正常；脾健而泻下止，功能复常。

第六节 传染性肝炎引起的精神障碍

一、临床表现

传染性肝炎是由肝炎病毒引起的一种传染病，一般认为经消化道和血液途径传染。发生精神障碍的主要原因是毒血症。

此种精神障碍的发生率不高，特别是严重者并不多见。精神症状可分两类：

（一）忧郁衰弱型

此型较为普遍。患者乏力症状颇为突出，终日思睡，对日常生活也懒于管理。情绪障碍以忧郁苦闷最为多见，也有表现为焦虑不安、易激惹者。可能拒食，有时情绪不稳，出现癔病样发作。躯体方面的主诉颇多，如眩晕、头痛、记忆力减退等，个别病情严重的患者有消极观念。

（二）意识障碍型

此型的发生率约占急性肝炎患者的60%左右。有人把这一型列入“肝脑综合征”，大多发生于急性黄疸型肝炎病情急剧进展或急性亚急性黄色肝萎缩时，患者呈谵妄状态，烦躁不安，定向障碍，可出现幻视和运动性兴奋以及间歇嗜睡。部分患者伴呃逆、抽搐及癫痫样发作，如不积极处理，可在数天内转入昏迷，最后死亡。

二、病例介绍

于×× 女性 59岁 初诊日期为1961年8月10日。

〔问诊〕患者于10天前恶寒发热，头晕，恶心，呕吐，胃脘不适，当天服藿香正气丸两次，有些好转，但仍感体乏无力，小便茶红色，五天后发现皮肤黄染而就诊，经检查诊断为传染性黄疸型肝炎，于八月五日收住院治疗。七日病情突然变化，患者烦躁不安，有时两手舞动，呼叫，或呈谵妄状态。经治疗症状不减而请中医会诊。

〔望诊〕意识模糊，手不住摸寻；舌质红，舌苔黄厚；巩膜黄染。

〔闻诊〕不时喊叫。

〔切诊〕脉弦滑。

〔辨证〕湿热蕴毒，邪蒙清窍，扰及神明。

〔立法〕清湿热解毒，开窍醒神。方用茵陈栀子汤加味。

〔处方〕茵 陈 15克 生栀子 6克 川黄连 4.5克 双花 10克
连 翘 10克 大青叶 10克 郁 金 6克 石菖蒲 6克
生 草 3克 滑石块 10克
安宫牛黄丸两丸，每次一丸。

二诊：1961年8月12日。服药后患者渐转安静，今日精神已清醒。自述头晕，不想吃饭，全身无力。舌质淡红，舌苔薄黄，脉滑缓。

〔处方〕前方去安宫牛黄丸、石菖蒲，加柏皮10克。

〔病例分析〕本例急性黄疸型肝炎，为阳黄证，其病机为湿热蕴结肝胆，胆液不得外泄，侵淫肌肤而发黄疸。湿热中

阻，脾胃升降失司，故不欲食，恶心呕吐。湿热蕴毒，毒邪蒙闭清窍，扰及神明，故意识障碍而呼叫谵妄。舌红苔黄腻，脉弦滑，均为湿热盛，邪在肝胆。经用茵陈栀子汤加清热解毒药，清湿热解毒退黄疸，加郁金、石菖蒲芳香开窍，加安宫牛黄丸开窍醒神，以防急性肝昏迷。药后意识清醒，精神正常，效果较好。

第七节 细菌性痢疾引起的精神障碍

一、临床表现

此处所谓细菌性痢疾引起的精神障碍，主要是指中毒性菌痢引起的精神障碍，多见于老年人、儿童或体弱的病人，有初期谵妄、发热性谵妄及虚脱谵妄等精神症状。儿童可有癫痫样发作。这种中毒性菌痢及其所引起的精神障碍，在临床上一般分为体克型、脑水肿型和混合型。

（一）体克型

它的典型临床表现是四肢厥冷，面色苍白，口唇紫绀，尿少或无尿，血压降低，脉微弱而数。病人处于昏迷状态。

（二）脑水肿型

其典型临床表现是烦躁不安，或嗜睡不醒，呼吸增快，不规则甚或停止，呕吐，惊厥，血压增高，瞳孔大小不等。

（三）混合型

兼有上述二型症状的即为混合型。

二、病例介绍

王× 女性 5岁 会诊日期为1959年7月12日。

〔问诊〕患者于五天前突然发热，精神异常萎靡，面色青灰，四肢厥冷，随后惊厥。急送××儿童医院，经化验检查诊断为中毒性菌痢，当时收入住院治疗。入院头两天每日都有惊厥抽搐，神志不清，体温40.2℃。自昨日患儿呈深度昏迷，医院采取各种急救措施无效，父母要求中医会诊治疗。

〔望诊〕精神呈深度昏迷，头枕冰袋，面色青灰，腹隆起，舌质紫，舌苔黑燥起芒刺。

〔闻诊〕呼吸微弱而表浅。

〔切诊〕脉沉数，四肢冷，腹部扪之灼手。

〔辨证〕肠中滞热，复感表邪；邪热入里，热结于肠，扰及神明。

〔立法〕清热泻下以安神。方用大承气合增液汤。

〔处方〕川大黄6克 枳实3克 川厚朴3克 元明粉3克
元参6克 麦冬6克

安宫牛黄丸一丸(分两次服)

二诊：7月13日。昨日患儿服药后四小时大便泻下甚多，今晨神志清醒，体温36.8℃，已知饥饿，吵着要吃，腹已软不热，舌质红，舌苔微黄，脉略数。停服中药，嘱其妥善护理。

〔病例分析〕本例患儿体素健壮，由饮食不节，肠中滞热，复感表邪，表邪急骤入里化热，与肠中滞热相结，里热炽盛，故身壮热，热极生风，故惊厥抽搐。内热亢盛，阳气郁而不伸，故反四肢厥冷。热扰神明，故神志昏迷。腹胀

满，扪之灼手；舌苔黑燥起芒刺，脉沉数，均表现为里实热盛，宜急下存阴。仅用大承气汤一剂，泻下后热退神清。

第八节 脑膜炎引起的精神障碍

一、临床表现

急性脑膜炎可由各种病原体引起。有时由中耳炎蔓延而来，有的由败血症引起。

本病发病多急剧，在体温升高前常有头痛、烦躁等前驱症状。高热期间的精神障碍多为谵妄状态，或意识模糊状态，重时可昏迷。

脑膜刺激症状常很明显，如颈强直、喷射性呕吐等，有时可见到神经系统局限症状。急性脑膜炎晚期，也可发现虚脱性谵妄。

二、病例介绍

〔例1〕

袁× 女性 4岁 会诊日期为1960年3月18日。

〔问诊〕患儿四天前发热，恶寒，头痛，继则呕吐甚急；次日发作惊厥，四肢抽动，神志不清，急送医院，经脑脊液化验检查，诊断为化脓性脑膜炎，收住院治疗。经过治疗症状不减，神志昏迷，项强抽搐。故请中医会诊。

〔望诊〕精神昏迷，牙关紧闭，撬开口方得舌诊，舌质绛、无苔。

〔闻诊〕呼吸急促。

〔切诊〕脉细数。

〔辨证〕外感风温，逆传心包，阴虚风动，心神被扰。

〔立法〕清营透热，开窍醒神。方用清宫汤。

〔处方〕元参心 4.5克 连心麦冬 4.5克 莲子心 1.5克
连翘心 3克 竹叶卷心 3克 犀角尖(磨) 3克
生 地 4.5克 钩 藤 4.5克 僵 蚕 3克
局方至宝丹一丸(分两次冲服)

二诊：1960年3月20日。前方服用一剂，抽搐渐止，次日下午神志清醒，体温 37.5°C ，今晨已能进饮食，惟精神不振，时欲睡，二便已知。舌红少苔。脉细滑。此为热退阴伤，再投以养阴扶正之剂。方用益气养阴汤。

〔处方〕生 地 6克 麦 冬 6克 元 参 6克
石 斛 3克 生 草 1.5克 沙 参 4.5克
西洋参 2.4克(另煎兑服)

〔病例分析〕本例为外感风温，故初则发热恶寒、头痛呕吐。迨热邪由表逆传心包，心神被扰，故神志昏迷；邪热内闭，故高热肢厥；热邪极易伤阴，阴虚风动，故见惊厥抽搐；舌降无苔，脉细数，均为热极伤阴之见证。以清宫汤清营透热，加钩藤、僵蚕以熄风，局方至宝取其开窍醒神以治昏迷。药后神清，风熄搐止，惟热退阴伤，精神不振；再以养阴扶正，以恢复精神。

〔例2〕脑膜炎后遗症

赵×× 男性 33岁 工人 初诊日期为1964年5月23日。

〔问诊〕患者于1960年9月患脑膜炎，发高烧，曾昏迷十余日始苏醒，醒后头痛如裂，身软无力，在××医院住院

治疗两个月。出院后头痛不减，痛的部位集中于右侧头部，并感头脑不清，不能用脑。以后头痛逐渐加剧，痛如刀刺，日夜不休，每夜痛醒多次，影响睡眠。头面右侧有汗出、左侧无汗，左半身逐渐出现麻木感觉，抚之冰凉，与右半身温度比较有明显差别。出院三年来，经常去原医院治疗。

最近检查，脑脊液细胞在100以上；白血球增多，其它正常。血管造影，无幕上肿状。

神经系统检查，颅神经正常。四肢躯干对称，运动正常。左侧三叉神经第一枝痛觉消失，温热觉正常。右侧正常，其它痛觉迟钝。跟腱反射正常，膝腱反射(-)。诊断为“脑膜炎后遗症(大脑萎缩)”。

另外，患者于1962年曾患过肝炎，现化验，肝功能基本正常，但仍饮食不佳，大便时干时溏。

〔望诊〕形体消瘦，舌质淡红，苔白厚而腻。

〔闻诊〕语言正常，口臭明显。

〔切诊〕脉弦滑。

〔辨证〕病始于湿热蒙闭清窍，热邪伤阴，肝风内动，上扰清空。热退后余邪未净，脉络被阻，以致半身麻木。

〔立法〕平肝清热，熄风通络。方用平肝熄风通络饮。

〔处方〕生石决明 30克 白蒺藜 10克 佩兰叶 10克
石菖蒲 6克 郁金 6克 石斛 12克
滑石块 10克 钩藤 10克 明天麻 10克
杭菊花 10克 橘络 10克 宣木瓜 10克
羚羊粉 0.6克(分两次冲)

二诊：1964年6月4日。前方服用六剂，头痛次数减少，程度也减轻，每日仅痛1~2次，每次痛1~2小时，睡

眠安稳。左侧腰胯有汗出，左半身有串麻感觉。舌质淡红，舌苔根厚。前方加酒地龙 10 克继服。

前方继服十三剂，头痛程度又减轻，左侧上下肢仍感麻凉。舌苔微黄，脉沉滑。仍以前方加减。

〔处方〕 生石决明 24 克 白蒺藜 10 克 龙胆草 6 克
炒山栀 6 克 细生地 15 克 黄芩 6 克
泽泻 10 克 当归 10 克 川芎 6 克
钩藤 10 克 全蝎 10 克 僵蚕 6 克
天麻 6 克 羚羊角粉 0.6 克(分两次冲)

上方继服八剂，头痛已不明显，左侧肢麻已明显减轻，睡眠安好。至 1964 年 8 月 10 日停药观察。

〔病例分析〕本例于三年前患急性脑膜炎，曾昏迷十数日。当时为邪热蒙闭清窍，热退神清，醒后头痛如裂，乃热退阴伤，余邪未净，肝风内动，上扰清空，邪不解，渐致经络被阻，随使左半身麻木、无汗，抚之冰凉。初诊时舌苔白腻而厚、口臭，说明湿浊尚重，虽为高热伤阴所引起，但在此湿浊尚重的情况下，不用滋腻之品养阴，仅用石斛一味养阴而不致恋邪。湿浊虽盛但不用苦寒之品以燥湿，仅用佩兰、菖蒲、郁金芳香化浊，滑石淡渗利湿，石决明、白蒺藜、钩藤、天麻、菊花、羚羊角平肝熄风，橘络、木瓜除湿通络。药后头痛减轻，左半身已有串麻的感觉，说明络脉有欲通之势，故左侧腰胯间有汗出。在此基础上再加酒地龙增强通络作用，连服十三剂，舌苔白腻已退，而现黄苔。说明湿浊已化而呈现出热象。此时改用清肝热之龙胆泻肝汤，去柴胡改用川芎，因柴胡升提，横走胸胁，而川芎能上至巅顶旁彻四肢，与当归配伍能和血通络。再加石决明、白蒺藜、钩藤、

全蝎、僵蚕、天麻、羚羊角平肝熄风通络，继服八剂症状明显减轻，经治两个半月症状消失，停药观察。三年零八个月的脑膜炎后遗症得以痊愈。

第九节 流行性乙型脑炎引起的精神障碍

流行性乙型脑炎，亦称“夏秋脑炎”，或“蚊性脑炎”（以下简称乙脑）。传染媒介为蚊类。此病流行季节为七、八、九三个月，是蚊子孳生最旺时期。15岁以下儿童最易感染此病，成年人发病率则较低。

此病病起急剧，开始先出现头昏、头痛、高热、嗜睡、疲乏无力、懒语、呕吐等症状，幼儿可有抽搐发作，持续1~3天即进入昏睡或昏迷状态。个别病人在发病开始即出现意识朦胧状态，定向力丧失，行动无目的，胡叫乱喊，表情茫然。

一般人特别是儿童患此病，在昏迷状态时可出现一些神经系统障碍，如肢体偏瘫，眼肌麻痹，手足徐动，舞蹈样动作，癫痫样发作等，轻者，意识混浊或昏迷数日可恢复正常；严重者可由昏迷而死亡，即使不死亡也常留有严重的后遗症。成年人患者出现上述现象是可逆的，实质上是属于传染性谵妄或传染性幻觉症。

幼儿或儿童患此病，神经精神障碍较多，以痴呆症候群较为多见，常见于乙脑后期，有时持续很久，或残留难以恢复正常。近年来用中西医结合治疗，后遗症显著减少。

乙脑后遗症，多数表现为思维迟钝、语言紊乱或少语、口吃或语音不清、情绪不稳、易哭闹或表情淡漠。此病对儿

童可引起各种不同程度的精神发育障碍和性格改变；有性格改变的病人，智力虽无明显障碍，但会变得自私，容易记仇，好攻击人，情绪不稳，兴奋不安，或行为孤僻；也有的变得轻浮，举动随便，性的意向增强，偷窃或说谎话等。

由于乙脑起病急剧、症状险恶，死亡率也较高，因此，将本病作为重点讨论。

一、关于乙脑的分型

根据中医历年治疗乙脑的经验，一般分为三型：

(一) 轻型

头痛发热(体温在 39°C 以下)，口燥咽干，有时伴有轻度呕吐或嗜睡，但神志始终保持清醒，无昏迷、惊厥、抽搐等症状；脉浮而有力。

(二) 重型

头痛剧烈，发热(体温在 40°C 左右)恶寒，口渴咽干，渴思凉饮，小便不利，头汗尤多，同时伴有浅昏迷及惊厥等症状，脉沉数者。

(三) 极重型

头痛项强，角弓反张，高热(体温在 40°C 以上)齿燥，舌干无津，完全进入昏迷状态，持续抽搐或四肢厥冷，脉沉伏促结者。

二、乙脑的主要症状

(一) 高热

无论幼儿或成年患者，都有发热的症状。发热持续的日期，过去一般认为七天左右，如果经过适当治疗，三、四天

即可退烧(如果早期治疗得当,还能更快退烧)。热度减退绝大多数呈梯型下降。

(二) 昏迷

昏迷是乙脑的重要症状之一,多出现在发病的第2天或第3天,昏迷出现越早,其死亡率越高。昏迷出现在发病的第4~5天之后的患者,绝大多数不致有生命危险。成年患者出现昏迷,在程度上比儿童更为险恶。

(三) 惊厥

惊厥多出现在发病后的2~5天;由于惊厥而死亡者,多在惊厥出现后的2~3天内死亡。如果惊厥持续时间超过4~5天,多能逐渐好转。儿童出现惊厥症状的,较成年人多见。

总之,昏迷和惊厥都是乙脑的主要症状。仅呈昏迷而无惊厥者,标志着病势最重,其死亡率也最高;有昏迷而兼惊厥者,其病势次之;仅呈惊厥而无昏迷者,死亡极少。至于昏迷和惊厥全无者,则未见引起死亡的。因此,昏迷和惊厥的有无,常常是衡量疾病轻重和预后良否的标志。

三、治疗乙脑的法则

根据乙脑的发病季节和出现的症状,有许多是和温病中的“暑温”、“暑风”、“伏暑”、“湿温”等病相同的。因此,依据治疗暑温、暑风、伏暑、湿温的理论治疗乙脑已获得显著疗效。根据长期的临床实践,治疗乙脑的主要法则为清热,解毒,养阴三法。大抵在发热初期,邪势方盛,正气充实,应以祛邪为主,宜清热解表;同时要注意到热邪伤阴的可能性。当疾病处于发展阶段,邪气弛张,出现正气不支的时候,应当

着重清热、解毒，兼顾养阴。迨至病势已衰，正气疲惫，当以扶正为主，但也要注意清理余邪。

四、不同症状乙脑的治疗方法

(一) 高热乙脑患者的治疗

乙脑病人均有发热症状。可以根据发热的高低判定病势的轻重。大凡高烧在 40°C 以上且持续不退者，往往出现昏迷、惊厥等严重症状。凡是体温在 $38^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ 之间者，病势就较轻。个别病人，如身体虚弱抵抗力差，只出现低烧，但其它症状严重也可出现深度昏迷、浅表呼吸、口唇发绀等，绝不可因为热势轻而忽视其危险性。

乙脑患者，在初期存在着有无表症的问题；到极期则存在着有无里滞的问题；到恢复期则存在着正气虚实的问题。观察病人在初期有无表症，应当注意病人是高烧无汗，还是汗出甚多。对无汗者可微微发汗，但不可使之大汗淋漓；汗出甚多者，应使之汗出有节，防止汗多伤津，甚致亡阴；这是治疗乙脑的一个关键。大抵病起一到三天内，常有发热、无汗、头痛、项强、呕吐等症，此时舌苔多为薄白而润，脉象多为浮数或浮滑，这是邪在卫分或气分，宜用银翘散或桑菊饮酌加香薷、藿香、佩兰、竹茹等治之。如见壮热有汗，口渴引饮，烦躁不安，舌苔黄燥，脉洪而数，应以辛凉重剂白虎汤加银花、连翘、竹叶，芦根等治之。如有正不胜邪，元气外脱者，其症表现为肢厥身冷，目瞪口呆，鼻翼扇动，汗出如珠，体温突降，呼吸迫促，脉象促急或散乱者，是虚脱之象，急宜生脉散、三甲复脉汤频服。亦可专用独参汤护阳固脱。

此外，尚有内闭外脱合并出现者，一方面由于热邪伤阴耗气太过，酿成大虚将脱之势；另一方面因为邪热内陷，气阻阳明，出现神昏谵语、气息短促，或手足厥冷、冷汗自出，或烦躁不安、扬手掷足、舌红起刺、欲伸无力，脉沉细数、或促或伏，这是正虚邪实、虚实夹杂的内闭外脱之证。此时不可专顾外脱，亦不可专开内闭，必须内外兼顾，宜炙甘草汤加入参、牛黄清心丸，以固脱开闭。

及至表症已解，里滞又结，证见腹满而胀，口臭矢气，大便秘结，舌苔黄垢，脉弦而实者，可酌用凉膈散、承气汤或紫雪丹，一下而热度顿逝。若患者已度过极期，症状都已缓解，惟有余热未净，这时病人表现大便干秘，小便短少，口燥心烦，脉数无力，这是邪祛正伤、阴虚内热之故，可予青蒿鳖甲汤、增液汤或五汁饮之类以养阴清热。如果舌苔白腻，脉象滑数，大便稀溏，胸闷头重，食欲不振，为余邪与湿热未尽之征，可予清络饮或薏苡竹叶散之类以善其后。

（二）昏迷乙脑患者的治疗

昏迷多见于重型或极重型的乙脑病人，是一种病情严重的征象。成年人出现昏迷比儿童尤为险恶。昏迷常在发病第二、三天出现。昏迷出现越早，其死亡率越高。如能及时治疗，经五、六天大多能逐渐好转。根据临床观察，患者早期出现昏迷，一般伴有高烧（40℃）；如果高烧消退，昏迷也多数随之缓解。可以说高烧与昏迷是有其因果关系的。昏迷程度的深浅，是病情轻重的主要标志。大抵昏迷程度有以下三种。

轻度：患者多嗜睡，一般伴有发烧，神志模糊，没有明

显意识障碍与错觉。

中度：患者由嗜睡转入昏睡，呼之虽能答应，但意识明显障碍。一般伴有高烧、谵语、抽搐、烦躁不安等症。

深度：患者完全进入昏迷无知的状态，呼之不应，一般伴有高烧肢厥，牙关紧闭，或二便失禁，或大便秘结、尿潴留等现象。

昏迷乙脑患者的预后，一般是深度者不良，中度者次之，轻度者较好。

治疗昏迷的乙脑患者，也应本着清热、解毒、养阴之原则，佐以芳香开窍之药物。一般采用清瘟败毒饮、紫雪丹、安宫牛黄丸等随证施治。

若发热头痛、嗜睡、骨节痠痛、烦躁不安、便秘口渴等有表里症者，可用双解法，如加味凉膈散。病势重者，用清瘟败毒饮。昏睡不醒者用清宫汤。

若高烧、昏迷、谵语、躁狂、弄舌者，用清瘟败毒饮加大青叶、菖蒲、郁金、莲子心等。如伴有惊厥、抽搐者，酌加全蝎、钩藤、蜈蚣、天麻、地龙、石决明、羚羊角等。

若烧退而仍昏迷者，宜芳香开窍、养阴清心。用局方至宝丹及苏合香丸，加生地、元参、栀子、麦冬、甘草、黄连、竹叶、天竺黄、石菖蒲等。

（三）惊厥乙脑患者的治疗

惊厥多见于重型及极重型的病人。惊厥一般在发病两、三天或更早出现，这是惊厥程度最高阶段，如能及时治疗，维持四、五天，惊厥大多可逐渐停止。

据临床观察，高烧是产生惊厥的主要原因，而惊厥又常是昏迷的前驱症状，惊厥的出现，常预示昏迷的来临。小儿

患乙脑，其病程一般是高烧——惊厥——昏迷。惊厥症状，在乙脑患者中的发生率是很高的。但从预后的结果来看，惊厥对于生命的威胁较昏迷为轻。临床证明，单独出现惊厥而无昏迷者，预后较佳；惊厥而兼昏迷者，其势险恶。

惊厥的程度及其表现，也是有不同的。大抵病人出现项强时，便当估计惊厥的到来。惊厥按其性质可分为三种：

强直性：此种惊厥多出现于高烧(40℃以上)的病人，可突然发作，四肢、颈项强直，角弓反张，牙关紧闭，唇舌可被咬破，时发吼声，持续不停；待至抽搐停止后，颈项四肢仍有强直者，此类病人最容易留有后遗症。

阵发性：此种惊厥多出现于高烧、嗜睡病人，一有震动就四肢痉挛、两目上吊，唇舌颤动，口吐涎沫；发作1~3分钟，逐渐停止，四肢如常。此类病人多不留后遗症。

颤搐性：此种惊厥成人较为多见，表现为眼球、口唇及手足徐徐颤动，时作时止，表情苦闷。如果烧退抽止，神志仍不清者，其势最为险恶。

对于有惊厥症状的乙脑患者，其施治原则是根据“热极可以生风，热解则风自熄”的理论，在出现高烧时，即当清热解毒，热解则痉自止，可用钩藤熄风散；如痰涎壅盛者，酌加胆星、天麻、川贝母、杏仁、天竺黄、竹沥水、法半夏、橘红、枯萎、鲜菖蒲等。热退后如仍微抽不已，应当考虑正气的亏耗部位而辨证施治。如脾阳虚而抽风者，酌加四君子汤；如阴虚风动者，可酌用三甲复脉汤，或大、小定风珠汤等；如热势已退，但头部微胀、视物不清者，可用清络饮以祛余邪。

五、病例介绍

〔例1〕乙脑急性期（本例摘自北京市1956年中医治疗乙脑总结）

赵×× 男性 20岁 会诊日期为1956年8月19日。

〔问诊〕患者于前日发病，头痛，身疼，恶寒无汗，发热，呕吐绿水；继则神志昏迷，牙关紧闭，手足厥逆，于昨日收住院治疗。

〔检查〕体温40.6℃。神志昏迷，二便失禁。营养发育良好，心肺正常，肝脾不大，瞳孔对光反射（+），颈项强直，克氏征（+），腹壁反射消失，提睾反射弱阳性，膝腱反射（+），巴氏征（+）踝阵挛（+）。

〔化验〕血象：红血球400万，白血球13110，分类：中性78%，淋巴19%，单核3%。脑脊液：细胞331；分类：中性多核66%，单核34%，糖1~5管（+），潘弟（±）。

〔临床诊断〕流行性乙型脑炎。

〔望诊〕呈急性病容，神志昏迷，烦躁不安，舌质红，舌苔白微黄。

〔闻诊〕问之不语。

〔切诊〕脉沉数有力。

〔辨证〕暑温夹湿，表邪未解，湿热蒙闭清窍。

〔立法〕辛凉解表，芳香开窍。方用清瘟败毒饮加味。

〔处方〕生石膏120克 鲜芦根30克 薄荷4.5克
白僵蚕10克 嫩桑枝20克 辛荑10克
杭菊花15克 忍冬花30克 竹茹10克
连翘12克 鲜菖蒲30克 莲心4.5克

鲜藿香 10克 鲜佩兰 10克 滑石 12克
鲜荷叶 30克 生知母 10克 黄柏 10克
羚羊粉 1克(冲服) 犀角粉 1.5克(冲服)
局方至宝丹两丸(和人)

水煎 400 克，分四次服，每四小时一次。

二诊：1956 年 8 月 20 日。昨日服药后，周身汗出，手足已返温，体温 39.2°C ，神志清醒，但仍有嗜睡现象，自述头身已不痛，呕吐已止，食欲欠佳，舌苔白腻。脉滑数有力。再以前方加减，继服两剂。

8 月 22 日，服药后一切症状消失，能下床行动，脉滑缓，体温 36.8°C ，停药观察，痊愈出院。

〔病例分析〕本例患者发病第二天出现重型症状，高烧 (40.6°C)，神志昏迷，当时辨证为暑湿夹湿，因有恶寒无汗，头、身痛，为表邪未解之征，其所以昏迷为湿热蒙闭清窍所致。表证既存，当以辛凉解表为先，用薄荷、忍冬花、连翘、菊花、鲜芦根，乃桑菊饮、银翘散之意。此时不重用生石膏，不足以清热。鲜菖蒲、鲜藿香、鲜佩兰清暑化湿，芳香开窍。荷叶、辛夷清轻上浮，上至巅顶直达入脑。莲心配犀角以解心热，用局方至宝开窍醒神，以治昏迷。羚羊粉、僵蚕平肝熄风，以防惊厥。知母、黄柏益肾水、泻相火，为釜底抽薪之法，且知母配石膏乃辛凉重剂白虎汤之意。黄柏苦寒，清热燥湿与滑石淡渗利湿之品配伍，利湿而不伤阴。全方配伍得当，服药后高热呈梯形下降，症状逐渐减退，最后以养阴存津法以清余邪，而使症状完全消失。

〔例 2〕“乙型”脑炎后遗症

盛×× 男性 25岁 未婚 洛阳××研究所技术员

初诊日期为1963年11月27日。

〔问诊〕患者于1962年9月突然高烧，体温在40℃以上，神志昏迷，抽搐，经洛阳××医院抽脑脊液化验检查，诊断为流行性乙型脑炎，当时住院，经中西医结合治疗，十几天后体温恢复正常，遗有精神痴呆，一个多月不能讲话，以后虽能说话，但语音不清。住院六个月诊断为流行性“乙型”脑炎后遗症，因无特殊治疗方法而出院。

现在症状为精神痴呆，终日呆坐，有时痴笑或哭闹，两手常做无意识动作。对家属及周围人不能辨认，少语，强问之下答问不正确，语音不清。少眠，昼夜不分，常夜间外出奔走，两足跛行，足跟不能落地，足跟落地则身向后倾欲跌倒。生活不能自理，饮食、大小便均需别人照料。

〔望诊〕精神痴呆，双目直视，不时痴笑。舌质淡红，少苔，舌中心沟裂。

〔闻诊〕语音不清，不能正确答问。

〔切诊〕脉沉细数。

〔辨证〕热邪伤阴，蒙闭清窍，热虽退而阴未复，清窍不宣，神明无主。

〔立法〕养阴清热，宣通清窍，以安神明。方用清营汤加减。

〔处方〕元 参 10克 丹 参 10克 麦 冬 10克
生 地 15克 石 斛 12克 沙 参 12克
莲子心 3克 竹叶卷心 6克 连翘心 6克
生知母 6克 石 菖 蒲 6克 甘 草 3克
干荷叶 10克 局方至宝丹 一丸

二诊：1963年12月7日。前方加减服用八剂，睡眠安

稳，每夜能熟睡 7~8 小时，昨日入睡前自己知道脱衣，今晨起床也能有次序地穿衣服。有人领着唱歌也能连续歌唱两、三句，有时听到音乐声，有伤感的表情。有时能主动发问。前日外出半小时，自行归来。昨日本单位来一同志探视，患者表现有感情，能叫出同志的名字。舌质红，舌碎裂已减少变浅，脉沉细。再以前方加减。

〔处方〕 珍珠母 24克 元 参 10克 丹 参 10克
远 志 10克 石菖蒲 6克 生 地 18克
白 芍 12克 石 斛 10克 钩 藤 10克
郁 金 10克 荷 叶 10克 炒山栀 6克
杭菊花 10克 麦 冬 10克
琥珀末 1.5 克(分冲) 羚羊粉 0.6 克(分冲)

三诊：1964 年 1 月 7 日。前方加减服用 12 剂，患者近两周逐渐关心周围事物，并感兴趣，主动发问。下跳棋时能考虑对策，战胜对方。能计算多位乘除法算术，看电影或看戏剧能理解内容，但不能综合联系，记忆不够巩固；有人提醒后尚能回忆。今日下雪，自己知道换上棉鞋。在车站遇见同事，能叫出姓名，并主动握手，表情激动，眼中含泪。今日就诊时让患者书写，字迹清晰，词句准确。舌质淡红，少苔。脉细滑。在前方的基础上加重开窍之品。

〔处方〕 生 地 30克 元 参 10克 丹 参 10克
石 斛 24克 麦 冬 15克 连翘心 10克
竹叶卷心 6克 龟 板 12克 阿 胶 10克
杭 菊 花 10克 荷 叶 10克 天竺黄 10克
石 菖 蒲 10克 苏合香丸两丸(分服)

四诊：1964 年 1 月 19 日。前方服用六剂，经过门诊治

疗50余日；精神症状逐渐好转，尤其以定向力和智能方面恢复明显，记忆力有一定的恢复。患者近日欲返回洛阳，为了巩固疗效，配制丸剂服用。

〔处方〕生龙骨 90克 熟地 60克 炙龟板 24克
丹参 30克 元参 30克 人参 12克
甘草 15克 五味子 18克 远志 30克
菖蒲 24克 麦冬 60克 当归 30克
茯神 60克 炒枣仁 45克

共研细末，炼蜜为丸，每服10克，一日两次，早晚服。

六、治疗体会

本节对于乙脑及其后遗症的辨证施治作了重点讨论。临床证明，高烧、昏迷、惊厥是本病的三大特征。特别是高烧一症，几乎是百分之百的患者都有；而其余各症，多是高烧所引起的。由于热邪伤津，所以在治疗上，首先突出清热、解毒、养阴三法，但在施治当中应有所侧重。一般在高烧初起阶段，应偏重于解表清热，而稍兼养阴。在中期阶段，由于热伤津液，应偏重于养阴解毒。在表里热盛出现昏迷、惊厥等症状时，应于清热、养阴、解毒的同时兼用清心开窍法，如安宫牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹等，都可选用。后期阶段，正气衰弱，邪气残留，意识模糊，表情淡漠，应予芳香开窍，扶正祛邪，如苏合香丸，至宝丹加四君子汤以及复脉汤等。

根据临床体验，当本病发生后，如能及早治疗和治疗得当，不仅能避免精神障碍，而且能防止后遗症。不过有的病

人，初期阶段短暂，容易被人们忽视，来不及治疗便很快进入危重阶段而出现精神症状。也有的病人，由于在初期阶段治理不当而导致病情加剧。因此，本病精神障碍的出现，与早期的失治或误治是有一定关系的。

七、附 方

为方便读者，将治疗乙脑的有效方剂附列于下，以便于读者临床上参考。

(一) 桑菊饮

桑 叶 菊 花 杏仁泥 连 翘
甘 草 苦 梗 薄 荷 芦 根

加水二杯，煎取一杯，日两服；若二、三日不解，气粗似喘，燥在气分者，加生石膏、知母。舌绛，暑热甚燥，邪初入营者加元参、犀角。邪在血分者去薄荷、芦根，加细生地、麦冬、玉竹、丹皮。肺热甚者加黄芩；渴者加天花粉。

(二) 银翘散(银翘解毒丸方同)

连 翘 银 花 苦 梗 竹 叶
生 草 荆芥穗 淡豆豉 牛蒡子
鲜芦根

勿过煎，肺气取轻清，过煎则味厚而入中焦矣。病重者四小时服一次，日三服，夜一服。轻者六小时服一次，夜一服。病不解者继服。

(三) 白虎汤

生石膏 知 母 生甘草 梗 米

加水八杯，煎取三杯，温分三服。病不减再服。

(四) 清瘟败毒饮

生石膏 小生地 乌犀角 川 连
梔 子 桔 梗 黄 芩 知 母
赤 芍 元 参 连 翘 甘 草
丹 皮 鲜竹叶

先以清水煮石膏数十沸，后下诸药，犀角磨汁和服或为末冲服。如见发斑加大青叶，少佐升麻，引毒外透。

(五) 清宫汤

莲子心 竹叶卷心 连翘心 犀角尖(磨冲)
元参心 麦冬连心

清水煎服，若痰热盛加竹沥，梨汁各五匙。咯痰不清加栝蒌皮。渐欲神昏加银花、荷叶、石菖蒲。

(六) 清络饮

鲜荷叶边 鲜银花 西瓜翠衣 鲜扁豆花
丝瓜络 鲜竹叶卷心

加水二杯，煎取一杯，日二服，凡暑伤肺经之气分轻症，皆可服用。

(七) 钩藤熄风散

钩 藤 羚羊角 全 蝎 蜈 蚣
地 龙 僵 蚕 龙胆草

(八) 安宫牛黄丸(成药)

每次一丸，小儿减半。病重体实者日再服。脉虚者人参汤送服。脉实者银花、薄荷汤送服。兼治卒厥、尸厥、五痫、中毒。

(九) 紫雪丹(成药)

水调，每服一到二钱。

(十) 局方至宝丹(成药)

每次一丸，小儿减半。

以上三药俗称三宝，是治温热重症必不可少之药。大抵安宫牛黄丸最凉，紫雪丹次之，局方至宝丹又次之，主治各有所专，宜临时斟酌使用。

(十一) 苏合香丸：(局方成药)

每服一丸，小儿减半。

(十二) 生脉散

人参、麦冬、五味子用长流水煎汤，不拘时温服。

(十三) 四君子汤

人 参 白 术 茯 苓 甘 草
生 姜 大 枣 水煎服

(十四) 三甲复脉汤

生鳖甲 生龟板 炙甘草 干生地
生白芍 麦 冬 阿 胶 麻 仁
生牡蛎

加水八杯，煮取三杯，分三次服，病剧者日三次，夜一次。

(十五) 独参汤

人参 30克 水大煎，不时温服。

(十六) 炙甘草汤

炙甘草 桂 枝 生 姜 人 参
阿 胶 大 枣 麻 仁 麦 冬
生地黄

水酒煎服，每日三次。

(十七) 凉膈散

大 黄 芒 硝 连 翘 黄 芩

甘 草 薄 荷 梔 子

(十八) 大承气汤

大 黄 芒 硝 枳 实 川 朴

加水四杯，先煎枳实、川朴，取二杯去渣再煮大黄，取一杯去渣纳芒硝，火上微沸，分两次服，得下勿再服。不下再作服，以下为度。

(十九) 青蒿鳖甲汤

青 蒿 鳖 甲 生 地 知 母
丹 皮

加水五杯，煮二杯，日再服。

(二十) 五汁饮

梨 汁 荸 荠 汁 鲜 芦 根 汁 麦 冬 汁
鲜 藕 汁

多少临时斟酌和匀冷服。不愿冷服，温服亦可。

(廿一) 增液汤

元 参 麦 冬 生 地

加水八杯，煮取三杯，口干则与令饮尽，不下再服，以下为度。

(廿二) 薏苡竹叶散

薏 苡 竹 叶 飞 滑 石 连 翘
白 薏 仁 茯 苓 通 草

(廿三) 小定风珠

生 鸡 子 黄 真 阿 胶 生 龟 板 淡 菜
童 便

加水五杯。先煎龟板、淡菜，得二杯去渣，入阿胶烱化，纳鸡子黄搅匀，再冲童便顿服。

(廿四) 大定风珠

生白芍 阿 胶 生龟板 干生地
麻 仁 五味子 生牡蛎 麦 冬
炙甘草 鸡子黄 鳖 甲

加水八杯，煎取三杯去渣，再入鸡子黄搅匀分三次服。
喘加人参，自汗加龙骨、小麦。心悸加茯神、人参、小麦。

第二章 神经性梅毒

梅毒一症，我国原来没有，是从外国传入的。因首先发现于广州，故俗称广疮。《医宗金鉴》有治疗记载，原名为杨梅。《中国医学大辞典》记载：“梅毒者，乃杨梅结毒之简称。有杨梅结毒之上窜头顶者，此证因患梅毒疮方炽，误服水银升炼悍燥劫药，希图速效。其疮痂尽落，一时侥幸而愈，不知遗害久远，引毒潜藏骨髓关窍之中，其毒积久外攻，以致结毒倒发。其始先从筋骨疼痛，随外结肿，皮色如常，将烂时色方紫红，腐臭不堪，以致脑顶塌陷，腮唇鼻梁损坏，穿喉蚀目，手足拘挛，终成痼疾，法以解毒为主，虚弱者兼补之……”自清以后，多用汞制剂，如“轻粉”和“三仙丹”等治疗，虽对早期梅毒收效快，但有使毒邪稽留深入，成为隐性梅毒，数年后侵犯脑组织，致成脑梅毒而出现精神症状。中医书中对脑梅毒的精神症状描述甚少，但梅毒犯脑之说已被证实。

解放后，在党和人民政府的领导下，新中国彻底废除了娼妓制，消除了梅毒的传染场所；卫生部门又大规模地进行梅毒防治工作，梅毒已被控制，晚期隐性神经性梅毒的发病率也大为降低，早期梅毒在我国已经绝迹。

神经性梅毒的类型很多，但属于精神病范围的主要有脑梅毒和麻痹性痴呆两种。

脑梅毒和麻痹性痴呆的临床表现和病程差异很大。但

是，要鉴别它们和其它精神障碍的不同往往是困难的。所以，在诊断本病时，除结合临床表现及病程等来考虑外，了解患者的血清反应和有无梅毒史、冶游史则是十分重要的，如血清为阳性反应和有过梅毒史、冶游史，则可确诊。

第一节 脑梅毒

脑梅毒主要损害脑膜和脑血管。脑实质虽然也会受到一些损害，但都是继发性的。由于病变的性质和部位差异很大，并且同一个病人可能发生很大变动，所以临床症状复杂多变和病程较长，就成为它的一个特点。但是，以脑膜炎性病变为主的和以血管病变为主的病例，其临床表现则很不相同。因此，目前一般是将病理变化和临床特征结合起来将脑梅毒区分为若干型。

一、脑梅毒的类型及其临床表现

(一) 梅毒性神经衰弱

其临床表现具有神经衰弱症候群。如头昏，头痛，失眠，容易疲劳和容易激动，注意力不集中，记忆力减退，并由此而产生焦虑感等。

(二) 早期梅毒性脑膜炎

其起病多较急骤，可能伴有发热。主要症状有三种：

其一为脑膜刺激症状，如头痛，颈项强直。

其二为急性期引起的症状，如不同程度的意识障碍，尤以谵妄状态为常见。

其三为神经系统局限性症状，因炎变主要涉及脑底部，所以常见第2、3、6、7、8等脑神经损害的症状。有时病变侵及颅顶部的脑膜，则可出现易激惹，精神迟钝，暂时的失语症或言语困难等，也可能出现癫痫发作。

(三) 血管型脑梅毒

病变主要限于血管。如果侵犯较大的血管，主要为局灶性神经症状，有卒中发作。其精神障碍主要是局限性痴呆，记忆障碍较重，而理解障碍较轻。卒中发作一次，则痴呆加重一层；若卒中多次发作，最后必致严重痴呆。如果小血管损害，则没有明显的局灶性症状，其临床表现基本为痴呆。在痴呆的背景上，往往出现意识障碍，幻觉妄想状态，紧张症等。总的说来，痴呆是进行性的。

(四) 脑膜血管梅毒

其脑膜除有慢性炎变外，还有某些大小血管的损害。同时，脑实质往往有或多或少的损害。脑膜血管梅毒，可依其精神障碍的特点，再分若干型，每型都具有神经系统局限性损害的症状，并且都有导致痴呆的倾向。

其一为梅毒性假性麻痹：其表现与麻痹性痴呆相近似。

其二为幻觉妄想性脑梅毒：以幻觉妄想为主要内容。

其三为其它类型：在脑膜血管梅毒的病程中，可能出现各式各样的精神障碍，有时可达精神病的程度，如谵妄状态，躁狂状态，抑郁状态，紧张症等。

二、病例介绍

王×× 男性 45岁 已婚 机关干部 初诊日期为

1964年6月3日。

〔问诊〕患者在青年时有冶游史，于23年前(1941年)感染过梅毒，当时曾经××医院连续注射“914”药针，症状减轻，但未彻底痊愈。1947年病又发作，服中药轻粉驱梅剂，仍未彻底痊愈。此后经常头晕、头痛、视力减退，继则左目失明。于1954年发现精神异常，出现夸大妄想，言语荒谬，乱说乱走，情绪不稳定；时而激动发怒或哭泣，时而情绪高涨而欣快，手舞足蹈；兴高彩烈等症状。经××医院诊断为“脑神经梅毒”，经治疗精神有所好转，但经常前额抽痛、耳鸣、眩晕、心慌，记忆力衰退，仍有妄想、多语、情绪易于激动、夜眠多梦、舌不能向外伸、左足震颤等症状，饮食二便尚正常。

〔望诊〕精神呆板，左目失明，左足震颤，舌颤不能向外伸。舌质淡红，舌苔白。

〔闻诊〕语言多，音尚清晰。

〔切诊〕脉象沉细。

〔辨证〕梅毒犯脑，久病正虚。

〔立法〕驱梅扶正。方用驱梅汤1号。

〔处方〕土茯苓 30克 金银花 12克 防风 6克
白藓皮 10克 宣木瓜 10克 当归 6克
人 参 3克 木 通 3克 皂荚子 3克

前方连服八剂，头已不痛，仅感颈后肌肉有时抽动，眩晕耳鸣也减轻，夜眠安稳，精神好转。舌虽颤已能向外伸，舌脉同前，患者近日欲回云南，将前方改用丸剂继续服用。

1965年5月24日，患者家属来医院代诉，患者经过前次治疗，症状显著好转，现已能做一般工作。患者要求继续服

丸药巩固疗效。仍予前方加减继服。

第二节 麻痹性痴呆

麻痹性痴呆，是最严重的疾病之一，乃由梅毒螺旋体侵入脑膜、脑实质所引起慢性炎变的结果。由于炎变不断发展和日益加重，除使人格逐渐改变和出现痴呆现象外，还能引起各种麻痹及躯体方面的病症。故而称为进行性麻痹或全身性麻痹。

麻痹性痴呆的潜伏期较长，一般在感染梅毒的5~25年之间，平均约为15年，因此，病人多在中年以后发病；据统计，此病患者中31~40岁的人占2.5%，41~69岁的占68%；其中男性与女性患者的比例为8:1。

一、临床表现

(一) 精神症状

麻痹性痴呆的主要特征是进行性痴呆，其发展情况，有以下几个阶段：

1. 初期阶段

起病隐渐，发展缓慢。开始多表现为神经衰弱症候群，病人常常诉说易于疲劳、头晕、头痛、睡眠不佳，记忆力减退、注意力不集中；患者情绪有时抑郁寡欢，但又容易激惹，往往容易误诊为神经衰弱。

这时患者在智能方面也有所改变，表现为工作能力差，工作效率低。病人的判断力和理解力也有所减退，对错误不能批判，思维活动比较迟钝，但低级意向(食欲、性欲)都有

所增强。

2. 发展阶段

病情持续发展，精神障碍日益明显，最突出的是人格的改变，如对工作敷衍塞责，缺乏责任感；有的变得态度轻浮，放荡不羁，滥交异性朋友，经常酗酒，到处游荡，举止粗野，行动暴戾；有的变得极端自私，挥霍无度，只图个人享受，不顾家庭困难，甚至做出一些违反社会秩序的事情。

这时智能方面的缺损日益明显，记忆力、判断力、计算力、理解力及综合能力的损害尤重。可出现不同的妄想，以夸大妄想更为多见。妄想的内容非常荒谬，多片断而杂乱，缺乏系统性和固定性，常因暗示的影响或随情绪的变化而改变或转移。情感也不稳定，有的表现兴奋，言语增多，情绪高涨，欢乐和欣快；有的表现情绪低落，意志消沉；有的表现哭笑无常。

3. 晚期阶段

此期智能损害极为严重，痴呆更形明显。言语零散，含糊不清，对事物缺乏兴趣，高级精神活动几乎消失，而低级本能活动(食欲)则有所亢进。由于痴呆的日益加重，日常生活多不能自理，可出现严重的意识障碍。

(二) 神经系统及躯体症状

发病早期，病人常有头痛、头晕、感觉过敏或感觉异常等症。晚期则感觉减退或消失。

瞳孔的变化是本病的重要体征。病人瞳孔两侧大小常不相等，一般多为缩小，形状和边缘也不整齐，瞳孔对光的反射迟钝或消失；视力显著减退，并常有原发性视神经萎缩。由于动眼神经的损害，常出现两侧上睑下垂，而眼轮匝

肌的不全麻痹则使眼裂变宽。由于面肌的不全麻痹，病人面孔显得呆板面毫无表情。舌下神经有不全麻痹，当伸舌时偏向一侧。

言语障碍，是本病另一重要症状。病人构音困难，发音不清，好象“大舌头”。还可能发生运动性失语症。

当病情发展严重时，可产生卒中及痉挛性抽搐，反复发作可使病情恶化并导致死亡。

发病晚期，由于膀胱及肛门括约肌的功能障碍，病人常有大小便失禁、尿潴留、膀胱炎及膀胱膨胀等现象。由于代谢机能障碍，不能很好地吸收营养物质，以致躯体消瘦，衰竭现象日益加剧。如长期卧床，容易产生肢体挛缩、褥疮、败血症、肺炎等合并症。

二、临床分型

本病在临床上还有其不同的特征，预后特征，综合起来可归纳为以下几型：

（一）夸大型（躁狂型）

其特征是情绪高涨，表现为欢乐和欣快，容易激惹。运动性兴奋表现得异常活跃。思维活动增快，有鲜明的夸大妄想，与躁狂忧郁性精神病躁狂状态相类似。本型预后较佳。

（二）痴呆型

本型最为常见，其特征是发病缓慢，但不断发展，智能的缺损和痴呆现象最为显著，思维活动迟钝，寡言少语，情感淡漠，表情呆板，动作呆滞，对于周围事物缺乏兴趣。本型预后较差。

（三）妄想型

本型以迫害妄想最为突出，情感淡漠，有时可因妄想的影响而有恐惧表现，因而引起行为异常。与精神分裂症妄想型相类似。

(四) 抑郁型

这一类型与躁狂抑郁性精神病抑郁状态和更年期忧郁症相类似，表现为情绪低落、抑郁、悲伤，经常出现自责自罪观念，以致寻求自杀。有时可产生疑病及虚无妄想，内容极为荒诞。

三、临床诊断

根据患者有冶游史和年龄的范围不难作出诊断。但是麻痹性痴呆，是一种严重的疾患，如不及时治疗，患者是不能自然恢复的。因此，早期发现、早期诊断，就有极大的意义。

(一) 一般检查

对于50~60岁的精神病患者，如有过冶游史或梅毒史，应考虑本病的可能性。人格改变和智能障碍(全面性痴呆)在诊断上具有重要意义。作检查时，应仔细进行智能测验，注意其精神活动、工作能力及计算、判断、理解、记忆、批判等能力是否减退。

(二) 神经系统检查

其中检查瞳孔的变化，对于早期诊断极有价值；其它如语言障碍、颅神经麻痹、震颤等也都很有意义。

(三) 血液和脑脊液的化验

如梅毒性血清试验为阳性和脑脊液改变，即可确定诊断。应当注意的是，脑脊液的康氏及华氏试验一次为阴性者，并不足以否定本病的诊断。如果临床表现疑似本病，应多次进

行康氏及华氏试验。

四、病例介绍

王×× 男性 55岁 初诊日期为1965年7月12日。

〔问诊〕患者以往有冶游史，于八个月前曾感觉头晕，而后逐渐精神异常，常无原因而哭泣，自言自语，行为古怪，用手捏着脖子学呃逆。最近两个月来狂言妄语，终日坐卧不安，自责，常打自己，不识亲疏，饮食不知饥饱。每夜不能自然入睡，需服安眠药，大便已数天未行。曾经××医院精神科检查，确诊为：神经系统梅毒，麻痹性痴呆。经注射青霉素，内服镇静剂治疗，因效果不明显而转中医治疗。

〔望诊〕精神痴呆，舌质淡，舌苔白厚。

〔闻诊〕痴笑不休。

〔切诊〕脉左细滑，右滑数。

〔辨证〕梅毒犯脑，邪害清窍。

〔立法〕驱梅清脑。方用驱梅汤2号

〔处方〕土茯苓 30克 连翘 15克 防风 10克
甘草 6克 甜桔梗 10克 远志 10克
菖蒲 6克 荷叶 10克 胡连 6克
郁金 6克

1965年9月17日，前方加减服用四十剂后，精神症状大为好转，多日来没有打自己和骂人及叫喊等狂妄现象。按时吃饭，食纳好，睡眠也安静。

〔处方〕土茯苓加至45克，加白矾3克，继服。

〔随访〕1965年11月25日，患者经治疗后精神症状已消失，除有时尚有些发呆外，一般尚属正常。

五、治疗体会

中医对神经梅毒之治疗，无论是脑梅毒或麻痹性痴呆，其治疗方法均以驱梅为主。而驱梅以重用土茯苓为主药，结合辨证随症加减。如脑梅毒临床见舌颤不能外伸，脉见沉细，为久病正虚，在驱梅的同时加以人参扶正。

土茯苓为治梅毒之主药，且有解汞毒之作用，对于因早期梅毒服用汞制剂(如轻粉等)取效于一时，致毒邪稽留深入，多年后复发神经梅毒并出现精神症状的患者，重用土茯苓效果良好，较之用青霉素加对症的抑制兴奋药疗效为好。

临床所用驱梅汤1号偏重于通络扶正，故在重用土茯苓基础上，选用木瓜、木通、皂荚、人参之品；驱梅汤2号偏重于通窍祛毒，亦在重用土茯苓基础上，选用远志、菖蒲、荷叶、甘草、桔梗、郁金之品。

第三章 中毒性精神病

中医对各种中毒所引起的精神障碍早有记载。晋代葛洪在《肘后方》中云：“食茛菪令人狂”。巢元方的《巢氏病源》有“恶酒候，狂悖变怒，失于常理”。后世更有“服芳草石药气慄悍发狂”和“秽浊恶气从口鼻入，谓之中恶，使人暴厥”之说。一般毒物进入人体，都有损害中枢神经系统的作用，但程度有轻有重。临床上较为常见的中毒性精神病，有的是由重金属铅、汞中毒引起的，有的是因一氧化碳和酒精中毒造成的。由于有毒物质的剂量不一，它们进入机体的途径、速度和持续的时间不同，以及它们的理化作用有差异，临床上出现的中毒症状有急性和慢性之分。急性症状是由较大剂量的毒物一次进入机体而引起的；慢性症状则是连续多次少量毒物进入机体而引起的。精神障碍的产生又同个体的敏感性、神经系统机能状态、年龄、躯体及精神状况等因素有关，不同的人可有不同的反应。

第一节 病因病机

中医认为，一切毒物侵入人体，其毒犯脑，蒙闭清窍，轻者精神异常，重则昏迷甚至死亡。现代医学认为，各种毒物引起的中毒机制及病理变化，一般可分为两个阶段：毒物进入机体之后，首先使大脑皮质抑制过程遭到破坏，出现短

时期的正诱导，引起兴奋性亢进；而后在大脑皮质内出现弥散性的超限抑制，形成各种不同的位相状态。这类机能变化是可逆的，但是当中毒严重时，神经细胞遭到破坏，就可引起不可逆的病变，甚至导致死亡。

虽然不同的毒物所造成的精神障碍各有其特征，但它们还是具有一些普遍的共同表现。

急性中毒时，除伴有多种躯体的和神经系统的症状外，精神方面主要表现为各种轻重不等的意识障碍，可从轻度的意识模糊、意识朦胧到严重的昏迷。

中毒较轻的，病人常出现类似神经衰弱的种种症状；中毒严重的可出现一些感知觉、思维及情感方面的失调。

慢性中毒者的症状，可因不同阶段而有所不同。早期往往呈现类似神经衰弱的症状；疾病发展时，病人可有各种感知觉、情感及智能的障碍，有时也可出现思维的障碍；疾病发展到严重阶段或后期时，就可出现意识障碍。中毒性精神病的种类很多，下面介绍比较常见的铅中毒、汞中毒、一氧化碳中毒和酒精中毒。

第二节 铅中毒

一、临床表现

铅中毒多见于铅矿开采、炼铅、熔铅和玻璃、蓄电池、油漆、颜料、橡胶、印刷排字等工业部门的工人。铅进入人体的途径，主要是呼吸道及消化道（通过染有铅尘的食物）。铅中毒分急性和慢性两种，其症状如下：

(一) 急性铅中毒的症状

急性铅中毒十分少见。一般是在大量吸入铅粉尘时，轻则头痛，耳鸣，失眠，记忆减退；重则恶心，呕吐，腹绞痛，贫血和中毒性肝炎；或精神方面表现为运动性兴奋、激动，或表现抑郁，有时可出现幻听；严重者可出现四肢抽搐，癫痫样发作及中毒性谵妄。

(二) 慢性铅中毒的症状

慢性铅中毒的临床表现有以下三方面：

1. 神经系统症状

早期表现为神经衰弱症候群，如头晕、头痛、疲乏无力，失眠、记忆减退、四肢痠痛等。继之可出现多发性神经炎，表现为运动型多发神经炎(手足无力，腕下垂)及感觉型多发神经炎(脚麻痛，手脚感觉减退)。

2. 消化系统症状

食欲减退，口中有金属甜味，恶心，便秘，铅痠痛，齿龈部可见铅线。

3. 实验室检查

慢性铅中毒患者，由于骨髓中红细胞病理性增生，周围血液中可出现大量嗜酸性幼稚红细胞——网织红细胞、点彩细胞及多染色红细胞。严重者可出现轻度的低色素性贫血，尿棕色素增高及尿铅的增高。

二、临床治疗

(一) 急性铅中毒的治疗

1. 乘热服用生鸭血，不限量，以症状缓解为度(下同)。

2. 白砂糖三两，用冷水调服。

3. 生萝卜汁一碗，灌服。

4. 腹痛、恶心、呕吐者，用橘皮10克，姜半夏10克，茯苓12克，甘草3克，竹茹10克，郁金10克，川楝子10克，元胡10克，水煎服。

(二) 慢性铅中毒的治疗

1. 石硫磺0.6克，元精石0.6克，共研匀，以滑石10克，瞿麦10克煎汤冲服，一日两次，连服一周。

2. 出现精神症状时，可用驱铅通络饮。

〔处方〕 灵磁石 20克 生龙骨 20克 生牡蛎 20克
远志 10克 菖蒲 6克 茯神 10克
当归 10克 炙黄芪 15克 甘草 3克
石硫磺粉 0.6克(分两次冲服)
水煎服。

三、病例介绍

谷×× 男性 48岁 ××印刷厂排字工人 初诊日期为1963年5月16日。

〔问诊〕 患者从事排字工作已近30年，近八年来经常头晕，头痛，失眠，多梦，记忆减退，四肢酸痛、乏力。经××医院诊断为神经衰弱，经长期治疗，无明显效果。后经××医院检查才确诊为慢性铅中毒，进行驱铅治疗，虽有些好转，但症状未除，时轻时重。近半年来食欲减退，口中淡，饮食乏味；大便干，两、三日一行。

〔望诊〕 舌质淡红，少苔，齿龈部分铅线明显。

〔切诊〕 脉象沉细。

〔辨证〕铅毒窜及经络，侵扰神明。

〔立法〕解铅毒，通经络，安神宁志。方用驱铅通络饮。

〔处方〕金钱草 30克 甘草节 5克 生龙骨 20克
生牡蛎 20克 当 归 10克 首乌藤 15克
木 瓜 10克 丝瓜络 6克 远 志 10克
大青盐 8克 硫磺粉 0.5克(分冲)

〔治疗经过〕前方服用五剂后，睡眠好转，昼日头晕、头痛、身痠痛等症皆轻，食欲增加，大便每日一行，不干。前方加减继服三十剂，症状消失，齿龈铅线仅存痕迹，脉象滑利有力。患者自觉精神体力均较前增强，记忆有所好转。停服汤剂，改用丸剂以巩固疗效。

第三节 汞中毒

汞又名水银，它在未升华前，体颇重，性喜流窜，称为至阴之精。它可用于外科疾患，但不可轻易口服，如误服，则使腹中重坠，甚至胃肠穿孔，还能入骨钻筋，无孔不入。因其性秉至阴，所以又能“绝阳蚀脑”。它升华之后，则由纯阴之体化为燥烈之火，但其阴毒之性仍然存在，走而不守，流窜经脉，深侵筋骨，毒气内攻而稽留不去，积累日久，便生结毒，是处破溃臭烂，使人变成瘫痪，致成废人。

一、临床表现

各种科学仪器制造工业及炼汞工业中常见汞中毒患者。汞主要由呼吸道侵入人体，多为慢性中毒。

慢性汞中毒的临床表现如下：

1. 神经系统症状

神经衰弱症候群是慢性中毒的早期症状，主要是头晕，头痛，失眠多梦(或嗜睡)，记忆减退，疲乏无力等。

2. 精神症状

较突出的表现是容易兴奋，情绪不安，烦躁易怒，感情脆弱，缺乏自知力。但也有的病人表现为悲观、胆怯。

3. 运动系统症状

突出的表现是震颤，早期出现部位为眼睑、舌、手指，继之可发展至腕、上肢或下肢。一般为对称性的，开始为细小震颤，逐渐发展为粗大的意向性震颤。

4. 口腔症状

口中有金属味，流涎，常感口干。口唇、颊、舌部可发生肿胀和溃疡。牙龈肿胀、易出血，常有硫化汞的暗蓝色线。

5. 植物神经系统症状

汞中毒患者常有植物神经紊乱现象，如多汗，血压、脉搏不稳定，皮肤划痕症等。

6. 化验室检查

血常规检查，可发现血中淋巴细胞增多。尿常规检查，可发现蛋白尿。血、尿、唾液及粪便中均可发现汞元素。

二、临床治疗

治疗汞中毒，可应用下列验方：

1. 猪脂二斤，切作小块，焙热调入蜂蜜一斤拌食，可解其毒。

2. 土茯苓 30 克，甘草 6 克，水煎，早晚各服一次。服药期间忌茶、醋。

有精神症状时，除用解毒药物治疗本之外，还需辨证施治，佐用其它药物，以治其标。

三、病例介绍

〔例 1〕

徐×× 女性 27 岁 仪表厂(体温表车间)工人 初诊日期为 1963 年 10 月 6 日。

〔问诊〕患者从事体温表制造工作已六年。三年多来精神异常，如情绪急躁，容易和别人吵架却又怕别人报复，甚至想到别人会用各种方法暗害她。行路时东张西望，处处提防，终日惶恐不安。自觉头晕，头痛，身体倦痛，记忆衰退。经本单位医务室诊断为汞中毒，用排汞方法治疗后，症状不减而就诊。

〔望诊〕表情淡漠，牙龈色紫肿胀。舌质紫，舌苔薄白。眼睑震颤，舌颤明显。

〔闻诊〕语言尚正常，能述说病情。

〔切诊〕脉沉缓。

〔辨证〕汞类中毒，窜及经络，侵犯神明。

〔立法〕解汞毒，通经络，安神志。方用排汞解毒饮。

〔处方〕土茯苓 30 克 黄 连 6 克 当 归 10 克
石菖蒲 6 克 远 志 10 克 甘 草 6 克
甜桔梗 10 克 杭菊花 10 克 首乌藤 15 克
鸡血藤 10 克

外用方：每日晨起刷牙后用黄酱擦牙龈。

前方加减服用一月后，精神症状消失，头晕、头痛、体痛已不明显，记忆也较前恢复。

〔例2〕

陈×× 女性 28岁 温度计厂工人 初诊日期为1964年9月4日。

〔问诊〕八年前，患者到温度计厂工作，经常接触水银。持续工作三年，为防止汞中毒，曾注射排汞剂三次。近四年来经常头晕，头沉，头痛，全身疲乏无力，昼日困倦，无精打采、夜间多梦，睡眠不实。经××及××医院检查，确诊为汞中毒，曾三次住院治疗，每次住院两个月。1963年检查体内含汞量为0.00925克，但症状无明显变化，故转中医治疗。

〔望诊〕双目直视，睛无光泽，牙齿稀枯，舌质淡红，舌苔薄白，两手颤动有冷汗。

〔闻诊〕声音正常。

〔切诊〕脉沉细数。

〔辨证〕水银中毒，侵入经络，上犯清空。

〔立法〕解毒通经络。方用排汞解毒饮。

〔处方〕土茯苓 30克 金银花 15克 连翘 10克
甘草 6克 甜桔梗 10克 首乌藤 15克
宣木瓜 10克 桑枝 15克 滁菊花 10克
当归 10克 白薇 10克 桑寄生 24克
淡豆豉 10克 四剂

二诊：1964年9月9日。服药后头晕、头痛均减轻，自觉头脑清楚，已不昏沉，睡眠也好，全身较前舒适有力。再以上方加减继服。

第四节 一氧化碳中毒

一、临床表现

在可产生一氧化碳的工厂、矿井和冬季用煤炉取暖的家庭，都可有一氧化碳中毒患者。

中毒者先觉头昏，头痛，恶心，甚至呕吐；如继续留在有毒气的环境而不开窗通风，即可发生意识不清甚则昏迷而死亡。有的病人昏迷前不出现前驱症状，如及时抢救或中毒轻时，可恢复正常。

病人经抢救苏醒后，有的出现精神异常症状。部分病人在精神症状出现之前，常有一段“清醒期”，即在中毒后1~8周内精神状态完全正常；以后可突然发病，意识不清，动作古怪、无意义，表情茫然，反应迟钝，言语不清，呈痴呆症候群，同时可伴有失语现象；病情继续发展，则逐渐出现四肢肌肉强直，大小便失禁等症。也有的病人经过一段“清醒期”以后，逐渐发生巴金森氏综合症，而不出现精神症状。

二、临床治疗

(一) 急性中毒的治疗

发现中毒时，应立刻将患者移至通风处，或打开门窗使室内空气流通。同时，可服用下列药物。

1. 白萝卜一个，切碎捣烂挤汁灌下，以苏醒为度，下同。
2. 渍酸菜水半饭碗，灌服。
3. 食醋二两，对冷开水二两，灌服。

4. 茶叶五钱，水煎一茶杯，以浓茶灌服。

5. 藿香 10克 佩兰 10克 苍术 10克 辛夷 10克
荷叶 10克 水煎服

上方药汁送服苏合香丸一丸

〔注〕：此方为芳香驱秽饮 1 号，多用于急性中毒症状较重的病人，不但能较快解除症状，预防后遗症的效果也较好。凡中毒较重者，虽经急救而苏醒，但为预防后遗症，仍应按此方服药 1~2 剂。

（二）一氧化碳中毒后遗症的治疗

患者中毒后，经过一段时间出现精神障碍，是由于恶毒之气未除，邪蒙清窍所致。一般以芳香化浊开窍为治疗本病的基本法则。常用药物为芳香驱秽饮 2 号：藿香、佩兰、苍术、郁金、菖蒲以及成药苏合香丸。

如有抽搐或手震颤等症，是肝风内动的现象。在用芳香化浊开窍的同时，可加入平肝熄风的药物，如生石决明、白蒺藜、钩藤、全蝎。

如伴有四肢肌肉强直（出现在下肢或一侧）或瘫痪等症，是恶毒之气不但蒙闭清窍，而且阻滞经络，一般不必使用通络药物，经过芳香化浊的药物治疗后，不但能开清窍而且能通经络。在精神症状好转的同时，肢体也随之灵便。个别严重的患者，当精神症状好转后，如肢体功能尚未恢复，可以采用益气通经络的方法治疗，如补阳还五汤加鸡血藤、牛膝等。

三、病例介绍

〔例 1〕一氧化碳中毒急性期

钱×× 女性 19岁 未婚 工人 初诊日期为1964年11月2日。

〔问诊〕五天前，患者夜间临睡时，将火炉烟筒通气口关闭，煤气不得外出，招致煤气中毒。被人发现时患者已神志昏迷、四肢抽搐。家人急将门窗打开通风，约半小时患者始苏醒，自觉头痛剧烈，家人急将患者送往××医院急诊，经过输氧后头痛减轻，意识也清醒，医生嘱其回家休养。患者回家后又出现剧烈头痛，继之抽搐又发作，恶寒怕冷，胸闷气憋，躁动不安，不能入睡。至今日就诊时前症仍存在。

〔望诊〕精神痴呆，两目直视，巩膜色青，舌质淡红，舌苔白少。

〔闻诊〕言语迟钝，尚能简单答问。

〔切诊〕脉沉细数。

〔辨证〕恶浊之气蒙闭清窍，神明之司传导失职。

〔立法〕芳香化浊，开窍醒神。方用芳香驱秽饮1号加味。

〔处方〕藿香10克 佩兰10克 苍术6克
滁菊10克 荷叶10克 远志10克
菖蒲6克 郁金6克 钩藤10克
苏合香丸两丸，每次一丸

二诊：1964年11月5日。前药服两剂，头痛已减轻。自服药后未出现过抽搐和躁动，睡眠安好，胸闷气憋症状已消失。今日患者自行就诊，精神正常。舌质淡红，舌苔少，脉沉细。前方加味继服三剂。

三诊：1964年11月11日。服药后头已不痛，一切症状均

消失，停药已三天，没有不舒适的感觉，精神睡眠都正常，停药观察。

〔随访〕两个月后随访，患者工作情况良好，没有发现任何后遗症。

〔例2〕一氧化碳中毒后遗症

池×× 男性 36岁 已婚 机械厂工人 初诊日期为1965年3月23日。

〔问诊〕患者在本年春节初三值夜班时，生一煤炉取暖，不慎煤气中毒，次日被人发现，患者当时已昏迷，经打开门窗后，逐渐苏醒。全身不能动，口不能言，呕吐出很多饮食物，随后呕吐鲜血三口。经本厂医务室抢救后，病情缓解。患者系车间主任，因生产任务忙，仅休息两天就上班参加生产。以后同志们发现患者神情呆滞，对一切事物反应迟钝，两下肢行走不便，步态不整，右腿强直不能屈，两足肿。自觉头昏沉，心中烦乱，总想哭，恐惧，妄想，不能入睡，右腿沉重没有感觉。曾在××医院检查，诊断为一氧化碳中毒后遗症。

经神经系统检查，瞳孔较大，四肢肌张力增强，腱反射亢进，病理反射阴性，右下肢触觉消失，痛觉迟钝。

〔望诊〕精神痴呆，面无表情，目直视，鼻涕流至唇边也不自知。舌质淡红，舌苔白。

〔闻诊〕言语迟钝，回答切题，能说出自己的感觉。

〔切诊〕脉沉滑。

〔辨证〕恶浊之气蒙闭清窍，阻滞经络。

〔立法〕芳香开窍通络。方用芳香驱秽饮加减。

〔处方〕佩 兰 10克 藿 香 10克 辛 夷 10克

荷 叶 15克 杭菊花 10克 远 志 10克

菖 蒲 10克 郁 金 10克 全 蝎 6克

生石决明 24克 白蒺藜 10克

苏合香丸两丸，每次一丸

二诊：前方加减服用十二剂，患者精神症状已消失，步履也正常，仅感右脚面发麻，足肿已消。有时觉咽中有粘稠痰不易咯出，用脑多时睡眠较差。舌质淡红、舌苔黄较腻。脉滑。再以化痰安神法治之。

〔处方〕珍珠母 24克 法半夏 10克 炒秫米 15克

远 志 10克 石菖蒲 6克 炒枣仁 18克

合欢皮 10克 茯 苓 10克 竹 茹 10克

黄 连 3克 炒山栀 6克 四剂

〔随访〕1965年7月10日。患者仍作车间主任工作，无任何后遗症。

〔例3〕一氧化碳中毒重型后遗症

刘×× 男性 57岁 食品公司售货员 初诊日期为1964年4月16日。

〔问诊〕患者于本年春节期间值夜班，不慎煤气中毒，当时无人发现，天亮被人发现时患者已昏厥，经抢救两小时始苏醒。当时患者左侧肢体因侧卧被压于下，皮肤肿胀，呈紫色瘀斑。经过治疗，数日后走路跛行；精神、语言均异常，并逐渐加重。此后仅能做一些简单工作。近半月来精神痴呆，无表情，下肢强直不能蹲、坐，二便失禁，不知饥饱，终日不语，动作迟缓，足不能举步，始来京治疗。

〔望诊〕精神痴呆，经常作无意识动作，嘴不停作咀嚼状，坐时上身不时向前摇晃，手颤动。因患者不合作，无法看清

舌质及舌苔。

〔闻诊〕仅能重复语言，不能答问。

〔切诊〕脉沉伏。

〔化验检查〕血常规：血色素12.32克；红血球 413 万；白血球 11400。尿常规：尿蛋白痕迹。胸透：心肺正常。心电图正常。血压100/60毫米汞柱。

〔神经系统检查〕精神痴呆，前冲式步态，面部缺乏表情，瞳孔左大于右，光反射(+)，左眼裂小，眼底视乳头清、动脉细，舌正中，四肢均能动，腱反射(++)，未引出病理反射，腹壁反射(+)，掌欸反射(+)，吸吮反射(++)，四肢肌张力齿轮样增高。

〔诊断〕一氧化碳中毒；脑软化；巴金森氏症；动脉硬化症。

〔辨证〕恶浊之气蒙闭清窍，阻遏神明，以致肝风内动。

〔立法〕芳香化浊，开窍熄风。方用开窍熄风汤。

〔处方〕生石决明 18 克 白蒺藜 10 克 辛 薊 10 克
杭菊花 10 克 全 蝎 6 克 远 志 10 克
石 菖 蒲 6 克 川郁金 10 克
苏合香丸两丸，每次一丸

二诊：1964年4月24日。前方服用六剂，精神痴呆状态较前好转。据家属称：虽不能主动说便溺，但令其小便时能够小便。现在已能自己吃饭、穿鞋，能简单答问。有时欲言，因无思考能力，常用手拍头，仍不能说出要说的话。舌质淡红，舌苔白少，脉沉细。继以芳香驱秽饮 1 号加减治疗。

〔处方〕藿香叶 10 克 佩兰叶 10 克 杭菊花 10 克

远志 10 克 石菖蒲 6 克 辛夷花 10 克
干荷叶 10 克 双钩藤 10 克 天竺黄 10 克
全蝎 6 克 苏合香丸一丸，每次半丸。

三诊：1964年4月28日。近两日能自坐起，也能主动下床送客人，无意识动作减少，自己能说出本人的姓名及单位来探视人的姓名，见人有感情，由于不能用语 言 表 达 而痛哭。舌质淡红，舌苔少，脉沉细。前法加补益之品。

〔处方〕生黄芪 12 克 紫丹参 10 克 党参 10 克
甘草 3 克 远志 10 克 石菖蒲 6 克
杭菊花 10 克 干荷叶 10 克 橘络 10 克
苏合香丸一丸，每次半丸。

复查：1964年7月6日。患者精神正常，语言清楚，智能恢复，记忆力稍差，能思考问题和作加法、乘法计算，对答自然而迅速。行走灵便，步态自然，坐凳子时稍迟缓，能上下床。

〔神经系统检查〕瞳孔等大，对光反应正常，两侧眼裂等大，舌正中并能自由伸出，四肢活动正常；腱反射正常，左侧稍亢进，未引出病理反射；腹壁反射正常，掌欸反射正常，左侧上肢肌张力稍紧张。

〔化验〕血常规：血色素16.2克；红血球512万；白血球7600。尿常规：尿蛋白阴性。

血压 120/76 毫米汞柱。

根据患者精神、智能及肢体运动的恢复情况停止治疗，恢复一般轻工作。

〔例4〕一氧化碳中毒严重后遗症

赵×× 男性 50岁 煤矿工人 初诊日期为1962年

5月5日。

〔问诊〕1961年冬季，患者在本单位培植蘑菇，春节期间在温室值班，因煤气中毒而昏迷。次日早晨换班时被人发现，经抢救苏醒，醒后两日意识尚清，三日后意识不清，并有发烧和谵妄状态。本单位将其送往××医院，经检查诊断为一氧化碳中毒，合并吸入性肺炎，乃住院治疗。住院后意识仍不清，体温经常在38~39℃之间，经用抗生素治疗20余日，体温正常，而患者严重痴呆，两下肢截瘫，二便失禁，并经常将大便抹于脸上、手上。对家属不能辨认；住院三个半月，症状没有好转，请过几个医院的精神科专家会诊，确诊为一氧化碳中毒后遗症，大脑萎缩，精神痴呆，两下肢截瘫。因该院无法治疗，建议出院回家疗养，后来我处就诊。

〔望诊〕精神痴呆；仰卧床上，两手常做无意识动作，两下肢色紫稍屈，两足皮肤呈黑暗色，左下肢较右下肢短八厘米，感觉及反射均消失。舌质淡紫，舌苔白厚腻（患者不会伸舌，用压舌板撬开口，始得舌诊）。

〔闻诊〕问之不语，但时有谵语，鼻不时作抽气声。

〔切诊〕脉沉涩。

〔辨证〕恶浊之气蒙闭清窍，横窜经络，筋脉失养，致成瘫痪。

〔立法〕芳香化浊，开窍通络。方用芳香驱秽饮1号合开窍熄风汤。

〔处方〕生石决明 18克 白蒺藜 10克 辛夷花 10克
藿香 10克 佩兰 10克 杭菊花 10克
全蝎 8克 远志 10克 石菖蒲 6克
苏合香丸两丸分服 三剂

二诊：1962年5月8日。据家属代诉，服药两剂后病人能认识家中人，能主动问其从外地回来看他的子女怎么回来了，并要吃对虾。

今日患者意识已清楚，见医生欲做起身动作，并说：“对不起，太麻烦您了。”能回忆病前经过，诉说苏醒后的片段。以后去医院的经过则完全不能回忆。两下肢仍瘫，二便自遗。舌质淡紫，舌苔白已薄。脉沉缓。前方继服四剂。

三诊：1962年5月12日。前方共服七剂，精神语言均正常，惟下肢瘫痪，二便不能控制。此因病久气虚，经络阻滞。改用补气活血通络，方用补阳还五汤。

〔处方〕生黄芪 60克 当归尾 10克 川 芎 6克
赤 芍 10克 桃仁泥 10克 南红花 6克
酒地龙 10克 川牛膝 10克 鸡血藤 10克

上方服十二剂，两腿已能屈伸，能坐起；两足浮肿，黑暗色死皮开始脱落。服至二十剂时两下肢长短已相等，浮肿已消，肤色正常，能下床扶杖在室内慢慢行动。共治疗三个月，患者已能离杖行走，自去街上散步。除表现略有自私（如食物不给子女吃）、对事物不大关心外，没有其它症状。1963年初回矿做一般工作。

第五节 酒精中毒

酒精中毒引起的精神障碍最为常见。古人谓之恶酒候，最早的记载见于晋朝。巢元方提出：“酒者……其气慄悍而有大毒，入于胃则酒胀气逆，上逆于胸，内薰于肝胆，故令肝浮胆横，而狂悖变怒，失于常理，故云恶酒也”。酒为嗜

好品，少饮使人精神振奋，血脉通畅，温胃散寒，促进饮食，帮助消化，如能掌握适量，对人精神、身体有益，并不损害健康。若过量饮酒，可使酒毒犯脑，精神由振奋而致紊乱，狂言絮语，行为暴戾。如过大量，可使人沉醉如泥，昏不知人。酒性燥烈，多饮则损伤胃阴，助长湿热，妨碍脾的健运。以酒代饭，致使营养缺乏而消瘦，久则损及肝肾；肝主筋，筋失濡养，肢颤而不能握笔；肾藏精，主髓充脑，主技巧，肾伤则精髓不足以充脑，记忆衰退，技巧不能。

古人又有酒后妄见妄闻的记载，如《名医类案》记有：“一官吏酒后见空中有五彩云，耳闻风雨声”。此乃中酒毒后的幻觉状态。

一、临床类型及表现

（一）普通酒醉

一次较大量饮酒引起的精神紊乱，其临床特征为一种特殊的兴奋状态。患者言语杂乱无章，絮叨重复，好追述往事，如发泄隐言，情感兴奋，容易激怒；对于素常不满的人和事，常失去自制力而破口大骂；喜与人斗殴或争吵。如过度兴奋，走路表现为东倒西歪，手、唇震颤，口齿不清。有时呕吐，眩晕，面部充血。另一些酒醉患者，则嗜睡、酣睡、少语，所谓“酩酊大醉”。一般可自然恢复，而无后遗症。

（二）病理性酒醉

其特点是很小量的酒即可引起严重的精神变化。患者常是语言清楚，步态稳健，动作连贯，但仔细观察，可发现患者对环境丧失正常的接触，不能辨认周围的人物，不能记住

讲过的话。有时可出现片断的幻觉、妄想，多具有恐怖的内容，因而常发生攻击性的行为，如剧烈兴奋可伤人毁物。

（三）慢性酒精中毒

慢性酒精中毒有两种：

第一种是由长期饮酒所引起的中枢神经系统严重病变。其特征为个性改变，智能减退。患者变得自私，孤僻，不修边幅，疏忽自己的职责。兴趣范围狭窄，工作能力低下，记忆力减退，综合能力降低，终于无法劳动。由于判断力差，对自己缺乏正确的认识，常把责任归之于别人。

第二种是由长期(不分早晚)饮酒过量、以酒代饭，而造成食欲不振、营养不良，以及消瘦和患维生素缺乏症。这种中毒患者睡眠不好，可出现内脏器官(肝、肾)严重病变及代谢障碍，身体抵抗力减弱，常合并严重躯体疾病，导致不良后果。

（四）震颤谵妄

震颤谵妄是在慢性酒精中毒的基础上急性发作的精神障碍。发作前数日，常有先兆症状，如心情不快，恐怖感，失眠，多梦等，偶见入睡前的幻觉。发作初期的主要症状是意识障碍和丰富多样的幻觉（幻听、幻视）、错觉及感觉综合障碍。幻觉生动而鲜明。病人对于这些幻觉场面，不是旁观者而是参与者。所以，常见病人急跑，似在追赶什么动物；或向空中挥手，似在捕捉鸟雀；或向前招手，似与人打招呼；或回头骂人，似在与人动怒。情感活动常随错觉和幻觉的内容而改变，时而恐惧、惊慌，时而兴奋、欣快，有时则伤感而哭。幻觉常于夜间加重，因此，情绪不安和恐惧感也在夜间加重。

躯体症状以震颤最为显著，如手、舌甚至全身震颤，病人笔迹不整，语言蹇涩，步态不稳，颜面充血，脉搏快速，血压升高，体温略高。一般经3~5日即可结束，在一次熟睡之后，醒来意识清醒，幻觉消失，震颤也逐渐减轻或消失。

（五）间发性酒狂

这是一种周期性的难以控制的狂饮发作。它和癫痫性情绪不稳很相似。发作之前，病人先觉情绪不好，痛苦，烦躁不安。接着就大量饮酒，难以控制，对于酒量有不平常的耐受性。发作持续几天或几周即结束。结束的先兆是病人自我感觉改变，呕吐，对酒的欲望消失。在间歇期，病人很少饮酒，多数病人全然不喝或对酒厌烦。

（六）酒精中毒性幻觉症

长期饮酒的人多发此病，大部分人意识清醒，症状以幻听为主。幻听的内容多是对病者不利的语言。在这些生动的幻觉基础上，病人产生被害妄想，认为自己处于被包围之中。幻觉一般是夜间加重，病人常因此失眠，有时可突然起床去寻找“暗害”他的人。

本病发生缓慢，但持续时间较久，可达数周、数月、数年。戒酒后可好转而康复。有些病人，症状平息后，痴呆现象日益显著，所谓“酒徒幻觉性痴呆”。

（七）酒精中毒性妄想症

此症是在慢性酒精中毒的基础上发生的精神障碍。主要症状是嫉妒妄想，也可有幻觉。起初仅在宿酒时出现，以后逐渐经常化并系统化，随之暴露出幻想内容的荒谬性。如病人怀疑自己的配偶对自己不忠实，为了证实他的猜想，多方寻找证据。例如病人回家看到妻子头发乱，或衣扣未扣好

等，都认为是妻子和别人发生关系的证据，逼迫对方承认，否则就打骂。由于嫉妒妄想，可使病人做出犯法的行为。

（八）酒精中毒性假性麻痹

此症是慢性酒精中毒的一种，症状与麻痹性痴呆相似。病人智能减退，判断力、记忆力均遭到破坏。有时伴有荒谬的夸大妄想和情感欣快。躯体症状，可发现腱反射两侧不对称，过高或过低，舌、手震颤，口齿不清，两侧瞳孔大小不等，对光反应迟钝等。此症预后较坏，停止饮酒也可出现躯体症状和精神衰退。

二、临床诊断与治疗

（一）诊断与鉴别诊断

诊断应根据患者饮酒史和临床特征。询问病史，不能单靠病人自述，还要询问病人的亲属和同志，才能得到可靠的材料。

震颤谵妄应与其它传染中毒引起的谵妄状态相区别，主要依靠病史和毒物接触史来鉴别。

酒精中毒性幻觉症及妄想症，应与精神分裂症及更年期妄想症相区别。

出现智力障碍的，应与其它原因引起的器质性痴呆相区别。

（二）临床治疗

对急性酒精中毒患者，如果饮量不多，中毒不深，病人休息一段时间即可恢复。如果昏迷较深的病人，可因地制宜就地取材，采用以下几种简便的方法救急：

1. 白萝卜一个捣烂拧汁，将萝卜汁用匙子慢慢灌入病

人口中，以清醒为度。

2. 甘蔗削去皮，捣烂拧汁灌入病人口中，并能止呕。
3. 麝香少许，放入病人口中，可使病人较快苏醒。
4. 黑豆半斤煮汁，乘温灌之。
5. 樟木二两，捣碎煎汤去渣，灌病人。
6. 枳椇子一两，捣碎煎汤，灌病人。
7. 葛花一两，煎浓汁，灌病人。

对慢性酒精中毒的病人，可采用连续服药的治疗方法。

8. 临床常用方药(醒酒汤加味)

〔处方〕 枳椇子 15克 葛 花 10克 黄 连 3克
黄 芩 6克 生石膏 24克 炒山栀 6克
远 志 10克 菖 蒲 6克 五味子 6克
茯 神 10克 杭菊花 10克 水煎服

本方可治疗慢性酒精中毒所致精神障碍、躁动不安、震颤性谵妄等病人。

三、病例介绍

〔例 1〕

刘×× 男性 59岁 印刷工人 初诊日期为1963年5月7日。

〔问诊〕患者嗜酒三十年，每日必饮。近四、五年来患高血压病，经常头痛、头晕、心悸、心中烦乱。近两月来发现尿频、尿血、面目浮肿，在××医院检查，诊断为肾炎，经治疗症状减轻。近20日来胃脘胀满，格逆不畅，自觉气上冲至咽，咽喉发堵，口酸，吐白沫清水，食欲不振，喜稀食、凉饮，大便干燥，精神痴呆，智能减退，手颤。

〔望诊〕鼻准头赤肿生疮化脓。舌质紫红，舌苔黄燥。

〔闻诊〕语音不够清晰。

〔切诊〕脉弦滑数。

〔辨证〕多年嗜酒，湿热内蕴，胃阴被劫，故喜稀食凉饮，肠道涩则便干，湿热上蒸准头生疮。

〔立法〕清湿热解酒毒，养阴增液。方用醒酒汤加味。

〔处方〕葛花10克 黄芩6克 黄连3克

石斛15克 麦冬10克 桔萎24克

枳椇子10克 知母6克 浙贝母10克

上方服用十二剂，药后精神痴呆现象减轻，手颤也减轻，食欲增加，大便已不干，鼻疮已结痂。前方加减继服。

〔例2〕

吕×× 男性 52岁 初诊日期为1965年11月20日。

〔问诊〕患者多年嗜酒，每饭必饮，量不多，平时性情急躁易怒，有时显得情感欣快，语言荒谬。近三、四年来胃脘痛，每遇冷或恼怒后胃脘痛加重，痛连两侧胸，痛时多在饭后一小时开始，持续一日。口干不欲饮，大便不黑，二日一行，饮食睡眠尚属正常。

〔望诊〕舌体胖，舌边紫暗，舌苔白，舌中心沟裂。

〔闻诊〕语音尚正常。

〔切诊〕脉细弦数。

〔辨证〕酒积，气血瘀滞。

〔立法〕消酒积，调气化瘀。方用醒酒汤加味。

〔处方〕枳椇子15克 葛根30克 当归尾12克

枳壳10克 香附10克 桃仁泥10克

南红花6克 牛膝10克 甘草15克

二诊：1965年11月29日。前药服用四剂，脘痛已除，饭后仅感胃胀，情绪也较稳定，大便日一行且不干。舌苔薄白，脉弦。继以前方加减。

〔处方〕 枳椇子 36克 葛 花 60克 当归尾 30克
旋覆花 36克 枳 壳 20克 香 附 20克
桃仁泥 20克 红 花 20克 牛 膝 20克
甘 草 36克

上药共研细末，炼蜜为丸，每次10克，日服三次。

〔随访〕1966年1月4日。经治疗精神正常，情绪稳定，胃脘未痛，脘胀已消失。现已戒酒，诸症皆痊愈。

第六节 治疗体会

对各种不同性质的毒物中毒，给予不同的解毒方法，就是对因治疗，也就是中医所谓“治本”的方法。例如解铅中毒用硫黄为主。汞中毒用土茯苓为主等。至于现代工业上的一些化合物中毒，中医无此记载。

本书以介绍治疗精神病方法为主，又是以临床实践为重点。对于锰、苯、二硫化碳等化学物品中毒，用中药处理，尚缺乏经验。如果临床遇到此类精神障碍的病人，根据出现的症状，采用辨证施治的法则，可以对症治疗。不过这种对症治疗与现代医学的对症治疗有所不同，那就需要根据四诊所见寒、热、虚、实加以辨证。例如中毒性精神障碍中最常见的睡眠障碍，在治疗上是否可以不辨寒、热、虚、实，一律使用某种安神药物？临床证明是不够妥当的。因为中医选用药物，都是根据其性能（寒、热、温、凉）归经（入那一经）而加

以选用。就是选用成药时也是如此。众所周知，“补心丹”是治失眠的成药，可是为什么有些病人吃了有效，而另一些病人吃了反而不能入睡呢？这是因为补心丹的药味、性能偏于温补，对于心血虚所引起的失眠是有效的，对于其它原因引起的失眠就无效。假如一个由于心火盛而引起的失眠者，服用补心丹不仅不能安眠，反而会使他兴奋得不能入睡。如果给这类病人服用“朱砂安神丸”，就能达到安眠的作用。这是因为朱砂安神丸选用的药物性能偏凉，泻心火，所以对心火盛引起的失眠症就有效；反之，对于心血虚引起的失眠也同样无效。这是根据病因的不同而采用不同的治疗方法，其它的症状也是如此。所以，中医的对症治疗与现代医学的对症治疗是有区别的，其特点就在这里。

气体中毒所引起的精神障碍，临床最常见的是一氧化碳中毒。治疗这方面的患者，在临床实践中摸到一些规律。中医认为它是吸入恶浊毒气，蒙闭清窍，令人昏迷。吸入恶浊毒气是其致病因素，邪蒙清窍是其病机；根据这一理论，采用芳香化浊、解毒开窍的治疗方法，在临床上取得显著效果。

不过一氧化碳仅是毒气的一种，至于其它毒气(包括烟、雾、蒸气及易燃物，挥发液体等)经由呼吸道进入人体而引起的精神症状，如意识障碍，智力低下，或呈痴呆状态，都是属于邪蒙清窍的范畴，所以都可采用芳香化浊开窍的方法治疗。

第四章 脑外伤性精神障碍

第一节 中医对于颅脑外伤的认识

关于颅脑外伤的学说，在中医文献里比较少见。其原因：第一，本病发生率低，没有引起内科医家的注意，因而略于这方面的记载。第二，古代关于外伤性疾病，一般推之于正骨医生。《医宗金鉴正骨心法》就记有各部头颅骨损伤多种。如颠顶骨：“颠者头顶也，一名天灵盖，位居至高，内涵脑髓如盖，以统全体者也，或碰撞损伤，如卒然而死，身体强硬，鼻口有出入声气，目闭面如土色，心口温热跳动者，此证可治。”如山角骨：“即头顶两旁棱骨也，凡有跌打损伤未破者，不拘左右宜紫肿硬，瘀血凝聚疼痛，或昏迷目闭，身软而不能起，声气短少，语言不出，心中烦乱，睡卧喘促。”如凌云骨：“在前发际下，即正中额骨，其两眉上之骨，俗名左天贤骨、右天贵骨，两额角也，跌打损伤皮破二目及面浮虚肿，若内损瘀血，上呕吐衄，气虚昏沉，不省人事”。如扶桑骨：“即两额骨旁，近太阳穴内凹处也，若跌仆损伤，或焮肿或血出，或青紫坚硬，头痛耳鸣，青痕满面”。如玉梁骨：“即耳门骨，其处上即曲颊，下即颊车，两骨之合钳也，耳门内上通脑髓，亦关灵明，若垫伤击伤而有碍于骨肉者，肿痛流血……若伤重内连脑髓及伤灵明，必昏沉不省人事”。如后山骨：“即头后枕骨也，凡有伤损，其入头昏目眩，耳

鸣有声，项强咽直，饮食难进，坐卧不安，……如误从高处坠下，后山骨伤太重，筋翻气促，痰响如拽锯之声，垂头目闭。……如被坠堕打伤，震动盖顶骨缝，以致脑筋转拧疼痛，昏迷不省人事，少时或明者，其人可治”。

脑外伤的精神障碍及其后遗症，是客观存在，在中医的文献中是能找出根据从而指导实践的。现将个人在临床实践中摸索到的点滴经验写出来，供同志们参考。

一、脑的生理和功能

关于脑的生理活动，《灵枢·海论篇》曾经指出：“脑为髓之海……。髓海有余，则轻劲多力，自过其度；髓海不足，则脑转耳鸣，胫痠眩冒，目无所见，懈怠安卧。”从这段记载里，可以知道脑是由髓汇集而成的。髓是怎样产生的？《灵枢·经脉篇》也曾指出：“人始生，先成精，精成而脑髓生……”。由此可知，髓来源于肾。因为肾藏精、生髓，所以肾足髓就足；足就是有余，有余就轻劲多力，自然能够胜任各种劳动。肾虚髓就虚；虚就是不足，不足则头晕耳鸣，旋转眩晕，目不能视，腰膝痠楚，倦怠喜卧。由此可见，肾与脑的关系极为密切。脑髓的有余和不足，即是代表着肾的有余和不足，而脑的症状自然也代表肾的症状，这是一个方面。

另一方面，五脏六腑的功能活动和各脏腑之间的相互联系，并不是自身所能表现的，而是通过经络的传导来表现的。脑的功能活动自然也不例外。但是，脑为奇恒之腑，自身并无专经。而诸阳经之脉皆上会于头，其会于头的作用就是接受脑的支配，以主导调节全身功能活动。可以这样理解，诸阳经的活动，与脑的主导有密切关系，但还需在督脉的监督之

下来进行活动，所以督脉又称诸阳之督。督就是监督的意思。中医对于生理功能尽管归属于五脏六腑，但是实际起主导作用的还在于脑，不然诸阳经皆会于头就无意义了。

从脑外伤的临床症状来看，轻者出现头晕、头痛、眼花，不敢睁眼，或意识模糊，神志恍惚，定向力一时消失等；重者可立即昏迷，对外界无任何反应，面色苍白，脉搏缓慢；在昏迷期间，全身的各种功能，几乎处于停顿状态。这说明一个问题，即古人所谓的“心主神明”的学说，显然是抽象的；实际上主神明、司智慧的不是心而是脑。

再从经络学说来看，脑外伤以后，诸阳经络必然受到一定的损伤，这时脑对各个脏腑器官的支配处于无能状态；督脉因为受损伤，亦起不到监督的作用。尽管每个脏器本身没有受到损伤，但其功能表现由于脑和督脉的失职，自然无法表达。必须说明，这样谈的目的，并非标新立异，否定中医脏象学说，而是说明脑对脏器功能活动的重要意义。

综上所述，可以得出这样一个概念，即脑为髓海，由肾所主。它的充盈与衰弱，都代表着肾的虚实状态。由于诸阳经脉上会于头，它又通过经络起着调节各脏功能活动的作用，特别是督脉的作用与脑的关系尤为密切。基于上述学说，就为治疗脑外伤及其后遗症提供理论根据。

二、脑和经络的关系

为了进一步弄清诸阳经上会于头的情况，有必要概略谈谈与脑有关的经络起止和交换，这对于指导治疗，有其现实意义。所谓诸阳经，就是三阳经（包括手足三阳经）。所谓“头为诸阳之会”，就是说三阳经都聚会于头。它们循着各自

的路线，在头部进行交换。

手太阳小肠经脉起于手小指外侧尖端，沿手外侧上行至腕，再上至缺盆。有一分支从缺盆沿颈上颊至目外眦，入耳内。另有一分支从颊起至目眶下部至鼻，行于目内眦，斜行而络颧骨，与足太阳经相接。

足太阳膀胱经脉起于目内眦，上额交会于巅顶。其支者从巅至耳上角。其直者从巅入络脑，还出下项，挟脊抵腰中……直至足小趾外侧的尖端。

手阳明大肠经脉起于食指尖端，循食指内侧上行，出合谷上至肩，通过肩峰前边至缺盆，下络大肠。其支者，从缺盆上走颈部，通过颊而进入下齿，转出来围着口至上唇中间，交叉而上鼻孔，与足阳明经相接。

足阳明胃经脉起鼻旁凹陷处，旁纳太阳之脉，沿腮下后方上行耳前，沿发际至额颅，……其它直分支从头下行至足大趾之端。

手少阳三焦经脉起于无名指尖端，沿手臂上行有两条脉。一条从臆中上出缺盆，上项连耳后至耳上角，然后下行经颊至眼眶。另一条从耳后入耳中，出耳前，至目外眦，与足少阳经相接。

足少阳胆经脉起于目外眦，上行头角，下至耳后；另一支从耳后入耳内，出走耳前，至目外眦后方。

督脉属于奇经八脉之一，它只有循行起止的路线，而无归属之脏器。但是，它的功能活动大部是代表着脑的。因其经络大部散布于脑。《灵枢·经脉篇》说：“督脉之别，名曰长强，挟脊上项，散头上，下当肩胛左右别走太阳，入贯脊。实则脊强，虚则头重……”。《难经·二十八难》说：“督脉

者，起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入属于脑。”

通过以上这些记述，可以看出三阳经在头部交换的情况，以及督与脑的关系。这些都是经过长期观察而发现的客观事实，决不是臆断和抽象的设想。特别是督脉的功能更为突出，一身的阳脉都受其监督，就是说诸阳脉是在督脉的监督之下进行活动的，它在肾脑之间起着输布精髓的作用，也就是说肾之精髓是通过督脉而上输于脑的。从督脉的主病来看，“脊强反折”，“头重、头痛”，这是由于督脉循行脊里直贯头顶的缘故。所以，督脉为病多见头重、腰脊强痛、不得俯仰，大人癫疾，小儿风痫。这些症状，都是属于脑脊病的范围。因此，有理由指出：督脉是属于脑的经脉，就象太阳经属于膀胱一样。因为脑为奇恒之府，督为奇经之脉，一个无经，一个无腑，而二者的关系又恰恰如此密切，所以提出督为脑之经不是没有根据的。

根据上述脑和督脉的关系，治疗脑外伤精神障碍就有了可靠的依据和范围。因为头颅受外伤，其经络也必然受到损伤和阻碍，其损伤和阻碍的表现形式一定要反映到症状上。从其症状表现，可以判定何经受损伤和受损伤的程度，而这都与督脉有关。

第二节 病因病机

引起颅脑外伤的原因是暴力直接的或间接的打击。直接暴力可使脑组织贯通、移位、受牵拉，于受力点局部或其对应部位产生挫裂伤，或因受大脑镰、小脑幕的阻碍而产生绞剪性损伤。间接性的损伤，是由于胸部受压，胸腔内急骤

升高的压力经由上腔静脉内的血液入脑产生瘀血或出血(习称“脑部挤压综合症”),或者下跌时因足或臀部先着地产生颅底骨折。暴力的直接、间接作用尚可造成脑室内、外液压的急骤变化,而出现脑水肿、颅内血肿或脑疝,产生严重损害。此外,根据外伤后脑组织是否与外界相通而分为开放性脑外伤和闭合性脑外伤两类。开放性者尚可并发颅内感染或引起感染性精神病,远期可于脑内形成囊肿、粘连、疤痕或萎缩性病变,产生继发性损害。

颅脑外伤常有久暂轻重不一的意识障碍,这是由于脑干内的网状结构受累及大脑皮质发生弥漫性超限抑制所致。脑的各种灶性症状,则因颅内原发性病变及继发性病变的部位而定。例如大脑结构的广泛性损害,或前额叶的损害,可产生外伤后的性格改变和智能减退,而大脑皮质表面的囊肿、粘连等病变,则可产生外伤后癫痫。上述两种情况,是发生外伤后远期精神障碍的主要原因。此外,患者的病前性格特征和精神因素,以及受伤时的环境和对待外伤的情绪反应等因素,可使患者的远期临床表现附加有心因性色彩。

第三节 脑外伤精神障碍的类型及临床表现

脑外伤引起的精神障碍,其临床症状表现多不一致,这是因为损伤的部位、性质、程度和机体的机能状态有所不同,再加上心理因素与既往经历等影响,那就更形复杂。根据临床常见情况,可分为下列两类:

一、脑外伤急性期的精神障碍

脑外伤急性期的精神障碍，有下列几种：

(一) 脑震荡的精神障碍

脑震荡造成的精神障碍，由于创伤程度的不同，其症状也有一定的区别。创伤轻者可没有任何意识障碍，只有短暂的轻度的意识模糊或神志恍惚，短暂的思维困难、缺乏判断力，几分钟或几十分钟内即能完全恢复。创伤较重者，可有短时的意识丧失，经过几分钟或几小时即可清醒；意识恢复后，可感到头痛、头昏、易于疲劳，间有呕吐、失眠等情况；在短期内分析能力不好，注意力不集中，情绪不稳定；有时容易兴奋和激动，可出现欣快感；有时可出现抑郁、恐惧或情感淡漠，对外界事物不感兴趣；症状存在的时间长短，要以受伤的程度而定；轻者可历时2~3周，重者6~8周。创伤更严重者，还可出现更长时间的昏迷或谵妄状态。

此外，一般症状方面，由于脑血液循环障碍所致的血管痉挛、血管扩张、瘀血或脑组织肿胀和水肿的不利影响，在最初几天内，病人可有头痛、眩晕、怕光、耳鸣、恶心、呕吐、尿量增多、排尿困难等。检查时可见眼球震颤，舌尖轻度偏斜，两侧腱反射不对称等现象。

(二) 脑挫伤的精神障碍

脑挫伤与脑震荡相似，脑挫伤可伴有脑震荡，临床上两组症状常合并出现，不可严格区分。但脑挫伤有器质性损害，主要为大脑半球的凸面受伤，局部损害占更主要的地位。因此，局部症状就更为显著和沉重。在本病中，意识障碍最为常见，比脑震荡更为严重。意识的丧失，可在受伤后

立即产生，也可过一段时间才出现。这是因为脑内继发性的出血，或者出血点继续扩大而造成的。这在脑挫伤的诊断上有其特殊意义。在意识障碍方面，可有意识混浊、昏迷、谵妄等不同症状。也可有癫痫状态。意识模糊历时较久而且有反复，意识的恢复需要一个较长的时间。恢复后通常伴有遗忘、头痛、眩晕、混浊状态、嗜睡或失眠、定向力障碍、情绪兴奋、欣快或恐惧、易激惹等。

（三）气压性脑挫伤引起的精神障碍

气压性脑挫伤引起的精神障碍，主要是由于爆炸物所引起的气浪直接冲击头颅，或因大气压力的急剧改变而使头颅遭受损害而造成的。受伤后，病人多处于严重昏迷状态，醒后常出现情感淡漠或情绪不稳定、记忆力障碍等极为明显的症状。在恢复过程中，病人常说急剧头痛，表现躁动不安、焦虑，对噪音不能忍耐。还可看到病人丧失听觉和说话的能力（聋哑症），如不及时治疗或可并发由外伤所引起的心因性障碍，并可持续较长时间。

（四）外伤性昏迷

在严重的脑震荡和脑挫伤时，病人可发生昏迷，对外界刺激均无反应，面色苍白，有时发绀，脉搏缓慢，间或呕吐。如昏迷超过24小时，常标志着有严重的脑挫伤存在；如有脑撕裂伤，则可产生迁延性昏迷。昏迷消失后，病人可表现有意识模糊或混浊、情感淡漠或焦虑、兴奋、躁动不安等症。

另外，脑外伤性谵妄、外伤性意识朦胧，都是在严重的脑震荡和脑挫伤等情况下产生的。当这些症状消失之后，病人都有程度不等的意识障碍和神志恍惚。

二、脑外伤后遗症引起的精神障碍

脑外伤后遗症引起的精神障碍，有如下四种类型；

(一) 脑震荡后遗症

脑震荡后遗症的主要症状如下：

1. 头痛

头痛为最显著亦最常见的症状。头痛常较剧烈，多为钝痛、压痛、尖锐的刺痛或搏动性疼痛。在安静休息或平卧时，头痛减轻；当头部旋转、俯身低头时，或使用脑力、体力时，或精神受刺激时，均可引起头痛或使头痛转剧。

2. 头晕

头晕也是很常见的症状。当病人身体或头部急剧转动时，或突然起身直立或俯身时，常会感到头晕，并且伴有短暂的视力模糊。当用力时头晕增剧并伴有恶心；严重时常感到身体旋转，以及周围物体都在旋转。

3. 敏感性增高。

这是患者对于环境中的各种刺激，如杂音、强光或人声嘈杂常感到不能忍受。

4. 情绪不稳定

情绪容易激动也是常见症状。患者常有显著的焦虑和抑郁症状；受轻微的刺激，常可有过分的恐惧和惊慌感。

5. 神经衰弱症候群

注意力不易集中，记忆力减退，思维迟钝，进行轻微的脑力或体力劳动很快感到疲劳、厌倦，工作能力减退，缺乏主动性和进取心，常独处一隅，不爱与人交往等。

6. 睡眠障碍

睡眠障碍，常见失眠和入睡困难，易惊醒。

7. 神经功能失调

植物神经系统功能失调，如心悸、胸闷、心跳、容易出汗、性机能减退等。神经系统方面，有时可有轻度的眼珠震颤、眼球集合障碍，腱反射亢进，舌及两手震颤等。

(二) 外伤性癫痫

外伤性癫痫是脑外伤比较严重的后遗症，是由于外伤而造成的脑内病变所引起的，它与疤痕的形成有密切关系。痉挛的发作，常在外伤后的几个月至十几年内不等，伤后1~3年发作者为多见，但发作形式不同。在精神症状方面，病人相当过敏，兴奋性增高，情绪不稳定，可出现抑郁或欣快，容易激动而行为粗暴，记忆力减退，对一般事物不感兴趣，发展下去，还可产生精神衰退的现象。

(三) 外伤性脑病

在这类后遗症中，器质性改变比较明显。除脑神经损害及前庭障碍外，可有失用症、失语症、计算不能症、头痛、眩晕等。在精神方面，常有感情淡漠、精神萎靡等症状；但有时也可出现容易激动、注意力不集中、记忆减退、容易疲劳等症状。在有些病例中，可发生关系妄想、迫害妄想及幻觉等，颇类似精神分裂症。

(四) 外伤性人格改变及痴呆

这类现象并不多见，常在伴有长时期谵妄状态的严重脑外伤后产生，它在儿童、老年人和脑动脉硬化的脑外伤病人中较多见。病人言语增多，好与人争吵，情绪不稳，常有阵发性暴怒及冲动行为，有时可表现诙谐和欣快，有时焦虑和恐惧。平时表现为自私，缺乏责任感，孤僻固执，不易与人

相处。儿童患者的性格改变随年龄的增长而日益明显，多为行为乖戾、残暴，说谎，偷窃，好争吵，不守纪律，兴奋性增高，情绪不稳，注意力涣散，学习成绩不好。

在严重病例中可出现痴呆现象，病人精神萎靡，感情淡漠，健忘，但人格变化不明显，无任何社交接触的障碍。

第四节 诊断与鉴别诊断

一、诊 断

对于脑外伤性精神障碍，根据病史、症状和体征，诊断并不困难。脑脊液检查，颅骨 X 照片，脑血管造影、CT 断层摄影等，对于在急性期及时诊断颅骨骨折、颅内出血等改变是很有帮助的。脑电图与气脑造影检查，对于确定远期后遗症病变的性质和程度有重要价值。定期的脑电图复查对照，有助于观察病情的动态。但是，大脑结构的改变（脑萎缩、脑室扩大变形）有时不一定与临床表现相一致。

二、鉴别诊断

诊断脑外伤性精神障碍时，要与以下几种疾病严加区别：

（一）与癔病的区别

二者在出现意识障碍的情况下，临床表现相似，常不易区别。癔病缺乏头颅外伤的病史，但有明显的精神因素，同时有癔病的性格特点和临床特征，如发作时情感鲜明，做作等，神经系统与脑电图检查均正常。

（二）与急性传染病及中毒性精神病的区别

这两种病所出现的谵妄状态，与本病颇为类似。鉴别时应多注意病史、病程经过、躯体证候以及化验特征等。

（三）与神经衰弱的区别

脑震荡后遗症的临床表现与神经衰弱极为相似。但前者在病史中有颅脑外伤的病史，并且在病的产生与精神因素的关系、产生的时间等方面与神经衰弱有显著的不同之处。此外，躯体检查与脑电图的变化也有一定的参考意义。

（四）与癫痫的区别

可根据有无外伤病史、临床表现的特征以及脑电图所见与癫痫相区别。

（五）与其它痴呆症候群的区别

除其它疾病具有其各自的躯体症状的特征可资鉴别外，在外伤性痴呆中，尽管谵妄症比较显著，但患者仍能保持基本的精神活动能力，并没有任何社交能力的障碍。因此，脑外伤性痴呆患者的性格改变不十分明显，可与其它痴呆症候群相区别。

第五节 临床治疗

一、脑外伤急性期患者的治疗

比较严重的脑震荡和脑挫伤，昏迷是其最主要症状，病人对于外界刺激的反应几乎全部消失；昏迷时间的长短，与创伤的轻重有密切的关系，昏迷时间越长（超过 24 小时），就标志着伤势越重。因此，促使患者尽早苏醒，是治疗脑外伤急性期患者的当务之急。

中医一向认为，昏迷是心主受邪、神明失职的表现，但这是对于一般疾病机理的认识。脑外伤患者的昏迷，就不同于一般疾病患者的昏迷，它是脑的经络受损，阻塞神明传导之路，因而产生昏迷症状。所以，在治疗上首先要考虑经络的损伤，特别是督脉的损伤。由于经络损伤，气血瘀滞，阻碍神明，因而昏迷。因此，补督脉，疗伤损，化瘀血，通脑络，就成为根本的治疗法则。

(一) 急性期昏迷患者的治疗

根据不同症状，多采用下列方法：

1. 颅脑外伤、经络损伤、瘀血阻滞的昏迷患者，可用七厘散。

〔处方〕 血 竭 30克 乳 香 4.5克 没 药 4.5克
藏红 花 4.5克 儿 茶 7.5克 朱 砂 6.6克
麝 香 0.6克 冰 片 0.6克

共研为细面，每服 0.3~0.6 克，黄酒冲服，（可以用鼻饲法），不苏再服，以苏为度。

2. 受伤以后立即昏迷的患者，经过一段时间（1~4 小时或更长）清醒随后再度昏迷，呼吸慢而深，血压升高，而色发绀，脉涩（脉来滞涩，至数少于正常），是脑络损伤、颅内瘀血的征象，宜用化瘀通络醒神法。方用化瘀通脑汤。

〔处方〕 琥 珀、血竭末、乳 香、没 药各 1.5克
三七面 1.8克 麝 香 0.3克

共研细末，分三次服，每六小时服一次，温酒或温开水冲服。

3. 病人深度昏迷，面色苍白，四肢厥冷，血压下降，呼吸浅慢或微弱，脉迟缓，是督脉受损，阳气将脱的征象急

宜回阳补督。方用参附汤加味。

〔处方〕人 参 10 克 附 子 6 克 补骨脂 10 克

肉苁蓉 10 克 骨碎补 10 克

水煎两次分服

4. 病人瘀血昏迷(颅内血肿)颅内压高, 发热(体温高), 呼吸迫促, 脉数, 是督脉受损, 不能统帅阳经, 阳气上越, 瘀血化热。宜化瘀清热醒神。方用化瘀清热汤。

〔处方〕泽 兰 10 克 茺蔚子 10 克 赤 芍 10 克

苏 木 10 克 水煎两次分服

每次送至宝丹一丸。

(二) 外伤性痉挛患者的治疗

本病多见于脑挫伤的病人, 在意识障碍的同时, 可有癫痫样发作, 四肢痉挛或抽搐。其病理机制, 多由督脉受损、脑络不畅、风阳上扰而出现痉挛。治宜化瘀通络, 潜阳熄风之法。方用活血熄风汤。

〔处方〕生石决明 24 克 白蒺藜 10 克 泽 兰 10 克

茜 草 6 克 茺蔚子 10 克 钩 藤 10 克

天 麻 10 克 羚羊粉 0.6 克(冲)琥珀末 1.2 克(分冲)

(三) 外伤性聋哑患者的治疗

本病多见于气压性脑挫伤病人。由于在近距离有爆炸物所引起的气浪和巨响冲击头颅, 或因大气压力的急骤改变而使头颅遭受损害。除受伤后的严重昏迷和苏醒后的一系列症状外, 特别突出的是病人丧失听力和说话能力而成为聋哑。另外, 在其它严重脑外伤中, 也可见到失听和失语病人, 其主要病机在于窍络阻塞, 因此, 急于通窍活血。方用通窍活血汤。

〔处方〕赤芍10克 桃仁10克 川芎3克
红花3克 老葱10克 生姜3片
大枣三枚 麝香0.15克（绢包）
水煎黄酒一杯兑服

〔外用方〕（导气通瘀锭）

巴豆一粒（不去油） 斑蝥三个 麝香0.15克
共研细末，以葱涎、蜂蜜和匀，捻成如麦粒大的颗粒，
以丝棉包裹置耳中，可感到耳中声响如雷，不需惊恐，待三周
后耳中可有水样分泌物流出，即可取出药锭。

〔注意事项〕不去油的巴豆与斑蝥均有腐蚀组织作用，包裹丝棉不可太薄，太薄恐腐蚀组织，太厚又恐影响药效，应适当掌握。

（四）脑外伤后的一般症状治疗和后遗症的预防

急性脑外伤患者，经过或长或短的昏迷阶段而苏醒之后，常出现头痛、头晕、怕光、耳鸣、恶心或呕吐、尿频或排尿困难等症状。精神方面，多表现为健忘、嗜睡或失眠、情绪易激动等精神障碍，这些仍是督脉受损、脑络不畅、阳气不布、神明不聪的表现，治宜补督脉，疗伤损，化瘀血、宁神志。方用补督疗伤汤1号。

〔基本处方〕川续断10克 补骨脂10克 肉苁蓉10克
菟藟子10克 泽兰10克 杭菊花10克
生地10克 远志10克 菖蒲8克
琥珀末1.2克（分冲） 血竭末1.2克（分冲）

〔随症加减法〕眩晕耳鸣者加荷叶10克；失眠者加炒枣仁18克；嗜睡者加生枣仁30克；肢体不灵活者加橘络、鸡血藤等。本方不但能治疗急性期的有一般症状的患者，促使其快

恢复，而且对预防后遗症也有一定的效果。

二、脑外伤后遗症患者的治疗

脑外伤后遗症，包括一般脑部损伤基本痊愈但因外伤而造成的慢性症状，大体有如下几种：

（一）脑震荡后遗症

此症常在脑外伤痊愈后，经过一段时间，当患者开始恢复脑力劳动或体力劳动时而出现。出现原因，常与急性期处理不当或过度劳累有关。也可由脑外伤后的精神因素或其它不良因素（如感染、饮酒）的影响而促成。此外，病人的年龄、个性特征、外伤情况和机体状况等对这类后遗症都有一定的关系。

（二）外伤性癫痫

外伤性癫痫系由于外伤造成的脑内病变所引起，它与疤痕形成有密切关系。这类疾患一般在头部枪伤中较为多见，其中硬脑膜的穿刺伤是主要原因。常在外伤后经过相当时期才发生痉挛，时间由几个月至十几年不等。

（三）外伤性脑病

在这类后遗症中器质性改变比较明显，除脑神经损害及前庭障碍外，精神状态波动也较大。此外，还可看到内脏器官活动的改变，出现呼吸、心脏活动失调（假性躯体性障碍）。

（四）外伤性人格改变及痴呆

此类现象多见于较长时间处于谵妄状态的严重脑外伤患者。除儿童外，在老年和脑动脉硬化的病人中比较多见。

尽管脑外伤后遗症有不同的类型，但脑络受损和督脉受

伤的病机是相同的。如果说它们和急性期的病机有所不同的话，那就是后遗症的患者多有病久伤阴、阴虚阳亢、肝阳上扰的征象。因此，在补督脉、疗损伤的同时，又需育阴宁神、潜阳熄风。方用补督疗伤汤 2 号。

〔基本处方〕生龙骨 生牡蛎 肉苁蓉 巴戟天
生熟地 金石斛 川续断 金狗脊
远志肉 羚羊粉

随症加减：头晕、头痛加荷叶、菊花；睡眠障碍加炒枣仁、五味子；肢麻震颤加天麻、白蒺藜；情绪不稳加茯神、合欢皮；嗜睡加生枣仁；痰多加天竺黄。如无严重精神障碍，可减去羚羊粉。

三、病例介绍

〔例 1〕闭合性颅脑损伤

邵×× 男性 25 岁 农民 入院日期为 1966 年 4 月 6 日。

〔问诊〕今日上午九时，患者骑自行车，被一正以每小时 50 里的速度行驶的汽车撞倒，患者左额撞到汽车车窗上，然后坠地，当即昏迷，头出血。九时四十分送至××医院，神志稍清楚些，十余分钟后神志又昏迷，未作处理，随即转院。血压 120/70 毫米汞柱，心率 120 次/分，双瞳等大，头皮裂，右下肢胫骨骨折。

〔处理〕对头皮撞伤清创缝合，将右下肢复位固定，输血 200 毫升。

〔诊断〕闭合性颅脑损伤。右下肢胫骨骨折。

〔望诊〕神志不清，嗜睡，舌红，苔棕黑燥。

〔闻诊〕呼吸尚匀，无痰鸣。

〔切诊〕脉涩。

〔辨证〕督脉伤，脑络损，血滞不畅。

〔立法〕补督脉，疗伤损，活血化滞。方用补督疗伤汤1号，合七厘散。

〔处方〕生龙骨 18克 生牡蛎 18克 当 归 10克
赤 芍 12克 川续断 10克 补骨脂 10克
远 志 10克 菖 蒲 6克 益母草 10克
乳 香 4.5克 没 药 4.5克 郁 金 10克
川 军 3克 七厘散一瓶(分两次冲服)

1966年4月11日，患者神志清醒，能答问，能坐起，自觉头痛。舌质淡红，舌苔白燥。脉弦涩。前方加白芷6克，三剂。

〔例2〕脑挫伤颅骨骨折

苏×× 男性 44岁 工人 入院日期为1966年5月3日。

〔问诊〕患者于今晨十时四十分，自三米高房顶上跌下，右枕部着地，枕后部撞破出血，昏迷不省，无抽搐。经同伴即刻抢救，急送××医院；呕吐4~5次，为血内容物。在当地医院用高张葡萄糖治疗，至中午呕吐好转。据介绍当时能主诉头痛，讲话时能示意。因治疗无效而转院。

颅片颞枕部可见线状骨折。脑脊液检查：压力152毫米水柱；红细胞数20,000/立方毫米；证实蛛网膜下腔出血，收住院治疗。

〔诊断〕脑挫伤，颅骨骨折，蛛网膜下腔出血。

〔望诊〕意识朦胧，舌质紫，舌苔白厚腻。

〔闻诊〕对答不清。

〔切诊〕脉左沉细，右细弦。

〔辨证〕督脉受损，脑络损伤，瘀血阻滞，脑络循行不畅。

〔立法〕补督脉，疗伤损，化瘀血，通脑络。方用补督疗伤汤1号。

〔处方〕生龙骨 18克 生牡蛎 18克 当 归 10克
川 芎 6克 远 志 10克 菖 蒲 10克
郁 金 6克 泽 兰 10克 滁菊花 10克
琥珀末 1.2克(分冲) 三七末 1.5克(分冲)
羚羊粉 0.6克(分冲)

1966年5月9日，患者神志清楚，不欲言，头痛，目不欲睁。舌质淡红，舌苔白厚腻。脉左沉细，右弦滑。

前方去琥珀末、三七末、羚羊末，加桃仁泥10克，川军6克。两剂。

〔例3〕脑震荡后遗症

孙×× 男性 38岁 农民 已婚 吉林省人，初诊日期为1963年8月5日。

〔问诊〕患者在两个月前，被压在翻倒的马车下，右侧面颊擦地，左颞枕部被车压，当时昏厥，右鼻孔出血，急送当地卫生所抢救，七昼夜后始苏醒。醒后自觉头昏沉，两目系作痛，且转动不灵活，全身痿软，不能起床，对外界刺激反应迟钝，入睡困难，睡后遗精不自知。以后转至××医院，诊断为脑震荡后遗症，住院治疗十余日，无明显效果而出院。

〔望诊〕精神呆板，反应迟钝，两目直视；舌质淡紫，

舌苔白腐，根微黄。

〔闻诊〕语声低，语言缓慢。

〔切诊〕脉沉缓。

〔辨证〕脑络受损，督与三阳之脉不得上充于脑，神动于中，精驰于下。

〔立法〕补督脉，疗伤损，涩精安神。方用补督疗伤2号。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生 芪 10克
川续断 10克 金狗脊 10克 补骨脂 10克
鸡血藤 10克 远志肉 10克 石菖蒲 6克
炒枣仁 15克 首乌藤 15克 五味子 6克
干荷叶 10克 三剂

二诊：1963年8月9日。患者精神好转，反应较前敏锐，表情较前活泼，目系已不痛，眼珠转动灵活。近两天睡眠好，没有遗精，语音正常。舌质淡红，舌苔白。脉同前。前方加白芍12克，五剂。

三诊：1963年8月26日。共服药十二剂，精神已正常，睡眠好，未出现过遗精，自觉症状消失，思维能力恢复，能书写家信。根据患者恢复情况，可以暂做轻工作，患者返回原籍。

〔例4〕脑震荡后遗症

田× 男性 28岁 已婚 芭蕾舞演员 初诊日期为1964年9月1日。

〔问诊〕患者于1962年4月演出时跌倒摔伤后脑，当时昏厥，经抢救苏醒。醒后头晕头昏，头痛，肢体倦乏，不能起床。住院20天症状好转而出院。出院后经常头昏，偏头痛，

怕听声音，说话时以手按头，口吃，记忆力减退，技巧不灵，体倦神疲，多睡，两腿乏力。食纳尚可，二便正常。经过几个医院检查，均诊断为脑震荡后遗症，经长期治疗，无明显效果。

〔望诊〕精神不振，面色正常，舌质淡，舌苔薄白。

〔闻诊〕说话口吃。

〔切诊〕脉沉缓。

〔辨证〕督脉受损，肾精少布，脑海不足，神明不聪。

〔立法〕补督脉，疗伤损，滋肾、健脑、强神。方用补督疗伤2号。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生熟地各 10克
川续断 10克 金狗脊 10克 肉苁蓉 10克
远志肉 10克 石菖蒲 10克 五味子 6克
干石斛 10克 杭菊花 10克 羚羊粉 0.6克(分冲)

按前方服药八剂后头痛已止，精神好转，心情愉快。继服四剂头昏消除，并能在诊室内作舞台旋转动作。患者自伤后经长期治疗无效，自认终身不能恢复舞台生活，颇感焦虑；经过中药治疗症状很快消失，精神、体力明显好转，作一些舞蹈基本动作已经没有困难。经过四次门诊治疗，口吃也消失，语言正常。记忆及思考能力已逐渐恢复。

六诊：1964年10月23日。一切症状均消失，精神正常，活动技巧灵便。患者近日欲去部队体验生活，为将来演出作准备。为了巩固疗效，促使患者精神、体力充沛，宗前方配丸药一料继续服用。

〔处方〕生龙骨 30克 生牡蛎 30克 生熟地各 30克

川续断 18克 金狗脊 18克 肉苁蓉 12克
滁菊花 18克 霜桑叶 15克 干荷叶 15克
云茯苓 24克 五味子 12克 远志肉 18克
石菖蒲 12克 羚羊粉 3克

上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每服一丸，一日两次，早晚服。

〔例 5〕脑干损伤后遗症

贾×× 男性 15岁 学生 河北省成安县人，初诊日期为1965年11月10日。

〔问诊〕患者1965年2月13日与人打架，被其母揪着衣领拖着走，后脑着地。其母在盛怒之下，将其头向地上猛磕，患者立即昏厥，约一小时后邻居将患者抬回家，发现后枕部鼓起一包块，大如核桃。昏厥时未经治疗，自行清醒，醒后精神狂躁，哭闹，抽搐。经当地医生注射镇静剂安静约两小时。次日送往县医院治疗，经检查血压200/?毫米汞柱，遗尿不自知，精神仍狂躁；注射镇静剂后，上肢仍舞动不休。住院第三天，鼻出血四次，第一、二次量多，血色暗红。住院一个月，出院时诊断为脑震荡恢复期。出院后仍神志不清，二便自遗。1965年5月18日转邻县医院外科检查，诊断为脑干损伤后遗症；高血压(140/100毫米汞柱)；陈旧性肋骨骨折；建议转院治疗。数月以来病情加剧，近一月昏迷不醒，不知饮食。若用匙子将水灌入口内，或将水泡馒头糊送进口内，经数分钟始能咽下。二便遗不自知。1965年10月底来京，经××医院神经外科检查，诊断为脑外伤性精神病。又转××精神病院，该院认为不适合住院治疗，因而请中医治疗。

〔望诊〕神志昏迷，面色晄白微肿，两目紧闭，瞳孔对光

反射迟钝，唇红，舌质淡红。舌苔白，满布。

〔闻诊〕呼吸正常，未闻鼾声，呼之不语。

〔切诊〕脉弦细略数。左下肢温度较右下肢低。

〔辨证〕督脉损，脑络伤，瘀血阻塞清窍，督与三阳之脉不得上输以充脑海。

〔立法〕补督脉，疗伤损，化瘀血，通脑络，开窍醒神。方用补督疗伤1、2号合方。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生熟地各 10克

川续断 10克 骨碎补 10克 茺蔚子 10克

泽兰叶 10克 当 归 10克 川 芎 4.5克

远志肉 10克 石菖蒲 6克 羚羊粉 0.6克(分冲)

苏合香丸一丸(分服)

二诊：1965年11月13日。服药第二天开始说话，答问正确，睁眼的时间多，能说前额及后脑痛，知大小便，知饥渴，能正常咀嚼吞咽食物。今晨鼻出血，色暗红，量不多。对医生检查能合作，能伸舌；舌质淡红，舌苔白。脉滑数。血压110/70毫米汞柱。

前方加鲜茅根30克，三剂。

三诊：1965年11月22日。患者今日由家属扶持步行就诊，神志清醒，自称仍有头痛、腿痛。鼻未出血，舌质淡红，舌苔薄白。脉弦细。

前方加珍珠母24克、白蒺藜10克。

四诊：1965年12月17日。患者精神继续好转，已能扶墙自去厕所。除有些头痛外，已无明显症状。本月11日鼻出血一次，仅流几滴即止。舌质淡红，舌苔少，脉细弦。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生熟地各 10克

赤芍 10克 当归 10克 羌蔚子 10克
泽兰叶 10克 川续断 10克 滁菊花 10克
荷叶 10克 肉苁蓉 10克 白蒺藜 10克
丹皮 6克 川芎 6克

1965年12月30日，患者欲返原籍，但仍有轻微头痛，嘱其继服前方。

1966年2月11日，患者家属来信称，患者精神正常，除有时感觉头晕和记忆力尚未完全恢复外，已无其它明显症状。

〔例6〕脑挫伤后遗症。

黄×× 男性 28岁 已婚 吉林省人 包钢厂技术员
初诊日期为1964年11月13日。

〔问诊〕患者于1964年2月20日在车间工作时，被吊车击中后脑，当即昏迷，鼻腔及右耳道出血不止，急送当地矿务局医院抢救。用各种方法止血无效，随后采用鼻腔加压止血法，三天后出血减少。至第七天又出血不止，血压下降至45/0毫米汞柱。输血670毫升，继续采用高压止血法，逐渐血止。连续抢救20余日，从昏迷中逐渐苏醒。醒后头昏，头胀痛，右眼突出，视力模糊，右耳聋。怕听声音，连听到别人一般说话声音也感觉痠麻串胀难过。不能说话，说话时必需用手按着耳门处，否则头内震痛。经长期住院治疗症状不减，至1964年7月21日转院治疗。经××医院X线照片检查及脑电图检查，发现颅骨骨折线达到颅底位；脑挫伤未完全治愈。临床诊断为Ⅲ颅脑损伤。住院治疗两个月，1964年9月21日第二次检查发现后脑神经系统一部分压缩；右眼底视乳头水肿，眼球明显突出；颅骨骨折，挫伤部分仍未痊愈。由于患者症状无明显好转，建议再转院治疗。曾转至××医院

神经外科及××医院脑系科，均诊断为颅脑外伤后遗症，不宜手术，始来中医院治疗。

〔问诊〕现在头闷痛，头中如有物压着，手不敢摸头发，摸头发时头中发麻很不舒服，怕听声音，不敢说话，说话时必须用手按着耳门，听到声音或自己说话时头内非常难过。右耳聋，耳内作响。右眼视物模糊，看东西头痛，晚间看灯光一片昏黄。吞咽饮食时，自觉左侧咽部下咽不顺利。记忆力衰退，不能思考，对事物反应迟钝，不能阅读和书写。两手颤抖，因头痛影响睡眠，眠后常因头痛而醒，阴雨天头痛加重。

〔望诊〕精神不振，面容痛苦，右眼突出(较左侧高出12.5毫米)，喉结向右侧倾斜。舌质淡红，舌苔薄黄。

〔闻诊〕声音低浊，语言迟缓。

〔切诊〕脉沉细略弦。血压110/80毫米汞柱。

〔辨证〕督脉与脑络损伤，阳气与阴精不足以上充于脑，虚阳上扰，神智失聪。

〔立法〕补督脉，疗伤损，育阴潜阳，清神益智。方用补督疗伤2号。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生熟地各 10克
川续断 10克 金狗脊 10克 巴戟天 10克
麦门冬 10克 干石斛 10克 五味子 4.5克
远志肉 10克 石菖蒲 6克 双钩藤 6克
滁菊花 10克 羚羊粉 0.6克(分冲) 四剂

二诊：1964年11月18日。患者自称服药后2~3小时觉头中有热感，头两侧似有气上冲，随后头顶向下压的感觉即消失，第二天头痛胀闷明显减轻，右侧颞部压痛(受伤时右侧

颞部着地)已不明显,右眼鼓胀感觉已无。自觉头脑清楚,心情舒畅。舌质淡红,少苔。脉沉弦细。仍以前法加荷叶10克 五剂

三诊:1964年11月24日。服上方第一煎后,右侧颞部内有跳动感觉,约4~5分钟跳动停止。此后头沉、头胀闷、头痛等感觉均不明显。自前日,在无明显诱因的情况下,左足背及足3~4趾皮肤突然变成棕紫色,微肿痛(可能为瘀血顺经脉下行之故),手心多汗。舌质淡红,舌苔薄白。脉沉细。

〔处方〕前方去荷叶,加茺蔚子10克 泽兰叶10克

四剂

五诊:1964年12月6月。头痛、闷胀等感觉已消失,右眼视力已明显好转;手已不颤,能书写,字迹端正;手心未出汗;足背足趾肿痛渐消,皮色已转为正常。睡眠安好,精神愉快。视力检查:左1.2,右0.7。舌质淡红,舌苔薄白。脉细滑。前方继服。

至1965年1月4日,经门诊治疗50天,症状消失,记忆思考能力已恢复,能够长时间阅读,已能写长篇书信,能够与人畅谈,逻辑性很强,突出的右眼已恢复与左眼相等。至此患者欲还乡。为了巩固疗效,配丸药继续服用。

〔处方〕生龙骨 60克 生牡蛎 60克 川续断 30克
金狗脊 30克 巴戟天 30克 肉苁蓉 30克
远志肉 30克 石菖蒲 18克 熟地 45克
全当归 30克 枸杞子 45克 滁菊花 30克
炒枣仁 60克 五味子 18克 干荷叶 30克
羚羊粉 4.5克

共研细末,炼蜜为丸,每丸重10克,每服一丸,一日两

次，早晚服。

〔随访〕1966年2月患者复信：1965年5月患者已恢复原来工作(设计画图)精神充沛，两眼视力均恢复为1.5。没有任何后遗症。

〔例7〕外伤性癫痫

吴×× 男性 35岁 伊春市××厂计划科干部 初诊日期为1964年12月15日。

〔问诊〕患者在1961年12月工作时，头部突受外伤，当即昏迷，急送伊春市××医院，由于颅脑伤势严重，立即实行开颅手术。手术数天后始清醒。住院期间，曾有数次癫痫发作，先是突然昏厥，继之四肢抽搐，小便失禁。出院后两年多未见癫痫发作。1964年7月18日突然发病，先大叫一声，随即昏倒，口眼向左斜，左上肢开始抽搐，继则全身抽搐，咬破舌腮，口吐血沫，经十余分钟抽搐停止，昏睡约半小时始清醒。醒后全身疲倦无力，头晕昏沉。而后至1964年11月又有四次发作，情况与上次相同，但小便未失禁。平时头痛，头晕，睡眠尚可，时有恶梦，饮食及二便均正常，记忆力完好。曾在××医院检查，神经系统大致正常，无颅内压增高症；癫痫发作可能系脑外伤后颅内血肿的遗留现象，与脑部伤及疤痕有关，诊断为外伤性癫痫。

还曾去××医院神经外科检查，结果是：右颞肌减压后肌力不高，神经系统正常，脑电图 { 右颞前 θ 波 不宜手术治疗。
双额棘慢波

〔望诊〕面色正常，头部左侧有手术疤痕。舌质淡红，舌苔薄白，舌边有齿痕。

〔闻诊〕语音正常。

〔切诊〕脉细滑。

〔辨证〕头为诸阳之会，脑为诸髓之海，督脉上贯巅顶，督脉损伤，脑海不足，风阳上扰，致使癫痫发作。

〔立法〕补督脉，疗伤损，熄风止痛。方用补督疗伤2号加减。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 紫石英 10克
肉苁蓉 10克 金狗脊 10克 川续断 10克
远志肉 10克 石菖蒲 6克 茯苓 10克
朱寸冬 10克 明天麻 6克 钩藤 10克
石斛 10克 天竺黄 10克 羚羊粉 0.6克(分冲)

前方加减共服40剂。在治疗过程中，12月24日曾有一次癫痫发作。观察至1965年4月16日，即三个月零23天没有发作，患者返乡。

〔函访〕1965年11月20日，患者复信，在当年6月即恢复原来工作；癫痫没有发作，但在7~10月之间曾有两次发病前兆，自觉不适即急速卧床，经过数分钟不舒适感即消失。

〔例8〕外伤性脑病

崔×× 男性 56岁 黑龙江双鸭山矿务局工人 初诊日期为1963年9月20日。

〔问诊〕患者于1960年9月从载重汽车上摔下，昏迷约两小时，苏醒后头痛、头晕、脑胀、目花。十日后，患者骑自行车外出，因一赶马车人将马鞭缠于崔的自行车把上，崔连人带车一齐栽入路旁沟中，当即昏迷，口鼻出血，前齿撞落，急送当地医院，经抢救四小时始苏醒。经检查：颈椎骨折，右上肢丧失活动能力。自觉头痛、头昏，住院十余日出院。出院

后经常头痛，头昏，头胀，右眼视力减退，右耳聋；左半身麻木，运动不灵；右眼逐渐失明，言语不利，嗅觉消失，精神呆板，对事物反应迟钝，有时精神狂躁，喊叫。至1961年病情加重，同年11月28日住入×××医学院附属医院。做神经系统检查，无脑膜刺激征，脑神经双侧嗅觉全丧失，左眼视力正常，右眼前手动；左面部轻感觉消失，其它颅神经正常，左上下肢肌力减弱，左半身深浅感觉均消失，协调动作不好，腹壁反射存在，肱二、三头肌、膝腱反射均存在，病理反射阴性。X线胸部透视正常。气脑造影所见：右侧大脑皮质有萎缩现象，其它未见异常，无颅压增高及占位病变。脑脊液检查：坐位脑压200毫米水柱；外观清明。常规化验：潘氏(-)，氯化物720毫克%；细胞数10个以下。其它化验均正常。诊断为外伤性脑病，建议长期休养，对症治疗。住院十天，于1961年12月8日出院。

患者于1962年3月去×××医科大学附属医院，仍诊断为颅脑损伤后遗头痛，建议同上。一月前又去天津××附属医院，诊断处理意见同前。

现在患者头痛、头昏、脑胀(昼夜头戴健脑器，不能摘除)，左眼花，右眼失明。左侧肢体不遂，行路需架双拐，颈项强直不能转动。语言不利，精神有时狂躁，时或高声喊叫，对事物反应迟钝，记忆衰退，睡眠少，饮食量少，小便频数，尿后余沥不尽。大便6~7日一行。

〔望诊〕精神痴呆，面无表情，头戴健脑器，手架双拐。舌质淡，舌苔白粗糙。

〔闻诊〕言语不利且不连贯。

〔切诊〕脉沉细略数，双尺部弱。

〔辨证〕脑为髓之海，头为诸阳之会，督脉上贯巅顶，因跌而伤及头脑，督脉受损，阴精不得上贯，脑海不足，阳气浮越，虚风内动。

〔立法〕补督脉，益阴精，潜阳熄风，加安神宁志之品。方用补督疗伤2号加减。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生熟地各 15克
枸杞子 12克 杭白芍 12克 干石斛 12克
肉苁蓉 10克 麦门冬 10克 远志肉 10克
石菖蒲 3克 炒枣仁 15克 五味子 6克
首乌藤 15克 橘 络 6克 羚羊粉 0.6克(分冲)
三剂

二诊：1963年9月24日。患者服第一剂药后，有微汗出，自觉头中有蚁行感，当晚睡眠安稳。醒后头脑清晰，颈项也能转动。次日心情舒畅，言语突然清晰，肢体灵便，行动轻快。三天来饮食增加，大便一日一行，小便畅通，尿频也减。今日就诊，语言流利，能补述已往病情经过。舌质淡红，舌苔白粗糙。脉细滑。

〔处方〕前方加杭菊花6克。

1963年10月10日，患者头已不痛，健脑器也摘除，自觉头脑清楚；但乘坐公共汽车，在开车和停车时头部感觉不适。左侧肢体运动灵便，最初去掉双拐感觉膝软，行走不利，改扶手杖，经过不断锻炼，离开手杖也能行走，但不能持久。经常自行外出散步。舌质淡红，舌苔薄白。脉细。

前方去杭菊花，加桑寄生18克，鸡血藤10克继服。

1963年11月9日，患者精神已正常，运动机能已恢复，嗅觉和视力也明显好转。因患者不愿做气脑造影复查，经×

×医院脑电图检查，广泛轻度异常，颅内占位病变可以除外。

经前方加减治疗两个月，患者于同年11月中旬愉快返乡。

〔例9〕外伤性人格改变

高×× 男性 15岁 初中学生 初诊日期为1970年8月20日。

〔问诊〕患者六岁时后枕部碰于石阶上，头皮撕裂出血。当时仅做一般处理，未被人重视。此后逐渐智能减退，性格乖戾，自入学后成绩一直不好，至15岁始入中学。上课胡闹，不遵守纪律，注意力不集中，情绪不稳，有时兴奋性增高。曾用椅子将同学打伤，老师制止不住，事后也不承认错误。在家经常和弟弟打架，常把别人的玩具抢过来毁掉。个人没有什么爱好和要求，母亲强迫他做些家务劳动，也不能很好完成。

〔望诊〕体格发育良好，精神涣散，坐不端正。

〔闻诊〕说话口齿不清，不能做简单诵读。

〔切诊〕脉细滑。

〔辨证〕幼年因颅脑外伤，督脉受损，阴精阳气上贯不足，脑髓不充，致智能低下。

〔立法〕补督脉，疗伤损，充脑益智。方用补督疗伤2号。

〔处方〕生龙骨 60克 生牡蛎 60克 熟地 30克
石斛 24克 麦冬 24克 炙龟板 24克
川续断 24克 肉苁蓉 24克 远志肉 24克
菖蒲 18克 益智仁 18克 杭菊花 18克

干荷叶 18克 羚羊粉 10克

上药共研细末，炼蜜为丸，每丸10克，一日两服，每服一丸，早晚服。

1970年11月10日，按前方服药两剂，行为、智能两方面均有所改善，学习有进步，也能主动向父母谈学习情况。前方加减继续服用。

1970年12月29日，患儿自行就诊，见人有礼貌，举止端正。自称学习有进步，除数学成绩较差外，其它功课尚好。能主动提问，也能详细述说学习情况和家庭情况。

第六节 治疗体会

随着医学科学的不断发展，医疗技术水平的不断提高，对于脑外伤的治疗，在临床上有很大的创新。尤其现代医学神经外科方面不断跃进，颅脑手术水平不断提高，使很多危重病人得以转危为安，这是十分可喜的。但是，关于防止和治疗颅脑外伤后遗症的文献报导却是寥若晨星。这一薄弱环节，需要医务人员共同努力加以克服。

中医关于脑外伤的治疗记载，古今文献上都很少。根据临床实践经验，我认为中医关于脑为髓海，为肾所主，与诸阳经脉皆会于头的理论，既肯定经络与脑的关系，又指出这些经络在头部的活动都是在督脉的监督之下进行的，这就为脑外伤的病理奠定了基础。通过肾、脑、督脉三者之间的密切关系，我认为颅脑遭受外力冲击或震荡，势必导致督脉和诸阳脉的损伤；由于各经络的损伤，必然妨碍诸阳脉的正常循行和造成督脉失司，因而肾精不能上布于脑，经络阻塞，神

明传导无路，从而出现种种躯体与精神症状。据此，在治疗上按照“补督脉，疗伤损，化瘀血，通脑络”的法则；结合损伤的部位、程度、性质以及躯体状况，予以辨证施治，就能收到良好效果。

根据临床实践，我的体会是：脑外伤急性期患者，由于脑血管受外力的猛然冲击而破裂，瘀血水肿，脑络不通，阻塞神明传导之路，昏迷是其主要症状，这时急应以化瘀通络为主；在后遗症阶段，由于脑络受损，阴精不得上布或疤痕形成而引起的精神障碍，这时应以补肾益精、育阴通络为主。如有阴虚阳亢，肝风内动，又须平肝熄风。至于补督脉疗伤损的原则，几乎应该贯彻整个治疗过程。这是因为“脑为髓海”，“督为诸阳之总督”，脑海充实则轻劲多力，思维灵敏；而这些能动的源泉，均赖肾中所生之精髓的上注，而肾中所生之精髓如何上注于脑，全赖督脉之运行，脑得髓补，则精力充沛。补督的目的，在于恢复督脉的功能，使肾精得以上注于脑，不致使损伤之脑中断营养。另外，督脉修复以后，又能发挥其督理的作用，使诸阳脉不致浮越无束而出现阴虚阳越之象。因此，补督脉，疗伤损，滋肾阴，为脑力的功能恢复提供可能的条件，因而达到消除症状、缩短病程的目的。

将治疗脑外伤的理论应用于颅脑手术后遗症的治疗，也取得一定的疗效。

第五章 躯体疾病所致的精神障碍

各种内脏疾病、代谢障碍、维生素缺乏症、内分泌疾病等躯体疾病，除躯体症状之外，还可出现精神障碍。精神障碍是作为这些躯体疾病的部分症状而出现的，因此，也称为症状性精神病。

躯体疾病所致的精神障碍，一方面随着躯体疾病的不同而有所不同，但不同的躯体疾病却可能有相同的精神症状。躯体疾病可能引起的精神障碍主要有以下几种：

(1) 意识障碍。包括从意识模糊、嗜睡一直到昏迷状态的各种不同程度的精神障碍，以及谵妄状态、精神错乱等。

(2) 记忆障碍。包括记忆减退、虚构和由于记忆减退引起的定向力障碍等。

(3) 智能障碍。包括器质性痴呆和假性器质性痴呆。

(4) 情感障碍。包括情绪高涨、情绪低落、焦虑、情绪不稳定、易激惹、欣快等。

(5) 思维障碍。包括关系妄想、被害妄想、疑病妄想等。

(6) 知觉障碍。主要有幻听，并往往在幻听的基础上出现被害妄想。

躯体疾病所致的精神障碍，主要是由于下列各方面的原因引起大脑功能紊乱而出现的。这些原因是：体内中毒，如肝昏迷、尿毒症等；大脑缺氧，如心力衰竭；长期营养不良，如维生素缺乏症；代谢障碍，如内分泌紊乱。

这类由躯体疾病引起的精神障碍，大多数患者的精神症状是随着躯体疾病的好转而好转，预后一般是良好的。但也有个别患者在躯体疾病好转之后遗留一些精神障碍，如幻觉症、记忆障碍、智能障碍等。所以，对躯体疾病的辨证治疗，就是对躯体疾病所致的精神障碍的治疗。

第一节 心脏病所致精神障碍 的症状及治疗

一、症状及治疗方法

这类精神障碍多在心力衰竭引起脑缺氧的情况下出现。早期表现为疲惫无力，注意力不集中，记忆减退，失眠等；继而情绪不稳，焦虑，紧张，恐惧，易激惹或呈现类抑郁状态，有的产生疑病观念。部分病人可出现幻觉和妄想，内容多不固定。脑缺氧状态加重时，可出现意识障碍，多伴有紧张、恐惧情绪的谵妄状态，病情加重则进入昏迷而死亡。躯体症状的特征早期可见呼吸喘促，脉率不整。严重时则表现呼吸困难，口唇发绀，出现结代脉。治疗原则以补益心气为主，盖心主血脉，肺主呼吸，心气衰弱，鼓动无力，气来不匀，血行不畅，故出现结代脉及呼吸困难等一系列症状。临床常用方剂生脉散及炙甘草汤化裁，随症加减治疗。如心气得以补益，诸症自然缓解。

二、病例介绍(心力衰竭所致精神障碍)

王××，女性，62岁，初诊日期为1964年7月23日

〔问诊〕患者素有风湿性心脏病，前日受凉突然恶寒战慄，发热汗出，心悸气短，喘息发作，不能平卧，影响睡眠，时时恐惧，焦虑不安，不进饮食。当日下午三时，呼吸困难，面色青紫，病势危急，当即送××医院急诊。诊断为风湿性心脏病、急性支气管炎、急性心力衰竭。经抢救病情稍有缓解，但未脱离危险，随抬来转院急诊。

〔望诊〕精神萎靡，面色晦暗，两目直视，呈半虚脱状态。舌质淡红，舌苔薄白。

〔闻诊〕语音低微，气短喘促。

〔切诊〕两脉微数而代。

〔检查〕体温38.4℃，血压100/60毫米汞柱，肺部高鼓音，心界向左扩大，心率124次/分，心律不齐，每分钟4~5次间歇，心尖部可闻3~4级双期杂音。主动脉第二音大于肺动脉第二音，双肺满布干鸣音，两肺底有中小水泡音；肝下缘可触及，双下肢有明显凹陷性浮肿。

〔辨证〕素体阴虚，复感外邪，心气不足，肺失肃降。

〔立法〕急以补虚固脱，养阴强心理肺。

〔处方〕西洋参6克 麦冬12克 远志肉10克
川贝母12克 百合12克 杭芍30克
竹茹10克 白前4.5克 双花15克
花粉15克 生甘草3克 两剂

服药两剂后，精神好转，恐惧及焦虑不安等现象已不明显，气短心悸减轻，喘止，咳嗽有少量白痰，热退，汗出已止。饮食增加，二便匀调，惟感疲乏无力，口渴喜热饮。舌质淡红，苔薄白，脉沉滑。体温36.4℃，心率64次/分，偶见早搏，肺听诊干鸣音，未闻及明显水泡音，肝未触及，下

肢浮肿已消。改为补气养血、滋阴清肺。

〔处方〕 生黄芪 30 克 当归身 10 克 杭 芍 30 克
生 地 12 克 元 参 10 克 沙 参 12 克
川贝母 10 克 远志肉 10 克 石 斛 12 克
橘 红 12 克 竹 茹 10 克 青 蒿 10 克
杏仁泥 10 克

按此方服药后心力衰竭及精神障碍症状均已消失。

〔病例分析〕患者平素患有风湿性心脏病，由于呼吸道感染诱发心力衰竭。感染发热使心脏负荷增加，感染毒素对心肌起不良影响；感染时心动过速，心肌舒张期缩短；呼吸道感染时咳嗽所产生的暂时性肺动脉高压，等等，均对有病变的心脏特别是对右心引起过度的负荷，因而导致心力衰竭。临床表现的恶寒发热为外感症状；心悸、气短、汗出为心气虚卫外不固的症状，但素质及舌脉又体现出阴虚证象；喘息、不能平卧，为肺气因外邪侵犯而失清肃下降之职的症状；时时恐惧、焦虑不安等精神障碍，为心的气阴两亏而引起的心神失守的症状。从四诊的综合情况来看，在立法上急以补虚固脱为主，即以扶正为主，佐加理肺药，即祛邪为补。药后热退，喘平，随着心力衰竭的好转，精神症状也消失。

第二节 肝脏病所致精神障碍的 症状及治疗

一、症状及治疗方法

肝脏病所致的精神障碍，大多出现于肝昏迷前期的患

者，常为肝昏迷的前驱症状。少数病人在进入肝昏迷之前，还可有阵发性意识模糊；急性黄色肝萎缩患者，可发生谵妄现象。肝脏病产生精神障碍的主要原因，是由于肝脏受到严重损害，不能清除血液中有毒的代谢产物造成的；或由于门、腔静脉之间有手术分流或自然形成的侧枝循环，门静脉血中的有毒物质绕过肝脏进入人体循环，而致中枢神经系统代谢紊乱所引起的。此症常见于肝硬化及重型病毒性肝炎患者。

患者开始发病，多为不同程度的意识不清，全身无力，反应迟钝，言语动作缓慢，接触不好，嗜睡，但定向力尚好。接着可过渡为混浊状态或谵妄状态，这时定向力欠佳，接触更不好，常出现不可理解的行为和动作，也可出现错觉或幻觉，因而恐惧、紧张、喊叫、躁动不安，继而进入昏迷，若抢救不及时则死亡。

当患者出现精神障碍时，已预示毒邪蒙闭清窍，进一步即可导致肝昏迷。治疗原则，急需以解毒开窍为主辨证治疗，根据临床不同情况，可选用牛黄安宫丸、紫雪丹、局方至宝丹、玉枢丹等。

二、病例介绍

〔例1〕急性传染性肝炎并发急性肝昏迷

蔡×× 男性 1岁半 会诊日期为1962年9月5日。

〔问诊〕患儿大便色白，小便茶红色，已一周。经××医院检查，诊断为急性传染性肝炎，于9月3日收入院。9月4日病情突然变化，患儿狂躁不安，并发急性肝昏迷，经抢救一夜未见好转，故请中医会诊。

〔望诊〕神志不清，昏不识人，狂躁不宁。舌质红，舌

苔微黄而厚。

〔闻诊〕狂呼乱叫不停。

〔切诊〕脉数。

〔检查〕全身皮肤及巩膜黄染(++)；两目充血，分泌物多；腹略胀；肝大在右肋下1.5厘米，剑突下2.5厘米，质软；脾未触及；肝功能化验：胆红素3毫克，黄疸指数30单位，凡登白试验阳性，麝香草酚浊度试验，13单位；尿化验，尿三胆强阳性。

〔辨证〕湿热蕴毒，邪蒙清窍，扰及神明。

〔立法〕清利湿热解毒，开窍醒神。方用茵陈栀子汤加味。

〔处方〕金银花6克 连翘4.5克 川连3克
大青叶3克 生栀子3克 茵陈6克
紫雪散1.2克(分三次服)一剂

二诊：1962年9月6日。昨日服药6小时后，患儿渐转安静，神志半清醒，对四周事物有反应，稍进饮食，未吐。今日神志转清，惟精神较弱，略显呆滞。能坐起玩耍，已认识人，有时哭闹要东西吃。舌脉同前，以上方加减。

三诊：1962年9月8日。精神已正常，食纳已佳，二便自调，舌无苔，脉细数。以后仍用清利湿热的茵陈栀子柏皮汤加减，同时配合维生素口服。至9月20日黄疸消失，10月8日检查肝功能恢复正常。

〔例2〕肝豆状核变性

崔×× 男性 38岁 邮递员 初诊日期为1966年3月19日。

〔问诊〕患者于1964年6月在送信时，自行车倾倒砸伤右

脚，经××医院诊断为足腱撕裂，住院治疗近一年。住院期间发现两上肢颤动，出院后尚能工作。近两月来发现精神痴呆，语言不利，口流涎水，两上肢震颤，以致吃饭时不能持碗筷。两下肢软而无力，身体前倾，走路易跌跤。卧床时自己不能翻身，小便自遗，生活不能自理。经××医院检查，诊断为肝豆状核变性。

〔望诊〕精神痴呆，面无表情，头向前倾，两手震颤。舌质红，舌苔白，口流涎水。

〔闻诊〕语言不利。

〔切诊〕脉象弦。

〔辨证〕阴虚阳亢，风阳上扰，横窜经络。

〔立法〕养阴潜阳熄风。方用止颤饮。

〔处方〕生龙骨 18 克 生牡蛎 18 克 玳瑁 6 克
白蒺藜 10 克 滁菊 10 克 钩藤 10 克
桑寄生 24 克 远志 10 克 菖蒲 6 克
佩兰叶 10 克 宣木瓜 10 克 荷叶 10 克

二诊：1966年3月25日。今日就诊精神好转，面部有表情，上肢颤抖已减轻，下肢有力，走路没有跌跤，语言较前清楚，未见流涎水，惟仍遗尿，舌质紫红，苔白多津。脉仍弦。

〔处方〕前方加菟丝子10克。

三诊：1966年4月5日。今日自己来医院就诊，精神已恢复正常，下肢走路已有力，一周来未遗尿。

〔病例分析〕

例一为暴发型肝炎，症状急转直下的肝功衰竭，病人在数日内进入肝昏迷。其精神症状，除狂躁不安、昏不识人之

外，与肝硬化病程较长的肝性昏迷略有不同，即从轻微的精神改变到深度昏迷的四级阶段不明显。但无论有何不同，肝昏迷前的精神症状皆为邪蒙清窍、扰及神明而产生的。所以，治疗本病要用开窍醒神的药物，方中清利湿热解毒之品是治疗急性黄疸性肝炎常用药物，其中紫雪散用为开窍醒神，药后精神症状消失。此后即以治黄疸性肝炎常用的梔子柏皮汤治疗，直至肝功能正常。清利湿热解毒为治本法，开窍醒神为治标法；所谓急则治标，缓则治本，而本例辨证为湿热蕴毒，为病之本，但湿热之毒邪已蒙蔽清窍，进而扰及神明，为病之标，所以本例中立法、方药为标本兼治法。

例二为肝豆状核变性，按一般精神科常规，本例不属于躯体疾病引起的精神障碍，但根据本病的特点，无论病因和病理及临床表现的一系列精神神经症状，均与症状性精神病极为相似，故将本病置于肝脏病之后，以与同道们商榷。本例的辨证，根据患者下肢软、头向前倾的特点，为下虚上实之症。舌红，脉弦为阴虚阳亢，即阴虚于下，阳亢于上；语言不利，口流涎水，为风阳上扰；肢震颤为风阳横窜经隧。故立法以养阴潜阳熄风，方中生龙骨、生牡蛎、玳瑁三味药的特长是滋阴潜阳，作为治本病的主药。白蒺藜、滁菊花、钩藤为熄风必需之品。方中重用桑寄生补肝肾之阴而有强筋骨的作用，配木瓜横走经隧。远志能使肾气上达于心，配菖蒲开心窍，且二者相配伍还能治语言不利。配用佩兰叶、荷叶，取其二者均能清轻上浮，以安风阳上扰之势。通过辨证治疗，使此顽固的症状在短期内消失。

第三节 肾脏病所致精神障碍的 症状及治疗

一、症状及治疗方法

这类精神障碍是由于尿中毒，体内的代谢产物排泄不良而引起的。目前认为尿毒症症状与多种物质代谢紊乱有关，如氮质等代谢产物滞留；水盐代谢及酸碱平衡紊乱等。早期常出现头昏、头痛、乏力、失眠、性情变化和注意力不集中等症，以后则出现嗜睡、精神萎靡、表情呆板、视力障碍等症，严重时可出现精神错乱、谵妄、骚动不宁甚至惊厥、昏迷，肌力变化常出现强直、抖动及抽搐。

其治疗原则是调整三焦，其中最重要的是加强肾脏的排泄功能。因为三焦有通调水道，下输膀胱，运行水液的作用。三焦决渎功能是联合许多脏器而发挥作用的，其中主要是肾、脾、肺三脏。肾主水液，经气化而渗入膀胱，肾的功能衰弱，水液不能气化亦不能排泄。脾主运化，消化饮食，输布营养，蒸化津液，脾失转输作用，水湿亦易停留。肺为水之上源，水液之通调，全靠肺气的宣通。所以，通利三焦是治疗尿毒症的有效疗法。常用方剂三仁汤化裁，恶心呕吐甚者，以温胆汤加利尿之品。

二、病例介绍(尿毒症所致的精神障碍)

王×× 女性 60岁 农民 初诊日期为1963年4月10日。

〔问诊〕患者于五天前在村外劳动，自觉雨后受寒而感

头痛、腰痛，发热，恶风无汗，胸闷气喘，当时未作治疗。两、三天后病势加重，小便闭涩不通，颜面及全身浮肿。精神疲乏，嗜睡，恶心呕吐。经××医院诊断为尿毒症，治疗无效而转我院治疗。

〔望诊〕精神萎靡不振，嗜睡，全身呈高度水肿，两目如缝，腹部隆起，但脐不凸，两下肢肿若穿靴。舌体稍胖，舌质淡红，舌苔薄黄而腻，舌面水滑，口流涎。

〔闻诊〕语言无力，呼吸气促不匀。

〔切诊〕脉弦滑而数。

〔检查〕体重64公斤，腹围94厘米，血压130/80毫米汞柱；尿蛋白(++++)，红血球1~2，白血球5~8，脓球20~40，甚则成堆，上皮细胞满视野，透明管型0~1，颗粒管型2~3；血常规正常；血中非蛋白氮为128毫米%，二氧化碳结合力130容积%；肌酐2.18毫克%，尿培养，大肠杆菌阳性。

〔诊断〕急性肾炎，尿毒症，合并泌尿系感染。

〔辨证〕寒邪束表，水湿内蕴，郁而化热，致使湿浊泛滥，弥漫三焦。

〔立法〕先以芳香化湿，后以清热利尿。方用三仁汤加减。

〔处方〕藿香叶10克 佩兰10克 黄芩10克
生苡米12克 半夏10克 生姜三片
杏仁泥10克 白蔻仁10克 滑石块12克
抽葫芦30克 两剂

药后精神好转，利下稀便如糜，日行10余次，尿量增至800~1200毫升。舌苔黄渐退，症系湿热未清，脾失健运。以健脾清利湿热。方用温胆汤加减。

〔处方〕鲜茅根30克 滑石块12克 陈皮10克

清半夏10克 云茯苓12克 生 草3克
炒白术 10克 枳 实 4.5克 竹 茹 10克
泽 泻 10克

每日服药一剂，连服15剂后，精神良好，饮食如常，尿量渐增（1200~1400~2000毫升）浮肿全消，体重降至53公斤，腹围减至83厘米，血压正常。

〔化验〕尿蛋白（±），红血球0~1，白血球0~2，脓球（-），上皮细胞2~4，管型（-）；血中非蛋白氮，40毫克%，二氧化碳结合力56容积%；肌酐1.42毫克%；酚红试验，2小时排出55%。

〔病例分析〕本例为急性泌尿系感染、急性肾炎，由尿毒症所引起的精神障碍。所以，精神障碍的程度较慢性肾功能衰竭尿毒症为轻，仅有精神萎靡、嗜睡等症状。从中医的辨证观点看，临床表现最突出的为头痛、身痛、发热、恶风、无汗等一系列外感寒邪束表症状，且又有外感受凉史。足太阳膀胱经主一身之表，为水之下源，寒邪束表后，除临床表现头痛、身痛、腰痛、发热、恶风、无汗之表证外，尚有水湿不能气化之小便闭涩不通，颜面及全身浮肿的水湿内蕴之症。脾阳为湿困不能运化，则恶心呕吐；脾阳不振，故精神萎靡而嗜睡。湿为浊邪，最易化热弥漫三焦；肺为水之上源，水湿泛溢波及上焦，肺亦受其邪而失清肃下降之能，故有胸满而气喘。此证既有寒邪之表证，又有水湿内蕴弥漫三焦之里证。所以，方中以藿香、佩兰二味芳香化浊以透表，兼有止呕之效；黄芩清热燥湿；杏仁开上焦肺气；半夏、薏仁宣化中焦湿浊畅利气机；苡仁、滑石渗利下焦之湿而泄热；重用抽葫芦利水消肿，药后取得满意的疗效。随着病势

的好转，精神也转为良好。

第四节 糖尿病所致精神障碍的 症状及治疗

一、症状及治疗方法

糖尿病是一种常见的内分泌疾病。其基本病理为绝对或相对的胰岛素分泌不足所引起的糖、脂肪及蛋白质等代谢紊乱。糖尿病患者的精神障碍，是由长期的代谢紊乱所引起的。常出现衰弱状态和抑郁状态，并有疑病倾向。病情严重则出现意识障碍，一般先有谵妄状态，然后进入昏迷状态。糖尿病性多发性神经炎病人，有时可出现类似麻痹性痴呆的精神症状。临床最常见的症状是精神不振，易于疲劳，情绪不稳，好激惹。因此，病人的主诉常给人一种神经质的印象，但典型精神病的表现不突出。

糖尿病导致的精神障碍，乃阴液耗伤，体内阴阳失调之结果，治疗原则以滋阴增液为主，胃热炽盛者兼清胃热。阴损及阳，气阴两虚者兼加益气之品。常用方剂为左归饮、玉液汤、一贯煎等加减治疗。阴阳调和症状自然缓解。

二、病例介绍(糖尿病所致精神障碍)

张×× 男性 46岁 干部 初诊日期为1962年8月10日。

〔问诊〕六年来患糖尿病未间断治疗。近两年来精神不振，头晕，视力减退，易疲劳，情绪不稳，多疑，常因小事

发脾气，失眠，烦躁，口渴、饮水多、尿多(每夜7~8次)。两个月前在××医院住院，注射胰岛素治疗。因患者情绪波动较大，对医护人员不信任，经常和医院工作人员吵架，要求出院。出院后上述症状加重，随转院治疗。

〔望诊〕精神不振，面容憔悴。舌质红，无苔。

〔闻诊〕语言正常。

〔切诊〕脉弦细数。

〔化验〕尿糖定性(++++)，尿糖定量5.2克%，酮体(+)，血糖250毫克%。

〔辨证〕阴虚肝胃并热。

〔立法〕养阴，柔肝，清热。方用滋阴清胃饮。

〔处方〕生石决明 24克 生地 30克 枸杞子 15克
天 门 冬 10克 麦门冬 10克 石 斛 15克
生 石 膏 45克 知 母 6克 天花粉 10克
首 乌 藤 15克 炒山栀 6克

前方加减服用12剂，精神症状好转，情绪稳定，睡眠好，头晕、视力模糊也减轻。夜尿减少(1~2次)，饮水减少，仍有口干。舌质红少苔。脉弦滑。前方去炒山栀，加元参10克、沙参10克。

上方加减服用16剂后，症状消失。

〔化验〕尿糖定性(±)，尿糖定量2.0毫克%，酮体(-)，血糖110毫克%。

〔病例分析〕糖尿病临床的主要症状为“三多”，即多饮、多食、多尿，故中医称为“三消症”。本例患糖尿病已达六年之久，近两年出现一些精神症状，但主要症状仍为多饮、多尿。从化验结果看，糖尿病仍为主要矛盾，一般精神症状则

居于次要地位。结合临床“四诊”所见精神不振、面容憔悴、舌质红而无苔、脉细等皆属于阴虚的见证。口渴多饮为胃热；易激惹、脉弦数为肝热。方中生石决明一味为平肝药，又可镇静明目，对失眠及视力减退效果较好。重用生地大补其阴，配以枸杞滋肝肾之阴，二冬、石斛养胃阴。生石膏、知母清胃热，佐天花粉以生津止渴。栀子清肝热。加首乌藤养神安眠。本症不易取速效，故不轻易改换方剂，每次就诊总予十数剂，治疗月余始收效。

第五节 甲状腺机能亢进所致精神障碍的症状及治疗

一、症状及治疗方法

甲状腺机能亢进是内分泌系统的常见病，系甲状腺分泌甲状腺激素过多所致。病理解剖上呈弥漫性、结节性及混合性甲状腺肿。病理机制则以氧化过程加速、代谢率增高为主。由于甲状腺机能亢进可引起神经系统功能紊乱，因而可出现精神障碍，常见的是神经衰弱症候群，如心慌、心乱、易烦躁、易生气、头晕、头痛、注意力不集中、失眠等。有些病人出现情绪不稳、焦虑、不安、易激惹、易兴奋等症状。而有些病人还可出现类似轻性躁狂兴奋状态，如多语、活动增多等；病情进一步加重则出现暴怒、躁动以至精神错乱、谵妄状态和昏迷状态。本病的诱发因素多与七情（即精神因素）有重要关系。

中医认为：甲状腺机能亢进属于瘰疬的范畴，其病机是

肝气郁结而致体液循环失调，聚液为痰，气郁与痰结合邪而致瘰疬。治疗原则以解郁化痰软坚为主，郁解气调，痰化瘰消，精神症状也随之消失。临床常用消瘰汤加减治疗。

二、病例介绍

褚×× 女性 40岁 工人 初诊日期为1965年3月1日。

〔问诊〕近五个月来，自觉颈部有压迫感，气憋，心悸，烦躁，坐立不安，情绪易激动，常因小事发脾气，咽喉发紧，舌麻；食欲增加，常有饥饿感，但却日渐消瘦，大便日3~4次。月经期错后，量中等。经××医院检查，诊断为甲状腺肿瘤，建议手术治疗。患者畏惧手术，要求中医治疗。病前有明显的郁怒史。

〔望诊〕精神正常，体质较消瘦，甲状腺大呈6×2平方厘米大小，摸之坚硬，随吞咽动作上下移动。舌质淡红，舌苔薄黄，舌尖有紫刺。

〔闻诊〕多语，声音略带嘶哑。

〔切诊〕脉沉滑数。100次/分。

〔化验〕基础代谢率+61%。

〔辨证〕气郁痰结，致成瘰疬。

〔立法〕解郁化痰，软坚消瘰。方用消瘰汤。

〔处方〕生牡蛎15克 夏枯草12克 龙胆草6克
炒山栀6克 元参10克 赤芍10克
川贝母10克 昆布10克 海藻10克
郁金6克 青皮6克
十二剂 早晚各服一煎

前方服用十二剂，情绪较前稳定，心悸、烦躁等症状已消失。自觉气出舒畅，甲状腺肿瘤扪之已软。

前方加枳壳 6 克，天花粉 10 克，继服十二剂。

复查：1965 年 6 月 13 日。甲状腺肿瘤已消散，月经期已准，基础代谢率 + 0.9%。

〔病例分析〕本例的突出症状是五个月来自觉颈部有压迫感，这种感觉是因肿瘤机械性压迫而产生的，但肿瘤长成绝非五个月，而是更早。患者病前有明显的郁怒史，这是本病的诱发因素。中医学认为，瘰癧是由于七情影响气机的正常运行，气郁导致体液的正常循环受阻，聚液为痰，气郁痰结而形成的。解郁、化痰、软坚，为治瘰癧的有效疗法。方中生牡蛎、夏枯草配元参为消瘰软坚药，昆布、海藻、贝母为化痰软坚药，配龙胆草，炒山栀解郁清热，赤芍活血消肿，郁金、青皮解郁理气。服药后先是精神症状消失，继之肿瘤消散，基础代谢的改变也是比较满意的。

第六节 肾上腺皮质机能减退所致精神障碍 的症状及治疗

一、症状及治疗方法

由于各种原因所致的双侧肾上腺皮质损坏均可引起本病。有许多慢性疾病也可引起肾上腺皮质机能减退。当肾上腺皮质机能减退时，皮质激素分泌常有不同程度的不足，引起轻重不等的代谢紊乱与各系统脏器的机能失调。临床表现除危象外，病程多缓慢，早期表现衰弱无力，容易疲乏，精

神萎靡，食欲不振，体重减轻，情绪易于激动，或抑郁淡漠，思想不能集中，多失眠。有时因血糖过低而发生一系列神经精神症状，严重者有昏厥甚而昏迷。早期出现皮肤色素沉着，为诊断本病的依据。

中医认为：肾上腺皮质机能减退，为肾元阳虚衰，脾胃失于温煦，饮食之精微不能很好消化输布，导致阴阳、气血皆虚所致。治疗原则以补肾阳为主，兼补气养血。肾阳充足，脾胃得以温蒸，恢复消化运输之功能以化生气血，各脏器机能自调。常用方剂补肾丸化裁。

二、病例介绍

赵×× 女性 34岁 干部 初诊日期为1958年3月14日。

〔问诊〕两年前开始发现精神疲倦，全身疲乏无力，头晕，心跳，气短，前胸及后背疼痛，心烦急躁，面色及口唇黝黑，皮肤干燥，容易脱皮，口鼻干燥，自汗出，食欲不振，大便溏稀且一日数次，小便频数，睡眠不好；以后腋毛及阴毛完全脱落，头发已大部分脱落；性欲减退，月经后错，经量极少，体重显著下降（由120斤下降到75斤）。曾在××医院检查，血糖63毫克%；基础代谢率-26%，诊断为阿狄森氏病。自1956年10月至12月使用甘草流浸膏治疗，效果不明显。1957年1月至8月使用醋酸去氢皮质酮治疗，效果仍不明显。

〔望诊〕精神不振，面色及口唇黝黑，发稀而枯，皮肤甲错，舌质淡，舌苔薄白。

〔闻诊〕语音低微。

〔切诊〕脉沉弱。

〔辨证〕肾阴不足，命门火衰，气血两虚。

〔立法〕滋阴壮阳、双补气血。方用阴阳气血滋补汤。

〔处方〕生黄芪 30克 人 参 6克 生白术 12克

云茯苓 12克 当 归 12克 杭白芍 10克

大青盐 10克 沙 参 10克 石 斛 15克

淫羊藿 15克 附 片 12克 巴戟天 12克

按上方加减服药百余剂，兼服紫河车粉或参茸卫生丸，主要症状基本消失，面色由黧黑转为白润，毛发重生如常人，性欲恢复正常，精神体力均恢复，能够胜任原职工作，体重增加到病前水平。基础代谢+17%，血糖上升到正常范围105毫克%。

〔随访〕1965年，患者精力、体力均充沛，工作如常，无任何不适感觉，复查基础代谢率为-8.5%。

〔病例分析〕在躯体疾病所致的精神障碍中(内分泌所引起的)，大多将肾上腺皮质机能亢进的柯兴氏症列入，而不列入本病。作者认为，一为肾上腺皮质机能亢进，一为肾上腺皮质机能减退，两者在临床表现都有明显的神经精神症状，有同时列入的必要，故将此病列于柯兴氏病之前。本病的一系列临床症状，均表现为肾气不足。肾为作强之官，“作强”是指精力充沛，轻劲多力。因肾贮藏五脏六腑之精，肾气的盛衰直接关系着精力的强弱，精力充足就轻劲多力，劳动不倦。精力不足就胫膝痿软，头晕，倦怠无力，月经错后而量少。另外，命门为肾之元阳所在，乃人生命活动的原动力，脾之所以能消化运转，全靠命门之火的帮助，命门火衰则脾不健运，故食欲不振，大便溏泻。肾阳不足则性欲减退。

又主水，通过肾关开合调节体液平衡，肾气不足则开合无力，故小便频数；肾气衰则皮肤干燥，毛发易于脱落。根据上述理论，肾的阴阳不足是导致气血两虚的原因。治疗以滋肾阴，壮肾阳，兼补气血。方中生黄芪、人参、白术、茯苓四味补气，当归、白芍补血，沙参、石斛、大青盐滋阴固肾；方中不用生熟地滋阴，是因食欲不振，大便溏泻，恐其滋腻妨碍脾胃。淫羊藿、巴戟天、附片以助肾阳。此症亏损已极，非短期所能取效，故服药百余剂始能收功。故遇慢性病要守法守方，贵在坚持。

第七节 肾上腺皮质机能亢进所致 精神障碍的症状及治疗

一、症状及治疗方法

肾上腺皮质机能亢进，是由肾上腺皮质激素分泌过多所引起的。主要病变在肾上腺及脑垂体，但其它腺体亦可有病变。临床表现为血压升高，肥胖，多毛，男性多阳痿、性欲减退，女性则男性化、月经减少或闭经；上述症状为本病的早期特征。晚期可出现精神变态，常见的精神障碍为神经衰弱症候群（头痛，注意力不集中，记忆力减退，易疲劳，易激惹等），亦可出现类似躁狂状态或抑郁状态以至短暂的幻觉、妄想状态。

中医认为：肾上腺皮质机能亢进为肾水不足，相火亢盛，导致冲任二脉失调所致。其治疗原则以益肾水、制相火为主，兼调冲任。常用方剂知柏地黄丸为主加当归、白芍等调冲任

之品。

二、病例介绍

周×× 女性 31岁 干部 初诊日期为1957年9月6日。

〔问诊〕三年来月经闭止，体格粗胖，口唇及前胸后背汗毛浓重，阴毛腋毛增多，性格变得粗鲁暴躁，精神不能集中，注意力集中时头痛、烦躁；不能耐劳，记忆力减退。

14岁初潮，经期准，量正常。20岁前有痛经史。22岁结婚，性欲正常，24岁初产一男孩，自己哺乳，哺乳期约一年无月经，停乳后曾有过月经，经期后错，2~3月一次，量少。近三年来月经完全停止，曾注射过黄体酮，服过很长时间通经活血药，均未见效。

〔望诊〕体肥胖而粗壮，髭毛黑长，前臂及小腿汗毛浓重，虽留有两条长发辫，但精神面貌已无女性特征。舌质淡，苔薄白。

〔闻诊〕声音粗高。

〔切诊〕脉沉细弦。血压150/90毫米汞柱。

〔辨证〕肾水不足、相火有余，冲任二脉失调。

〔立法〕益肾水，制相火，调冲任。方用知柏地黄汤加味。

〔处方〕生熟地 各15克 山芋肉 10克 山 药 15克
茯 苓 12克 丹 皮 10克 泽 泻 10克
知 母 10克 黄 柏 6克 女贞子 15克
当 归 10克 杭 芍 12克 炙龟板 10克
怀牛膝 10克

按上方加减服药四十余剂，症状减轻，血压正常，改用

丸剂长服。治疗半年后，性格有所改变，记忆力恢复。至1958年7月始见月经，此后中断治疗。1962年3月生一女孩，发育正常，此女孩较第一胎男孩相差12岁。

〔病例分析〕本例从临床表现上足以确诊为柯兴氏综合症，但由于当时条件所限，未作任何化验，缺乏机能诊断，不能确定肾上腺机能亢进和肾上腺病理性质与部位。主要根据临床的下列特征确诊，(1) 典型体态；(2) 高血压症候群；(3) 闭经，不孕；(4) 多毛症；(5) 性格改变等。

根据临床辨证，本症一系列症状皆属于肾。因为人的生长、发育、衰老均与肾的盛衰有关系，如《素问·上古天真论》说：“女子七岁肾气盛，齿更发长。二七天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子……。”本病为肾的阴阳不平衡，肾水不足(阴虚)，相火有余(阳亢)；肾水不足，天癸不至(即不排卵)；冲、任二脉失调，故月经闭止。相火有余(相对的有余)，毛发丛生，性情暴躁，虽体格观之粗壮，但不能耐劳。血压偏高，头痛，烦躁，也反映出阴虚阳亢之象。治疗以知柏地黄汤滋肾水，泻相火。女贞子、炙龟板、怀牛膝滋阴通任脉。当归、杭芍补血调冲脉。长期服用才取得效果，月经恢复后三年又能妊娠。

第六章 脑血管疾病所致的 精神障碍

脑血管病，既是脑疾病，也是全身性疾病，不过它的表现突出于脑部罢了。当血管系统患病时，血管壁发生改变，这些改变都能导致神经与精神障碍。这些障碍多见于高血压和脑动脉硬化病人。因此，本章仅介绍此二者所致之精神障碍。

高血压病和脑动脉硬化症，有着不同的病因和发病机制。高血压病患者，早期不伴有动脉硬化。而动脉硬化患者，其血管纵然很硬，却不一定伴有高血压；虽然晚期动脉硬化患者可伴有高血压，但它们对脑的作用并不完全一致。高血压病患者的血管运动，常是兴奋性亢进（血管痉挛）。而动脉硬化患者相反，其血管运动兴奋性常常减低。因而高血压多是发作性、一时性的机能障碍。而动脉硬化，则多为渐进性、持续性的机能减退。

尽管如此，也不能把它们对立起来。二者仍是有着相互关系的。因为高血压早期症状虽然是由小动脉痉挛引起的，是机能性的，但后期症状却是由微动脉硬化所导致。并且高血压有促进动脉硬化的作用，而动脉硬化又可使血压升高。因此，二者常是同时存在并引起复杂的症状，很难加以区别。

第一节 高血压精神障碍的症状及治疗

我国高血压病发病率，据1959年13个省普查，平均为

5.11%；1964年11个省普查为3.4~7.3%。由于过去对高血压病及动脉硬化症的概念及其间关系的认识未能统一，故对高血压性精神病的诊断标准不一致，影响发病率的精确统计。50%以上高血压病患者有神经衰弱症状群，而严重精神障碍者无确切统计。本病患者多为40~50岁的中年人，男女性别上无明显差别。

一、病因病机

(一) 病因

精神紧张与情绪波动，在高血压病病因中占主要地位。此外，遗传因素也有密切的关系。高血压病患者，动脉血压的持续升高以及其后继发的脑部小动脉硬化，是这类精神障碍的基本原因。此外，由于高血压病患者对精神因素的敏感性增强，所以精神因素往往是这类精神障碍的诱发因素。但精神因素的作用，主要是间接地通过促使血压升高或发生脑血管危象而产生精神障碍。必须注意，并非所有高血压病患者出现的精神障碍都是高血压病性精神病。高血压病患者也可发生其它各种原因所致的精神病，如感染中毒性精神病、反应性精神病、躁狂忧郁性精神病或精神分裂症等。

(二) 病机

高血压病性精神病的发病，或源于脑血管的功能性障碍，或由血管器质性病变所致。两者造成的共同结果是使脑血流量不足，甚致缺血。通常认为脑小动脉痉挛是脑血管的功能性障碍，在高血压病的各期，尤其是第一、二期，它是一时性脑血管危象(或称为局部型高血压脑病)的原因。而脑小动脉的硬化，使管腔狭窄或血栓闭塞，则是高血压病后期持久

性神经精神障碍的病理基础。然而必须看到，有时功能性和器质性的因素可以同时发生影响。例如脑小动脉痉挛时间过久或反复痉挛，可使脑组织持续性缺血而产生不可逆的神经细胞坏死。另外，在脑小动脉硬化造成脑器质性病变的同时，由于硬化的动脉易于发生痉挛或血栓而又可夹杂一时性的脑功能障碍。

二、临床表现

（一）初期阶段的临床表现

此时常可出现神经精神方面的症状，如头痛、眩晕、睡眠障碍（失眠、多梦、易醒）、敏感性增高、易兴奋、情绪易激动和焦虑、心率过速，或心前区不适感、记忆力减退等。当病人努力注意工作时，可引起症状加剧或疲劳。有些患者可有疑病的倾向，过多地注意自己的病情，怀疑自己患了不治之症，对死亡有恐怖感或强迫观念。

（二）中期阶段的临床表现

此时精神症状明显，多表现为发作性症状，血压常随之增高。有时出现意识障碍，多呈谵妄状态或精神错乱状态。也可伴有恐怖性幻觉或片断性妄想，言语不连贯，定向力丧失。但可与环境保持一定的联系，意识障碍的程度也时深时浅。每次发作，可延续数日至数周，过去之后常遗忘。有时表现兴奋躁动，恐惧不安，可伴有焦虑忧郁。此期症状多由血管痉挛所引起。

（三）晚期阶段的临床表现

此期表现面红，盛汗，心慌，潮热，剧烈的头痛，眩晕，手足震颤，听力、视力减退，嗜睡，耳鸣，头响，有时出现

一过性意识丧失，常尿频尿多。此型症状多是逐渐发生，经过时间可由数小时到数日。严重者意识模糊，感觉异常，恶心呕吐，短时间的语言障碍。有时出现卒中发作，意识丧失，继则一侧不全麻痹或伴有失语症，记忆力严重减退，理解力、判断力均有障碍，可出现痴呆状态，所谓假性麻痹性痴呆。

三、中医有关高血压精神障碍的学说

高血压精神障碍，是动脉血压持续升高的结果。如果血压下降，精神神经症状也会随之而减轻，因此，治好高血压，也就能防止和治好由高血压所引起的精神障碍。中医治病以辨证施治为主，并非把高血压与精神神经症状绝然分开，这是与现代医学用降压药和另外给予精神障碍的对症药治疗有所不同的。

以前，有人认为高血压是属于中风的范畴，因为中风也可出现偏瘫、失语、意识障碍、精神障碍等症状。但是，这些症状多是在中风以后出现的。一般来说，中风以前可先有高血压的存在(也可以说高血压是中风的前驱症状)，而高血压则不一定出现中风。因此，只能说高血压是中风的前因，而中风则是高血压的后果。所以，中风后的症状，自然不是考虑的对象，但也不能绝对排除。

中医对于任何疾病都是以脏象经络为基础进行研究的，对于高血压病也是如此。由于高血压病是一种多发病和常见病，所以历代医学文献都有记载；特别是现代医学对于本病的研究更为详细。对于本病的发病机理，人们一致认为是多方面的(而其症状表现也各不相同)。兹据文献记载并结合临

床所见，将高血压精神障碍的病机和症状分述如下：

（一）肝胆气逆

其症状为头痛，耳聋，目眩……（现代医学的神经症状）。因为肝与胆相表里，它们的经脉都上注于头。如肝经之脉，从目系上出前额，与督脉会合于头顶中央。胆经之脉，起于眼外角，上行头角，下至耳后。肝胆之气上逆，必然通过它们的经络来表现。所以，头痛、耳聋、目眩都是两经所表现的症状。

（二）肝热上冲

其症状不仅有头痛、目眩，而且有头晕旋转、房屋运转之象。“诸风掉眩，皆属于肝”，可见诸眩晕症多属肝风内动，风为阳热之邪，肝热循经上冲，故有上述表现。

（三）心热上蒸

其症状为卒然心痛，烦躁苦闷，恶心欲呕，头痛面赤……。心与小肠相表里。心经之脉起于心中，下过膈肌络于小肠。其另一支脉，从心系上挟咽喉连于目系。小肠经脉从缺盆沿颈上颊，至眼外角转入耳内。又有支脉从颊到眼眶下部至鼻，行于眼内角，斜行络于颧骨部。所以心热上蒸的症状，也是循行其经的表现。

（四）肾热病者

其症状为颈项强痛。肾与膀胱相表里，肾热盛必溢于膀胱，循经上行，因而呈现头项强痛。人的头部为诸阳脉上会之所，受督脉的监督，所以阳顺行于上而不逆。如果督脉失司，阳逆于上而不顺，冲壅于头，也可呈现头痛脊强。

从以上高血压病的机制来看，虽然心与肾热都可导致头晕、头痛，但最突出的还是肝经发病为多（肝气上逆，肝热上冲，肝阳上亢等），临床证明确是如此。值得引述的是清代

华岫云氏在总结“肝风”一案时所说：“故肝为风木之脏，因为有相火内寄，体阴用阳，其性刚，主动主升。全赖肾水以涵之，血液以濡之、肺金清肃下降以平之，中宫敦阜之土气以培之，则刚劲之质，得为柔和之体，遂其条达畅茂之性，何病之有。倘精液有亏，肝阴不足，血燥生热，热则风阳上升，窍络阻塞，头目不清，眩晕跌仆，甚则癱痲瘛厥矣。”华氏把肝的特性以及它和其它脏的关系，描述得相当全面。根据肝经发病的不同机理，从而订出不同的治疗法则。华氏说：“缓肝之急以熄风，滋肾之液以驱热，是介（介为海产蛤壳、牡蛎之类）以潜之，酸以收之，厚味以填之，或用清上实下之法。若思虑烦劳，身心过动，风阳被扰，则营热心悸，惊怖不寐，胁下动跃，……清营中之热，佐以敛摄神志。若因动怒郁勃，痰火风交炽……风木过动，必犯中宫，则呕吐不食，法用泻肝安胃。它如辛甘化风，酸甘化阴，清金平木等种种治法”。从这些治疗法则中，可以看出辨证施治的圆机活泼，绝不是凭一方一法所可了事的。

华氏在总结“眩晕”一案之后说：“诸风掉眩，皆属于肝；头为六阳之首，耳目口鼻，皆系清空之窍。所患眩晕者，非外来之邪，乃肝胆之风阳上冒耳。甚则有昏厥跌仆之虑。其症有夹痰、夹火、中虚、下虚、治肝、治胆、治胃之分。火盛者，以清泄上焦窍络之热，此先从胆治也。痰多者必理阳明……下焦者必从肝之，补肾滋肝，育阴潜阳，镇摄之治是也。”华岫云氏的上述两段论述，实乃中医治疗高血压病的两条基本法则，对于指导医疗实践具有重要意义。

四、高血压精神障碍的分型及治疗

基于华氏上述两个结论(肝风与眩晕)，得出治疗高血压病的法则，以此指导实践，确已发现和证明高血压病有若干不同类型。本人根据不同类型制订不同的方剂而用于临床，收到良好的效果。现将各种类型的证治分述如下：

(一) 肝胆风热型的症状及治疗

〔症状〕头晕、头胀，主要是偏正头痛，或牵及肩背强痛，或兼有口眼歪斜。

〔脉象〕浮弦或弦数。

〔立法〕泻肝胆、疏风热。方用疏风止痛合剂。

〔处方〕生石决明 30克 白蒺藜 10克 龙胆草 6克
炒山栀 6克 当归 10克 川芎 6克
羌活 6克 防风 6克 白芷 8克
细辛 3克 杭菊花 10克 薄荷 6克(后下)

〔典型病例〕

陶×× 女性 38岁 会计员(因病退职)

主诉：自1953年(五年前)因经常头痛而去××医院，经检查诊断为高血压病(血压200/100毫米汞柱)，治疗三个月，血压未降，症状未减。又转其他医院治疗，均无明显效果。经常服用利血平，每日晨起必须服用止痛片，否则头痛不能忍受。至1957年底终因不能坚持工作而退职。五年来每日头痛，无一日停服止痛片，否则头痛难以遏止。

现在症状：头晕、头痛剧烈，有时头胀且麻，耳鸣、目眩，不欲睁眼，气短，肢麻，大便干燥。舌质红、苔黄；脉浮弦。血压180/100毫米汞柱。辨证为肝胆风热型，予以疏

风止痛合剂，三日量。

服药后头晕、头痛、头胀麻均减轻，其它症状几乎消失，血压降至130/90毫米汞柱。服药六日后，除偶有头痛、气短外，其它症状均消失。为了巩固疗效，以后间日服药一次，三周后停药。血压130/86毫米汞柱。无任何不适感觉，以后每两周复查一次，观察三个月，血压无波动，也未再发现任何症状。

（二）心肝并热、心神不安型的症状及治疗

〔症状〕头晕胀痛，心悸，烦躁不安，耳鸣面赤，情绪易激动，或心率过速，失眠。

〔脉象〕弦滑，或弦数。

〔立法〕平肝清热安神。方用泻肝安神合剂。

〔处方〕生石决明 24克 龙胆草 8克 炒山栀 6克
珍珠母 20克 白蒺藜 10克 黄 芩 6克
生 地 15克 当 归 10克 朱茯神 10克
朱寸冬 10克 柏子仁 10克 炒枣仁 15克
远 志 10克 生甘草 3克

〔典型病例〕

李×× 女性 29岁 护士。

主诉：患高血压病已五年，症状时轻时重，经治不愈。

现在症：头晕甚重，头胀痛，耳鸣，目眩，心悸，气短，失眠，多梦，肢麻，下肢浮肿，饮食无味。脉沉弦而数。舌质红，舌苔白。血压204/140毫米汞柱。予泻肝安神合剂三日量。血压下降为160/110毫米汞柱。除头部稍有胀痛外，其它症状大部消失，睡眠好。服药三周，兼用针灸配合治疗，症状全部消失。血压降至130/80毫米汞柱。观察两月，血压

稳定在115/80毫米汞柱。其它症状也未再出现。

(三) 阴虚阳亢、肝风内动型的症状及治疗

〔症状〕头目眩晕，肢麻，手指抽动，舌强不利，视物模糊，有时一过性意识丧失，甚而卒中发作。

〔脉象〕左关脉多弦或沉弦。

〔立法〕养阴平肝熄风。方用平肝熄风合剂。

〔处方〕生石决明 30 克 白蒺藜 10 克 甘菊花 10 克
钩 藤 10 克 首乌藤 15 克 杭白芍 12 克
生 地 30 克 桑寄生 15 克 石菖蒲 6 克
天 麻 10 克 宣木瓜 10 克 橘 络 6 克

〔典型病例〕

王×× 男性 51岁 印刷×厂排字工人。

主诉：三年前夏天，下夜班回家吃饭之际，忽觉头晕，突然昏倒，头面碰伤。经××医院检查为高血压病，给予对症治疗。此后经常头热眩晕。三天前晚间散会后，自觉左半身有触电样麻感，长达一小时之久。次日发现左手肿胀，颜色紫红，此后左半身仍有麻的感觉。今日就诊时左侧颜面浮肿，舌强，语言不利。脉沉弦，血压 200/100 毫米汞柱。予以平肝熄风合剂三日量。服药后自觉头晕、头热、左半身麻木感觉均减轻，左侧颜面浮肿也消，左手肿胀大减，但皮色仍红，舌强现象已无，语言流利。血压降至 140/90 毫米汞柱。自觉心情舒畅，精神愉快。服药十日后症状全部消失，已恢复半日工作；继续服药一个月，恢复整日工作。停药观察三个月，血压无波动。

(四) 肝胃并热型的症状及治疗

〔症状〕头痛目眩，目不欲睁，口舌生疮，口渴引饮，

舌红苔黄。

〔脉象〕弦数或洪大。

〔立法〕凉肝清胃。方用凉肝清胃饮。

〔处方〕生石决明 24 克 生 地 18 克 甘菊花 10 克
桑 叶 10 克 黑芝麻 10 克 石 斛 15 克
炒山栀 6 克 丹 皮 10 克 生石膏 24 克
生白芍 12 克 天花粉 10 克

〔典型病例〕

王×× 女性 65岁 家庭妇女

主诉：患高血压病已四年，血压经常在170/180/100～110毫米汞柱。头晕，头痛，目赤痛，甚则目不欲睁，口舌生疮，口渴多饮，食欲不振，小便赤，大便干燥，舌红无苔有龟裂，脉弦滑而数，血压182/106毫米汞柱。予凉肝清胃饮三日量。服药后诸症状均减轻，血压降至154/90毫米汞柱。共治疗一周血压降至140/80毫米汞柱。自觉症状全部消失，观察四个月，血压稳定，无明显症状。

（五）肾阴虚、肝阳上越型的症状及治疗

〔症状〕头晕，头项强痛，耳鸣，头面阵阵发热，头重脚轻。

〔脉象〕沉弦细。

〔立法〕滋阴潜阳。方用清上实下合剂。

〔处方〕桑 叶 10 克 杭菊花 10 克 丹 皮 10 克
炒山栀 10 克 生白芍 12 克 夏枯草 15 克
生 地 15 克 沙苑子 10 克 生龙骨 15 克
生牡蛎 15 克 珍珠母 24 克 秋 石 2 克

〔典型病例〕

王×× 女性 49岁 家庭妇女

主诉：病已多年，头晕，头项强痛且胀重，心悸，气短，行路时自觉脚下无根，惟恐跌倒，有时脊背及手指麻木；记忆力减退。脉弦细，尺弱。血压200/120毫米汞柱。给予清上实下合剂四日量。药后症状显著好转，血压降至168/96毫米汞柱。继续服药两周，症状消失，血压降至134/86毫米汞柱。观察两个半月，血压稳定，无不适感觉。

(六) 肝肾阴虚、阴不敛阳型的症状及治疗

〔症状〕头目眩晕，时欲昏倒，腿软无力，手足不灵，语言不清，有时意识障碍，心悸，倦怠；耳鸣，阵阵颜面潮红。

〔脉象〕弦而无力，尺弱。

〔立法〕滋阴养肝。方用清上填下合剂。

〔处方〕熟地30克 杭芍12克 沙苑子12克
炙龟板30克 生龙骨24克 生牡蛎24克
山萸肉10克 泽泻10克 杭菊6克
天麻6克 钩藤15克 天竺黄15克

〔典型病例〕

王×× 女性 67岁 家庭妇女

主诉：三年前发现患高血压病，经常头晕，心悸，两腿麻木，足软无力，手持物无力，语言有时不清。曾服降压药，血压不降。经针灸、按摩，有时好转，但不能持久。

现在症：头晕，头痛，头胀，心慌，气短，失眠，手足抬动不利，语言迟缓，手握力差，行路蹒跚。胸透：主动脉扩张。眼底检查：可见小血管硬化和出血病变，血压168/100毫米汞柱。予清上填下合剂四日量。药后症状减轻，血压降至138/80毫米汞柱。经治两周症状消失，血压120/60毫米汞柱。

(七) 肝肾阴虚、肝阳上亢型的症状及治疗

〔症状〕头晕目眩，时轻时重，遇劳则心悸、耳鸣，血压持久不降。

〔脉象〕弦紧或沉弦有力。

〔立法〕养阴平肝潜阳。方用百合地黄合剂。

〔处方〕生石决明 24 克 珍珠母 24 克 生 地 30 克
百 合 24 克 黄 芩 10 克 夏枯草 12 克
钩 藤 10 克 丹 皮 10 克 白 薇 10 克

〔典型病例〕

冯×× 男性 35岁 干部 初诊日期为1959年3月21日。

主诉：1951年7月间，自觉头昏痛，心率过速(100次/分)，睡眠时常因心悸而醒，经××医院检查，诊为高血压病(血压220/130毫米汞柱)，心律不整。1952年因头昏头痛严重，不能起床，即住院治疗。住院八个月，血压不降，症状稍轻即出院。1954年症状如前，二次入院，住院45天血压仍未下降，能起床即出院。1957年8月因症状加重又第三次住院，住院两个月症状减轻，但血压仍在220/130毫米汞柱。1958年5月第四次住院治疗3个月，血压仍持续不降，后又经针灸及服中药治疗两月余，仍无明显效果。

现在症：头晕，头痛，头胀，耳鸣，心慌，气短，失眠，饮食减少，大便干燥。血压200/120毫米汞柱。脉弦急。当时辨证为肝热心神不安型，予泻肝安神合剂后，症状消失，血压降至170/110毫米汞柱，但波动不稳，脉沉弦。改用百合地黄合剂，连服10剂后血压降至118/80毫米汞柱。停药观察六周，血压128/88毫米汞柱。体重增加11斤，已

恢复工作。

五、治疗体会

在分型治疗之前，曾受某种思想的影响，认为治疗高血压病只可从降压方面考虑，一味迷信降压药物，因而走过一段弯路。经过复习中医有关文献，认识到高血压病的病机不同，症状也不一样，因而在治则上也就应当有所不同。根据辨证论治的原则和患者的临床表现，我们把高血压病分为七种类型，并对症制订七种合剂，不仅消除了迷信降压药物的思想，而且也打破了辛温药物不可用于高血压的陈规戒律。例如疏风止痛合剂中就有辛温药物，用于治疗陶××的高血压病（他突出的症状是剧烈的头痛，五年来经过各医院的长期治疗，服用各种降压药物均未奏效），仅服药三剂，不仅头痛减轻，而且血压迅速下降。方中的防风、羌活、细辛、白芷这一类的辛温升散药物，过去是不敢用于高血压病人的。

治疗高血压病是预防血管硬化和脑血管意外的有效措施，也是防治高血压病精神障碍的最基本方法。例如平肝熄风合剂，对于即将发生的卒中，能使血压下降，症状消失。再如清上填下合剂，对于血压持久不降、半身不利、言语不清的高血压患者，能使血压逐渐下降，症状由减轻而消失，疗效可靠。泻肝安神合剂，重点用于心肝并热、心神不安的高血压，有神经衰弱症候群的高血压患者，效果明显。其它如清上实下合剂，其中滋肾药物较多，兼以潜镇肝阳，用于肾阴亏损、肝阳上逆的本虚标实证，收效甚佳。至于百合地黄合剂，在临床上多用于有较长高血压病史者；对于自觉

症状不多、舒张压偏高且持久不降者，也有一定的效果。

第二节 脑动脉硬化症精神障碍的 症状及治疗

一、病因病机

据国外统计，脑动脉硬化症引起的精神障碍患者占精神病院住院病人的第二位(10%左右)，仅次于精神分裂症患者(1956年)。本病在我国的发病率远较国外为低。发病年龄多在50岁以后，患者男性略多于女性。

不同程度的脑动脉硬化，是本病的基本原因。它使脑组织缺血，缺氧，发生变性、出血或坏死，最后形成疤痕、囊肿或弥漫性脑萎缩。应当指出，并非每个脑动脉硬化的患者都出现明显的精神障碍，且其出现的迟早也因人而异，病理变化的严重程度与临床精神症状的轻重也往往不成比例。因此，除组织学的改变外，尚有其它因素促使本病发生。如病前人格特点，中枢神经系统的机能状态，遗传因素和精神因素等都有一定影响。

二、临床表现

脑动脉硬化症的早期表现，类似神经衰弱症状，这时称为动脉硬化的神经衰弱期。部分病人，虽已患脑动脉硬化，但并无明显症状。

早期神经衰弱症候群的症状有头痛，头部沉重，一过性眩晕，昏厥，眼花，轻度的感觉异常，四肢麻木感，蚁行感等。特别明显的是容易疲劳，工作能力降低，思考、理解能

力降低，记忆力减退(先是近记忆困难)，情感脆弱而易激动，顽固的失眠等。但是，这些症状进展很慢，并且初期常有波动，所以在患病的过程中可有或长或短的停止期或间隔期，可经过数年、十数年才过渡到动脉硬化性脑病。

记忆障碍，在脑动脉硬化的痴呆中占有重要地位。

情感障碍，表现为情感脆弱，易激惹，易伤感。特别容易产生抑郁情绪，常伴有焦虑、苦闷或怨恨。

病情逐渐发展，智能障碍逐渐达到痴呆状态。此时记忆力明显下降，判断力、理解力、思考力均明显减弱，创造力进取心丧失。但病人的基本人格在很长时期内仍能保持，能意识到自己有病。这就是所谓“局限性痴呆”，在脑动脉硬化中有着特征性的意义。智能障碍发展得比较缓慢，但如果卒中发作，则能看到痴呆状态明显加重，还可出现脑器质性疾病所特有的强制性哭笑，最后出现感情迟钝的严重痴呆。

脑动脉硬化症引起的精神障碍，表现为发作性症状，多见的是卒中发作。在卒中发作后，可出现急性精神病状态，病人表现兴奋躁动不安，意识不清，可有片断的妄想和幻觉，也可有攻击性行为。此种状态一般维持不久，事后有完全或不完全的遗忘症。

脑动脉硬化或早或晚会出现神经系统损害的局限症状，在卒中发作后更为明显，如一侧肢体麻痹，单肢不全麻痹，失语症，一侧面神经麻痹，舌、手震颤。常出现瞳孔大小不等，对光反射迟钝或减弱。腱反射一般亢进，有时有共济运动障碍等。

三、预防与治疗

脑动脉硬化症的早期治疗，可预防卒中的发生，防止神经系统损害的局限症和脑器质性疾病。除药物治疗外，做心理治疗工作也是不可缺少的。帮助病员消除顾虑，树立革命乐观主义精神，加强战胜疾病的信心。消除有害因素，如有烟酒嗜好者，劝其戒烟戒酒，避免躯体和精神创伤，对病员的生活、工作做适当安排等。一般早期患者不宜轻易停止工作，更不宜调动工作，避免脑力过劳。这样常能在相当长的时间内维持一定的工作能力。

中医治疗脑动脉硬化症，在没有发生卒中之前，辨证治疗大体同治疗高血压病一样。有的在出现卒中前兆时，如阵发性的眩晕、眼花、昏厥、肢麻等，这就说明是“风动”的现象，继之就有卒中的可能。这时如果治疗得当，可防止卒中发生。

对于自觉头重足轻，足若踏棉，时常头目眩晕、耳鸣、心中烦热，或时感肢麻渐而不利，脉弦长有力者，可用镇肝熄风汤。

〔处方〕 怀牛膝 30克 生赭石 30克 生龙骨 15克
生牡蛎 15克 生龟板 15克 生杭芍 15克
元 参 15克 天 冬 15克 川楝子 10克
生麦芽 6克 青 蒿 6克 甘 草 3克

对于经常头晕目眩，心中烦闷躁扰，有时手足痿痹，或如触电样麻者，可用天麻钩藤饮。

〔处方〕 生石决明 24克 天 麻 10克 钩 藤 10克
桑 寄 生 15克 牛 膝 11克 杜 仲 10克

炒山栀8克 黄 芩6克 益母草 10克

朱茯神 10克 夜交藤 15克

对于头目眩晕，心中烦热，急躁易怒而痰盛者，可服成药牛黄清心丸，每次一丸，一日两次，连服5~7日，症状减轻即停服。

对于有时头目眩晕，自觉头脑发热、发胀，偶有肢麻者，可用野菊花10克、夏枯草15克，开水泡当茶饮，有降低血压、软化血管的作用。

对于已经发作卒中，脑血管发生不同程度的改变，出现神智不清、失语、一侧面神经麻痹和一侧肢体麻痹者，都应以类中风半身不遂的辨证方法治疗。

四、病例介绍

〔例1〕脑动脉硬化(卒中前兆)

张×× 男性 65岁 退休工人 初诊日期为1961年11月22日。

〔问诊〕患者一年来经常头晕，经××医院检查确诊高血压病。近一个月来曾四次发作一过性头目眩晕，目不敢睁，睁目则视房倒屋塌，心中烦乱不堪，呕吐，四肢厥冷，面色苍白，出冷汗，舌卷囊缩，二便欲遗。每次发作约两小时始止，发作后口中干涩无津，吐血沫数口。平时呃逆吞酸，自觉热从胸中上升，口中即吐血沫。大便溏，小便清长，口渴思热饮，恶冷。

〔望诊〕精神紧张，面色潮红；舌质红，光滑无苔；齿缝舌面有渗血，唾液色红。

〔闻诊〕声音嘶哑。

〔切诊〕脉两关洪大，关后濡滑兼数。血压 240/115 毫米汞柱。

〔辨证〕肾阴早损，龙雷（龙指肾火，雷指肝火）之火上僭，虚风内动，有虚阳欲脱之兆，谨防卒中暴脱。

〔立法〕育阴填下，引火归原（导龙归海法）。方用桂附八味合三甲复脉汤。

〔处方〕生龙骨 24克 生牡蛎 24克 大熟地 30克
山萸肉 10克 败龟板 12克 枸杞子 12克
怀山药 15克 云茯苓 12克 粉丹皮 6克
制附片 3克 肉桂 1克 两剂

二诊：1961年11月24日。药后热上冲之势已减，头目眩晕已轻，胸中烦乱未作，至今一日余未吐血沫，大便溏较前好转，已有矢气，小便仍频，仍有时呃逆吞酸。今日面色潮红已退，舌质淡红，略有白苔出现，未见舌及齿缝出血。上肢已温，仍感足冷。切脉关上仍有洪大现象，尺脉濡软已不数。血压180/80毫米汞柱。药后虽自觉症状减轻，血压亦下降，但此症亏损已极，仍以前方加减三剂。

三诊：1961年11月28日。药后已无头晕目眩的感觉，五天来未吐血沫，小便不频，大便日行一次已成形，下肢已温，面色正常。舌质淡红，舌苔微白，脉濡软。血压 160/80 毫米汞柱。前方加减。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 大熟地 24克
山萸肉 12克 云茯苓 12克 麦门冬 10克
五味子 4.5克 远志肉 10克 石菖蒲 4.5克
巴戟天 10克 川石斛 10克 制附片 3克
肉桂 1.5克 仙半夏 6克 败龟板 10克

〔随访〕1962年3月19日，经治疗三个月，前症未犯，血压稳定。

〔例2〕脑动脉硬化性精神障碍

王×× 女性 49岁 家庭妇女 初诊日期为1964年10月22日。

〔问诊〕患者患高血压病已四年，收缩压经常在180~190毫米汞柱（舒张压不详）。头痛，头晕，烦躁失眠，半年前经服用降压药物治疗，一月后血压降到正常范围。五天前突然精神失常，焦虑不安，哭闹，多语不休，但语言不清，呵欠多，意识朦胧。尿频，常遗于床上，大便五天未解。

〔望诊〕精神痴呆，舌质淡，舌苔棕黄色。

〔闻诊〕语言不清。

〔切诊〕脉弦细。血压130/80毫米汞柱（服降压药后）。

〔辨证〕肾阴不足，肝阳上亢，风痰上扰，痰阻神明。

〔立法〕滋阴潜阳，熄风化痰。方用平肝熄风合剂加减。

〔处方〕生石决明 24克 白蒺藜 10克 生地 15克
枸杞子 12克 杭白芍 12克 钩藤 10克
天麻 10克 橘络 6克 滁菊 10克
远志 10克 石菖蒲 6克 天竺黄 10克
牛黄清心丸两丸，每次一丸

二诊：1964年10月30日。前方服用六剂，意识清醒，语言虽不利但能听清，情绪安静，没有出现焦虑和哭闹现象。大小便时能自己去厕所，大便仍干，食欲睡眠均好，不欲饮水。舌质淡，舌苔满布、色白微腻。脉弦细滑。

前方去生地、白芍、天麻、钩藤，加胆星6克、桔梗15克、郁金6克。六剂。

经过治疗，精神、语言已恢复正常，记忆力逐渐恢复，能够料理家务，已没有明显症状。改用丸剂缓图，以巩固疗效。

〔处方〕生龙骨 90克 炙龟板 24克 熟地 30克
肉苁蓉 24克 石斛 24克 炒枣仁 30克
甘草 15克 当归 30克 羚羊粉 3克

上药共研细末，炼蜜为丸，每丸10克，每服一丸，早晚各服一次。

〔随访〕1965年6月4日。患者经过治疗能操持家务，无任何后遗症。

〔例3〕脑动脉硬化(卒中后神经系统损害的局限症)

佟×× 男性 65岁 退休工人 初诊日期为1965年3月12日。

〔问诊〕患者于七年前发现患高血压病，头痛，头晕，曾经针灸及药物治疗，至1961年血压收缩压一直在180毫米汞柱以上。近三、四年来，头晕、头痛、肢麻等症状时轻时重，近两周来精神异常，表情痴呆，言语不利，口流涎，口眼喎斜，左半身不遂，全身震颤，行走欲倒，手不能持物，手持饭碗不能接近口边，前日曾将饭碗掉在地上。咽中有痰不易咯出，痰色黄稠成块。

〔望诊〕面色晄白，右侧颜面抽动，不时痴笑。舌质淡紫，舌苔根白腻，舌尖红，舌中心有龟纹裂。

〔闻诊〕语言不利。

〔切诊〕脉弦细滑，血压180/90毫米汞柱。

〔辨证〕肾阴不足，虚风内动，挟痰上扰，阻遏经络。

〔立法〕滋阴潜阳，熄风化痰通络。方用平肝熄风合剂加

减。

〔处方〕 珍珠母 24克 白蒺藜 10克 生熟地各 12克
枸杞子 15克 炙龟板 10克 滁 菊 10克
天 麻 6克 钩 藤 10克 桑寄生 18克
宣木瓜 10克 橘 络 6克 远 志 10克
菖 蒲 6克 天竺黄 10克

二诊：1965年3月19日。服药后精神好转，痴呆现象已不明显，语言较前清楚，肢颤已轻，口眼已正，口未见流涎，左半身仍不灵便，痰容易咯出。血压150/80毫米汞柱。舌质淡红，舌苔白。脉弦细。前方加减。

〔处方〕 生熟地各 10克 枸杞子 15克 女贞子 10克
石 斛 15克 麦 冬 10克 玳 瑁 10克
杭白芍 12克 滁 菊 10克 炒山栀 克
桑寄生 18克 宣木瓜 10克 钩 藤 10克
天竺黄 10克

前方加减共服十二剂，精神、语言均正常，左半身已经有力，行走如常人，已经能自行就诊，生活能自理，智能无障碍，饮食睡眠正常，大便通畅，停药观察。

〔例4〕 脑动脉硬化进行性痴呆

杨×× 男性 54岁 工程师 初诊日期为1964年4月18日。

〔问诊〕 十数年来患高血压病，血压经常170~180/110~120毫米汞柱，并有头痛、头晕、耳鸣、失眠等症状。三年前曾在门诊治疗，一度血压下降，症状好转，返回原单位工作。近半年来工作能力低下，周围人发现其性格及精神异常，少语，对工作漠不关心，讨论工作时呆坐不发言，当别

人征求意见时仅含糊一两句。此后逐渐精神痴呆，生活不能自理。在当地治疗无效，本单位将其送至我院治疗。其爱人代诉：患者不能辨认子女，终日呆坐不发一言，不知自取饮食，不知饥饱。大小便不自知，不辨昼夜，穿衣、脱衣均需家人照料。

〔望诊〕精神痴呆，面无表情，舌质淡红，舌苔白厚腻。

〔闻诊〕不能答问。

〔切诊〕脉弦滑。血压 210/130 毫米汞柱。

〔辨证〕肝阳上亢，风痰上扰，痰蒙清窍。

〔立法〕平肝潜阳，化痰开窍。方用十味温胆汤加味。

〔处方〕灵磁石15克 法半夏10克 化橘红10克

茯 神10克 远 志10克 石菖蒲10克

郁 金10克 枳 壳6克 桔 萎15克

陈胆星6克 牛黄清心丸 苏合香丸

各一九 每次各半丸。

二诊：1964年4月22日。前方服用三剂后能说出女儿的名字，有人提醒能自己大小便，三天来仅有一次夜间遗尿，晨起能自行穿衣，精神仍痴呆，但知道自己有病。血压 190/110毫米汞柱。舌质淡红，舌苔白腻已薄，脉弦滑。前方加天竺黄10克。

前方加减服用三十二剂，精神已接近正常，生活能自理，能自行上街散步，但智力仍迟钝，记忆力差。血压 160/90~100毫米汞柱。

〔例5〕高血压脑动脉硬化卒中后

刘×× 男性 60岁 工人 初诊日期为1965年11月19日。

〔问诊〕十数年来患高血压病，有时头晕、头痛、肢麻。昨日因工作劳累，晚上感觉疲乏不适，随即出现语言蹇涩，左侧半身不遂，右侧偏头痛，口干不思饮，不欲食，胸闷，昨夜仅睡一小时，今日大便尚未解。血压 200/120 毫米汞柱。

〔望诊〕神志尚清，体胖；舌体红胀，舌苔边白腻，舌中干黄。

〔闻诊〕语言蹇涩，呵欠频作。

〔切诊〕脉弦细。

〔辨证〕阴虚阳亢，风痰上扰。

〔立法〕滋阴潜阳，化痰熄风。方用平肝熄风合剂加减。

〔处方〕珍珠母 24克 白蒺藜 10克 熟地 24克
玳瑁 10克 炙龟板 10克 远志 10克
菖蒲 10克 天竺黄 10克 滁菊 10克
钩藤 10克 天麻 10克 木瓜 10克
竹沥水 30克 牛黄清心丸一丸 三剂

二诊：1965年11月22日。药后精神好转，睡眠好，右侧头痛已不明显，语言较前清楚，左半身运动较前灵便，大便仍未解。血压 170/110 毫米汞柱。舌质红，舌苔棕黄，舌中心黑。脉弦细。前方加减继服。

〔例6〕脑动脉硬化症、脑血管痉挛

冯×× 男性 61岁 农民 初诊日期为1965年12月27日。

〔问诊〕近五个月来感觉头晕，四肢发麻。五天前突然昏厥，神志不清，二便自遗，十数分钟后缓解，左半身不遂，口眼喎斜，语言不利，口角流涎。五天来每天都昏厥一、两次，

每次十数分钟始清醒，每次发作均遗尿。经××医院检查，诊为高血压病、脑动脉硬化症，脑血管痉挛。

〔望诊〕精神痴呆，口角流涎，舌质淡红，舌苔黄厚腻。

〔闻诊〕语言不利。

〔切诊〕脉左弦细，右弦滑。血压190/110毫米汞柱。

〔辨证〕风痰上扰，蒙闭清窍，阻滞经络。

〔立法〕熄风化痰，开窍通络。方用十味温胆汤合平肝熄风合剂。

〔处方〕珍珠母24克 白蒺藜10克 化橘红6克
法半夏10克 竹茹10克 枳壳6克
郁金10克 远志10克 菖蒲10克
茯苓12克 钩藤10克 竹沥水30克
苏合香丸两丸 每次一丸 四剂

二诊：1966年1月12日。按上方服药后，左臂及腿已能屈伸，左臂也能抬起，说话已清楚，精神正常，未出现过昏厥，仅感有时头晕。前方加减继服。

二诊：1966年2月3日。未再出现过昏厥，精神已正常，语言流利，左侧肢体运动灵活，口眼已正，能自行料理生活。

〔例7〕脑动脉硬化、脑血管意外后遗症

王× 男性 48岁 工人 初诊日期为1966年4月10日。

〔问诊〕患者素有高血压病，一个月前在高温车间工作，突然跌倒两次，第二次跌倒后发现左侧偏瘫，失语、二便失禁，右上肢不停摇动，精神痴呆。经××医院神经外科作脑

电图检查，发现右额颞转波段病斑，诊断为脑动脉硬化症、脑血管意外后遗症、左侧陈旧性偏瘫、失语。

〔望诊〕卧床不能动转，精神痴呆，对外界反应迟钝，舌质暗红，舌前段燥，舌根苔白。

〔闻诊〕失语。

〔切诊〕脉沉细而结。

〔辨证〕肾之阴阳两虚，虚阳上扰清窍。

〔立法〕补肾收摄虚阳。方用地黄饮子加减。

〔处方〕生龙骨 15克 生牡蛎 15克 生熟地各 10克
枸杞子 10克 石斛 10克 麦冬 10克
远志 10克 菖蒲 6克 肉苁蓉 10克
巴戟天 10克 茯苓 12克 五味子 6克
川断 10克

上方加减服用三十剂后言语正常，答问正确而流利，能持续坐两小时以上，左下肢活动有劲，在扶持下能步行，精神已恢复正常。

五、治疗体会

早期脑动脉硬化症的临床症状与高血压病的症状相似，两者的界限不易绝然分开。中医以辨证为治疗依据，因此，治疗脑动脉硬化早期有类似神经衰弱症状患者，仍可选用高血压病分型治疗的方法。

当脑动脉硬化患者进展到智能障碍而出现痴呆状态时，如病例介绍〔例4〕杨某，根据当时临床所见舌苔白腻而厚、脉弦滑，说明“痰”是主要病邪，而痰的产生是由于肝阳上亢的结果，阳亢——风动——痰升——风痰上扰——痰蒙清

窍——导致痴呆。从病机来讲，肝阳是本，痰邪是标；根据急则治其标，缓则治其本的理论，治标是主要的，治本是次要的。所以，在处方中仅用灵磁石一味以平肝潜阳，其它药物都集中到化痰开窍方面。经过治疗，不但痴呆状态好转，血压也相应地下降。

当脑动脉硬化症患者出现精神障碍、躁动不安时，其病机多为在阴虚阳亢的基础上，风动痰升而影响神明。阴虚阳亢为本，风盛痰凝为标。在治疗上则应该标本兼顾，也就是说应将滋阴潜阳和熄风化痰放在平等地位。如病例介绍之〔例2〕对王某的处方，以生石决明重镇潜阳；生地、枸杞子、白芍以滋阴柔肝，白蒺藜、天麻、钩藤、滁菊以熄风，橘络、天竺黄、远志、菖蒲配牛黄清心丸化痰开窍；经过一段时间的治疗，症状缓解，精神恢复正常；为了巩固疗效，防止前症再发，又采用缓则治本的方法，就是转移到肾阴虚和肝阳亢的方面，肾阴虚是本，肝阳亢是标，所以在最后的处方中以滋肾阴为主。龙骨、龟板这两种药本身具有滋阴潜阳的作用，因此，就不必单独选用其它平肝潜阳的药物。熟地、肉苁蓉、石斛滋肾益精，枣仁、甘草、酸甘化阴兼安心神，是针对精神症状的；当归养血以缓肝之急，羚羊角清肝熄风。由此看来，治疗同一种疾病，要根据其不同阶段的病机转化，处理好治标、治本的主次关系。

脑动脉硬化症卒中，大多数是有前驱症状的，如发作性的眩晕、呕吐、肢麻、昏厥等。病例介绍的〔例1〕张某，发作前的征兆为类中风脱症之前兆，症属阴精亏损，虚阳上越，故脉关后濡软，关前洪大；头目眩转乃虚风内动之象；四肢厥冷，舌卷囊缩，二便欲遗，为虚阳欲脱之兆；口干思热

饮，便溏洩清，即命门火衰之候；面红如妆，舌面齿缝出血，为真火衰于下，虚火浮于上，即所谓阴虚不敛阳，虚阳不能孤存之危候。若仅以高血压、面红、脉洪大等局限认证，妄用平肝潜阳之剂，使虚阳再伤，恐难挽救。方以桂附八味引火归源，加龙骨、牡蛎、龟板仿三甲复脉之意填下潜上，导龙以归海，使阴平阳秘而诸证皆消。继之以地黄饮子加味，滋补肾命以收功。但是，这一例的治疗，只能说对张某当时的特殊情况适宜，还不能概括所有卒中前的规律。

脑动脉硬化症发展到脑血管意外，出现一侧肢体麻痹和失语等症状时，均以中医的类中风辨证论治。目前，有些人一见脑血管意外，便机械地采用活血化瘀法治疗，而舍弃辨证论治这一基本法则。活血化瘀法只能说是治疗类中风的方法之一，不可不分析临床的具体情况，一概使用活血化瘀法来治疗所有的脑血管意外症；否则，会造成不良后果，甚至使患者终身残废。

第七章 精神分裂症

精神分裂症是精神病中较多见的一种，其典型的临床表现是思维、情感、意向行为的互不协调，联想散漫、情感淡漠、言行古怪而脱离现实，病情迁延而逐渐进展，除少数病人可自行缓解外，如不经适当治疗，部分病人可在晚期呈现精神衰退。

第一节 中医的有关论述

一、关于症状的论述

早在公元七世纪，巢元方就在《诸病源候论》对精神分裂症的病象有所描述：“其状不同，或言语错谬，或啼哭惊走，或癫狂悖乱，或喜怒悲笑，或大怖惧如人来逐，或歌谣咏啸，或不肯语……”。“其状不欲见人，如有对忤，独言笑，或时悲泣……。”

唐代孙思邈在《千金方》中说：“凡诸百邪之病，源起多途，其有种种形相，示表癫邪之端而见其病，或有默默而不声，或复多言而漫说，或歌或哭，或吟或笑，或眠坐沟渠、噉食粪秽，或裸形露体，或昼夜游走，或嗔骂无度……。”以上这些描述，很象精神分裂症的表现。总之，精神分裂症是属于癫狂的范畴，而且本病患者兼有狂癫二症，即既有癫的

意志活动减弱，缺乏主动性，孤僻、沉默、情感反应迟钝，对周围事物漠不关心，表情淡漠，推之不动，问之不语的木僵状态；又有狂的突然发作，兴奋躁动，语无伦次，行为暴烈，突然冲动以及伤人毁物等状态。尽管症状多端，但毕竟还是具有一些共同的基本特征。

二、关于病因病机的论述

精神分裂症的临床表现，很象中医所称的癫狂。古人对癫狂的病因机理论述很多，如张从正在《儒门事亲》中说：“肝屡谋，胆屡不决，屈无所伸，怒无所泄，心血日涸，脾液不行，痰迷心窍则成心风”。朱丹溪在《丹溪心法》中说：“癫属阴，狂属阳，癫多喜而狂多怒，脉虚者可治，实则死，大率多因痰结于心胸间”。明虞传在《医学正传》中说：“大抵狂为痰火实盛，癫为心血不足，多为求望高远不得志者有之。”清陈士铎在《石室秘篆》中说：“癫病之生也，多生于脾胃之虚寒，脾胃虚寒，所食水谷不变精而变痰，痰凝胸膈之间，不得化，流于心，而癫证生矣。”清丁甘仁说：“肾阴不足，心肝之火有余，此坎离不交之象也。痰热蒙闭清窍，神不守舍，舍空而痰热居之，痰火上凌，故彻夜不眠，痰蒙心则多疑，时闻申申之语”。

综上所述，无论肝屡谋而不决，屈无所伸，怒无所泄，或求望高远不得志，皆为诱发本病之精神因素。根据多年临床所见，精神分裂症患者病前多有明显的精神刺激因素，而后发病。至于刺激因素的强弱是否足以引起发病，则因人的素质(个性)特点和当时躯体状况而异。有的人由于微不足道的原因竟引起发病；有的人虽受到较大的刺激，却能坦然处

之。可见精神因素为诱发精神分裂症的重要条件。

至于病机，与病因有密切的联系。一切事物都不是无因之果。如谋而不得志，或屈无所伸，怒不得泄，这些精神因素负担日久，就会耗伤心血。心主神明，心血不足，则神不守舍，就会出现精神恍惚的异常表现。至于痰，乃是病机转化过程中的病理产物。气机失调影响脾的运化功能，水谷不能运化精微充养五脏六腑，脾液蓄而为痰，痰盛蒙闭清窍，而使病情明显化，清窍被蒙，神明被阻，出现一系列离奇古怪的症状。正如周梦觉在《三指禅》中说：“顽痰生怪状”。这为以化痰开窍的治疗法则提供了理论根据。但临床必须注意，痰蒙清窍的现象并不少见，而必须根据临床“四诊”确见痰的征象，如舌苔厚腻、脉象滑等确证为准。体弱之患者，或传染病后热伤阴液，或素有神经官能症的患者，肾阴早虚，再加之精神因素，引动心肝之火上逆，势必造成肾水虚于下，肝火合邪燔于上，使水火不相济，心肾失交，火热炼液为痰，痰热蒙闭清窍，致使夜不成眠，多疑妄想，时时申诉骂詈。还应注意，痰蒙清窍之症，尚有脾胃虚寒、脾不运化之寒痰；气机不畅妨碍脾液运转、水湿停蓄之湿痰；以及心肝火盛炼液成痰之热痰。这些鉴别，尚需根据临床“四诊”详细辨认，辨证才不致有误。

第二节 临床表现

精神分裂症的临床表现十分复杂，不仅每个患者表现不一样，就是同一患者在不同时期也可表现不一样。一些基本症状，如联想障碍、逻辑障碍、妄想、情感淡漠或情感倒

错、意向缺乏、脱离现实以及思想、情感、行为分离等，不一定在任何患者任何情况下都可见到。现将本病常见的症状介绍如下：

一、思维障碍

思维障碍是精神分裂症最具有特征性的症状之一。其特点是病人在意识清楚的情况下，思维联想过程分裂，思维内容脱离现实，缺乏具体性和实际性。病人在言谈或书写中，其语句在文法结构上可能是正确的，但语句之间、概念之间、上下文之间缺乏内在的、意义上的联系。严重时，言语显得零乱，毫无中心内容与实际意义，使人无法理解和捉摸其中心思想。有时病人独创新词，将不完整的词拼凑起来，常人不能理解其内容。或者在说话过程中，无任何干扰而突然中断。或涌现大量的强制思维，有时思维可突然转折，或出现一些无关、意外的联想。有时病人感到思想不由自主，难以控制，并常常作出妄想性的判断。

二、情感障碍

情感障碍主要表现为情感淡漠，情感反应迟钝，不关心周围事物；对任何刺激均无反应，即使出现一些反应，其表情也不鲜明生动。有的患者情感变化多端，喜、怒、哀、乐转化很快，令人不解其因。有的情感倒错，常常以漫不经心的表情叙说其最痛苦的经历，或者谈到令人高兴的事情竟痛哭流涕。

三、意向障碍

意志活动低下或缺乏，其表现是缺乏动力，缺乏主动性和积极性，行为懒散，萎靡不振。尤其是高级神经活动受到影响，如对社交、工作和学习没有要求，不主动与人往来，整日闭门幽居或蒙头而卧，生活懒散，不修边幅，不注意清洁，孤僻、退缩，日益脱离现实。有的患者发生矛盾意向，即使对日常极简单的事物，也反复考虑难于决定。有的患者意向活动障碍可表现为刻板动作，模仿动作，机械性服从或违拗等紧张综合征。有的患者有“外力感”，感到自己的思想是外来的，不受自己的支配，表情、动作是人为的，是别人在让自己哭或笑；缄默不语或做奇怪的动作是违反自己意愿的，自己想说的话又说不出；患者常对上述现象加以妄想性解释，认为有外来的力量在操纵控制自己。

四、感知障碍

幻觉，是精神分裂症常见的感知障碍症状之一，其特点是幻觉常在患者意识完全清醒的状态下出现；听幻觉，特别是语言性听幻觉最多见，而触幻觉、嗅幻觉、视幻觉和内脏幻觉则较少见。幻觉的内容比较单调，缺乏变化，往往使患者不愉快，或对患者的行为加以评论，或谩骂、威胁、命令等。这类幻觉多为真性幻觉，声音清晰，患者往往信以为真，因而可支配患者的行为或影响其情绪。幻听可来自各方，耳旁、枕下、窗外，或十分遥远的地方。幻听的内容多离奇，患者可与幻听中声音对话，出现喃喃自语，或作侧耳倾听状，或沉醉于幻觉体验之中，自笑、自言自语、作窃窃私语状。

妄想，是精神分裂症感知障碍的又一常见症状。妄想可为原发性的，也可为继发性的。以关系妄想、被害妄想和影响妄想最常见。妄想的结构可系统，可片断。主要特点是离奇、突然和脱离现实。如患者认为周围事物都是针对自己的，新闻内容、广播内容、街上标语等等都含沙射影地在说他。到处有人在跟踪他，或用特殊仪器控制他的思想，以致自己的语言，行动周围人都知道。有时可见疑病妄想、钟情妄想。

第三节 临床分型与治疗

精神分裂症的上述基本症状和临床特点，并非在任何患者均可全部呈现，但就每一患者而言，必然具备其中若干基本症状。为了反映患者在疾病发展过程中某一阶段的临床特点，以往临床精神病学家按患者的基本症状、病程和预后的不同，将精神分裂症分成几种临床类型。通过较长时间的观察，表明每一患者所表现的临床类型具有相对的稳定性，但有部分患者随着疾病的发展演变，其临床表现可从一种类型转变为另一种类型。精神分裂症早期阶段的患者，其各种临床表现的特点不一定十分明确，经过长期的演变，到后期出现精神衰败时，则各型的转归又趋向一致，很少再保持原有类型的结构。对分型的意见，国外颇不一致，但国内一般采用克雷丕林的分型原则，把精神分裂症分为单纯型、青春型、紧张型和妄想型；不能归入这四型的或症状不典型的病例，则归入未定型。

一、单纯型的临床表现及治疗

(一) 症状表现

此型精神分裂症，发病多在青少年时期，起病缓慢，持续进行，病情自动缓解者少。临床表现主要是日益加重的孤僻、被动，活动减少，生活懒散，情感逐渐淡漠，对学习、工作和生活的兴趣越来越少，对亲友逐渐冷淡。开始可出现类似神经官能症的症状，如易疲乏，失眠，不主动等。幻觉、妄想一般不明显。此型病人在发病早期常被误认为是思想问题或性格问题，往往经过数年病情发展较严重时才被发现。治疗效果较其它类型为差。

(二) 典型病例

〔例1〕张×× 男性 18岁 大学生 初诊日期为1962年5月29日。

〔问诊〕患者平日性格孤僻，自幼好静，沉默寡言，不喜爱娱乐和运动，不善与同学交往，爱读书，从小学至高中学习成绩良好。十七岁高中毕业考入大学。上大学后学习感觉吃力，两个月后听课时精神不能集中，记忆力减退，学习成绩下降。半年后家人发现他精神异常，对一切事物无情感反应。其父在外地工作，寄信回来患者不闻不问，其母令其读信，手持信半日不能读出只字。日常饮食、睡眠均需人督促。不能辨认昼夜，睡眠少，常午夜后不眠，独自呆坐。夜静时常低声自语，听不懂在说什么，问他时能勉强说出：“脑子乱”。一日，其母叫他把垃圾倒掉，竟将垃圾箱搬进屋内。叫他到附近商店买两种东西，或遗忘一种，或错购而归，或出去终日不归，找到时需强迫他回家。生活懒散，不

知清洁。经××医学院附属医院精神科诊断为精神分裂症单纯型，经过半年治疗无明显效果，故转中医治疗。

〔望诊〕精神呆板，表情淡漠，舌质淡，苔白。

〔闻诊〕答问切题，但有时是重复别人的语言。

〔切诊〕脉沉细，小数。

〔辨证〕强读苦思、劳伤心脾。心藏神，脾藏意，心强用则耗神，脾过思则伤意，神昏意乱，若癡若痴。

〔立法〕养心补脾，强神益智。方用补心丹加减。

〔处方〕熟地12克 当归10克 白芍12克
党参10克 丹参10克 元参10克
炒枣仁15克 远志10克 菖蒲8克
五味子6克 甘草4.5克 益智仁10克
首乌藤15克

二诊：1962年6月12日。按前方服药七剂，精神接近正常，能主动做些家务劳动，看完电影能复述内容，下棋时能考虑对策战胜对方。服中药时即停服西药，睡眠安好，就诊时面有笑容，能主动交谈。舌质淡红，舌尖红，苔根微黄。脉细小数。

〔处方〕前方去益智仁，加莲子心3克，麦冬10克。

经门诊治疗一个月，共服药二十一剂，精神正常，能在十数分钟内写出给他父亲的回信，能独立思考，阅读长篇小说能够谈出书中人物的特点。曾去原医院精神科复查，认为精神分裂症已基本痊愈。停药四周，嘱其再去原医院检查，认为精神恢复正常，可以参加学习，并开给复学证明。停药观察两个月，疗效巩固。

〔例2〕王×× 女性 33岁 会计员 初诊日期为1962

年5月30日。

〔问诊〕患者于1952年曾患过神经衰弱，经过治疗症状好转，能坚持正常工作。1958年，因精神受刺激，前症复发，头晕、耳鸣、目眩、睡眠不实、多恶梦，并感胸闷气短，心悸，烦躁。此后意志日渐消沉，对周围事物不感兴趣，不愿与人接触，常闭户独处，生活懒散，不注意衣着整洁，不洗脸理发，有时言语错乱，从1958年底不能坚持正常工作。经××医院诊断为精神分裂症单纯型。四年来一直服用西药，病情无明显改善，故转院治疗。

〔望诊〕形体较胖，表情淡漠；舌质红，尖赤，舌苔白。

〔闻诊〕语音低微，语无伦次，不能正确答问。

〔切诊〕脉沉细数。

〔辨证〕肝郁血虚，心阴不足，心火有余，神不守舍。

〔立法〕平肝舒郁，养阴清心安神。方用清心安神汤。

〔处方〕生石决明 18克 珍珠母 18克 生地 15克
杭白芍 12克 首乌藤 15克 炒枣仁 15克
远志 10克 菖蒲 6克 阿胶 10克
黄连 3克 合欢皮 10克 甘草 3克

二诊：1962年6月20日。按前方加减服药十剂后，精神较正常，但不巩固，睡眠好仍有梦，头脑胀大，头晕已大为减轻，自觉心情舒畅，近十天来没有语言错乱，能主动与人交谈，自己能料理生活。就诊时面有表情，衣着较前清洁。舌质淡红，苔根白。脉沉细略弦。

〔处方〕前方去黄连，加生栀子6克、白薇10克。

1962年7月18日。经过一个半月治疗，患者精神逐渐恢复正常，能从事家务劳动；头晕胀大的感觉已消失，睡眠好，

在考虑自己的工作。舌质淡红，苔薄白，脉沉细有力。继服补心丹以巩固疗效。

〔处方〕补心丹每服一丸，早晚各服一次。

（三）病例分析

以上两例均为精神分裂症单纯型，其基本症状如情感淡漠，对周围事物不感兴趣，孤僻，生活懒散等，均有其共同之处，但因二者的患病诱因不同，一为强读苦思、劳伤心脾，一为郁怒伤肝，故对二者的辨证治疗也不同。例一除基本症状外，无任何自觉症状，舌质淡，脉以沉细为主，属于纯虚证，故辨证为心脾两伤，神智失常，以养心补脾、强神益智之法治疗，在短期内取得疗效。例二除基本症状外，尚有头晕、头胀、耳鸣、目眩、睡眠不实、多梦、胸闷、心悸、烦躁等自觉症状，且有语言错乱现象及舌质红、舌尖赤、脉沉细数等体征；结合病前因素及临床所见，认为本例是肝郁日久，耗伤阴血，阴血虚而肝阳上亢，故以平肝舒郁、养阴清心安神之法治疗。方中以生石决明平肝潜阳治头晕、头胀、耳鸣、目眩；珍珠母镇静安神，治语言错乱；生地、白芍养阴柔肝；首乌藤、炒枣仁、远志、菖蒲养血安神，治睡眠不实多梦；阿胶、黄连、甘草清心火，治烦躁不安；合欢皮舒肝解郁，治胸闷不舒。经过治疗，临床症状消失，精神逐渐恢复正常。

二、青春型的临床表表及治疗

（一）症状表现

青春型精神分裂症多发生在青春期，起病可急可缓；发病急骤的，常于短期内达到高潮。此型患者的主要症状是语

言内容离奇，不可理解，甚至言语思维破裂，情感喜怒无常，行为幼稚愚蠢，可有片断的幻觉和妄想，患者的动作和情感改变，多受幻觉和妄想的支配。常伴有食欲、性欲亢进。冲动行为颇多见。如能及时治疗，效果较好。

（二）典型病例

〔例1〕仲×× 女性 17岁 高中学生 初诊日期为1964年7月3日。

〔问诊〕患者病前性格孤僻，沉默寡言，倔强好胜，爱面子。自小学起学习成绩尚好，现在高中二年级读书。父母为双职工，弟兄姐妹六人，患者最大，除在学校学习，回家后尚需负担家务劳动，影响自习。因此，在期中考试有两门功课较差，受到一些同学的讽刺，自己感觉心中委屈。回家后向父母申诉，又遭到父母的批评。此后情绪低落，不关心家务，不理睬父母，回家后常面对墙坐，用手指挖墙，父母督促她做家务事，不声也不动。父母认为她是耍性子闹脾气，一周前将她责打。她于受责打次日下午放学去外婆家，突然精神失常，哭闹喊叫，打人毁物，数人阻止不住；夜间不睡，时而侧耳倾听，时而向窗外说：“我知道了，我知道了……”语言杂乱，词句不连贯。经数人强制将其送到××精神病院，诊断为精神分裂症青春型，当时未收住院。因患者见父母闹得更凶，因此父母不敢接近她，故仍将患者送到外婆家。有人建议中医治疗，曾三次来医院，因患者不进医院均未得到治疗。患者的姨母对她较好，向她说到朋友家去玩，将患者带到医院，指着医生说这是阿姨，因此就诊尚属合作。

〔望诊〕精神表现紧张、拘谨，舌质红，苔黄。

〔闻诊〕 答问荒谬。

〔切诊〕 脉弦滑数。

〔辨证〕 抑郁不伸，怒不得泄，肝郁化火，邪扰神明，症属为狂。

〔立法〕 解郁泻火宁神。方用分裂症青春1号。

〔处方〕 珍珠母 24克 龙胆草 6克 炒山栀 6克
黄 芩 6克 黄 连 3克 细生地 15克
杭白芍 12克 丹 参 10克 元 参 10克
炒枣仁 18克 远 志 10克 菖 蒲 6克
合欢皮 10克 天竺黄 10克 琥珀末 1.5克(分冲)

二诊：1964年7月6日。上次就诊后，当晚将药服下，夜间沉睡至次日，醒后问：“我为什么在外婆家？”精神较清楚。此后再没出现冲动行为和乱语。昨日已回家继续服药，对父母态度如病前。今日患者随父亲来医院就诊，认识医院环境，承认曾来过医院，也认识医生。问她为什么病中哭闹、打人毁物，回答说：“因为听到很多人在说话，心里急躁，有人说打……打……打，当时不由自主”。舌质淡红，苔白，脉沉弦细。

〔处方〕 前方加朱寸冬10克，继服三剂。

三诊：1964年7月9日。患者随其母就诊，精神、语言、行动均已正常，近几天来饮食睡眠均如病前，并能料理家务，患者征求意见说：“暑期考试快到了，是否可以参加考试，利用这几天时间好好温习功课”。舌质淡红，苔白，脉沉细滑，前方加减继服四剂。

患者就诊三次共服药十剂，停药后精神正常，病情无波动。同年7月16日，患者参加暑期考试。

〔随访〕十个月后追访，患者学习成绩良好，没有任何精神症状。

〔例2〕刘× 女性 20岁 技校学生 初诊日期为1981年3月10日。

〔问诊〕患者姐弟三人，患者居长。父母及外祖父非常疼爱女孩，自幼年一切生活琐事均需家人照料，对一般事物自己也不肯独立思考，凡事皆需家长给予安排，性格懦弱。高中毕业后未能考取大学，于1979年考入专科技校学习。患者虽对本专业不十分喜爱，但学习成绩尚好。四个月前家长发现其精神异常，经常对着镜子笑，继之声称学校某男生爱慕她，自认为该男生的一切举动言行都是暗示对她的爱慕之情，从此学习精神不能集中，后就医休病假。一日自己打扮好说是与某男生约好在某处会面，其母陪同前往，并未见到有人等她。随后家长去学校访问班主任，班主任从未发现她与某男生有过接触；于是又找某男生了解情况，该生否认和她有过联系。至此，家长始意识到她病情的严重。经××精神病院诊断为精神分裂症青春型。经治两月余无效，逐渐发展到常将衣服脱掉，裸体在房中行走而大笑不止；食欲增加，不断要东西吃。

〔望诊〕精神恍惚，神态似十六、七岁少女。唇红；舌质红，边尖起红刺，苔黄。

〔闻诊〕问她和某男生是否交谈过，回答是：他的一切动作都代表语言，只有我自己才能领会。

〔切诊〕脉滑数。

〔辨证〕龙雷上僭，引动心火，邪扰神明。

〔立法〕泻相火，益心阴，镇静安神。方用 分裂症青春

2号。

〔处方〕珍珠母 30 克 龙胆草 8 克 炒山栀 8 克
黄 芩 8 克 黄 连 3 克 丹 参 10 克
元 参 10 克 远 志 10 克 菖 蒲 6 克
知 母 10 克 黄 柏 8 克 炒枣仁 15 克
琥珀末 1.8 克 (分冲) 朱砂末 1.8 克 (分冲)
川 军 3 克 胆 星 10 克
五剂

按前方加减服药十五剂，愚蠢动作消失，幻听已无，睡眠也好，精神接近正常，对病中的想法有批判能力，承认与某男生从没有交谈过。4月13日停服汤剂，为了巩固疗效，配制丸剂缓服。已参加学习。

〔处方〕珍珠母 120 克 龙胆草 30 克 炒山栀 30 克
黄 芩 30 克 黄 连 12 克 生 地 60 克
丹 参 40 克 元 参 40 克 远 志 30 克
菖 蒲 24 克 知 母 30 克 黄 柏 30 克
炒枣仁 60 克 胆 星 30 克 川 军 10 克
琥珀末 6 克 朱砂末 6 克

以上共研细末，炼蜜为丸，每丸 10 克，每服一丸，早晚服。

〔随访〕虽因病停止学习三个多月，但暑期考试成绩尚好。本年寒假期末考试，成绩优良，被评为优秀学生。1982年毕业后被分配×厂工作，专业技术熟练，无任何精神症状。

(三) 病例分析

典型病例之一为急骤发病的青春型精神分裂症。患者病前有孤僻、倔强、爱面子等个性特征，发病的诱因因为期中考

试成绩差受到同学们的讽刺，父母不但不同情和给予安慰，反而批评，尤其是在患者已示病情的情况下，父母仍不理睬，并加以责打，致使患者屈无所申，怒无所泄，抑郁化火，邪扰神明，很快形成势不可挡的情感冲动，表现为打人毁物的精神狂妄状态。这种行为是由幻听觉的影响造成的。根据《内经》“诸躁狂越皆属于火”的理论，治以解郁泻火宁神是当务之急。药后患者沉睡，醒后前症若失。实践证明本型如能早期得到适当治疗，疗效快且愈后较佳。为了预防精神病的发生，也应作到群防，普及精神卫生学知识。本例说明，父母对子女一定要教育得法，切忌简单粗暴。

典型病例之二，为病情逐渐发展的青春型精神分裂症。患者由钟情妄想开始，一切行动均受幻觉妄想的支配，出现不知羞耻等行为，最后出现本能（性欲、食欲）的亢进。患者为家庭之宠儿，性格懦弱，病前无任何精神因素，因何而患此症？据当时临床所见，患者出现一派火盛之象。究其火之来源，非为五志所化，乃自身生理过程中相火偏盛所致。肝胆也为相火之属，肝肾同源，肾为龙火，肝为雷火，龙雷之火上僭，肾水不得上济心火，坎离失既，反被上僭之相火引动心火，致成上下如焚之势，心神被火扰而丧失理智，故裸体而不知羞耻。患者发病年龄正值青春期，心理及生理都发生较大变化，最突出的是“性”的成熟。根据作者多年对本型精神分裂症患者的观察，无论男性还是女性，都有性欲亢进的特点。古人也曾有“花癲”（见男子抱之不放，认为情人）之记载。故治疗本型患者多采用泻相火之法，收效较好。方中用知、柏泻相火；胆草、山栀泻肝火；黄芩、黄连泻心火；川军泻胃肠之火；重用生地益阴，合元参以补偿火盛所伤之阴；丹参

入心，元参入肾，取其心肾相交；远志能令肾气上达于心，菖蒲开心窍；远志、枣仁以养泻火后所伤之心神；珍珠母、琥珀、朱砂重镇邪扰之神，以除行为之躁扰；使用胆星以防火炽炼痰，恐痰火交炽病情加剧。

上述两例虽同为青春型精神分裂症，但病因病机并不相同，故治疗方法也不同。

三、紧张型的临床表现及治疗

（一）症状表现

此型精神分裂症患者多为青年人，起病较快，早期表现萎靡不振，食欲低下，怠惰少动，对任何事情都无兴趣，情绪低落。随着疾病继续发展，则有紧张型木僵和紧张型兴奋两组不同的综合征出现。

1. 木僵状态

患者情感淡漠，言语动作明显减少，有时呆立或呆坐数小时不动，可显示刻板动作、刻板语言、模仿动作、模仿语言和违拗等症状。严重时不言、不动、不饮、不食，两目紧闭或凝视，面无表情；推之不动，呼之不应，对一切刺激均无反应。膀胱和直肠内虽积有大量尿和粪也不排泄；口腔中虽积有大量涎液既不下咽也不吐出，任其自流；全身肌张力增高，并可有蜡样屈曲出现；这一状态短的只维持几小时，长的可达数年之久；既可逐渐消失，也可突然结束，部分患者随即进入兴奋状态。

2. 兴奋状态

这一状态往往是突然暴发的。患者兴奋激动，行为暴烈，常有毁物伤人行为，幻觉常很丰富。这一状态一般维持几

小时或数日，然后缓解，或进入木僵状态，或出现持续的刻板动作。严重时可昼夜躁动不安，以致衰竭。本型患者预后较好，有时可自行缓解。

（二）典型病例

蔡×× 女性 14岁 小学生 初诊日期为1965年初夏。

〔问诊〕两年前，患者开始出现一些无意识动作，如不正常的跳跃，向后倒着走路，有时突然惊叫，表现恐惧，眼球常作异常转动。其母请医生，患者哭闹拒绝检查，病未看成，母亲打了她。后强迫将其送到××医学院精神病院，当时诊断为神经官能症。住院两个月，症状有所缓解，出院后去北戴河疗养。初时白天游泳玩，精神无明显异常，但夜间哭闹，仍有无意识动作，常说一些单调使人听不懂的话，好反复地叠被子，或经常将双手放在腋下。在北戴河疗养四十多天。回家后的某一天，她随一看她的同学出走，并住在同学家不肯回来。天气冷了不穿棉衣。春节期间将其送到南京，经××精神病院注射镇静剂后始收入住院，诊断为精神分裂症，以胰岛素休克法治疗，在第一次治疗时呼吸停止，经抢救始恢复，此后停用胰岛素治疗。随即出现孤僻、怀疑、拒不进食等症状，经常需要强制注射葡萄糖以补充营养。出院回家后，常倒锁房门，一人独居，不许家人见她，整日低头缄默不语，两目紧闭。常呆立数小时不动，小便解于裤内，大便数日未解。

〔望诊〕呆立不动，呈木僵状态，两目紧闭，口涎外流，面无表情，推之不动，无法令其开口望舌。

〔闻诊〕问不作答，默默无声。

〔切诊〕脉沉(患者违拗拒按，三人强制诊得)。

〔辨证〕发病之始，躁动不休，为肝风内动之象；风动痰升，痰阻神明，清窍被蒙，转为痴呆。

〔立法〕豁痰，开窍。方用豁痰饮。

〔处方〕法半夏6克 栝 蒌15克 菖 蒲6克
远 志10克 茯 神10克 竹 茹6克
陈胆星6克 天竺黄10克 郁 金6克
竹沥水30克(分两次兑) 生姜汁十滴
礞石滚痰丸10克(布包煎)

(三) 病例分析

本例紧张型精神分裂症患者发病年龄较早，初病时仅有十二岁。开始表现为无意识动作，眼球异常转动，或有不正常跳跃，这些都是肝风内动之征象。肝主惊，故有时惊叫，夜间哭闹不休，此种征象在儿科颇为多见，若当时以镇惊熄风之法治之，其症状或可消失。久之风动痰升，痰阻清窍，则出现孤僻、怀疑、拒不进食等精神状态，直至发展到缄默不语、呆立不动的木僵状态，皆属痰蒙清窍之故。若日久病机转化，体液不得充养，液涸津伤，脏燥化火，痰火相并，病即转变为狂妄的兴奋状态。此即本型由木僵状态转为兴奋状态的病理机制。兴奋状态时，治以清火化痰法，以泄其邪势，可使患者症状早日缓解；若不经治疗，在兴奋状态时消耗体力，火气消散，以致衰竭，有的则又转入木僵状态。

四、妄想型的临床表现及治疗

(一) 症状表现

妄想型是精神分裂症中较多见的一型，发病年龄较其它

各型为晚，多在 30 岁以后，起病也较缓慢。开始时敏感、多疑，逐渐发展形成关系妄想，总觉得周围发生的一切现象都与自己有关。如把旁人的咳嗽认为是侮辱他 或是在传递暗号，把旁人吐痰认为是鄙视他，把旁人谈话都认为是议论他，甚至把报纸和电台广播的消息也认为是影射他而发表的。这种关系妄想涉及的范围越广，就越容易形成被害妄想，即患者认为周围的一切变化，都是有人为了要迫害他而故意布置的。除被害妄想外，还有疑病妄想、嫉妒妄想、自罪妄想和影响妄想等。这一类型的患者绝大多数有幻觉，以听幻觉最常见，幻觉妄想的内容多较荒谬。其情感和行为常受幻觉及妄想的支配，可表现为疑惧、愤怒、激动，因而有时甚至有伤人、自伤等危险行为，自发缓解者较少。早期患者的人格变化一般均不明显。除表现为病人常不愿意暴露自己的幻觉妄想内容外，在精神活动的其它方面变化不大。因此，在发病后相当长的一段时间内，患者的工作能力尚能保持，故往往不易早期发现。这一类型患者的精神衰退出现较晚，预后一般较好。

（二）典型病例

〔例 1〕刘×× 男性 51 岁 职员 初诊日期为 1965 年 2 月 26 日。

〔问诊〕患者在八年前调动工作，因不能正确对待而精神不愉快，怀疑组织有意迫害他。此后，他总觉有人跟踪监视自己，每出门都要东张西望，或躲在门后等一会儿再出去。走在街上不时向后看，忽而快走急奔，忽而停下不敢前进；要到什么地方去，不走应该走的路，而要东转西绕，意在甩掉监视他的人；他说邻居都是组织上串通好的，都在监视他，蓄

意迫害他。有人吐口唾沫，或小孩在地上大小便，他说是有
意污染环境散布细菌来迫害他；对此，他除了叫骂之外，还
满屋满院到处泼水。患者夜里不睡觉，家人经常给他服安眠
药。1964年12月12日，经××医院诊为精神分裂症妄想
型，收住院治疗20天症状缓解而出院。出院后半个月症状
如前，且有气促发憋、饮食减少等症，故转中医治疗。

〔望诊〕面色黄，形体瘦，两目闪动不停，面部时做出怪
表情，嘴动磨齿作响，随着呼吸微微点头。舌质淡红，舌苔
棕黄腻。

〔闻诊〕喉中痰鸣，一般能正确答问。

〔切诊〕脉滑有力。

〔辨证〕气郁不舒，痰结不化，痰阻清窍，症见为癫。

〔立法〕解郁化痰，开窍醒神。方用十味温胆汤加减。

〔处方〕法半夏 10克 北秫米 15克 远 志 10克

石菖蒲 6克 黄 连 6克 橘 红 6克

竹 茹 10克 炒枳壳 6克 栝 蒌 15克

郁 金 10克 茯 苓 10克 胆南星 10克

炒枣仁 24克

苏合香丸两丸，牛黄清心丸两丸，每次各一丸，
早晚服。

二诊：1965年3月11日。按上方加减服药八剂，每次
服药后吐痰量多，痰如胶冻(总量大约有2000~3000毫升)，
大便泻粘液或水样便。就诊时未见面部怪动作。睡眠好，自
觉胸中舒畅，精神好转，几天来没有大闹。仍有怀疑，晚上
睡前还要在屋内泼些水，骂几句再上床睡觉。舌质淡红，苔
微黄。脉滑。按前方加减共服药二十八剂，症状消失，精神

已正常。

〔例2〕包×× 男性 46岁 干部 初诊日期为1965年5月28日。

〔问诊〕患者病前个性孤僻，心胸狭窄，多疑，倔强，沉默寡言，与同事相处关系不好。两年前常因小事发脾气，此后精神逐渐异常，妄想有人在监视自己行动，幻听到别人在议论自己，常喃喃自语，睡眠少。两年来不能工作，近一年来自觉头脑混乱不清，不能阅读，分析能力差，记忆减退，性欲减退。于1964年3月经××医院诊断为精神分裂症妄想型，住院治疗七个月，服大量氯丙嗪，症状好转而出院。

现在精神表现痴呆，少动不语，仍有妄想及幻听觉，睡眠少，多梦易醒，痰多，饮食不主动。

〔望诊〕精神呆滞，表情淡漠，目直视，手颤，舌质淡红，舌苔黄腻，舌中心沟裂。

〔闻诊〕强问能回答，声低而缓慢，答问正确。

〔切诊〕脉沉细滑。

〔辨证〕气郁痰结，痰阻神明，致成癫症。

〔立法〕解郁化痰，开窍醒神。方用十味温胆汤加减。

〔处方〕橘 红6克 法半夏6克 茯 苓10克
竹 茹10克 枳 壳6克 胆 星6克
郁 金6克 远 志10克 菖 蒲6克
天竺黄10克 合欢皮10克 黄 连6克
苏合香丸两丸每次一九 四剂

二诊：1965年6月1日服药后精神好转，言语主动，自觉头脑较前清楚。睡眠仍少，舌质淡红，苔腻减少，脉沉

细滑。前方加炒枣仁 18 克。

至 1965 年 6 月 29 日治疗一个月，共服药二十三剂，妄想幻听已消失，精神、睡眠均已正常，能一次阅读一整版报纸，并能分析内容，记忆力逐渐恢复。停药观察至 7 月 8 日，根据患者已基本痊愈的情况，准予参加轻工作。

〔例 3〕陈× 男性 40 岁 干部 初诊日期为 1965 年 3 月 19 日。

〔问诊〕近一个月来，患者上班或者呆坐，或者外出奔走，言语颠倒，自卑自罪，拒不吃食，昼夜不眠，自语不休，有时哭泣，有时作笑。曾去××附属医院精神科诊断为精神分裂症妄想型，经治疗效果不显而转院治疗。

〔望诊〕精神呆板，表情淡漠，舌质淡红，舌苔白厚腻。

〔闻诊〕语言迟缓，答问不够正确。

〔切诊〕脉沉滑。

〔辨证〕气郁痰结，痰蒙清窍，致成癫症。

〔立法〕解郁化痰开窍。方用十味温胆汤加减。

〔处方〕橘 红 10 克 法半夏 10 克 茯 苓 12 克

竹 茹 10 克 远 志 10 克 石菖蒲 6 克

佩 兰 10 克 藿 香 10 克 枳 实 15 克

郁 金 6 克 秫 米 15 克

苏合香丸两丸 每次一丸 三剂

二诊：1966 年 3 月 22 日。服第一剂药后，精神即好转，有兴趣看连环画，能理解内容。三天来没有哭泣及语言颠倒现象，每夜能睡 3~6 小时，主动进饮食。今天就诊能主动讲话，有喜悦表情，目光较前有神，自觉胸闷，总想长吁。答问正确。舌质淡红，舌苔已退，舌根苔呈灰色。脉沉

细滑。按前方加减继续服药。

三诊：1965年3月30日。患者精神已完全正常，每日能学习，分析、记忆能力尚好，心情舒畅。近两日饭后腹痛，一日大便2~3次，便溏，内有粘液。舌质淡红，苔薄白，脉沉细滑。

〔处方〕 陈皮6克 法半夏10克 茯苓10克
甘草3克 砂仁6克 藿香6克
枳壳6克 郁金6克 川楝子10克
香橼10克 焦三仙各10克
舒肝丸两丸 每服一丸 四剂

药后症状消失，停药观察。

〔例4〕 药×× 男性 18岁 中学生 初诊日期为1963年5月13日。

〔问诊〕 患者自幼偏头痛，平素心量狭窄，胆小，沉默寡言，学习成绩一向尚好。近半年来学习成绩下降，听课时思想不能集中。本学期因申请入团未被批准而有自卑感，情绪低落，怀疑老师、同学都在监视他，连上厕所也需家人陪伴，怀疑厕所中有录音机；睡觉不敢就枕，怀疑枕头里有录音机，怕把他的思想和语言都记录下来。大小便滞留，不知排泄，当家人问他是否解手时，他会反问家人：“我是不是要大小便？”近一周来幻听严重，常自语、哭泣，已数昼夜不眠，自称脑子乱，有电子仪器在操纵脑子。经××精神科诊断为精神分裂症妄想型（影响妄想）。

〔望诊〕 精神呆板，目直视，舌质淡，苔白，舌尖红刺。

〔闻诊〕 语声低，定向力尚好。

〔切诊〕脉弦细数。

〔辨证〕忧虑不解，耗伤肝血，肝血虚则魂不藏，神无所依，证属为癫。

〔立法〕养血柔肝、镇怯宁神。方用养血安魂汤。

〔处方〕珍珠母 24克 元 参 10克

丹 参 10克 党 参 10克 白 芍 12克

熟 地 12克 麦 冬 10克 炒枣仁 15克

远 志 10克 石菖蒲 6克 合欢皮 10克

五味子 6克 琥珀末 1.5克（分冲）

二诊：1963年5月16日。服药后睡眠已好，幻听已消失，没有自语和哭泣，恐惧感转轻，晚间也能自行去厕所，不需人陪。但仍怀疑床下有无线电侦察设备监视自己。现已能和他父亲交谈。舌质淡，苔白，舌尖红刺已退。脉弦略数。

〔处方〕前方去党参，加生地 10克，柏子仁 10克三剂

三诊：1963年5月20日。其父陪同就诊，精神接近正常，自觉头脑清楚，妄想已能控制，睡眠安稳，也能主动做些家务事。舌质淡红，苔白少，脉弦细数。前方加黄连 3克。

四诊：1963年5月30日。按前方继服药六剂，精神已恢复正常。除偶有多疑外，其它症状已消失，分析、判断能力已恢复，停药观察。

〔例5〕刘× 女性 27岁 大学生 初诊日期为1963年10月12日。

〔问诊〕患者平素沉默寡言，心细胆小怕事，但个性倔强。五年前在大学读书时成绩尚好，因故突然精神紧张，表

现不安，失眠，言语增多，自认为有失检的言行，日夜在作检讨，自卑，怀疑周围同学对自己有敌对情绪，曾多次自杀未遂。此后哭笑失常，妄想内容多为死亡观念。在××精神病院住院治疗，诊断为精神分裂病妄想型。五年来前后反复发病五次，至今仍服大量氯丙嗪，五年来从未间断过。

现在妄想不能控制，睡眠少。月经前症状加重，经期后错，两个月一次。大便干燥2~3天一行。

〔望诊〕两目炯炯，精神紧张，舌质淡紫，苔白粗糙。

〔闻诊〕能述说病情。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证〕性素胆怯，因恐而病，胆怯者神不足，恐惧者神不安，心血虚神无所依，致成癔疾。

〔立法〕补心养神。方用补心汤合甘麦大枣汤。

〔处方〕熟地15克 丹参10克 元参10克

党参10克 炒枣仁15克 远志10克

石菖蒲6克 五味子6克 朱寸冬10克

淮小麦30克 甘草3克 大枣10枚

夜交藤15克 合欢皮10克 白芍12克

二诊：1963年10月21日。按前方服药七剂，睡眠安好，妄想已能控制。大便每日一行不燥。本月17日月经来潮，经期已准，量、色正常。已能阅读长篇文章，看书时间过久略感头痛。按前方加减继服药。

至1964年1月4日，按前方加减继服药二十六剂，患者就诊时精神正常，面色红润，两个多月来未出现妄想，耐受性较前增强，遇事能分析、综合，也能主动团结周围人。睡眠饮食均好，每日坚持学习，但记忆能力尚未完全恢复。体重

增加。舌质淡红、少苔。脉沉细滑。为巩固疗效，按前方配制丸剂，每丸重10克，早晚各服一丸。

〔随访〕1964年3月5日患者复信，内容清晰，逻辑性强，对自己的病有充分认识，回忆起病中情况觉得可笑。并表示今后努力学习，加强锻炼，排除不利因素，以防前病复发。

〔例6〕陈×× 男性 28岁 医生 初诊日期为1965年3月17日。

〔问诊〕患者平素沉默寡言，自幼学习成绩尚好，23岁在××医学院毕业后，被分配到×厂医务室工作。自觉工作不符自己愿望，不能正确对待，曾多次写信给卫生局，要求调换工作。于1961年底调到××医院内科工作，从此常有妄想。1964年5月开始精神异常，对周围人有敌对情绪，惟恐有人迫害自己，多疑、妄想而不能控制，偶有自语。经××医院诊断为精神分裂症妄想型，住院治疗一个半月。出院后虽无精神异常表现，但妄想、多疑仍存在，入睡困难，长期服用眠尔通等安眠药。

〔望诊〕舌质淡红，舌苔黄，舌中心沟裂。

〔闻诊〕能述说病情，否认多疑、妄想。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证〕抑郁不伸，谋虑不遂，耗伤心神，致心肝血虚。

〔立法〕养血柔肝安神。方用补心汤加减。

〔处方〕丹 参 10克 元 参 10克 当 归 10克
白 芍 12克 五味子 6克 炒枣仁 18克
朱寸冬 10克 甘 草 6克 远 志 10克
菖 蒲 6克 首乌藤 15克 合欢皮 10克

炒山梔6克 四剂

二诊：1965年3月25日。药后自觉头脑较前清楚，妄想已能控制。舌脉同前。前方加熟地12克。

三诊：1965年4月1日。精神正常，妄想已无，睡眠好，现已能每天坚持学习。近日大便一日三次。舌质淡红，苔白。脉沉细。

〔处方〕前方去熟地、山梔、白芍、首乌藤，加太子参10克，茯苓10克。

四诊：1965年4月8日。多日来未出现妄想，思维、记忆逐渐恢复正常。舌脉同前，用缓则治本法。

〔处方〕安神补心丸（水丸），每次服20粒，早晚各服一次。

（三）病例分析

妄想型精神分裂症在本病中最为多见，故多选几例以说明不同的治疗特点。其中例一、例二、例六均为被害妄想，例三、例五为自罪妄想，例四为影响妄想，临床表现都比较典型，皆属于癫症的范畴。对于前三例，根据其临床特征，辨证均为气郁所致的痰蒙清窍，故均采用解郁化痰开窍的方法，用十味温胆汤随症加减治疗。服药后的共同表现为排痰量增多，继之妄想症状明显减轻乃至逐渐消失。在治疗过程中自始至终坚持化痰开窍一法，最后均取得满意的疗效。由此证明化痰开窍是治疗精神分裂症的基本法则之一。但此法只适用于湿痰者，对于痰与火热交织的蒙闭清窍者，则不宜用此法。如前述紧张型一例，虽辨证也为痰蒙清窍，但因临床见症不同，故立法以豁痰开窍，选用药物也就有所不同。十味温胆汤药味较温燥，适用于湿痰，如气机失畅影响体液循

环蓄积而形成的痰，或者脾失健运、水湿停留而形成的痰，其临床表现为舌苔腻、脉滑，均为湿痰的确证；若舌苔黄腻者则为有热之象，方中须加黄连、桔梗以清热豁痰；舌苔白腻而厚者，须加藿香、佩兰，以芳香化浊。

例四为影响妄想型，病因为忧虑耗伤肝血，临床所见舌质淡、脉弦细，证见自卑恐惧、疑虑不眠，均为肝血虚损的表现。且患者个性胆小怕事，其神必怯，兼之有申请入团未被批准之诱因，其妄想虽属荒谬，但却是围绕着一个中心思想逐渐发展的，最初尚有一定的逻辑性，随着病情的发展则妄想结构散漫而不严密，内容荒谬且不固定。经过养血柔肝、镇怯宁神法治疗，首先消除胆怯，令其接触事实，逐渐扭转怀疑妄想，半个月后病遂痊愈。

例五以自罪妄想开始，例六为逐渐形成的被害妄想，此两例均为妄想型的晚期阶段，其共同点为脉沉细，辨证均为心血虚，治以养血安神法而获得较好疗效，使数年之症得以痊愈。另外，例五因病而造成月经后错，服药后经期准而精神亦恢复正常，由此说明，精神分裂症女患者的月经症状好转，标志着整个病情的好转。

第八章 躁狂忧郁性精神病

躁狂忧郁性精神病，又名循环性精神病，是精神科常见病之一。躁狂和忧郁恰好是相反的两组不同的情感障碍，临床特征为周期性的躁狂状态或忧郁状态反复发作，或者躁狂状态与忧郁状态交替发作；在两次发病之间有明显的间歇期，此时精神状态可完全正常。它具有反复发作、自行缓解、无残留症状的特点，少数病人可迁延不愈，成为慢性病程。

据医籍记载，躁狂症相当于中医所说的“狂症”。如《灵枢·癫狂篇》说：“狂始发，少卧不饥，自高贤也，自辨智也，自尊贵也，善骂詈，日夜不休……”，生动而形象地描述了躁狂病人的高度兴奋、情感高涨、言语、动作增多以及思维内容明显夸大等特征。忧郁症相当于中医的“癫症”，如《医学入门》中说：“癫者异常也，平时能言，癫则沉默，平日不言，癫则呻吟，甚则僵仆直视，心常不乐”。描述了忧郁症病人的高度抑制、情感低落，言语、动作减少甚至不言不动、思维缓慢等特征。

第一节 病因病机

一、遗传因素

在躁狂忧郁性精神病患者的家族成员中，同种疾病的发

病率要比一般居民高出 30 倍以上。血统愈近发病率愈高。目前，国外比较流行的是斯莱脱、考尔曼的观点，他们认为本病是通过单个常染色体显性基因来遗传的，但此种基因的外显率则较低。

二、素质基础

素质是秉受先天以及后天环境的各种因素相互作用下形成的躯体和精神类型，又称为性格。它是一个人的个性特征。有人发现大部分躁狂忧郁症病人的病前性格可分为下列几种类型：一类是性格沉静、严肃，遇事认真，多愁善感，受到挫折易陷于消极，常带有轻微的忧郁气氛，称为忧郁素质。另一类是好动，开朗，热情，乐观，进取心强，精力充沛，常带有情感高涨的色彩，称为轻躁狂素质。还有一类则为上述两种性格特征交替出现，每种可以历时数月之久，称为环行素质。具有上述几种性格的人，都容易发展成躁狂忧郁性精神病。此外，环行素质和肥短体型之间关系密切，据统计，肥短体型的人的发病率高于一常人。

三、间脑功能紊乱

间脑和边缘系统与情绪活动有密切关系，特别是下丘脑部位功能障碍，往往是躁狂忧郁性精神病的诱因。

四、单胺物质代谢紊乱

哺乳动物脑中发挥重要生理作用的已知单胺物质，有儿茶酚胺和 5-羟色胺。这两类单胺在脑内浓度的高低变化与躁狂忧郁性精神病有一定的关系。据研究，去甲肾上腺素

浓度过低，因而不能兴奋脑内肾上腺素能受体时，会出现忧郁；反之便出现躁狂。据研究，5-羟色胺也有同样影响。

五、精神和躯体因素

躁狂忧郁症患者在首次发病之前，约有半数以上存在精神因素，少数存在躯体因素。这些因素对于诱发本病可能有一定的作用。

第二节 中医对躁狂忧郁性精神病的认识

中医根据辨证的原则，认为躁狂症是属于狂的范畴，而忧郁症则是属于癫的范畴。一般认为狂属阳症（表现兴奋亢进），癫属阴症（表现抑制衰退），尽管两种相反的症状能在同一个病人身上交替出现，但它们的病机 and 治疗方法则是截然不同的。

躁狂和忧郁，既然是两种截然不同的病理机制，为什么会在同一个患者身上出现呢？这里不妨以“阴阳互根”与“阴阳体用”的道理来解释。笔者认为，阴和阳代表着人体精神活动的两个方面，即兴奋和抑制。它们必然是一种互相依存而又互相制约的关系，它们既是矛盾的又是统一的，如此才能进行正常的精神活动。这就是阴阳互根的道理。再就“阴为体、阳为用”的关系来讲，阴代表着物质基础，而阳代表着功能活动。功能活动不是凭空产生的，而是必须依靠一定的物质基础；反之，物质基础也不是凭空而来的，而是功能活动的结果。因此，有了阴这种物质基础，才能供给阳产生

功能活动。反过来，阳的功能活动又能促进阴的物质产生。这样互相体用，互相促进，精神、生命乃能进行正常活动。如果一旦客观因素有所变化，阴阳失去平衡，就会出现阳亢的躁狂状态；由于阳的功能活动极度亢进，势必大量消耗阴的物质基础，其结果必然导致阴虚。当阴的物质基础不能满足阳的功能活动需求时，阳的功能活动必然趋于衰退，因而由兴奋转为抑制，这就是由狂转癫的道理。反之，阴虚过久，必然出现抑制衰退状态，因为阴的物质大量消耗，使阳无所敛而妄动，即在阴虚的基础上相对的产生阳亢，因而由抑制转为兴奋(由癫转狂)，即由忧郁转为躁狂。

以上就阴阳互根学说，说明躁狂忧郁性精神病中的转化关系。前者说明由躁狂状态转化为忧郁状态，后者说明由忧郁状态转化为躁狂状态。从两者的转化过程中也可以看出阴虚和阳亢的矛盾转化过程。

至于临床上单独出现一种状态，或只有躁狂而无忧郁，或只有忧郁而无躁狂，两者并不转化，那是单独的阴虚而无阳亢，或是仅有阳亢尚未导致阴虚。所以，在阴虚和阳亢转化的过程中，不一定从一个极端走上另一个极端，它们可始终以某一个单独状态出现，而不出现另一个状态。也可能在没有外界因素影响下，阴阳转化趋向平衡而使疾病自愈。

至于混合型的出现，即既有躁狂状态的特征，又有忧郁状态的特征，两者同时交错出现，此种情况，称为阴虚阳亢并发症。

为什么说躁狂属于“狂”而忧郁属于“癫”呢？这种提法表明中医有关狂和癫的范围很广，绝不仅仅是躁狂忧郁性精神病而已。狂和癫可以包括躁狂忧郁性精神病以及其它，而躁狂

忧郁性精神病却包括不了狂和癲。就是因为狂、癲病的范围广泛，它几乎包括整个精神病系统。所以，中医关于精神症状方面，除痛、痴呆之外，主要分为两大类，即狂和癲两大症候群。

关于躁狂证和忧郁证的病因机理，虽然可由各种原因引起，但精神因素的诱发占主导地位。一般认为躁狂忧郁性精神病多因忧思太过，志愿不遂，郁闷不舒，耗伤心脾，以致血虚、肝阴不足；或因暴怒愤郁，肝胆气逆，郁而化火，煎熬成痰，上蒙清窍；或因过喜伤心以及胃热上蒸，扰乱神明所致。

由于二者的病机不同，在治疗上也就有所不同。治躁狂症以平肝潜阳、清心化痰为主，治忧郁症以益阴养心安神为主。

第三节 临床表现

一、躁狂症患者的精神症状

本症的临床表现有三个特点，即情感高涨——愉快而欢乐；思想奔逸——思维过程加速；精神运动性兴奋。

（一）情感高涨

本症始发，患者可先有头痛、失眠等现象，而后出现情感高涨，内心充满愉快和欢乐，病人显得活跃多语，主动与别人交往，觉得任何事情对他来说都是可喜的、美满的，所以不停地追求新鲜事物。

（二）思想奔逸

病人联想过程加速，思想内容丰富而多变，常随外界事物的改变而改变，常出现“随境转移”的现象。由于思潮的加速转变，因而有相应的各式各样的行为，忽而做这，忽而做那，但对每一件事情均不能有始有终，结果一无所成。

(三) 精神运动性兴奋

由于情绪高涨，思想奔逸，故病人处于一种兴奋状态。这种状态可持续很久，病人经常处于精力充沛的状态，睡眠较少但不感到疲乏，并且好炫耀和夸大自己的能力和智慧，内容一般不给人以荒谬的感觉。此时病人常有本能活动的增强(食欲和性欲)。性欲的增强，表现在无节制地买弄风情，放荡无忌地谈论一些有关两性之间的事情。当病情加重时，病人情感更加高涨，终日喜笑不休，有时变得粗野，易因小事而暴怒，指责人、骂人、命令人，甚至打人毁物。但这种状态往往较短暂，很快又转为情感愉快，所以显得情感极不稳定。此时，病人思维活动更加快速，谈话变得更无条理，夸大自己也更明显，思维达到妄想的程度，本能活动更为显著，可能当众对于异性粗野无礼，言语秽污，要求暴食狂饮。最严重时，可能有意识障碍，病人极度兴奋，思维十分零乱，语言不连贯，此时定向力发生障碍，有后遗遗忘症。

二、忧郁症患者的精神症状

本症的临床表现也有三个特征：即情绪低落和悲伤；思维活动缓慢；精神运动性抑制。

忧郁症常常始于身体不适，病人感到食欲不振，睡眠不好，心中憋闷，头痛，头晕，精神萎靡，易于疲劳，工作能

力减低，同时具有情绪低落和忧郁，对于任何事情都不感兴趣，说话减少，动作迟缓，生活显得懒散。

忧郁症明显时，病人整日愁眉苦脸，感到无限悲伤。个别病人在悲伤情绪中夹杂着焦虑和恐惧情绪。此时病人悲观厌世，认为自己是无用的人，出现自责自罪的想法。在难以忍受这种无止境的悲伤时，病人常有自杀观念。如不及时采取相应措施，病人可能因此而自寻短见。这时病人精神运动性抑制也很明显，说话缓慢，很少主动开口，自觉思想活动极度迟缓，思考问题困难。思维内容多与悲伤情感相联系。因此，病人喜独居一隅，卧床少动，动作极为缓慢，两肩下垂，弯腰驼背。病情进一步发展，患者可有明显拒食现象，对于外界刺激几无反应，大小便潴留，卧床不语，达到木僵程度。极严重时，患者自责自罪可达到妄想程度，常常决然做出自杀行为。值得注意的是，如果病人忽然变得活跃而愉快，这并不是病情的好转，很可能是自杀的预兆。

老年人患此病，病程可持续较长，成为迁延状态，也可有迫害、疑病性质的妄想等。

三、混合型患者的精神症状

其特征是躁狂症的三特征和忧郁症的三特征互相交错出现。如病人情感高涨、思想奔逸，但精神运动不是兴奋而是抑制，即所谓抑制性躁狂状态。如病人情绪低落、悲伤，但却没有运动抑制，而表现出搓手顿足，坐立不安，动作加多，即所谓焦虑性抑制症。此类病人初发病或表现为失眠，头痛，情绪低落，担心自己的健康，焦急不安；或表现为全身不适，心口发堵，憋闷，焦虑恐惧，认为自己是世界上最痛苦的人。

较严重的患者，为了摆脱焦虑，甚至揪掉自己的头发，打自己，撞头，向人下跪要求挽救。因此，医务人员应具极大的耐心，同情和慰抚这类病人，以免发生意外。

四、躁狂忧郁性精神病患者的躯体症状

(一) 体重方面

躁狂期病人虽然食欲亢进，但由于持久性兴奋，缺乏足够的休息和睡眠，因而体重减轻。忧郁期患者由于食欲不佳，摄食太少，体重也是减轻的。在睡眠方面，二者均有障碍。

(二) 心脏血管系统

躁狂症患者和忧郁症患者的血压均有增高，脉搏加快。躁狂期病人面部充血；忧郁期病人面部苍白，四肢发绀。

(三) 呼吸系统

躁狂期病人由于机体耗氧量增加，呼吸频率加快；忧郁期病人呼吸缓慢而表浅。

(四) 腺体分泌

躁狂期病人汗腺分泌增多。忧郁期病人汗腺分泌减少，其它如泪腺、唾液腺、胃液腺等分泌也都减少，所以病人感觉口干和皮肤干燥。

(五) 月经

女性躁狂忧郁症患者可出现月经失调，严重忧郁症病人可完全停经。月经的恢复，往往是病情好转的标志。

另外，躁狂忧郁症病人，在躁狂期和忧郁期均有瞳孔扩大及便秘等现象。

第四节 临床分型治疗

一、躁狂忧郁症的治疗

(一) 典型病例

〔例1〕 咎×× 女性 18岁 中学生 初诊日期为1965年4月7日。

〔问诊〕 患者精神失常已近四年。据家属代诉，因学习吃力，患者经常头晕，头胀，头痛，以后逐渐失眠，甚至彻夜不眠。有时喜笑异常，胡言乱语，吵闹不休、终日兴奋、不知疲倦，时间可达一周之久。过此阶段则沉默不语，体倦乏力，嗜卧不动。1961年冬季经××医院诊断为躁狂忧郁性精神病，先后住院三次，治疗一年之久，一直服用西药，从未服过中药。1963年8月出院，因旧病反复而就中医治疗。

现在经常头晕，目胀，不欲睁眼，有时头痛。每1~2周发作一次，表现为哭闹不休，甚则打人，不听劝阻。发作过后，自觉气憋胸闷，叹息呵欠；咽中似有物堵，又咯之不出咽之不下；痰多白稠，咯吐不爽；睡眠多，饮食尚可，二便正常。月经14岁来潮，病后经期错后。

〔望诊〕 面色正常，舌质淡、尖红，苔白根部厚腻，两手颤抖。

〔闻诊〕 语言正常，能正确答问，时有叹息。

〔切诊〕 脉左弦滑，右弦细。

〔辨证〕 强读苦思，劳伤心脾，脾失健运，聚液成痰，兼之素性急躁，致火郁痰结，痰蒙清窍。

〔立法〕清心化痰，解郁宁神。方用解郁化痰汤。

〔处方〕珍珠母 24 克 炒山栀 6 克 丹 参 10 克
元 参 10 克 甘 草 3 克 合欢皮花各 10 克
天竺黄 10 克 竹 茹 10 克 胆 星 6 克
滁 菊 10 克 玉蝴蝶 6 克

二诊：1965年4月12日。按前方加减服药十二剂，哭闹未作、吐痰较爽，月经过期未见，脉沉细弦，舌质淡，苔白滑。根据患者临床表现，郁火渐轻，痰蒙清窍之势已减。改用和血解郁宁神法。

〔处方〕当 归 10 克 川 芎 6 克 醋柴胡 6 克
香 附 10 克 赤 芍 10 克 泽 兰 10 克
茺蔚子 10 克 牛 膝 10 克 丹 参 10 克
远 志 10 克 石菖蒲 6 克 郁 金 6 克
十香返生丹两丸每服一丸

三诊：1965年6月2日。患者自行就诊，精神正常，月经期准，能帮人做些家务活，除有时感到咽中不利、咯痰不爽外，其它均正常。

〔例2〕王×× 女性 46岁 农民 初诊日期为1962年5月23日。

〔问诊〕患者20年前因暴怒导致精神失常，曾一度出现躁狂症。一年后，经中医治疗，精神接近正常，但为时不久又出现精神兴奋异常，兴奋起来几昼夜不眠，对于任何事物都感到特别高兴，喜言笑，爱唱歌；言语虽多，但无狂妄现象。此时自觉头大如斗，腿粗如柱，全身有用不完的劲，拿一百斤的东西也不觉重，昼夜忙碌，不知疲倦，不知休息。如泡上一盆衣服，只洗一半就放下去扫地，扫几下地又去缝

衣，结果一件事也做不成。每到吃饭的时候，家里人叫她吃饭，她总回答吃过了，往往几天不知饥饿。兴奋期一过，精神体力转为衰竭，面色由红润转为萎黄，目不欲睁，多睡，懒言，多食善饥，一日数餐不觉饱，食量倍增，自觉全身无力，懒于动转，连拿一根鸡毛也觉得吃力，气短，心慌，睡眠多梦，与兴奋时期对比如同两人。

近两年来，兴奋好动的时候少，多睡懒动的时候多，月经已停两年。经××医院精神科诊断为躁狂忧郁性精神病。服西药两种，躁狂期服抑制剂，忧郁期服兴奋剂，经治两年无明显效果，故转中医治疗。

〔望诊〕面色萎黄，眼睑下垂，精神呆板(正值衰竭期)，舌质淡红，舌体瘦薄，舌苔白少。

〔闻诊〕除语音较低外，别无异常。

〔切诊〕脉沉细略数。

〔辨证〕初因暴怒伤肝，致肝阳妄动，故多语好动，体力逾常。继则心脾血虚，无以自养，故肢体倦怠，喜卧懒言。

〔立法〕养血宁神，补益心脾。方用归脾汤加减。

〔处方〕黄 芪 12 克 党 参 10 克 生白术 10 克
甘 草 3 克 当 归 10 克 白 芍 12 克
生枣仁 15 克 远 志 10 克 菖 蒲 6 克
茯 神 10 克 益智仁 10 克 三剂

二诊：1962年5月31日。服药后精神又转兴奋，昨晚又失眠，多语，喜笑，喜动，但肢体疲倦，不像以往兴奋期之有力。心慌，气短，手足浮肿。舌脉同前，改用养心安神法。

〔处方〕珍珠母 18 克 熟 地 15 克 白 芍 12 克
首乌藤 15 克 炒枣仁 15 克 远 志 10 克

菖蒲6克 五味子6克 当归10克
甘草3克 三剂

三诊：1962年6月4日。据述上药仅服一剂睡眠即好，精神正常，心情舒畅。患者欲回家乡，故改服丸剂。

〔处方〕 补心丹20丸 每晚服一丸。

人参归脾丸20丸 每早服一丸。

1962年6月25日，患者家属来称，患者回家服药后，适值兴奋期，根据以往规律应是昼夜不眠，而这次能睡3~4小时，且多言喜笑也不明显。以往兴奋一过，随即出现忧郁状态，而这次并未出现，精神保持正常。再以前药继服。

（二）病例分析

躁狂忧郁性精神病，其临床特征为周期性躁狂状态或忧郁状态反复发作。如例1为躁狂状态与忧郁状态交替出现，中间无间歇期；躁狂时间短，为发作性的；忧郁时间长。根据就诊时临床表现，除有躁狂发作外，突出的还有胸闷气憋，咽中梗塞，痰多咯出不爽。舌质虽淡，舌尖红，舌苔白，根部厚腻。脉左弦滑、右弦细。所以，当时辨证为火郁痰结，以清心化痰治疗为主，解郁宁神治疗为辅。由于本病特定的躁狂为阳亢、忧郁为阴虚的双层关系，选用药物时就要顾此及彼，清心而不用苦寒药物泻火，以免苦燥伤阴，而以丹参、元参配以山梔、生甘草。解郁不用理气药，恐其破气伤阴，仅用合欢花皮、玉蝴蝶配山梔，清淡之品达到解郁而已。化痰而不用栝蒌、半夏等物，仅用天竺黄、竹茹、胆星，达到痰化即可。重用珍珠母一味具有养阴潜阳、重镇宁神之效。针对头痛而选用滁菊，取其性和而不散。经治疗，躁狂、忧郁未交替出现，精神恢复正常。

例2也为躁狂状态与忧郁状态交替出现的患者，就诊时正值忧郁期，临床所见面色萎黄，眼睑下垂，精神倦怠，声低懒答。舌质淡红，脉象沉细。当时辨证为心脾血虚，以养血益心脾法治疗。服药后转为躁狂状态，虽有多语、喜笑、好动，但舌脉无变化，随改用养心安神法，内加重镇安神兼有潜阳作用的珍珠母，药后很快控制躁狂状态，精神恢复正常，此后忧郁状态也未再出现。

二、躁狂症的治疗

(一) 典型病例

〔例1〕张×× 男性 25岁 农民 初诊日期为1963年3月22日。

〔问诊〕两年来有间发性精神异常，病情发作时喜怒无常，突然变得高兴愉快，出入歌唱，见人有说有笑，表现热情，什么事都要管，终日忙忙碌碌，东抓一把，西摸一把，但什么也做不好。与人说起话来纠缠不休，常在女青年面前说些放肆话，如果有人劝阻，他会粗暴无礼甚则打人骂人，而且不论亲疏。患者行为乖僻，经常惹事，少眠多食。经××医院诊断为躁狂忧郁性精神病——躁狂症。

〔望诊〕两目炯炯有神，舌尖起红刺，苔白，舌中心沟裂。

〔闻诊〕絮语繁杂。

〔切诊〕脉弦数。

〔辨证〕肝郁化火，痰火内结，邪扰神明。

〔立法〕解郁降火，化痰宁神。方用清燥汤1号。

〔处方〕生龙骨 18克 生牡蛎 18克 胆 草 6克

妙山梔 6 克 黄 芩 6 克 黄 连 4.5 克
生 地 15 克 当 归 10 克 丹 参 10 克
元 参 10 克 朱寸冬 10 克 远 志 10 克
菖 蒲 6 克 天竺黄 10 克 三剂

二诊：1963年3月26日。药后情绪稳定，语言减少，睡眠增加，运动减少，吐痰量多。前方加胆南星10克。

至1963年4月20日，按前方加减服药二十剂，精神症状消失。

〔例2〕陈×× 男性 37岁 干部 初诊日期为1970年3月20日。

〔问诊〕三年前，因精神受刺激，曾连续十几夜未成眠，继则突然精神兴奋，情绪高涨，易激动，好象什么事也难不住他，对一切都自信而有把握，遇有发言机会，口若悬河，滔滔不绝，高谈阔论，一个话题未谈完，很多话题又涌现出来，所以谈话常是有头无尾。写文章也是下笔万言，自觉胜李白多矣。后来他爱人感觉到他精神不正常，才督促他去看病。经××精神病院诊断为躁狂症，强迫住院治疗。住院两个月，症状稍有缓解而出院。患者经过住院治疗，承认自己有病，家属动员就医也能欣然前来。

〔望诊〕精神活跃，表情喜悦，很有礼貌，主动亲切地同医务人员握手。舌质红，舌苔少。

〔闻诊〕患者多语，词意不连贯，缺乏逻辑性。

〔切诊〕脉弦细数。

〔辨证〕不寐已久，心阴耗损，心肝阳亢，致心不藏神。

〔立法〕养阴潜阳，镇心宁神。方用清燥汤2号。

〔处方〕珍珠母 20 克 青龙齿 15 克 丹 参 10 克
元 参 10 克 生 地 10 克 杭 芍 10 克
麦 冬 10 克 五味子 6 克 朱茯神 10 克
炒枣仁 15 克 夜交藤 15 克 琥珀末 15 克(分冲)

二诊：1970年3月26日。按前方服药五剂，精神较前安静，自称浮想联翩现象好转，感觉思维似乎能有休息时间，睡眠增多，醒后知道头脑得到休息。脉弦细已不数。按前方加减继续服药。

至1970年5月28日，经两月治疗，服药五十剂，症状消失。

(二) 病例分析

上述两例均为躁狂症，但两者的临床表现却不相同。当然，这与患者的经历、文化程度有一定关系。例一为农民，病情均由家属代诉，其临床表现突出的是粗暴，激动，兴奋，甚至打人毁物，属于急性躁狂；临床所见舌尖红刺，苔白，脉弦数。辨证为肝郁化火，痰火内结，邪扰神明。用胆草、炒山栀、黄芩、黄连等苦寒药解郁泻火。恐火热伤阴血，故佐以生地、当归益阴清热。用丹参、元参、朱寸冬、远志、菖蒲养心安神，以交通心肾。以龙骨、牡蛎镇静安神，天竺黄化痰而清神明。药后情绪稳定，运动减少。由于药后排痰量多，故加胆星以增强化痰之功。服药二十剂，症状消失。

例二患者能主诉病中体验。这些体验是典型的躁狂症的情感高涨、思想奔逸和精神运动性兴奋等三大症状，属于轻性躁狂。追溯其病源，乃是精神受刺激，数昼夜不眠而耗伤心阴和相对的心肝阳亢所致。阴虚阳亢，心神浮越无束，精

神散乱，乃出现典型的轻性躁狂症状。以养阴潜阳、镇心宁神并用之法治之。潜心阳非同于潜肝阳，选用珍珠母、龙齿、琥珀三味药，有潜阳、镇心、宁神之效；配以丹参、元参、生地、白芍养阴柔肝，交通心肾；以麦冬、五味子养阴敛心气；以茯神、炒枣仁、夜交藤养心安神。药后效果良好。

三、忧郁症的治疗

(一) 典型病例

〔例1〕张×× 女性 34岁 农民 初诊日期为1963年8月30日。

〔问诊〕三年前，患者因生气而抑郁不舒，此后精神倦怠，多卧懒言，对周围事物反应迟钝，自觉头脑昏沉。经过一段时间曾一度好转。近两个月来前症又犯，自觉头痛、头昏、胸中憋闷。脑子里什么都没想，但总觉得悲伤要落泪，对什么都没兴趣，父亲从远路探视她也没表示高兴。终日萎靡不振，全身疲乏懒动，懒得说话，虽然卧床不想睁眼但却不能入睡，饮食也减少。自觉成为废人，不愿接触人，喜欢独处。经××医院诊断为躁狂忧郁性精神病——忧郁症。

〔望诊〕精神萎靡，表情忧郁，双目无光，舌质淡，舌苔白，舌尖有红刺。

〔闻诊〕懒言低声。

〔切诊〕脉弦细而结。

〔辨证〕抑郁不伸，怒不得泄，忧思不解，劳伤心脾。

〔立法〕解郁和肝，养心健脾。方用补心汤加减。

〔处方〕熟地黄12克 丹参10克 元参10克

党参 10克 甘草 3克 远志 10克
菖蒲 6克 茯神 10克 麦冬 10克
炒枣仁 15克 柏子仁 10克 合欢皮 10克
炒山栀 6克 首乌藤 15克

二诊：1963年9月6日。按前方服药六剂，精神好转，头脑清楚，已能适应环境，睡眠好，饮食也增加，但脉尚有结象，此因心气未充，仍以前方加五味子6克，阿胶10克。

三诊：1963年9月23日。按前方服药十二剂，精神完全恢复正常，饮食睡眠均佳，已无不适感觉。心情舒畅，有说有笑，脉滑利已无结象，停药观察。

〔随访〕1964年3月20日，患者半年来操持家务井井有条，无精神症状。

〔例2〕马×× 男性 32岁 工人 初诊日期为1982年11月16日。

〔问诊〕患者与爱人长期两地分居，半年前调往女方所在地(东北某地)工作，但去后感到生活不习惯，有些懊悔，心情不畅，情绪低落，继之钱钞被窃，爱人又加以责备，遂逐渐少语懒动，终日头脑昏沉，不去上班。家属认为他装病，也不领其就医，致旷工多日。后来才发现他精神异常，开始就医。患者趁家属不注意，自购火车票回京。当火车行至长春时患者突然产生畏罪潜逃会被逮捕的心理，几次欲下车，正值夜间天黑寒冷，又惧怕下车。到达北京下车后未回家，径直前往××区公安分局，声称要交待问题，待公安人员问讯时，他又什么也说不出。暂时将其拘留，一连三日也未谈出问题。公安人员见他不食不喝，也不睡，始发觉他精神不正

常。根据他的工作证，用长途电话向其所在单位联系，并得知其北京家庭住址，通知所在派出所及家属去分局领人。当家属用车接其回家时，患者执意不肯下车，乃强行将其拖下。患者见家人不声不响，呆坐并以手撕衣，或以牙齿咬指甲，手指甲皆被咬破。家人将饭端给他也能吃一些，但不主动吃饭。两日后其单位派人同其爱人一同来京，将其送往××精神病院，诊断为忧郁性精神病，收住院治疗。住院后第五天，其爱人强行要求出院。患者出院后不敢见人，不敢外出。

患者生母曾患此种精神病，二十多年前卧轨自杀。

〔望诊〕举步迟缓，头低，腰弯，两肩下垂，愁眉苦脸。令其伸舌，家属催促数遍始稍伸舌，舌质淡，苔白腻，舌中心沟裂。

〔闻诊〕多次提问不肯回答，经家属催促仅低语一声。

〔切诊〕脉沉细滑。

〔辨证〕郁怒伤肝，肝血虚则令人恐，肝气郁则气机失调，聚液为痰，痰蒙清窍，症现为癫。

〔立法〕本急则治标的原则，先予解郁化痰开窍。方用十味温胆汤加减。

〔处方〕橘 红 10克 法半夏 8克 茯 苓 10克
甘 草 3克 炒枳壳 8克 竹 茹 8克
远 志 10克 菖 蒲 8克 郁 金 8克
栝 蒌 15克 胆 星 10克 炒山栀 8克
合欢皮 10克 苏合香丸两丸 每服一丸

二诊：按前方服药三剂，晨起吐黑色痰甚多，大便中带有粘液。按前方加减服药十剂后，精神好转，焦虑和恐惧感

已不明显，但仍不敢外出，怕见民警，吃饭已主动。就诊时仍需家人陪伴，面有表情，步态正常，能主诉，声音正常，但说话仍不多。舌质淡、苔白少，中心沟裂已浅。脉象沉缓。后以缓则治本，改用养血柔肝、益心安神法。方用补心汤加减。

〔处方〕 太子参20克 丹 参10克 元 参10克
当 归10克 杭 芍10克 生 地10克
远 志10克 菖 蒲6克 麦 冬10克
五味子6克 甘 草3克 炒枣仁15克
首乌藤15克 合欢皮10克

按上方加减服药十五剂后，患者精神正常，就诊时面有笑容，对病中的行为均能回忆。已考虑返回东北参加工作。

（二）病例分析

忧郁症的临床特点恰与躁狂症相反，突出的症状是情绪低落，思维迟钝，运动抑制。如例一的临床表现为多卧懒动，懒言，对事物反应迟钝，喜欢独处，脉有结象，说明心气虚弱，心神失养，神虚则不能支配思维活动，故反应迟钝。神虚则恶劳，故喜独处。心气弱无力推动血液，故脉有结象。以补心汤加减，服后精神好转，结脉亦未出现。本例为轻性忧郁，属于虚证。

例二为典型的抑郁症，思维、运动均处于抑制状态。最突出的是自罪妄想，因而产生恐惧和焦虑，并由于妄想的支配始有潜逃行为。本例直系亲属有同样的病，患者病前又有明显精神因素，临床所见舌质淡、脉沉细，均表现为虚象。但舌苔白腻，舌中心沟裂、脉中有滑，又为肝郁痰结之征。精神呆滞，行为颠倒，分明是痰蒙清窍所致。肝血虚，心神失

养为病之本；肝气郁，痰蒙清窍为病之标，先用十味温胆汤增减加苏合香丸以治其标，药后排痰甚多，待至痰化窍开，精神好转，舌白腻苔已退，脉象沉缓时，证明邪祛正虚，再改用养肝血益心气之法而收效。

第九章 癲癇所致的精神障碍

癲癇是一种阵发性的短暂的脑机能障碍。它猝然发作，自行终止，有反复发作的倾向。癲癇的临床表现很复杂，既可有运动、感觉和内脏机能方面的症状，也可出现意识丧失或其它久暂轻重不一的精神障碍。我国早期的医学著作中，关于癲与癇的定义是含混的。《素问》只谈癲而不言癇，《灵枢》则有癇瘖、癇厥之名。癲的古字作𦝵，是否古人言𦝵，是指病的部位在巅顶，即头脑而言？癇一般是描述症状的，癇瘖、癇厥都是指痉挛、僵仆而言。但历代医家对癲与癇的认识始终有争议，有的认为是名异而实一，有的认为是两类性质不同的疾病。直至明代王肯堂，才明确划分癲是指的某些精神症状，癇是指的某些运动症状。王肯堂在《证治准绳》中说：“癲者或狂或愚，或歌或笑，或悲或泣，如醉如痴，言语有头无尾，秽洁不知，积年累月不愈，俗呼心风，此志愿高而不遂所欲者多有之。……癇病发则昏不知人，眩仆倒地，不省高下，甚而瘖瘖抽掣，目上视，或口眼喎斜，或口作六畜之声。”明清以后一般沿用此概念。本章所谈是以现代医学中癲癇的疾病概念为准，它属于中医的癇证以及癲狂的范畴。

第一节 原发性癫痫的辨证治疗

一、病因病机

(一) 病因

除症状性癫痫外，中医认为本病是一种先天性疾病，《素问·奇病论》中说：“人生而有病癫疾者……病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癫疾也。”如是把胎儿于母腹受惊做为先天因素，其机理为胎儿时期与母体同循环共生活，母体受惊，必然波及胎儿，那么胎儿所接受的惊气之邪潜伏在哪里？中医认为，命门(肾间动气)为先天的基础，生命的根源，有生之初，生命即由此开始，所以称为命门；胎儿在母腹所受的惊气即潜伏于此。这是癫痫的内在根据。

先天的遗传因素，产生于男女媾精、两精相搏的时候，此种因素遗传下来也潜伏于命门之中，成为癫痫的素质。

后天因素，一般是风寒暑湿得之于外，惊恐震慑得之于内，饮食饥饱属于不内外；更主要的还是精神因素，如异常的愤怒，剧烈的惊恐，精神过度紧张，情绪长期郁闷和过分悲痛等。

(二) 病机

癫痫患者的遗传因子潜伏于命门之中，出生以后如无足够的后天因素诱发，也可与常人相同，发生癫痫的可能性很小。但是，一旦遇到足够的外因激发，引动命门伏邪，命门之火(龙火)上逆，肝火(雷火)从之，形成龙雷之火妄动，就

会发作癫痫。因命门之火为一身之元阳，如釜底之薪，可助脾阳的运化，使津液四布，内灌脏腑，外润肌肤，以进行正常的体液循环。如果命门之火为邪所逆，不能上助脾阳的运化，水精不能四布，致使体液蓄积、滞留成痰，借助龙雷妄动之火，形成如风逐浪之势，泛滥成灾，填塞窍络，以致脐下“天枢”之机不发。“天枢”司清阳之上升，理浊阴之下降，若天枢失司，清阳不得上升，浊阴不得下降，清浊不分，阴阳混乱，一时五脏六腑、十二经脉皆不胜其扰，导致神明无主，意识丧失而昏倒；四肢受肝风牵动而抽搐；滞留之体液，脾之涎沫，被迫而上胸膈，溢出于口；当风熄火退，发作顿止，神疲而入睡，移时正气渐复而苏醒。若生气未复，则余邪渐炽而复作，成为连续发作。

综以上所述，癫痫发作的机制，大致过程如下：

命门之火上逆，肝火从之；脾失健运，体液蓄积，填塞窍络，天枢不发；神明无主，猝然昏倒；风动痰涌，痉挛发作；涎沫上出于口，排出体外；涎出风熄，痉挛停止。

二、临床表现、病程及预后

癫痫性精神障碍的临床表现是多种多样的，其病症和预后也不完全一样。为便于叙述，现按其临床表现形式分别介绍如下：

（一）临床表现及类型

1. 癫痫大发作

对于癫痫大发作，历代医家都有描述，如《内经》有“癫痫始作先反僵，因而脊痛。”扁鹊《难经》有“癫痫始发，意不乐，僵仆直视，”隋巢元方有“卒发仆地，吐涎沫，口咽目急，

手足缭戾无所觉知，良久乃苏。”明王肯堂有“痫病发则昏不知人，眩仆倒地，不省高下，甚而痰涎抽掣，目上视，或口眼喎斜，或口作六畜之声”。以上各家描述了抽搐发作时意识丧失，呈昏迷状态。对继发作之后的精神障碍也有所描述，如《诸病源候论》说：“癫痫……发则仆地吐沫无知若僵，惊起如狂……”。《幼科释谜》说：“痫者，卒然昏倒，目睛流涎……四肢抽搐，沉默昏愦……过后惺惺。”象“惊起如狂”和“过后惺惺”等系描述大发作后的朦胧状态。

癫痫大发作为常见的一种发作形式。发作开始，意识即突然丧失，全身肌肉强直而跌倒，由于胸肌及喉肌痉挛，有的伴有尖叫声。因为肌张力增强，故病人笔直栽倒，多数病人向前倒，少数向后倒，向一侧的最少。同一病人，每次发作跌倒的方向都是相同的，因而每次跌伤的部位也常常一致。由于发作异常迅速，病人来不及防备，常因跌入水中、火中或倒于运转的机器上而发生更大的不幸事故。

病人跌倒后，迅速进入强直性痉挛期。此时病人全身肌肉强直，头常转向一侧，眼珠上翻或转向一边，瞳孔散大，对光反射及其它反射消失，呼吸停止，脸色很快由苍白变为紫绀；脉数、血压升高，意识完全丧失。强直期持续10~30秒钟，即进入阵发性痉挛期。

在痉挛期，抽搐动作从部分肌肉开始，先是比较缓慢，迅即增快并波及到全身肌肉。此时因咀嚼肌高度紧张，常咬破舌唇及内颊。由于痉挛剧烈，也可引起骨折或脱臼。唾液分泌增多而不能下咽，常呈泡沫状从口中溢出。痉挛期可持续2~3分钟，发作一停，呼吸恢复而急促，脸色由青紫而变为苍白，痉挛也消失。

意识恢复后，病人对发作情况丝毫不能记忆。此时病人常感头痛无力，全身不适，可持续数小时至一、二天。

癫痫大发作患者，有时痉挛发作一次接着一次，间歇期极其短暂，病人意识来不及恢复便又再次发作，这叫作癫痫持续状态，这种状态常可导致生命危险。

2. 癫痫小发作

癫痫小发作时，患者多突然中断原来的谈话或其它活动，僵持原来的姿态，既不倒下，也无痉挛，只是对周围丧失感知能力，面色苍白，局部小肌肉跳动，口角流涎，多汗等。意识丧失仅持续几秒钟或十几秒钟即可恢复，并可继续进行中断的活动。患者清醒后，对发作时的经过毫无记忆。

3. 精神运动性发作

这类发作以精神症状为突出表现，患者意识模糊，伴有感知觉、记忆、思维、情感及运动方面的障碍，患者清醒后，对发作的情况完全遗忘或部分遗忘。癫痫的精神运动性发作有下列几种类型的症状：

(1) 癫痫自动症是指在意识模糊的情况下，患者出现许多比较协调的动作，但不能理解其目的，且与当时的处境不相适应。意识清晰后，患者对发作的经过不能回忆。其表现的运动状态比较简单，如咀嚼、吞咽、舐舌、摸口袋，解钮扣，脱衣服或突然站起无目的地走动，有的说些使人难以理解的话，或刻板的重复单调词句。也有的患者能做比较复杂的动作，如外出游走而茫然无一定目的，清醒后不知何以会外出，这种表现又称为“癫痫性神游症”。有的可在晚间睡眠中发作，突然起床，穿好衣服鞋袜，在屋内走动，搬挪物件，或外出活动，有的随地躺下，有的还可回到原处睡下，醒后对

发作情况全然不知，这种表现又称为“癫痫性梦行症”。自动症可单独出现，也可在抽搐发作之前或发作后发生。发作时间长短不一，短的数秒至数分钟，长的可达数小时或更长。

(2) 癫痫性朦胧状态是最常见的癫痫性发作意识障碍，其特征是与周围环境的接触差，反应迟钝，有生动的幻觉，常伴有情绪冲动的行为。幻觉生动丰富，主要为视幻觉。患者表情恐惧、紧张、直视，可有重复语言、刻板动作，或呈现不协调的精神运动性兴奋，甚至有伤人毁物的残暴行为。称为“癫痫性谵妄”。发作持续数小时或数天。

(3) 癫痫性梦幻状态是一时性的精神障碍，常无运动方面的症状。有些学者称它为“精神性癫痫发作”。发作时患者如置身梦幻中，有许多奇异的感知、体验和回忆。意识障碍较轻者，或有云雾感，发作后多能回忆。患者常有自知力，能了解异常体验的荒谬，但不能自制。它的症状很多，可因人而异，现概述如下：

甲、感觉综合障碍。患者对当时周围环境的感受及体验异常。可有视物变大、变小、变近、变远；听觉减退或过敏；自我与周围环境之间出现似曾相识或陌生疏远感等。此类障碍称之为精神性错觉症。

乙、精神性幻觉症。这是一种复杂的幻觉状态。其内容与患者对当时所处环境的感知和体验无关，而突出的表现为一系列生动而丰富的回忆性障碍。患者如在梦中，有往事的再现或有幻想的成份。如患者在某一时期感受过惊险遭遇，癫痫发作时，常生动地再现过去的景象；有的患者在癫痫发作时幻听到铃声、音乐声或人声喧哗。

丙、情感障碍。患者突然感到无端恐惧、忧郁或孤单

感等。

丁、思维障碍。患者有强制性思维或思维云集。

(4) 癫痫性情绪障碍可发生于癫痫发作之前或之后，也可在间歇期出现；一般在无明显的诱因下，突然情绪低下，易激惹、焦虑忧郁，紧张恐怖；对周围一切都不满意、挑剔，抱怨别人对己不好，有时暴怒并有攻击行为（癫痫性妄暴）；极度忧郁者可有自杀企图。或者表现欢快，无端狂喜（销魂状态），持续的时间由数小时至数日，往往突然终止。

(5) 部分癫痫患者可出现癫痫性性格障碍。其临床表现无固定形式，一般表现为固执，过分拘泥于形式，好计较，过分礼让，自卑或过分自信。精神活动粘滞而不灵活，行动缓慢，思维过程及表达能力缓慢，可有病理性赘述、刻板动作及持续语言，情绪不稳定，易激惹。遇到环境变化难以适应，易猜疑，等等。

(6) 癫痫性智能障碍在严重的抽搐发作后，患者可处于精神运动性抑制状态。此时患者的思维困难，理解力、判断力以及记忆力减退。如果抽搐得到控制，这些症状多在若干天后逐渐消失。这是一种可逆性的假性痴呆。严重者不仅不能学习新的知识、技能，而且原来获得的知识、技能也会逐渐丧失。思维贫乏，甚至不能自理生活。一般说来，发病年龄愈小，抽搐发作愈频繁者，愈易发生这类障碍，但年龄大小与抽搐发作次数并无严格的平行关系；痴呆并非是所有癫痫患者的结局。有的患者虽然抽搐发作次数较多，多年后也无明显的智能障碍；而有些患者癫痫发作次数并不频繁，对智能却已有影响。由此看来，发生这类障碍是多因性的，可能

与初发病年龄、癫痫的性质、癫痫病灶的部位，以及抽搐发作频繁导致脑缺氧性病变的程度等都有关系。

（二）病程及预后

属于症状性癫痫者，其病程与是否去除原发性病灶有密切关系。少数原发性癫痫可于中年后趋向缓解。原发性癫痫一般病程是漫长的，有的自儿童开始可持续一生。有的从儿童时起病，经过一段时间似乎停止了，但过几年又复发，并且多在青春期复发。多年反复发作，或迟或早会导致性格障碍和智能障碍。

症状性癫痫所致的精神障碍患者，其预后和病程，依癫痫的病因及病灶部位而定，如原发病得到根治，癫痫性精神障碍也可减轻或消失。原发性癫痫患者，多数经过治疗能控制其发作，并能照常工作。

三、鉴别诊断

癫痫性精神障碍具有癫痫的一般特征，多呈发作性的，在精神障碍出现的前后或发病期内可伴有大发作或小发作，其症状如前节所述，是不难诊断的，但需要与下列疾病严加区别：

（一）要与癔病区别

癔病患者有时兼有抽搐及精神性发作，但它与癫痫不同，其抽搐发作是肢体舞动或持续性肌强直，可接受暗示，一般不发绀，无咬破唇舌或尿失禁等现象。癔病精神性发作时，常有做作性和戏剧性表现，症状内容与病前的心因性因素有关。

（二）要与神经官能症性梦行症及梦魇区别

神经官能症性梦行症可于发作时被唤醒，而癫痫性梦行症除非发作停止，否则不能唤醒。应将梦魇与夜惊加以区别，前者与神经质有关，后者可能是癫痫发作的表现；二者多见于儿童期，症状类似，发病时患儿从睡眠中突然惊起、恐惧，但前者可被唤醒，后者则不能唤醒，且伴有幻视以及面色苍白、出汗等植物神经系统症状。

四、临床治疗

(一) 基本疗法

根据癫痫的病因机理，可以得出立法的依据，即镇惊宁神，清火熄风，豁痰开窍。在此基础上采用《金匱要略》中的“风引汤”和《医宗金鉴》中的“清热镇惊汤”两方之义，并结合临床经验，拟定方剂“清风熄痫饮”，通过临床实践取得一定效果。兹将药物组成列下：

〔处方〕生石决明 紫石英 赤石脂 龙胆草
炒山栀 朱茯神 川黄连 细木通
柴胡 远志肉 朱寸冬 石菖蒲
天竺黄 天麻 钩藤

随症加减法：

痰热盛者加胆南星、川贝母；湿痰盛者加法半夏；燥痰盛者加栝蒌、浙贝母；气郁者加枳壳、郁金；口渴舌赤者加花粉、知母；体壮痰稠者加礞石；心悸少寐者加炒枣仁；大发作频繁者加羚羊角粉。

如大发作被控制，可改服“泻肝安神丸”，一日两服，每服三钱。

〔处方〕生石决明 珍珠母 生龙骨 生牡蛎

龙胆草 炒山栀 黄芩 白蒺藜
生地黄 当归 朱寸冬 朱茯神
柏子仁 炒枣仁 远志肉 甘草
泽泻 车前子

共研末，水糊为丸，一日两服，大人每服三钱，小儿减半。

如癫痫患者长期服用抗癫痫药不能控制病情，而配合中药治疗能够控制发作，在初服中药时可以暂不减服抗癫痫药，待控制发作后，采用递减法逐步撤去抗癫痫药。中药一般无副作用，配合小剂量抗癫痫药效果更好。

（二）病例介绍

〔例1〕癫痫大发作

孟×× 男性 48岁 工人 初诊日期为1963年3月25日。

〔问诊〕患者十年前因暴怒数日后突然昏倒、抽搐，口吐涎沫，咬破舌腮。经××医院诊断为癫痫大发作。此后每隔2~3日发作一次。近几年发作频繁，大发作之前的先兆是自觉鼻酸沿鼻向颅顶放射，惊叫一声，随即意识丧失而昏倒，手足抽搐，两目上吊，口吐白沫，持续20分钟始清醒。发作后自觉头昏，体倦。长期服用苯妥英钠，未能控制发作。

神经系统检查(-)，脑电图正常。

〔望诊〕舌质淡少苔，舌尖边红，唇舌均有咬破伤痕。

〔闻诊〕语言正常。

〔切诊〕脉弦滑。

用清风熄痫饮煎剂。

患者每次服药后两小时，手足心及腋窝出汗甚多，尿量增

多，据称四小时内小便十余次，并从鼻中流涕如水，有数量不等的咯痰，大便中也有粘液。治疗期间停服西药。三个月内，每周服药四剂，三个月后每周服药两剂，观察一年多，未见大发作，此后服用泻肝安神丸，每次10克，一日两次，早晚服。

〔例2〕癫痫小发作

陈×× 男性 27岁 编辑 初诊日期为1963年4月29日。

患者去年三月突然昏倒，无抽搐，十数分钟始清醒；两周后再次发作，此后经常发作，但无规律，有时一日发作2~3次，有时2~3日发作一次，最长间隔为十余日发作一次。发作时无先兆，突然意识丧失，目睛神呆、口角流涎，经过2~3分钟始清醒，对发作时情况不能回忆。今晨在候诊时阅读书籍，突然两目闭合，从旁观之似乎入睡，唤之不应，转瞬间启目，意识朦胧，从衣袋中掏出证件及粮票等物玩弄，随后又装入衣袋内，3~4分钟后意识清醒，自己没有意识到刚才犯病。经××医院检查脑电图轻度异常，诊断为癫痫小发作，一直服用苯妥英钠及鲁米钠等抗癫痫药物，未能控制发作。

用清风熄痛饮。服后咯痰多，只在服药七十日时发作过一次；继续服药，基本控制发作。

〔例3〕精神运动性发作(癫痫自动症)

李×× 男性 32岁 汽车修配工人 初诊日期为1963年7月14日。

〔问诊〕患者在三年前由于精神受刺激，长期郁闷不舒，一日突然昏倒，继之四肢抽搐，咬破舌，遗尿，大约十数分

钟抽搐停止。近两年来除大发作外，主要有发作性意识障碍。发作时无目的乱走，进行很多复杂奇怪的动作。一日发病时走进百货店，将柜台上任顾客挑选的玻璃杯一个个接完小便仍放原处，当时被顾客及店员扭住，后发现他精神异常，待他清醒后才送回家。又有一次发作，将家里家俱拆毁，其母拦阻时被他打伤，邻居多人将其捆绑起来。其发作间隔时间不定，有时几小时，有时1~2天，患者醒后对发生的事不能回忆。三年来不能参加工作。几个医院均诊断为癫痫。

用清风熄痫饮。服药后发作次数显著减少，发作时间缩短，症状也减轻。后改服泻肝安神丸。

〔例4〕精神运动性发作(癫痫性梦行症)

岳×× 男性 38岁 干部 初诊日期为1963年1月11日。

〔问诊〕患者于1948年在一次战斗中被炮弹炸伤手及前臂，治愈后无缺损。1949年一天夜间口吐白沫但无抽搐，此后五年多未再发作。自1955年经常在夜间犯病，或穿上衣服鞋袜，奔出家门推打邻居房门；或将被褥叠好，奔赴厕所反复拉动水箱，浸湿衣服鞋袜，然后回到房内睡下。醒后对夜间所做的事完全不知。家人发现，患者犯病时无法将其唤醒和阻止他的行动。经××医院脑系科等治疗近十年，近一年又经针灸治疗，但仍不断发作，平均每周发作2~3次。

用清风熄痫饮。服药后发作次数显著减少，平均一月发作一次，发作时间缩短，发作时仅起床做些小动作，随即入睡。

〔例5〕精神运动性发作(颞叶癫痫)

阎×× 男性 37岁 职员 初诊日期为1965年5月29日。

〔问诊〕患者20年前曾有过头晕，一年内发作过四次，有一次曾晕倒。自1960年以后，每次头晕发作时，先感觉头昏，随即出现幻觉，视物体变远，房屋摇晃，自觉鼻孔扩大几倍，闻到从来没有闻过的一种香味，继之脊背发凉，左半身发热并逐渐麻木，头晕而达到意识不清。自1963年，每次发作前自觉左额至右额之间有一条泥鳅爬过，头晕即开始，意识不清，于是手中持物即落掉，手臂摇摇摆摆，口眼紧闭，约一分钟终止发作，意识清醒。醒后感觉喉咙发紧有痰，无其它不适感觉。发作无规律，最多一天发作四次，有时相隔5~6天发作一次。经××医院神经科脑电图检查，双侧颞叶前叶部有许多杂乱和成群的低幅 θ 波，右侧较明显。诊断为颞叶癫痫。患者右手无名指爪甲凹陷，为幼年时挤伤。

用泻肝安神丸。服药后发作次数显著减少，有时仅感头晕片刻即过，没有意识障碍和幻觉。

（三）治疗体会

凡服药后有痰涎、汗液、尿液大量排出者，其疗效显著，排泄越多，效果越好，这说明本方有调节体液循环的作用，使滞留之病理产物排出于体外，从而改善临床症状，促使发作减少或控制其发作。

由于本病根深蒂固，治疗不可要求过急。虽然有的病例能在短期内控制其发作，但还要观察远期疗效，所以需要坚持长期服药，才能达到预期效果。一般经一年而不发作者，才可考虑逐渐停药。

患者长期服用抗癫痫药(如苯妥英钠等)而不能控制其发作时,配合服用中药疗效比较显著。但应注意,在开始服中药时不要立刻停药西药,应在取得明显效果之后逐渐减服西药。如原来一日服西药三次,可在服中药取得疗效后减为日服两次西药;以后再根据情况减为一次,直到完全控制发作时再全部停药西药。采用这种服药方法,效果比较可靠而显著。

笔者在治疗癫痫的病例中发现,有的患者在十几年中经过许多大医院的神经科专家诊断为癫痫大发作,但多次做脑电图检查均为正常,而神经科专家并不因脑电图正常就否定癫痫大发作的诊断。其它癫痫发作形式的病例,症状虽较轻,但脑电图却有不同程度的异常。由此看来,癫痫发作的症状轻重与脑电图的异常与否不成正比。

第二节 局限性癫痫的辨证治疗

现代医学认为癫痫局限性发作,为大脑皮层局部神经细胞群受病理性刺激所引起。常见的局限性运动性癫痫,即从一侧口角、手指或足趾开始局部肌肉抽搐,常按大脑皮层运动区的分布顺序扩散到这一侧的半身;局限性抽搐停止以后,病人这部分肢体可能有暂时性的轻度瘫痪。

局限性感觉性癫痫,即先从一侧口角、手指或足趾开始的感觉异常,如触电感或针刺感等,也可扩散到这一侧肢体,或者接着又出现局部抽搐,发作后这一侧肢体可能有暂时性感觉减退。局限性发作一般都不伴有神志丧失,对发作经过常能回忆。由于患者神志清醒,所以在发作时精神格外紧张,因

而感到非常痛苦，患者诉说病情时，对发作时的体验很深，这样就为临床诊断提供详细的资料，有利于诊断和治疗。

一、病因病机

中医认为，局限性癫痫的病因病机与原发性癫痫的截然不同。原发性癫痫以先天因素为主，由后天因素而诱发。而局限性癫痫无先天因素，纯为后天因素所引起。尽管临床所见病例不多，但值得注意的是，局限性癫痫患者有一个共同特征，即其肢端一般都有外伤痕迹或残缺。这些伤痕和残缺，往往不会引起人们的注意，但它们却是发生局限性癫痫的种子。这些早已被患者遗忘的肢端创伤，经过漫长的岁月，当某些原因使机体抵抗力减弱时，它们便会导致局限性癫痫的发生。局限性癫痫患者的阵挛性抽搐，都是严格地分布在受伤一侧的躯体。

中医认为，肢端受伤所造成的经络损伤，是本病的病因。因为四肢的指(趾)端是十二经脉的起止点。经脉受伤以后，为什么当时不发病，而延至多年后才发病呢？这是因为它和脑外伤癫痫有所不同。颅脑外伤后，经过一段时间，损伤的区域会形成瘢痕，瘢痕刺激大脑皮层，就能引起癫痫发作。而局限性癫痫，因为受伤部位不在头，而是在离头较远的四肢尖端，它引起的癫痫发作就不是由于瘢痕直接刺激大脑皮层，而是通过其它途径，因而往往在伤愈之后很久才发病。

人体的经脉循行不是孤立的，而是互相衔接、彼此联系着的。正常的循行是畅通无阻的，如果某一条经脉阻塞，就有引起疾病的可能。至于本病不在受伤后即刻发病，也可能

是由于当时的气血旺盛，虽然经络受到损伤，还不足以引起发病。但是，它已经是内在因素，经过若干年，一旦机体受到其它原因影响而“气血不足”时，就会促成本病的发作。

二、临床治疗

〔例1〕朱×× 男性 31岁 职员 初诊日期为1965年4月26日。

〔问诊〕半年前，患者的左腿曾两次不自主地向里转动，每次2~3分钟。三天前夜间四时，患者左腿又向内转动，继则半身拘紧，左上肢拘挛，喊叫一声即神志丧失，两目天吊，口角向左喎斜，小便失禁，约半小时始清醒。当日早晨八时又发作一次，仅左腿抽动，神志清醒。第二日晚上又有同样发作，抽搐过后，饮食睡眠均正常。近几日大便较干燥。

病人1962年患过肺结核，现已痊愈。15年前，被铁锤于砸掉左手拇指爪甲，以后长出灰色爪甲。

〔望诊〕面色黄白，形瘦，左手拇指、无名指和小指爪甲灰白粗糙，两小腿腓肠肌松弛，左腿较为明显。舌体大，舌颤，舌质淡红，舌尖深红，舌苔色白满布，舌边有齿痕。

〔闻诊〕语言清晰。

〔切诊〕脉弦细滑。

〔辨证〕阴血不足，肝失濡润，筋脉失养，虚风内动。

〔立法〕养血荣筋，柔肝熄风。方用荣筋熄风汤。

〔处方〕生石决明 24克 白蒺藜 10克 当 归 10克
熟 地 15克 首乌藤 15克 桑寄生 15克
宣木瓜 10克 钩 藤 10克 天 麻 6克

天竺黄 10克 滁菊 10克 菖蒲 6克

二诊：1965年5月19日。服药后近一个月，局限性癫痫未发作，无明显症状。舌质淡红，苔白少。脉弦细。前方加和血通络之品。

〔处方〕珍珠母 24克 白蒺藜 10克 当归 10克
川芎 4.5克 赤芍 10克 首乌藤 15克
鸡血藤 10克 桑寄生 24克 钩藤 10克
地龙肉 10克 白附子 6克 菖蒲 6克
滁菊 10克 天竺黄 10克

三诊：1965年8月14日。按前方服药二十二剂，四个月来局限性癫痫未发作。

〔例2〕王×× 女性 35岁 家庭妇女 初诊日期为1963年6月7日。

〔问诊〕患者四个月前生一子死亡，产后十余日感受风邪，右臂痛不能动作。继之突然发现右臂及手不自主地摇动，虽用强力压迫也不能制止。发作时神志清醒，但口不能言，心中烦乱。因右臂摇动剧烈，精神非常紧张，数分钟后，手臂摇动停止。此后每隔4~5天发作一次，症状同前。平时常感右肩发凉，有沉麻感觉，饮食睡眠正常。经××医院神经科诊断为局限性癫痫，服抗癫痫药不能控制发作。

〔望诊〕口唇有色素沉着。右手中指缺损一厘米，系十一年前被石碾压伤。舌质淡紫，舌苔白。

〔闻诊〕语言正常。

〔切诊〕脉弦细滑。

〔辨证〕右手中指碾伤后，经络受损，因产后百脉空虚，感受外邪，虚邪相搏，窜犯经络。

〔立法〕祛风邪，通经络。方用荣筋熄风汤加减。

〔处方〕橘 络 6克 法半夏 6克 白附子 6克
茯 苓 10克 甘 草 3克 首乌藤 15克
鸡血藤 10克 桑 枝 15克 宣木瓜 10克
全 蝎 6克 天 麻 6克 钩 藤 10克
远 志 10克 葛 蒲 6克 当 归 10克

二诊：1963年7月8日。按前方服药十八剂，局限性癫痫未发作。自觉右臂有力，动作灵便，凉麻感觉也减轻，仅昨日上午右臂抽动两下，瞬间即过，未觉心中烦乱。现已能操持家务。

三、治疗体会

例一患者，15年前左手拇指被锤子砸伤，发病的前两年患过肺结核，望诊面色晄白，形体消瘦，说明肺结核损伤了患者的健康，因而诱发本病。例二患者在11年前右手中指被碾掉前段，发病在产后十余日，既有婴儿死亡所造成的精神因素，又有感受风邪的病史，这些都会损伤患者的健康而诱发本病。临床上还有数例本病患者，也都有不同程度的肢端外伤史。因此，考虑局限性癫痫的病因，应认真注意肢端外伤史这一事实，这有助于临床诊断和治疗。

第十章 更年期精神病

更年期精神病，是人体由壮年过渡到老年这一年龄阶段中由于内分泌机能减退及精神因素所诱发的一种精神障碍。主要临床表现为情绪焦虑，忧郁，并可伴有某些妄想幻觉，同时具有各种植物神经症状和躯体不适感。其发病年龄，女性多在45~55岁，即绝经期前后；男性多在50~60岁之间。女性患者多于男性。

人体更年期的生理和心理特征，随着年龄的增长会发生很大改变，代谢机能的改变，内分泌功能的改变，性腺分泌功能的改变（主要表现为性功能减退，在女性为月经停止、性器官萎缩），植物神经功能发生紊乱；面貌趋向衰老，如头发变得苍白，牙齿开始脱落，皮下脂肪开始减少，脸上皱纹增加等等；这些都标志着“老之将至”。

由于以上生理方面的改变，再加上社会经历和家庭生活的变迁，在这段时期也会形成一些心理方面的特点，有时自己意识到工作能力减退，常容易产生自卑感。

人在更年期的生理和心理特征的基础上，如果遇有急性的或慢性的精神因素刺激，或某种躯体疾患的不良影响，则易导致高级神经活动失调而诱发更年期精神病。更年期精神病并不是指所有发生在这个年龄的精神病，而是在这个年龄发病而又有其独特临床特征的精神病。

第一节 病因病机

中医认为人的生长、发育及衰老等生理变化，均由肾气的盛衰来决定。如《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通、太冲脉盛，月事以时下，故有子。……六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”这段经文论述了女性一生的发育过程，即十四岁时生理发育成熟，开始有月经，并能按周期来潮，这是青春期的开始；四十二岁时生理开始向衰退方面转变，面容趋向衰老，头发变得苍白；四十九岁时性功能减退、月经停止，性器官萎缩，不能再生育。人的发育过程，除与肾气的盛衰有关之外，冲、任两脉的盛衰也起着重要作用。人在更年期由于生理的和心理的上述改变，如果身体健康状况较差和有精神因素的刺激，就容易诱发更年期精神病。

中医认为，任何疾病都以临床症状作为辨证的根据。临床症状既然是疾病的现象，那么产生这些现象的本质就是病机。中医关于更年期精神病的发病机理，有以下几个方面：

一、肾气虚衰

肾是先天生命之本，又是储藏后天水谷精微之所。所谓“肾藏精”，一是指藏来源于水谷精微的五脏六腑之精，即人体各器官功能活动的物质基础；二是指藏由先天之精和后天水谷之精结合转化而来的肾脏本身之精，它与人的生殖、生

长、发育、衰老有密切的关系。肾精充足，人的体力和脑力就充沛，表现在劳动上就轻劲多力；思维活动就灵敏；在形体上就面色红润，毛发光泽。待到更年期，肾气逐渐虚衰，阴精虚少，体力和精力均形衰退，在形体上显得面容苍老，皮肤干燥，头发脱落或苍白。思维迟钝，缺乏技巧，工作能力减退，记忆力衰退，喜忘前言和往事。性机能也减低，女性月经可不调或停止。

二、冲任失调

冲为血海，任主胞胎，此二脉主管妇女的月经和孕育，但冲任二脉都以肾气为本，肾气旺盛，冲任二脉得养，则月经正常，故能孕育。肾气虚衰，冲任失调，则月经紊乱或停止，子宫逐渐萎缩而不能孕育。冲任失调是女性更年期的主要生理变化。

三、脾失健运

脾为后天之本，主运化水谷精微，以充养四肢百骸。但脾的运化功能全赖肾中之阳气，故古人常以肾阳比作釜底之薪。肾阳充足，脾就运化有力，精微得以输布，全身就能获得足够的营养。若肾阳不足，脾的运化就会受到妨碍而表现为胃肠机能障碍，食欲不佳，饮食减少，食后腹胀，大便失常。由于脾运不健，水谷之精微无力化生，营养缺乏，机体即日渐衰弱。脾主思，忧思易伤脾，更年期正是人一生操劳最盛的时候，亦即思考事务最多的时期，如果过度的忧思，必致脾气更伤，使脾的运化功能减弱。所以，脾失健运是造成机体衰弱的主要原因。

四、肝失柔润

肝性喜条达，体阴而用阳，属木，全赖肾水以涵养，所谓水能涵木。如果肾阴不足，肝失涵养，必柔润不足而致肝阳上亢，表现为头晕头痛，烦躁易怒，焦虑不安，心悸汗出，不易入眠或夜眠多梦。肝主谋虑，若肝失涵养就多虑而渐致妄想，好谋而无断；若肝风内动，则四肢抽动或偏身麻木，有的患者血压可升高。

第二节 临床表现

一、更年期综合症

更年期综合症是临床最常见的一种更年期症候群，其症状表现繁多，包括几个系统的症状，如敏感、喜静、怕声、怕光、心悸、胸闷、出汗、阵发性颜面潮红等；胃肠机能障碍，如食欲不佳，食量减少，腹胀、大便秘结等；月经紊乱或停止，性机能减退；四肢麻木感；头疼、头晕、失眠；情绪不稳，易激惹，易烦躁或情绪低落，或焦虑不安；注意力不集中，记忆力减退等。

二、更年期忧郁症

本症患者女性较多。病起缓慢，初病时感到全身乏力，不适，睡眠早醒，失眠，食欲不振，体重减轻，兴趣不佳。经过数周或数月后症状逐渐明显，患者情绪更显低落，惶惑，焦虑，烦躁，恐惧，多愁善感，悲观消极，长吁短叹，

坐立不安，惶惶不可终日，主要是自责、自罪及疑病观念，严重者可有关求别人的同情和援助的表现。有的病人为了摆脱痛苦，常采取隐蔽而巧妙的方法自杀。患者由于兴奋不眠和拒食而消瘦，面容苍老，伴有便秘及植物神经性症状，如阵发性颜面潮红、心悸、出汗增多等。此外还可伴有脑动脉硬化和程度不一的智能衰退。

三、更年期妄想症

更年期妄想症的主要症状为妄想，并伴有幻觉。其中以嫉妒妄想、被害妄想及关系妄想更为明显。由于起病时往往敏感多疑，经常注意别人的态度神色，怀疑别人看不起自己。由于伴有性功能减退，常常发生嫉妒妄想，尤以女性病人更为明显。开始认为爱人对自己态度不好，进而怀疑对方厌恶自己而另有所欢，起初是没有根据的怀疑，为了寻找事实根据，就经常注意爱人的行动及其与异性交往时的言谈和态度，偷偷地检查爱人的衣物、书信、笔记，有时跟踪。妄想形成以后就将所有接触到的事物都当作妄想的依据。

被害妄想也很多见，开始时怀疑经常接近的人，如怀疑家属、邻居、爱人要害她，继而怀疑所有的人都在监视她和串通起来谋害她。有时，患者将以往生活中的经历也按照妄想观念加以歪曲的解释，以证明所遭受的迫害由来已久。

妄想内容虽然系统性并不完整，但开始也有一定的逻辑性，而且从表面上看似乎尚合情理，甚至被人信以为真，发展下去则越来越荒谬。

出现幻觉者，以听幻觉及触幻觉较为多见，幻觉的内容与妄想密切联系，并会助长妄想的发展。

由于妄想幻觉的影响，患者情绪容易激动，经常一面诉说一面哭泣，常因妄想而发生冲动行为，也可能发生自杀举动。一般智能往往良好。

第三节 临床治疗

一、治疗方法

更年期总的病机，不外乎肾的元阳不足，阴精亏损。因此，在立法上首要的是壮肾阳，滋肾阴。壮肾阳的目的在于促进肾的功能活动，以改善其它器官的功能活动，如使冲任二脉协调，使脾阳健运等。滋肾阴的目的，在于加强功能活动的物质基础。二者相合，从而改善由于肾气虚衰所导致的一系列更年期症候群，达到维持正常生理机能的目的。如冲任得养，则经血自调，其面自华。脾得肾阳温煦，其运化功能恢复正常，水谷精微四布，四肢百骸得养。肝得肾阴滋养，平熄相火妄动，就可改善由于肝阳上亢所引起的一系列症状。这就是“治病必求其本”的体现。

根据壮肾阳、滋肾阴的立法，选用“二仙汤”（仙茅、仙灵脾、巴戟天、知母、肉苁蓉、黄柏、当归）加味。其中取仙茅、仙灵脾、巴戟天、肉苁蓉的温热兴阳之性，大补肾阳，乃虚则补之之意；知母、黄柏滋肾降火，起壮水制火的作用，以克服相火妄动；当归可补血和补女子诸不足，为调经之良药。

“二仙汤”是上海曙光医院用以治疗更年期高血压的验方。我们在原方的基础上加入肉苁蓉，以增强滋肾的效能，

经过临床实践，证明它治疗更年期精神病有良好的疗效。它有以下几个特点：

- (1) 能很快消除更年期的一系列精神症状。
- (2) 能使更年期的高血压降低而稳定。
- (3) 能使更年期紊乱的月经恢复正常，早期停经的能够再行。
- (4) 能改善更年期的衰老状态，使面容华泽，精神焕发，体力恢复。

二、病例介绍

〔例1〕更年期症候群

李×× 女性 49岁 干部 初诊日期为1964年11月5日。

〔问诊〕患者两年来精神焦虑不安，烦躁，睡眠不实易醒，自觉有热气上冲，其时面红赤，头脑乱，思虑多而不能控制。终日头昏沉、眩晕，耳鸣如风响，心悸，体倦，自觉全身肿胀，不能向下俯身，俯身时自觉气憋，两胁痛。月经去年已停，本年仅行一次。经××医院诊断为更年期症候群。

〔望诊〕体胖腹大，精神忧郁，舌质淡红，舌尖红，苔白少。

〔闻诊〕言语正常。

〔切诊〕脉沉细。血压150/125毫米汞柱。

〔辨证〕七七之年，肾气虚衰，冲任失调。

〔立法〕补肾气，调冲任。方用二仙汤加味。

〔处方〕仙茅10克 仙灵脾10克 肉苁蓉10克
巴戟天10克 知母6克 黄柏6克

当 归 10克 炒枣仁 18克 首乌藤 15克

二诊：1964年11月12日。服药后自觉头脑清楚，情绪稳定，自称这是两、三年来没有过的现象。睡眠安稳，心悸、胁痛已不明显，感觉全身轻快，俯身时也不感气憋。血压130/90毫米汞柱。前方加桑寄生18克。

三诊：1964年11月19日。自服药以来上述症状继续好转。两年来月经将断，前日月经已见，色鲜红，量正常。舌质淡红少苔，脉细较前有力。血压120/80毫米汞柱。

经门诊治疗六周，服药30剂，症状消失，停药观察。

〔随访〕1966年5月10日。经过治疗，精神充沛，体力健壮，月经维持正常。一年半来无明显症状。

〔例2〕更年期忧郁症

戴×× 女性 49岁 干部 初诊日期为1963年4月6日。

〔问诊〕五年前生育第七胎后，血压增高，经常头晕、头痛，目胀干涩，入睡困难，早醒，睡眠多梦，记忆力减退，烦躁易怒，腰痛。近两年来月经提前八、九天，带经十数日，量多，每次均需用止血药。性欲减退。

患者自称对爱人和孩子都没有感情，视爱人、子女如陌生人。患者忧虑自己已经没有感情，并且逢人便讲她是一个没有感情的、最痛苦的人，对一切事物都没有兴趣。患者自愿就医，要求医生为她解除痛苦。经××医院诊断为更年期忧郁症。不能工作已一年余。

〔望诊〕精神忧郁，面容苍老与年龄不相称，舌质淡，少苔。

〔闻诊〕不断述说自己的痛苦感受，恳切要求治疗。

〔切诊〕脉沉细，血压140/90毫米汞柱。

〔辨证〕肾气不足，冲任失调。

〔立法〕补肾调冲任。方用二仙汤加味。

〔处方〕仙茅10克 仙灵脾10克 巴戟天10克
肉苁蓉10克 当归10克 黄柏6克
知母6克 桑寄生15克 合欢皮10克

二诊：1963年4月22日。按前方服药12剂，精神忧郁明显减轻，焦虑现象未出现，本月17日月经已见，经期准，经行四日即净，按前方加减继续服。

三诊：1963年5月21日。经治疗一个半月，忧郁症状显著减轻，对事物的兴趣提高，就诊时不再诉说痛苦的体验，面有喜悦表情。面色亦较前红润，睡眠好，饮食增加，精神体力较前充沛。血压124/80毫米汞柱。本月15日月经来潮，经行三日即净。近日考虑工作。将前方改为丸剂，每服10克，一日两次，早晚服。

随访：1965年8月7日。疗效巩固。患者精神正常，面色红润，肌肤润泽，精力体力均健壮，经期准，无任何症状，性欲正常，能胜任繁忙工作。

〔例3〕更年期妄想症

郭×× 女性 52岁 工人 初诊日期为1962年3月10日。

〔问诊〕两年前，患者因担心儿子做手术治疗而精神紧张，引起失眠、多恶梦和血压升高(170/110毫米汞柱)。经治疗血压时高时低，经常精神紧张、胆怯易惊、焦虑不安。自觉有阵阵热气上冲，颜面潮红，易汗出，心悸、气短、体倦乏力。近两年来月经紊乱，三个月前曾行经一次，血量过

多，经医院采用止血法治疗血始止。性欲衰退，但又有性生活要求。

近几个月来，逐渐怀疑爱人有外遇，并想象出爱人外遇对象的年龄、相貌；对他们的一切活动，好象她都看得见，所以时常跟踪爱人。每日爱人回家，她便偷偷地搜查爱人的衣袋和提包，察看爱人的内衣。患者曾找过爱人单位的领导，要求每日跟随爱人上班，以监视爱人。经她爱人单位的领导做工作，证实她爱人没有生活作风问题，但她又说领导和她爱人一样，都在欺骗她，闹得全家不得安宁。患者否认自己有病，不肯去医院，两周前曾强制去精神病院就医，因哭闹打人，未能得到医治。今日，经其妹劝说给她治疗高血压和月经病，才来医院就诊。

〔望诊〕面色萎黄面憔悴，不时欲泣。舌质淡，苔白少。

〔闻诊〕言语正常，声音较低。

〔切诊〕脉细略数，血压150/100毫米汞柱。

〔辨证〕肾气虚衰，肾水不足，肝木失养。肾气虚则性欲衰，肾水虚则肝失濡养。肝主谋虑，肝阳亢则多谋妄想。

〔立法〕补肾气以兴欲，滋肾水以柔肝。方用二仙汤加味。

〔处方〕仙茅 10克 仙灵脾 10克 知母 6克
黄柏 6克 巴戟天 10克 肉苁蓉 10克
当归身 10克 炒枣仁 24克 女贞子 10克
杭芍 12克 合欢皮 10克 五剂

二诊：1962年3月16日。服药后睡眠好，对爱人有外遇的妄想，经过分析解释有所动摇。舌脉同前，血压130/90毫

米汞柱。前方加制首乌15克。

按前方加减服药32剂，1962年4月14日曾有月经来潮，量不多，经行三日即净。精神正常，承认自己有病，对妄想能批判，已能自行就诊。为巩固疗效，前方加减改成丸剂。

随访：1962年9月18日。患者已做半日工作，无任何精神症状。

三、治疗体会

根据更年期精神病患者的发病机理，总的可以归纳为肾的元阳不足，阴精亏损。其临床表现的症状虽然繁多，但不外乎是由肾虚而引起的。如肾阳虚可见到类似现代医学中肾上腺皮质功能减退、甲状腺机能减退、性腺功能减退的一些症状，最突出的是性欲减退和女性的月经紊乱或闭止。中医认为，妇女在绝经之前的月经周期来潮和妊娠，都是冲任二脉所主，月经的紊乱与停止为冲任二脉失调。由此观之，冲任二脉的功能，相当于卵巢内分泌的机能。冲任二脉的虚衰，就相当于卵巢内分泌机能的减退。所以，补肾阳正是调节内分泌机能。肾的阴精亏损，意味着内分泌物质基础的不足。要促进各个脏腑机能的正常活动和延缓其衰退的过程，就需要足够的物质基础。补肾阳，就是要促进各器官保持正常的机能活动；益阴精则是补充各器官的物质基础；只有如此才能使功能紊乱的器官恢复正常，延缓其衰退的进程，使人平稳地过渡到老年期。

第十一章 老年性精神病

人到老年，除躯体机能逐渐出现衰老现象以外，某些人可表现出精神活动迟缓，喜谈往事，说话絮叨，情绪不稳定等，但如不产生显著的记忆障碍，对适应新事物不发生困难，并保持行为的合理性，即不是病态。

判定老年性精神病时，年龄并不是唯一的条件。事实证明，很多高龄的老人保持着很强的生活力、广泛的兴趣和工作的创造性。老年性精神病多发生六十岁以后，它是在整个机体发生老年性变化的背景上发生的一种进行性精神衰退性疾病，有其特殊的疾病发展过程，各种不良因素如中毒、感染、外伤、消耗性躯体疾病以及精神因素等，都可促使本病的发生。其主要临床表现为智能减退、记忆障碍，同时还可有显著的情绪和人格改变，以及整个机体的衰老；其主要病理改变为脑萎缩。

第一节 病因病机

中医认为：人的生长、发育及衰老均由肾气的盛衰所决定。《素问·上古天真论》说：“丈夫八岁肾气实，发长齿更；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和故能有子……七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八则齿发去。肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛

乃能泻，今五脏皆衰，筋骨解堕，天癸尽矣，故发鬓白，身体重，行步不正而无子耳。”老年性精神病，就是在人体自然衰老的过程中，受到外界各种因素的刺激而诱发的。本病发病的机理仍归于肾气衰，阴精少。肾主骨生髓，脑为髓之海，肾的阴精阳气不足，髓不得上充于脑，脑海不足，所以喜忘前言(记忆衰退)，智能和技巧显著减退。

清代王清任在《医林改错》中指出：“灵机记性在脑者，因饮食生气血，长肌肉，精汁之清者，化而为髓，由脊骨上行人脑，名曰脑髓。……脑气虚，脑缩小……”他还指出：“所以小儿无记性者，脑髓未满；高年无记性者，脑髓渐空。”他的这些论述，有些已为现代医学病理解剖所证明。老年性精神病患者，其主要病理改变为脑萎缩，尤以前额叶最为明显，脑重量减轻，严重者脑重可低于800克，脑回变平，脑沟增宽，脑室扩大。显微镜检查，表现为神经细胞缩小，染色质溶解和脂褐质增加，胶质细胞增生及神经纤维变性。可发现具有特征性的老年斑，此斑为一种嗜银性组织变性灶，形状多不规则。特别是与记忆功能有关的核糖核酸、蛋白质等含量和更新率降低，脑神经元接受信息的树突退化、变形。这些病变可侵犯大脑皮质、丘脑、基底节、小脑及中脑灰质等处。

第二节 临床表现

老年性精神病以缓慢进行性智能衰退为主要临床特征，常以性格改变最先出现。患者的早期表现为多疑敏感，狭隘自私，注意力不易集中，做事草率马虎，难于熟悉新的工

作，墨守成规，固执己见；并且生活懒散，不爱整洁，不修边幅，食欲减退，睡眠颠倒(夜间不睡，到处乱走，或无目的地收拾东西，但白天则嗜睡)，萎靡不振。由于患者年龄较大，上述症状常不引人注意，一般经2~3年症状日趋严重。患者的感觉、反应、动作迟钝，易激惹，对外界事物逐渐失去兴趣，或出现幼稚性欣快；语言、行为杂乱无章，唠叨絮语，重复罗嗦；行为幼稚，荒诞无稽；收藏废物，不知羞耻。

随着上述症状的加重，智能障碍也日趋严重，尤以记忆障碍发生较早而且最显著。初则近事遗忘，渐渐延及过去，对远事亦多遗忘，严重者会忘记自己的姓名，不认识自己的子女。由于记忆缺失，患者常不自觉地虚构事实加以弥补。例如自己遗失了物件，会说成是被盗窃。以后定向力、理解力亦渐发生严重障碍，甚至离家数步即找不到家门。

多数患者仅有上述表现，无幻觉妄想，亦无精神运动性兴奋发作。但少数患者可在痴呆背景上发生精神运动性兴奋，或出现片断荒谬的妄想及幻觉。妄想多为被害、自责、关系、疑病、贫穷性妄想，部分患者呈现夸大妄想。痴呆进一步发展，妄想多消失。晚期患者，生活则完全不能自理，大小便也不能控制。

本病患者在躯体方面表现为老态龙钟，发白齿落，皮肤萎缩而干燥多皱；舌手震颤；角膜老年环，瞳孔对光及调节反应皆弱；可有视力及听力减退，浅、深反射减弱；如伴有脑动脉硬化，则可有局灶性神经系统体征。患者在晚期长期卧床，极易并发褥疮及其它感染，如受感染、骨折或患其它严重躯体疾患时，部分患者可出现急性谵妄。一般病期仅数年，多

死于感染和衰竭。

第三节 诊断与鉴别诊断

一、诊断

老年性精神病症状明显者诊断不难，主要依据是发病年龄，起病隐缓而有进行性智能减退和人格的改变，其中尤以记忆障碍最为突出，并常有遗忘性。

老年性精神病患者的舌象，一般是舌体干瘪，舌质暗淡（为老人舌的特点），舌苔呈白霉状（非苔，类似光滑之白膜附在舌体上，不易剥掉）。舌体震颤，伸舌迟缓或不利。脉多沉细或弱，两尺明显无力。作脑脊液检查，多无明显异常，或仅有轻度蛋白质增高。对疑难病例可进行气脑造影，常显示有脑萎缩，如脑室显著扩大、蛛网膜下腔明显增宽或呈团球状扩大等。气脑造影显示的脑萎缩程度，不一定与临床所见的痴呆程度成正比。作脑电图检查，对诊断有时有一定帮助，但老年性精神病的脑电图一般接近正常。

二、鉴别诊断

诊断本病时，要注意与脑动脉硬化所致的精神障碍及麻痹性痴呆相区别。

（一）与脑动脉硬化所致的精神障碍相区别

脑动脉硬化患者的智能障碍较轻，在病程中常有时好时坏的起伏现象。早期以头昏、头痛、失眠等神经衰弱症状为主，其人格的正常性可维持很长时间，患者情绪以亢奋为

主，妄想极少见等特征可资鉴别。

（二）与麻痹性痴呆相区别

麻痹性痴呆患者一般都有智能障碍，但其血和脑脊液康、华氏反应阳性，有冶游史，早期可见瞳孔、腱反射及肌张力的特征性改变，有以夸大妄想为主的妄想等可资鉴别。

第四节 临床治疗

一、治疗方法

根据上述病因机理，可采用补肾气以促进脑的功能、益阴精以补充脑的物质基础的方法治疗，临床常用补脑合剂或补脑丸。

二、病例介绍

〔例1〕陈×× 男性 62岁 退休干部 初诊日期为1963年7月17日。

〔问诊〕患者两年来每于睡中癫痫而醒，醒后不能入睡，夜间常起来做些无目的动作。昼日精神萎靡，不爱活动，反应迟钝，记忆力衰退，因不能工作而退休。近来精神逐渐痴呆，举止异常，易激动，常自责，拒绝饮食，言语絮叨，经常自语，但不能主动提问或正确答问。经××医院诊断为老年性精神病。

〔望诊〕精神痴呆，头向下低，目向下直视，嘴不断作咀嚼状。舌质暗红，满舌碎裂无苔。

〔闻诊〕不能正确答问。

〔切诊〕脉沉细，尺微。血压130/90毫米汞柱。

〔辨证〕脑为元神之府，肾主技巧之能，肾精虚损，脑髓不充，神智技巧失灵。

〔立法〕滋肾益精，补脑充髓。方用补脑合剂。

〔处方〕熟地 15克 肉苁蓉 10克 鹿角胶 10克
枸杞子 15克 巴戟天 10克 炒枣仁 15克
远志 10克 菖蒲 6克 五味子 6克
麦冬 10克 炙草 6克 炙首乌 15克

二诊：1963年7月26日。按前方服药六剂，夜眠已佳，白天亦能午睡。易激动情况减少，近几日没有自责，自语减少。食量已增加，惟大便两日一行较干燥。舌质淡红，碎裂较前好转。脉沉细。

前方去炙草、炒枣仁。肉苁蓉加至15克，加石斛12克，炙龟板10克。

三诊：1963年8月10日。患者痴呆现象已减轻，能主动交谈，面有表情，答问正确。饮食、睡眠均正常，睡后无癫痫，大便一日一行不干。

〔例2〕刘×× 女性 65岁 初诊日期为1962年4月18日。

〔问诊〕患者在爱人亡故后移居女儿家。具体患病时间不详。最早发现多疑，常向女儿诉说邻居在说她坏话，或说有人在骂她。经女儿访问邻居皆非事实。后来发展到偷听女儿和女婿说话。记忆力减退，常把东西放下就忘记；每当找不到东西就说被××人偷去，甚至坚信不移，并痛哭流涕；当找到东西又破涕为笑。近半年来好收拾东西，发现患者的床下有一包东西，其中有女儿多日找不到的木梳、牙膏、口罩、毛衣针和女

婿的袜子、小孩的奶瓶等，但患者不承认是自己收拾的。患者终日不出房门，亲友来看她不能辨认。逐渐生活也不能自理。

〔望诊〕精神痴呆，面无表情，舌质淡，舌苔白少，舌体瘦瘪。

〔闻诊〕能说出自己的名字，但不知道自己的年龄和女儿的名字。

〔切诊〕脉沉缓无力。

〔辨证〕肾气衰微、阳气阴精不得上贯以充脑，脑海不足，喜忘前言。

〔立法〕补肾气，益阴精，健脑强神。方用补脑丸。

〔处方〕仙灵脾 30克 巴戟天 24克 肉苁蓉 24克
熟地 30克 女贞子 24克 益智仁 18克
远志 18克 菖蒲 12克 鹿角胶 15克
紫河车 10克

共研细末，炼蜜为丸，每丸10克，每服一九，一日两次，早晚服。

二诊：1962年5月20日。患者服药两周，精神逐渐好转，饮食起居正常，生活能自行料理。一日突然问女儿：“你弟弟有信来吗？”此后对周围事物也关心，愿意到室外活动，能和邻居交谈，除有时说话尚絮叨，痴呆已不明显。舌质淡红，少苔。脉沉缓较前有力。前方加黄精24克继服。

三、治疗体会

基于老年性精神病的病因机理是脑海不足和脑机能的退化，故治疗本病应首先考虑如何解决脑海不足和促进脑机能

这一关键性的问题。因为肾是藏精之室，精又能生髓，髓汇集于颅腔内而成脑，脑是人的最高级神经活动中枢。脑既然是由肾精产生的，那么补充肾精，即是填补脑的物质基础。补益肾气，即是促进脑的机能活动。脑髓充实，肢体亦就轻劲有力，不但能增强体质，解除懈怠安卧等症状，同时又能供给脑机能活动的物质。补益肾气能够使脑的机能活动增强，既可使精神焕发，消减精神症状，又可促进肾精的产生以充脑。在这一理论指导下，采用补肾益精、充脑强神的方法治疗老年性精神病，通过三十年的临床实践，证明它确有预期的疗效。运用此法治疗多例，症状都有不同程度的改善。前面所选两例症状较重者，都达到痊愈水平。就是经治病例中疗效较差者，亦能达到生活自理。在治疗老年性精神病的临床实践中，制订出“补脑合剂”与“补脑丸”，现将两方的药物组成和方解列下，供参考。

（一）补脑合剂方解

熟地黄：熟地黄取其质厚，能滋肾水，补真阴，填脑髓，生精血、聪耳明目。

枸杞子：清肝滋肾，益气生精，助阳补虚，强筋骨，明目。

麦门冬：强阴益精，清热除烦，明目悦颜。

五味子：收敛耗散之气，滋肾水，益气生津，补虚明目，强阴涩精。

炙首乌：温补肝肾，收敛精气、添精益髓，养血乌发，强壮筋骨。

巴戟天：补肾壮阳，强健筋骨，治肾虚骨痿不能起。

肉苁蓉：补肾壮阳，滋润五脏，益髓强筋，润肠通便，

治肾虚骨软。

鹿角胶：生精补髓，养血助阳，强筋健骨。

远志：能通肾气，上达于心，强志益智，补精壮阳，聪耳明目，利九窍、长肌肉、助筋骨、治迷惑善忘。

菖蒲：配远志能交通心肾之间的联系，益心开窍，聪耳明目，发音声。

炒枣仁：补心强神，治虚烦不眠，惊悸健忘。

（二）补脑丸方解

1. 方解

仙灵脾：补肾壮阳，益精气，坚筋骨（本品有促进内分泌系统功能之效）。

巴戟天、肉苁蓉、鹿角胶作用见前。

益智仁：入心肾，补君相之火不足，摄涎唾，缩小便，治老年口流涎、遗尿。

紫河车：为入之气血所生，故能大补气血，补精益肾，治一切虚损劳极、恍惚失志。

女贞子：滋肾益肝，乌发，明目，安五脏，强精神。

熟地黄、远志、菖蒲作用见前。

2. 随症加减

阴精虚损重、语言恢复较差者加炙龟板；智力丧失、定向缺损者，加生龙骨；记忆丧失或因外伤等诱因使病情加剧者，适量加补骨脂、川续断；大便秘结者，将肉苁蓉分量加倍；津液虚者配以石斛；血虚者配以当归；腰膝痿软站立不稳者，加桑寄生。

（三）重视舌诊

临床辨证治疗本病，舌诊更重于脉诊。如病例介绍之

一，舌质暗红，无苔，满舌碎裂，说明肾阴精虚损重于肾阳气虚，用药时应以滋肾益精为主，补肾阳为辅，在配伍上滋阴药的比例要大于补阳药。如例二，舌质淡、苔白少，舌体瘦瘪，说明肾气衰微重于阴精不足，用药时应以补肾气为主，益阴精为辅。掌握阴阳虚衰的程度，是治疗本病的重要关键。

第十二章 心因性反应症

在人与外界矛盾激化的过程中，由于精神因素而导致脑机能失调的疾病，叫做“心因性反应症”。本病原名“反应性精神病”，但这一名称不能包括心因性反应症中较轻的类型，而且本病与精神分裂症有比较明确的界限，因此以改称“心因性反应症”较为恰当。

第一节 病因病机

急剧的或持久的精神刺激因素，是导致本病的直接原因。某种精神因素是否能导致大脑机能失调，除取决于精神因素的刺激强度和持续性之外，常与人们对待它的态度以及大脑活动的机能状态有密切的关系。在精神矛盾激化过程中，人的情感反应过分强烈，在程度和持续时间方面都超过一定的范围，甚至思维活动受到影响而产生反常行为，这就就会发生心因性反应症；此时病人不能工作，生活不能自理，需要采取特殊医疗措施。

中医把由于“七情”、“五志”(精神因素)过激所引起的疾病称之为“情志病”。情志活动本来是对客观环境的一种情感反应。人在正常情况下，偶有情感波动，本不致于产生病症，但若在正常生活中突然遭到意外或持久的精神挫折，由此而产生的情感反应超过人的正常耐受极限，就会影响机体

活动的协调，从而发生病变。如《素问·举痛论》所说：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。”这些由于情感过激所引起的无形气化的改变，会影响正常的精神活动。如“悲哀动中则伤魂”，“怵惕思虑则伤神”，“忧愁不解则伤意”，“喜乐无极则伤魄”，“盛怒而不止则伤志”。

情感过激虽然有引起气化改变的可能，但是否真能引起这种改变还要取决于人们的思想境界和对待事物的态度。一般是思想开朗、豁达大度者得此病者少，心胸狭窄、患得患失者易得此病。此外，健康状况不佳、妊娠或产褥期、感染、中毒、过度疲劳者和处于青春期、更年期者较易患本病。

第二节 临床表现

一、急性心因性反应症

患者在急剧的精神因素刺激下而迅速发作的一种心因性障碍，临床表现可有剧烈的精神运动性兴奋和各种杂乱行为。病人情绪激动、吵闹不休，哭喊、高歌、狂笑，随地大小便，不知饥饱，甚至神志模糊，无目的地乱跑，伤人毁物、自伤；病人不认识周围环境，有定向力障碍。有的病人亦可表现为精神运动性抑制，如呆滞不动，缄默不语，甚至僵住不动，呈现木僵状态；情感反应迟钝，即所谓“情感性麻痹”。急性心因性反应症患者，在躯体方面可见有颤抖，面色苍白或潮红，心跳加快，出汗，瞳孔扩大等植物神经系统失调症状。

二、持久性心因性反应症

患者在持久的精神因素刺激下，经过较长时期逐渐地发生精神异常反应，其临床症状的持续时间较久，而且表现形式较为复杂，主要有以下几类：

（一）反应性忧郁症

病人情绪抑郁，不幸的往事持续地占据着病人的全部思维，一切客观事物皆易招致患者难过与忧伤。患者焦虑，自责自罪，对生活丧失信心和兴趣，对前途悲观，甚至有自杀的意念。有自杀意念的病人，仍可对周围环境保持较密切的联系，并能作出消极行为的周密计划，以致发生严重意外。此外，病人的言语、动作均可减少，但一般来说抑制程度较轻。病人睡眠多有障碍，全身疲乏，食欲减退。

（二）心因性妄想

病人受到某种精神因素作用后，产生与该因素有关的猜疑。最常见的是关系妄想和迫害妄想，妄想的内容接近真实，与处境密切相联，常常具有突出的自我中心性。病人敏感而多疑，常把周围人的活动与自己联系起来，认为别人在议论、跟踪、监视、迫害自己，或认为自己被某种仪器控制着。有时猜疑的对象也可有一些泛化，此时应与精神分裂症的妄想型相区别。精神分裂症的妄想具有脱离现实的倾向，而本病的妄想与幻觉的内容常与精神因素相联系。病人对自己的妄想症状也多少具有一定理解能力，认识到这些妄想是不够合理的，有时也有动摇和疑惑。

有的病人出现幻觉，如幻听、幻视，内容多与他的精神体验有关，称为“心因性幻觉”。情感多与其精神体验相适

应，记忆良好，但睡眠差。

本症也可发生在感官有缺陷的人身上，如重听患者，因听力失聪，不能与周围人保持正常的交往关系而易产生敏感、多疑，甚至发展至心因性妄想。

第三节 诊断与鉴别诊断

一、诊 断

诊断心因性反应症的依据有下列多项：

- (1) 有明显的足以对病人引起精神反应的精神因素；
- (2) 发病与精神因素在时间上紧密配合；
- (3) 临床精神症状内容体验与精神因素有着密切联系，有情感易于外露并比较容易接受解释劝说的临床特点，诊断并不困难；

(4) 病情在演变过程中有时可出现波动，在一个时期的精神紊乱之后，当情绪紧张减轻或思想矛盾转缓时，常可出现一个好转时期，此期内症状可减轻或消失，自知力存在；

(5) 当经过心理治疗而使精神因素的矛盾缓解后，病情亦可缓解，恢复到正常状态，无残留症状存在；但有些病人愈后再遇某种精神因素刺激又可发病。

二、鉴别诊断

(一) 反应性忧郁症与躁狂抑郁症的抑郁状态和更年期忧郁症的区别。

躁狂抑郁症的抑郁状态，没有相应的精神因素在起作用。

用，并有明显的运动抑制。如果病人正处于更年期，应与更年期忧郁症相区别，更年期忧郁症有更年期症候群的明显特点，发病中没有起决定作用的精神因素。

（二）心因性妄想症与精神分裂症妄想型的区别。

心因性妄想症的妄想内容具有具体性与精神因素关系的密切性，以及外露情感，接近于真实的特点。而精神分裂症妄想型的妄想内容脱离现实，荒谬离奇。精神分裂症的基本症状也与本症差别较大，不难鉴别。

第四节 临床治疗

一、心理治疗法

中医早在《素问·阴阳应象大论》中提出：“怒伤肝，悲胜怒”。“喜伤心，恐胜喜”。“思伤脾，怒胜思”。“忧伤肺，喜胜忧”。“恐伤肾，思胜恐”的七情疗法，历代医学家又各有发展。这种方法就是利用一种人为的精神因素来调节自身的精神，使之兴奋或抑制。针灸药石虽能治有形之疾，但不能治无形之七情，如李中梓所说：“境缘不遇，营求不遂，深情牵挂，良药难医。”所以，必须结合七情疗法（心理疗法）辅以针药，既能提高疗效，又能解除病原。

心理疗法应根据每个病人的不同情况，分别采用以下几项措施：

（1）启发病人振奋起来，认真总结发病的经验教训，以亲身体会变消极因素为积极因素。

（2）启发病人用理性支配感情，摆脱受感情支配的错误

观点。

(3) 改善环境，消除不良诱因，帮助病人从思想上正确对待环境。

(4) 帮助病人正确分析主客观条件，看清前途，增强信心，正确对待不利条件。

二、药物治疗法

治疗心因性反应症，在采用心理疗法的同时，辅以药物治疗是必要的。用药物调节体内阴阳气血的平衡，促使五脏各安其职，有助于消除临床症状，使病人尽快恢复健康。临床常用调神汤加减治疗。

〔处方〕 丹 参 元 参 生 地 朱寸冬
菖 蒲 远 志 甘 草 生梔仁
合欢皮 首乌藤 炒枣仁 五味子

〔加减〕 若郁火亢盛，加珍珠母、琥珀。若心肝血虚较重，加莲子心、大枣、白芍。若睡眠瘕疾，加钩藤等。

三、病例介绍

〔例1〕急性心因性反应症

陈×× 女性 31岁 家庭妇女 初诊日期为1963年7月18日。

〔问诊〕 患者个性强，但说话不注意场合，经常受到爱人的批评，个性受到约束。一周前又因随便说话，引起邻居质问，被爱人当众责打。事过后，患者精神呆滞，两目直视，不说不动，对外界毫无反应。半日后突然呼叫，言语错乱，长时哭嚎，继而狂笑高歌，无目的地奔跑，惊慌恐惧。

幻视从墙壁上走下一个白发老人和她的五个孩子在桌上跳舞，又说她爱人就是那白发老人。几天来不眠不食，经××精神病医院诊断为反应性精神病。

〔望诊〕精神紧张，躁动不安，两目圆睁，舌质淡红，舌苔根部白腻。

〔闻诊〕言语错乱。

〔切诊〕两手脉忽大忽小，忽疾忽迟。

〔辨证〕暴怒伤肝，郁火妄动，神明失守。

〔立法〕平肝解郁，镇静宁神。方用调神汤加减。

〔处方〕珍珠母 30克 琥 珀 3克 丹 参 10克
元 参 10克 远 志 10克 菖 蒲 6克
甘 草 3克 朱寸冬 10克 生梔仁 6克
郁 金 6克 合欢皮 10克 首乌藤 15克
炒枣仁 15克 三剂

除用药物治疗外，请其爱人向患者陪礼道歉，并请邻居协助耐心劝解，挽回面子，同时耐心说明说话随便的危害性，在患者认识错误和心悦诚服之后将药物服下。再次就诊时，患者精神基本正常，定向力完好，能正确认识产生矛盾的性质和原因，但对病中的片段不能完全回忆。自服药后四天来睡眠安稳，每夜能睡6~7小时，已能正常进食。前方加减继服两剂，以巩固疗效。

〔病例分析〕本例患者个性强，好说好笑，当众受到爱人的责打，自尊心受到损伤，怒不得泄，致暴怒伤肝。当时不言不动者，乃肝之条达之性，一时受到抑制闭而不达，为郁火暴发前的沉静，随之郁火妄动，扰及神明则表现剧烈的精神运动性兴奋。此时采取何种方法压抑制止，都无济于

事，这些表现亦是一种泄怒的方式。待到适当的时候，以药物调理病机，令其安静下来，再劝说开导，方易奏效。方中用珍珠母、琥珀镇静安神；丹参、元参、朱寸冬清心火安神；菖蒲、郁金、生梔仁、合欢皮解郁开窍醒神；远志、炒枣仁、首乌藤养心安神以收耗散之心气。在药物和心理治疗互相作用下，很快取得较好疗效。

〔例2〕反应性抑郁症

熊×× 女性 26岁 医生 初诊日期为1965年2月19日。

〔问诊〕平素性格不够开朗，沉默寡言。两年前结婚，婚后夫妻两地分居，患者前往爱人处探亲，其爱人因工作忙，对她缺少体贴、关心，因而情绪低落，对一切事物不感兴趣，终日抑郁不乐。近一个月来，精神呆滞，两目直视，整日不语，沉醉于回忆之中。唉声叹气，无故落泪，别人唤她也不应声。有时焦虑，烦躁，夜间不眠，需人几次劝导才能就寝，睡眠不实，多梦。食欲不振，口干不欲饮。体倦乏力，二便调，月经正常。经××医院诊断为心因性反应症。

〔望诊〕面色萎黄，反应迟钝，舌质淡红，舌尖红，苔根部白。

〔闻诊〕语声低微，能正确答问。

〔切诊〕脉弦细数。

〔辨证〕抑郁不伸，思虑无穷，心肝血虚，神不安舍。

〔立法〕养血解郁安神。方用调神汤加减。

〔处方〕生 地 15克 丹 参 10克 元 参 10克
朱寸冬 10克 五味子 5克 炒枣仁 18克
合欢皮 10克 炒山梔 6克 莲于心 3克

首乌藤 15克 远志 10克 菖蒲 6克

甘草 6克 淮小麦 30克 大枣 10枚

除给患者服药外，寄语患者爱人前来医院与其详说，并对患者加以劝解，指出夫妻感情应该培养，要互爱互谅，要支持爱人的工作。结合心理治疗服药八剂后，精神显著好转，心情较前舒畅。就诊时精神愉快，表情活泼，有时爱人陪她外出游玩，对周围事物的兴趣提高，爱人陪同一起进餐，饮食增加。舌质淡红，苔薄白，脉沉细已不数。改服丸剂以巩固疗效。

〔处方〕早服人参归脾丸，晚服朱砂安神丸，每次一丸。

〔病例分析〕本例患者的致病之因，是由于患者对爱人的满怀希望和要求未能得到充分理解和满足，因而满腹委屈，由怨到恨，日久耗伤肝心之血，神不守舍，故精神涣散，对周围事物漠不关心，充分表现出抑郁症的特点。故方用生地、丹参、元参、朱寸冬、炒枣仁、首乌藤、五味子养阴血安心神；合欢皮、炒山栀解郁；远志、菖蒲交通心肾而安眠；莲子心、合甘麦大枣汤，缓泻心中郁火而不伤血。更令其爱人配合，以满足患者的愿望解除病因，两者互相配合，使病情缓解而至痊愈。

〔例3〕心因性妄想症

王×× 女性 39岁 教员 初诊日期为1964年10月4日。

〔问诊〕一年前，患者因与同事意见不和而发生争吵，找领导申诉，领导未按其要求处理，便自觉受了委屈，埋怨领导不公平，后来觉得其他同事也歧视自己，怀疑别人都和自己过不去，进而认为自己的行动是由别人用电流控制着等

等。经××医院精神科诊断为心因性反应症、妄想症，住院治疗五个月。

现在仍有多疑和迫害妄想，对过去的精神因素仍耿耿于怀。入睡困难，眠后全身痠疼而醒，情绪易激动，胸闷烦躁。饮食尚可，二便调，月经正常。

〔望诊〕精神忧郁，舌质淡红，舌尖有紫刺，舌苔白。

〔闻诊〕能诉说病情。

〔切诊〕脉沉细略弦。

〔辨证〕肝郁血虚，心神不安。

〔立法〕平肝解郁、养血安神。方用调神汤加减。

〔处方〕珍珠母 18克 生熟地各 18克 杭白芍 12克
丹 参 10克 元 参 10克 远 志 10克
菖 蒲 6克 五 味 子 6克 甘 草 3克
炒枣仁 15克 首 乌 藤 15克 合欢皮 10克
生梔仁 6克 香 橡 10克 钩 藤 10克

前方服用八剂，症状明显减轻，对妄想有一定的批判能力，睡眠安好，情绪仍有时不稳，舌质淡红、少苔，脉沉细。改服丸药调理。

〔处方〕补心丹20丸，每服一九，一日两次，早晚服。

〔病例分析〕本例患者病程持续一年余，虽经五个月的住院治疗，但基本症状未能解除。究其原因是思想问题没有得到解决，所以具有突出的自我中心感，怨恨之情未消，肝失条达之性，肝气郁则胸闷不舒，肝主谋虑，以防外侮，多谋不决，则产生猜疑；谋虑不解，则肝血暗损，肝血虚神魂不能安舍，则难入睡，眠后则痠疼而惊醒。采用药物以调理机体，方用珍珠母平肝镇静安神；生地、白芍养血柔肝；丹

参、元参、远志、菖蒲以交通心肾；五味子、甘草酸甘敛阴以助养血柔肝之效；炒枣仁、首乌藤养血安神；合欢皮，梔仁、香橼舒肝解郁；钩藤熄风以止癲疯。但最根本的治疗方法还需要解除患者思想上的矛盾。于是用摆事实讲道理的方法，启发患者正确对待和处理矛盾。经过三周的治疗（个别心理治疗三次），精神恢复正常，症状消失，观察四个月无波动。

第十三章 神经官能症

神经官能症是由各种精神因素引起高级神经活动过度紧张，致使大脑机能活动暂时性失调的一组疾病。本章将只介绍其中的神经衰弱、癔病、强迫性神经官能症的治疗方法。

精神因素对于这组疾病的发病和治疗有着直接的密切的关系。病人的神经类型和病前性格特点往往构成发病的内因。当人受到感染、中毒、外伤或其它躯体疾病而使神经机能受损时，则很容易发生这种病。

中医有关“官能”的学说，早在两千多年前就有记载，《素问·灵兰秘典论》中云：“心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。大肠者，传道之官，变化出焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉……”。所谓“官能”，即功能的意思。古人把精神的功能活动分配给各脏器，并在君主之官心的统帅下，形成一个完整统一的精神和神经活动的系统。《灵枢·本神篇》中云：“所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远谋谓之虑，因虑而处物谓之智。”这些有关精神活动的描述，与现代医学有关高级神经中枢功能活动的学说相类似。由于中医把有关功能活动分配给各脏所司，所以，当某脏功能失调而出现某种症状时，结合病因，

就可知道这些症状是何脏功能失调的表现。如悲怒气逆则伤肝，表现为头晕，头痛，项强不利，巅顶沉，面热，目胀，烦躁易怒，夜眠多梦。忧愁思虑则伤心脾，表现为精神不振，体倦乏力，喜卧少动，入睡困难，记忆减退。劳逸不节则伤脾，表现为精神萎靡，懒言少动，嗜卧失眠，饮食减少，食后不消，大便溏。悲哀动衷则伤肺，强烈的悲哀可致肺气暴伤，表现为突然失音；长期忧愁不解可致肺气渐伤，表现为心慌，气短，体倦乏力，易汗出。房室不节则伤肾，表现为头眩，耳鸣，腰膝痿软无力，尿频，男性有遗精、阳痿，女性则月经不调、不孕。临床就是运用这种方法辨证施治的。

第一节 神经衰弱

神经衰弱是神经官能症中最常见的一种，病人多为青壮年。它是由各种精神因素引起的大脑皮层兴奋和抑制过程失调而造成的，常表现为易兴奋、易衰竭的各种临床症状，一般起病缓慢。

一、病因病机

(一) 病因

神经衰弱，多是因为患者的神经活动遭受急性的或慢性的刺激而处于持续的和过度的紧张状态所导致的。例如从事精细复杂工作的脑力劳动者，思考过久，得不到适当的休息；或过分地克制情感；或突然遭受意外的惊吓；或骤然改变长期适应的定型规程、环境、习惯；或长期的内心矛盾不

得解决、主观愿望不符合客观要求等等，都是造成神经活动过度紧张的因素。对于神经活动的过度紧张，不能只理解为工作时间长，它和工作的性质、工作组织得是否恰当，以及工作时的劳动态度等因素有关。例如从事精巧细致的工作，需要注意力的高度集中，就容易使神经过度紧张和疲劳；但是，如果工作者有高度的责任感，热爱自己的本职工作，就不容易造成神经紧张而导致神经衰弱。

神经衰弱的发病原因，除上述因素之外，还与患者的神经类型、特点和当时躯体的机能状态，以及社会环境等条件因素有关。中医认为，神经衰弱乃为七情所伤、劳逸失调、房事过度、病后失养等因素造成的，这些因素使五脏的阴阳、气血失调，因而产生的一系列症候群。

（二）病机

根据临床症状的表现，结合诱发本病的因素，作者认为对神经衰弱的病机应作如下分析：

七情所伤，或长期忧愁思虑，耗伤心脾，使心脾血虚，血虚则上不荣于面，故面色苍白，唇淡，舌淡；血虚神无所养，则精神萎靡不振，懒言，少动嗜卧，心悸，怔忡，健忘，失眠；血虚神不安舍，眠后多梦易醒；女性则经血失调。或郁怒伤肝，使肝血不足，肝主目，目受血而能视，肝血虚不能养目，则目干涩，视物不清；肝又主筋，肝血虚则筋失所养，表现为瘈瘲而醒；肝阴血虚又可导致肝阳上亢，则头晕，头痛，口燥咽干；肝郁化火，肝火上逆与心火合邪，则木火燔心，心神被扰，表现为烦躁易怒、卧不安席、面红、头胀、头痛，有时可出现血压偏高现象；肝郁不舒，则常感胸膈憋闷；胁为肝之分野，故两胁串痛；若肝气横逆，侵犯脾

胃，胃降失和，则呃逆呕吐吞酸，造成胃不和、卧不安。

病后失养或房室过度，耗伤肾阴，肾阴虚不能上养清窍，则耳鸣、头晕、目无光泽。腰为肾之府，肾虚则腰膝痿软无力，精关不固则早泄、梦遗、滑精。阴虚生内热，则颧红、口干、潮热；阴不敛阳，则盗汗出。

房劳过度或幼年手淫耗伤肾阳，致使肾阳虚。腰为肾之府，督脉贯脊属肾而督诸阳，肾阳虚，则腰脊痠痛。命火衰微，故男性阳萎，性欲减退，阳虚精关不固，则早泄，女性则经闭不孕。阳虚肾关开合不利，则尿频而淋漓不尽。命火衰不能温脾助水谷运化，则便溏。阳气不能外达，故形寒怕冷。肾之华在发，肾虚则毛发易脱落，致早年秃顶，记忆减退，昼日精神倦怠嗜睡，夜间则昏沉睡不实，醒后不解乏。

总之，无论本病的临床表现如何，仍需根据辨证施治的原则，予以分型处方。

二、临床表现

神经衰弱的临床症状有下列二组：

（一）兴奋性增高症状

早期可表现为感情的控制能力减低，常因小事引起强烈的情感反应。病人易激动，缺乏耐心，常因小事与人争吵。好伤感，以致易笑易哭，烦躁，甚至感到委屈、气恼。

睡眠障碍，常表现为入睡困难，睡眠表浅，多梦，易醒或早醒。

头部感觉过敏，易感到头疼、头晕或头胀。头部压沉有盪盪状的紧束感。躯体不适及感觉过敏，如全身痠痛，怕光，

怕噪音。

植物神经系统的功能障碍，表现为内脏及皮肤的敏感性增高，病人感到心慌，心悸，胸闷，气短，易汗出，脸发红或发白。性功能障碍，如阳痿、早泄及女性月经不调等。

（二）衰竭性增高的症状

衰竭性增高表现为主动性注意减弱，病人不能持久集中注意力，记忆力减退，精神不振，脑力与体力均易疲劳，全身疲倦无力，工作、学习能力减退和不能持久。还可表现精神萎靡嗜睡，虽多睡而不解乏。

情感方面表现为情绪易波动，容易忧伤沮丧；情绪反应强烈，但不持久。

由于本病症状多样复杂，病人对于疾病本质缺乏正确认识，因而容易对疾病产生顾虑及焦虑，加之病人更多地注意躯体的各种异常感觉及对外界刺激的敏感，因此，容易产生疑病观念。

三、诊断与鉴别诊断

神经衰弱的临床诊断，除详细了解患者病史、病因及症状特点之外，患者躯体和神经系统检查、以及化验室检查均无阳性体征是一个重要的依据，一般比较容易诊断。但是，一定要做好鉴别诊断，以避免误诊，给病人带来痛苦。

需要进行鉴别诊断以与神经衰弱相区别的，主要有以下几种疾病：

（一）神经衰弱症候群

神经衰弱症候群患者，常是有器质性疾病的人，如溃疡病、结核病、高血压病、脑动脉硬化症、贫血、甲状腺机能

亢进、肝炎等等，都可表现出明显的神经衰弱症状。这就需要运用各种检查手段来排除这些器质性病变，排除不了的，则要同时进行对症对因治疗。

（二）精神病

精神病中的轻型抑郁症和早期精神分裂症，均有类似神经衰弱的表现。而轻型抑郁症以情感忧郁为突出表现，患者消极悲观、自责自罪，甚至有轻生观念。而早期精神分裂症则以情感淡漠为突出表现，患者不主动就医，行为懒散，反应迟钝。

（三）疲劳症候群

疲劳症候群，是人在短时间内脑力和体力过度消耗而产生类似神经衰弱的症状，如头痛，全身不适，失眠等。但这些症状经过充足的休息、调整之后，可很快消失。

另外，还应与屈光不正、鼻窦炎等疾病加以区别。

四、临床治疗

治疗神经衰弱，除采用药物之外，还要结合进行心理治疗。心理治疗一般采用集体和个别相结合的方法，即将一批神经衰弱患者约到一起（最好 20~30 人一批），给他们讲清神经衰弱的病因、性质，帮助患者正确认识疾病，并鼓励患者发扬革命乐观主义精神，增强战胜疾病的信心；然后在临床治疗中对每个患者个别进行心理治疗，与患者建立感情，取得信任，详尽地了解患者的病史和有关情况。在进行心理治疗的同时，可根据每个患者临床表现的不同症状，给与辨证分型治疗。

（一）分型论治

1. 阴虚肝热、心神不安型的治疗

〔主要症状〕情绪易激动而难以控制，急躁敏感，语言粗暴，常因无关重要的事情而冲动和发脾气。自觉头晕头痛，痛重于晕；记忆力减退，注意力不集中；失眠多表现于入睡困难，严重者可彻夜不眠；心慌胸闷，尤以激动时更为明显。也可见易汗出，食欲时好时坏，大便干燥，小便黄。

〔望诊〕多表现急躁不安，舌质红，苔黄或舌红无苔。

〔闻诊〕声高气粗。

〔切诊〕脉弦数有力。

〔辨证立法〕此型多因过怒所致，古人云，“大怒气逆则伤肝”，肝气郁而化火，肝火盛则急躁易怒；肝火上攻于头，则头痛头晕，有的病人也可血压偏高；木火燔心，则心神不安，故心慌、失眠、记忆减退、注意力不集中；肝气郁则胸闷不舒，火盛灼津，则便秘尿黄。舌红、苔黄或舌红无苔、脉弦数，均为阴虚肝火盛之象。脉证合参，治以养阴镇肝、泄火安神法，用泄肝安神合剂。

〔处方〕生石决明 16克 珍珠母 18克 生龙骨 15克
生牡蛎 15克 龙胆草 10克 炒山栀 6克
白蒺藜 6克 生地 15克 元参 10克
朱寸冬 10克 朱茯神 10克 炒枣仁 15克
柏子仁 15克 甘草 3克 泽泻 10克

〔方解〕石决明、珍珠母、生龙骨、生牡蛎，平肝潜阳，镇静安神；龙胆草、炒山栀泻肝火；生地、元参养阴配于泻火药中，不致火降阴伤；朱寸冬、朱茯神、炒枣仁、柏子仁养心安神；白蒺藜佐于平肝潜阳和泻肝药中而增强其作用，乃治头晕头痛之对症药；甘草和中佐味，使重镇及苦寒药不致

伤胃；泽泻使火降自小便排出而开出路，不留余邪。

2. 肝郁血虚、心神不安型的治疗

〔主要症状〕情绪低落而有较大波动，悲观失望，在生活中遇到极小的波折也会引起伤心哭泣。敏感，过分注意生活小节。常有无味的思虑，好猜忌，多疑虑；常为担心别人不了解自己的病痛而苦恼。自觉头晕头痛，体倦乏力；记忆力很差，但对以往精神上受过的创伤却记忆犹新。入睡前想事多，失眠多表现为睡不沉，常是半睡眠状态，恶梦多，易惊醒，醒后常有盗汗。心悸气短，紧张时加重。常长吁短叹。大便干稀不定。工作能力减低，可勉强坚持工作，紧张时则感到吃力。

〔望诊〕舌质淡，舌尖红，少苔。

〔闻诊〕能平静地诉说病情，时作叹息。

〔切诊〕脉弦细或沉弦。

〔辨证立法〕此型为长期精神郁闷或因谋虑不决所致。长期精神郁闷，肝气郁而不舒，谋虑不决，则肝血暗损，致成肝郁血虚。肝郁不舒，则情绪易低落，易伤感；胸闷则气短，易长吁短叹；谋而不决，则多思虑，形成猜忌，对周围事物敏感，情绪易波动；久则肝血虚不能上充于脑，则头晕头痛，记忆减退。由于对以往的精神刺激耿耿于怀，故记忆犹新；血虚心神失养，则心悸失眠；肝藏血而舍魂，肝血虚不舍魂，则恶梦易惊醒；阴血虚不敛阳，故易出盗汗。肝为罢极之本，肝血虚，易疲倦，精神不振，工作能力减低。舌淡苔少，脉弦细，乃肝郁血虚之象，治以解郁养血安神法，用养肝安神合剂。

〔处方〕当 归 10 克 杭 芍 12 克 炙首乌 15 克

柴 胡 6 克 生 草 3 克 朱茯神 10 克

远 志 10 克 菖 蒲 6 克 炒枣仁 15 克

柏子仁 15 克 五味子 6 克

〔方解〕当归、杭芍、炙首乌养血柔肝；朱茯神、远志、菖蒲、炒枣仁、柏子仁养心安神；甘草、五味子酸甘敛阴，以收耗散之心气；使以柴胡一味引诸药入肝，以顺肝之条达之性，配以养血药中而起到养肝之作用。

3. 劳伤心脾型的治疗

〔主要症状〕精神困倦，自觉躯体易疲劳，对日常工作感到吃力。记忆力差，阅读书报不能很好记忆，勉强记忆则引起头痛。一般情况下头晕，工作紧张时可昏倒。四肢发冷，手足常出冷汗。有时困倦思眠，但睡不沉。心悸气短，上楼走路时较为明显。食欲不振，大便稀而少。妇女多有经期错后、量少、色淡等现象，或一月行经两次，血量较多，经期症状加重。男子常有性欲减退。

〔望诊〕一般形体瘦弱，精神不振，面色萎黄，唇舌色淡。

〔闻诊〕气短声低。

〔切诊〕脉沉缓无力。

〔辨证立法〕此型为思虑劳倦用脑过度所致。《内经》说：“心怵惕思虑则伤神，脾愁忧不解则伤意”。心脾既伤，则功能失职。脾虚则运化不健，食欲不振，大便溏泻；脾主四肢肌肉，虚则形体消瘦，肢体倦怠，手足冷而易汗出；脾主化血，脾虚则血无从化生，故月经量少而色淡；脾主统血，脾虚则血不行故道，故月经血量少；脾又为后天之本，虚则不能上充于脑，故头晕痛，记忆力差，劳累可晕倒。心藏神，主神明，心血虚则神不内守，故心悸气短，失眠。至于面色

萎黄，唇舌色淡，脉沉缓无力，皆为心脾两虚之象。治以健脾养心安神法，用加味归脾合剂。

〔处方〕 黄 芪 15 克 党 参 10 克 白 术 10 克
当 归 10 克 杭 芍 10 克 茯 神 10 克
远 志 10 克 菖 蒲 6 克 炒枣仁 15 克
柏子仁 10 克 龙眼肉 10 克 焦神曲 10 克
甘 草 3 克

〔方解〕 此方为归脾汤加减。方中黄芪、党参、白术、甘草健脾益气；当归、杭芍养血；茯神、远志、炒枣仁、龙眼肉养心安神；加柏子仁以增强养心安神之功；以菖蒲易木香，因菖蒲之芳香入心，配远志有交通心肾安神的作用，用于心脾虚以失眠为主的患者，较之原方中用木香之散气更为适宜。

4. 肝胆风热型的治疗

〔主要症状〕 阵发性剧烈的偏头抽引目系痛，或后头牵及肩项痛，痛甚不能转侧；或为颜面痛牵及牙痛，也可有周身串痛。上述各处疼痛不是同时发生，上述痛处也不是每一患者都有，疼痛发作次数也不一定，可一天发作数次或几天发作一次，也可周期性发作，因而引起患者的精神紧张。精神不愉快或工作紧张可使头痛频作，头痛时常伴有心悸失眠、急躁易怒，疼痛不发作时，无其它不适。

〔望诊〕 表现苦恼、急躁，舌边红，苔薄白。

〔闻诊〕 疼痛时不愿多言。

〔切诊〕 脉弦而有力，或浮弦。

〔辨证立法〕 此型多因大怒引起肝胆二经风热所致。肝与胆相表里，同为风木之脏，风热上攻于头，则头痛剧烈，风者善行而数变，故时痛时止，或痛无定处；舌边红、脉浮

弦均为肝胆风热之象。治以平肝胆疏风热，用疏风止痛合剂。

〔处方〕生石决明 24 克 白蒺藜 10 克 龙胆草 6 克
炒山栀 6 克 当归 10 克 川芎 6 克
羌活 6 克 防风 6 克 白芷 6 克
细辛 3 克 杭菊 10 克 薄荷 6 克(后下)

〔方解〕石决明、白蒺藜平肝潜阳熄风为君；胆草、山栀泻肝胆热为臣；当归、川芎和血，即治风先治血，血行风自灭之意，以之为佐；羌活、防风疏风；白芷、细辛止痛；杭菊、薄荷疏散风热，即芎菊茶调之意为使。

5. 肝郁血虚、血不荣筋型的治疗

〔主要症状〕有经常性手颤和多阵发性手指痉挛，情绪与工作紧张时发作较严重，甚至不能做精细工作或握笔写字；可有全身或部分肌肉颤动，夜间常因四肢痠痒而惊醒；精神紧张时可有口吃。女性在经期上述病情加重，还可伴有四肢抽痛。

〔望诊〕舌质淡，少苔。眼睑震颤，手颤明显。

〔闻诊〕多能详述病情。

〔切诊〕脉弦细。

〔辨证立法〕肝主藏血，又主筋，筋赖肝血濡养。肝郁化火耗伤肝血，肝血虚则不能荣筋，轻则肢颤、肌肉动，重则筋急而挛，出现痠痒或手拘挛。肝藏血舍魂，血虚则令人恐，故常容易紧张惊恐。女性经期因信水外排，故血虚较甚，病情加重。舌淡，脉弦细，皆肝郁血虚之象。治以解郁养血荣筋法，用荣筋止痉合剂。

〔处方〕白头翁 10 克 秦皮 10 克 黄连 3 克

炒黄柏 6 克 当 归 10 克 杭 芍 12 克
 茯 神 10 克 甘 草 3 克 柴 胡 6 克
 桑 枝 15 克 丝瓜络 10 克 宣木瓜 10 克

〔方解〕白头翁凉血以缓筋之急，其物有风不动，无风自摇，以其相象肝，有治肝之功；配以秦皮有平肝益肾之效；更用黄连泻心火，黄柏泻肾火、益肾水，此治肝补母泻子之意，古人称之为“泻南补北”。四味皆为苦寒药物，互相配伍有治肝凉血以缓肝之急的作用。配以解郁养血之逍遥散合用，其中茯苓、白术、甘草温中健脾，配伍于苦寒药物中，以防其伤脾；佐以桑枝、丝瓜络、木瓜可收到养血荣筋之效；对瘰疬和下肢瘫软，效果良好。

6. 肝胃不和型的治疗

〔主要症状〕两胁胀满，胃痛，胃脘堵闷，呃逆，恶心呕吐，嗳气吞酸，不思饮食。常因胃气不舒引起失眠，昼日头胀头晕，心情郁闷而情绪易急躁。

〔望诊〕舌苔白或白腻。

〔闻诊〕常闻呃逆呃逆之声。

〔切诊〕脉弦滑。

〔辨证立法〕此型由于肝气郁结，疏泄失常，肝气横逆，胃降失和，故见呃逆，水谷不消，胃脘胀痛，嗳气吞酸，恶心呕吐等症。两胁为肝之分野，气机不利，故两胁胀痛，胃不和则卧不安，故脘闷而不眠；肝气郁则情绪急躁。舌苔白腻，脉弦滑，皆肝胃不和之象。治以舒肝降逆和胃法，用舒肝和胃饮。

〔处方〕旋覆花 10 克 代赭石 15 克 法半夏 10 克

陈 皮 10 克 茯 苓 12 克 甘 草 3 克

竹 茹 10 克 枳 壳 6 克 砂 仁 6 克

郁 金 6 克 川楝子 10 克 檀 梗 6 克

〔方解〕旋覆花、代赭石、法半夏，平肝降逆；温胆汤合香砂二陈汤，利湿化痰和胃止呕；方中以檀梗易木香，其芳香止呕和中之性胜于木香，且无木香刺激胃粘膜分泌胃酸之弊（对吞酸的患者不太适宜）；加入郁金、川楝子平肝解郁，除满止痛，使胃不和、卧不安的患者肝胃和、胀满除而眠自安。

7. 肾阴不足、精关不固型的治疗

〔主要症状〕早泄、梦遗滑精，患者对此感到恐惧；甚至怕遗精而不敢入睡；睡后多梦、盗汗；昼日精神不振，记忆力减退，注意力不能集中；头昏沉，腰痠体倦。

〔望诊〕舌质红无苔。

〔闻诊〕一般患者不欲多谈病情。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证立法〕此型多因心身过劳，或幼年有手淫习惯，致使肾阴不足，肾水不能上济于心，心肾不交所致。精藏于肾而主于心，精生于气而役于神，神动于中，精驰于下，精关不固，则早泄或梦遗滑精。腰为肾之府，肾虚故腰痠体倦；肾虚则精髓不足以上充于脑，故记忆力减退，注意力不能集中，头脑昏沉。舌红无苔，脉沉细，皆肾阴不足之象。治以滋肾固精安神。用滋阴固精安神合剂。

〔处方〕生熟地各 10 克 山萸肉 10 克 山 药 12 克
茯 神 12 克 丹 皮 10 克 生龙骨 15 克
生 牡 蛎 15 克 炒枣仁 15 克 远 志 10 克
五 味 子 6 克 菟丝子 10 克 莲子心 3 克

〔方解〕方用六味地黄汤滋补肾阴，以茯神易茯苓，取

其有安神之长；去泽泻不用，以病遗泄而无需再用泽泻泻肾浊；龙骨、牡蛎、五味子固肾涩精；菟丝子强阴益精；莲子心清心火使之下交于肾水，以防神动于中，精驰于下；炒枣仁、远志安心神，远志又能令肾气上达于心，使之心肾相交而遗泄止，睡眠自安。

8. 肾阳不足、精关不固型的治疗

〔主要症状〕性欲减退，阳萎早泄；精神不振，头目昏沉，记忆力衰退，工作能力降低，对一般事物不感兴趣；有时嗜睡，面容和表情显得衰老而与年龄不相称。

〔望诊〕面容苍老，精神不振，舌质淡少苔。

〔闻诊〕声低懒言。

〔切诊〕脉弱或沉缓无力。

〔辨证立法〕此型多因房事太过或幼年手淫以致精气耗损，阴损及阳，元阳不足所致。元阳为人生命之根本；主人生长、发育、衰老；肾阳虚，则日渐衰老，性欲减退，阳萎不举或举而不坚；阳虚则精关不固，故早泄。肾为作强之官，主技巧，肾阳虚，故精神不振，头目昏沉，记忆力衰退，工作能力降低。由于精神的衰退，故对一切事物不感兴趣，时而嗜睡。舌质淡，脉弱或沉缓无力，皆肾阳不足之象。治以补肾壮阳法，用壮阳固精合剂。

〔处方〕熟地 15 克 巴戟天 10 克 肉苁蓉 10 克
淫羊藿 10 克 鹿角胶 10 克 补骨脂 10 克
川断 10 克 菟丝子 10 克 益智仁 10 克
五味子 6 克 远志 10 克 菖蒲 6 克
肉桂 3 克

〔方解〕巴戟天、肉苁蓉、淫羊藿、鹿角胶、补骨脂、川续

断，补肾壮阳，以促进脑功能活动，对过早出现的衰老现象能有所改善，从而焕发精神；熟地滋肾益精，以填补肾脑之物质基础；菟丝子、益智仁、五味子强智固精，配以远志、菖蒲交通心肾，互相作用增强记忆力；佐以少量肉桂，取其气厚纯阳之性导诸药而固守丹田，使之昼则精神，夜则眠安。

笔者将神经衰弱分为上述八型，并制订八种合剂，经过多年临床实践，只要辨证无误，均可收到满意的疗效。

（二）病例介绍

〔例1〕张×× 男性 27岁 汽车司机 初诊日期为1959年3月18日。

〔问诊〕患者1957年12月始出现失眠，难入睡，多梦、易醒，昼日头晕、头痛，记忆力减退，烦躁，胸闷气不畅出，心慌，食欲不佳，溺黄便燥。经××医院诊治服西药治疗无明显效果，患者虽仍坚持工作，但很吃力。服安眠药后，昼日难于胜任工作。

〔望诊〕一般表现急躁，舌质红，舌苔黄。

〔切诊〕脉弦数。

〔辨证〕阴虚肝热、心神不安。

〔立法〕养阴，泄肝，安神。

〔治疗〕以泻肝安神合剂。治疗一周，病情明显好转。继服两周，除仍多梦外，其它症状消失。共治疗四周，症状全部消失，病告痊愈。两月后复查，疗效巩固。

〔例2〕阎×× 男性 38岁 ×厂商业经理 初诊日期为1959年2月24日。

〔问诊〕头痛、失眠已十二年之久。伴有头晕、记忆力减退，昼日困倦乏力，病情时轻时重，严重时通宿不眠，即

使入睡也多梦不安，常处于半睡眠状态。曾因不能坚持工作而长时期住疗养院休养。经服多种安眠药治疗，病情时有波动，患者对疾病的态度敏感而紧张。

〔望诊〕精神疲倦，舌质淡红，苔白少。

〔切诊〕脉弦细略滑。

〔辨证〕肝郁血虚，心神不安。

〔立法〕解郁，养血，安神。

〔治疗〕用养肝安神合剂。治疗五十天，除记忆力未完全恢复外，病情基本痊愈。又一月后复诊，症状全部消失，体重增加三公斤。早晨参加体育锻炼，长跑六里路而感到有力。食欲增加，心情愉快，对恢复健康有充分信心。后恢复工作。

〔例3〕邹×× 女性 39岁 文艺工作者 初诊日期为1959年2月25日。

〔问诊〕十二年来头晕、失眠，卧床后思想云集不能控制，影响睡眠。心悸，疲倦，精神不振，记忆力减退，食欲不振。经淡量少，经期症状加重。曾服西药治疗仅暂时有效。1953年曾卧床一月。

〔望诊〕形体瘦弱，舌质淡、无苔。

〔切诊〕脉沉弱。

〔辨证〕心脾血虚。

〔立法〕补益心脾。

〔治疗〕用加味归脾合剂。治疗一月，症状全部消失，面色红润，精神充沛，病痊愈。

〔例4〕赵×× 男性 28岁 会计员 初诊日期为1959年3月27日。

〔问诊〕七年来经常头痛，时轻时重，头痛牵及目系痛，重时肩项强痛。失眠多梦，易醒，记忆力减退，精神不能集中，大便干燥。经常服用止痛片，晚服安眠药，始终未能控制。

〔望诊〕面容痛苦，舌质红，苔微黄。

〔切诊〕脉象浮弦。

〔辨证〕肝胆风热。

〔立法〕平肝胆，疏风热。

〔治疗〕用疏风止痛合剂。治疗半月，症状全部消失。一月后复查，停药后无明显症状，能胜任会计工作。

〔例5〕乌×× 男性 28岁 干部 初诊日期为1959年3月10日。

〔问诊〕四年来手颤，时感身上部分肌肉跳动，跳动时可以看见某处肌肉明显在动。入睡时常因全身一抽动而惊醒，醒后再不能入睡。心悸，易汗出，全身疲倦。

〔望诊〕舌质淡红，苔白。

〔切诊〕脉弦细。

〔辨证〕肝郁血虚，血不荣筋。

〔立法〕解郁，养血，荣筋。

〔治疗〕用养血荣筋合剂。治疗一月，症状全部消失，病痊愈。

〔例6〕吴×× 男性 32岁 干部 初诊日期为1959年3月10日。

〔问诊〕三年来常梦遗，心情紧张，致经常失眠，昼日神疲体倦，腰痠胫软，头晕目花，精神不易集中，记忆力差。经过中西医治疗无明显效果。

〔望诊〕舌质红，无苔。

〔切诊〕脉沉细数。

〔辨证〕肾阴不足，精关不固。

〔立法〕滋阴，固精，安神。

〔治疗〕用滋阴固精合剂。治疗一月，症状消失，睡眠安好，病痊愈。

〔例7〕程×× 男性 48岁 干部 初诊日期为1960年10月20日。

〔问诊〕患者青年时有手淫习惯，婚后又恣情纵欲。近十数年来阳痿早泄，近三年性欲减退，阳痿不举，失眠多梦，夜尿频，尿后余沥不尽。昼日头昏沉，神疲体倦，记忆力减退，对事物不感兴趣。

〔望诊〕头脱顶，面容衰老与年龄不相称，舌质淡、苔白。

〔切诊〕脉沉弱。

〔辨证〕肾阳不足，精关不固。

〔立法〕补肾，壮阳，固精。

〔治疗〕用壮阳固精合剂。治疗一月，睡眠好转，夜尿减少，有举阳现象。昼日精神、体力均增。继续治疗三周，症状消失，病痊愈。

第二节 癔病(歇斯底里)

癔病是神经官能症中较常见的一种。其发病比例仅次于神经衰弱。患者发病年龄(首次发病)以20岁左右为最多，40岁以上发病者较少，但在更年期则发病率稍高。患者中女性

多于男性。

一、病因病机

癔病患者的发病原因主要有二：一个是病人常具有相当特别的癔病性格，另一个是各种精神因素的刺激。

病人常具有的癔病性格特点如下：

(1) 高度的情感性。病人情感浓厚，鲜明，强烈，易变，但不深刻，不持久。

(2) 高度的暗示性。病人的症状可因暗示而产生或减弱、消失。

(3) 自我中心性。病人主观片面，任性固执，胸怀狭窄，好表现、夸耀自己。另外，还有好幻想等特点。

容易引起患者发病的各种精神因素来自家庭、社会的各个方面，这些精神刺激引起患者痛苦、激动、恐惧、人格受辱、自尊心受损等情感变化，直接导致癔病的发生。

中医认为：癔病的病机主要是患者体内阴阳失和，气机紊乱。五志过极，或郁而化火，或郁而生涎。正如《素问·生气通天论》所说：“阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂。阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。”因此，调阴阳、理气机是治疗本病的关键。

二、临床表现

本病的症状多种多样，与许多疾病的症状相似，不仅表现为精神方面的失调，还表现为各种内脏器官的障碍，更由于患者的高度暗示性，因而在暗示或自我暗示的影响下，常常改变其症状，这就更增加其临床症状的复杂性。

本病的症状常以发作的形式出现。在发作间歇期间，有些患者没有明显的其它症状；但另一些患者则伴有轻重不等的头痛、失眠、多恶梦，明显的情绪不稳，易激动，烦躁不安，心中委屈，总想哭喊等症状。

中医对瘧病症状的描述，散见于各种医籍。如张仲景在《金匱要略方论》中写道：“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。”巢元方在《诸病源候论》中指出：“夫贲豚气者，肾之积气，起于惊、恐、忧、思所生。若惊恐则伤神，心藏神也；忧思则伤志，肾藏志也。神志伤动，气积于肾，而气下上游走，如豚之奔，故曰奔豚。其气乘心，若心中踊踊，如事所惊，如人所恐，五脏不定，食饮辄呕，气满胸中，狂痴不定，妄言妄见，此惊恐奔豚之状；若气满支心，心下闷乱，不欲闻人声，休作有时，乍瘥乍极，呼吸短气，手足厥逆，内烦结痛，温温欲呕。此忧思奔豚之状……”朱肱在《活人书》中云：“七情气郁，结成痰涎。随气积聚，坚大如块，在心腹间。或塞咽喉如梅核粉絮样，咯不出，咽不下。每发欲绝，逆害饮食。”以上这些论述，为我们认识瘧病的临床表现和发生机理有很大帮助。

瘧病的临床表现一般有下列几种：

（一）精神障碍

精神障碍以意识障碍与情感失调为主要特征。在意识方面，有的患者可不自觉地完成一系列活动，外观与常人无异，但清醒后却对自己的行动毫无所知（瘧病性精神自动症）。有的患者在精神因素作用下，突然好象什么都不懂，答问常给人以故意说错的印象，或是摹仿儿童的表情和行为，与实际年龄极不相称（假性痴呆）。有的患者突然倒地，做过度

喘气或憋气，双眼紧闭，呼之不应，检查时，撑开眼皮，眼球上翻，回避看人，其它检查无异常(癔病性昏厥)。还有的患者可有癔病性梦行症、癔病性神游症等表现。

情感方面，以情感暴发为主。患者的情感色彩浓厚，夸张、做作，带有戏剧性表演的特点。可因小事而暴怒，大喊大叫，捶胸顿足，撕衣咬物，但随后经旁人劝慰、同情而破涕为笑。有少数迷信思想严重的患者，还可出现鬼神附体的姿态，是为“附体现象”。有的还可呈现情感麻痹和木僵状态。

(二) 运动障碍

运动障碍可表现为功能亢进或功能减退、消失。常见的表现形式有下列几种：

1. 癔病性瘫痪

患者可有单瘫、偏瘫或截瘫，轻重程度不等。但通过神经系统检查，包括各种生理、病理反射均无阳性体征。虽有长期瘫痪但无明显的废用性萎缩，亦无二便的功能障碍。

2. 癔病性震颤

患者可有躯体和四肢的震颤，幅度大，频率快，尤以检查时更为明显，可随暗示减轻或消失。

3. 癔病性惊厥

患者突然倒地，全身强直，两手握拳，做不规则的抽动。双目紧闭，呼之不应。但发作时一般无跌伤，无二便失禁，不咬破唇舌，神经系统检查正常。

4. 癔病性失音

患者突然失去发音能力，整日缄默不语。但可借助手势或书写来表达思想和要求，或只发出嘶哑声、耳语声。检查

时，声带的运动良好。

(三) 感觉障碍

癔病性感觉障碍，可表现为感觉过敏、迟钝或消失。无论属于何种，其所涉及的部位都与神经分布的区域不相符合。这种感觉障碍，有时可通过医生的暗示而改变。感官机能障碍以视力障碍较为常见。如完全失明(癔病性失明)，视力减弱，视野缩小(管状视野)等。这种视力的改变多是突然发生的，眼科检查均正常。患者虽失明，但能自动避开障碍物。其视野缩小常表现为同心性视野缩小(即视野远近同样大小)。

有的病人表现为听力障碍，即所谓癔病性耳聋。这种耳聋一般也是突然发生的，患者对强声刺激有瞬目反应，睡梦中可被人叫醒。

有的病人自己感觉头顶某处有如钉钉子样的头痛，称为“癔钉”；有的病人感到头部紧缩疼痛如裹，称为“癔盔”。这种现象统称为癔病性疼痛。

(四) 植物神经和内脏功能障碍

植物神经机能障碍可表现为各系统或器官的功能障碍，常见的有癔病性呕吐，这种呕吐常不伴有恶心，多在进食后一口一口地吐，有时表现为呃逆、厌食或贪食。

癔病性气喘发作也较常见。癔病性气喘发作多在白天，常是呼吸短促表浅，有的病人每分钟呼吸可达一百次，但检查心、肺部却无任何阳性体征。另外也可表现为血管舒缩性机能障碍，如四肢发凉、发青，或皮肤划痕症等。

此外，癔病球曾被认为是特征性的症状。这是指患者感到有一球状物在喉部堵塞，吐之不出，咽之不下；或是有一

股气体由下腹部经胸部向喉部滚动的感觉。

总之，癔病患者可表现为某种单一的症状，但在更多的情况下是相继或间断地出现两种或多种症状。癔病患者在发作的间歇期可有神经衰弱的症状。

三、诊断与鉴别诊断

(一) 诊断

诊断癔病有时是很困难的，因为它易与其它精神障碍相混淆。下列几点可作为诊断癔病的依据：

1. 癔病性格

患者有明显的特殊性格，即高度情感性，高度暗示性，爱表现自己，自尊心强，自以为是等。

2. 精神因素

患者发病前有明显的精神因素刺激，并有反复发作史。

3. 临床检查

癔病患者的各种临床检查无阳性体征。

(二) 鉴别诊断

癔病发作应与癫痫发作相区别。癫痫发作是突然意识不清，栽倒在地；发作之前，多无精神刺激因素，发作之后又不能回忆当时发作的情况；有的口吐白沫，咬破唇舌，并有大小便失禁等现象。癔病发作时，则有情绪刺激史，发作前有胸闷、喉梗阻、头晕等感觉；发作时有不规则的抽动，虽然也有跌倒的，但都是慢慢地倒下，不是突然栽倒，不会发生意外摔伤，瞳孔反射正常；发作后能片断回忆发病情况，既无大小便失禁情况，也无咬破唇舌的现象，并且经过暗示就会停止发作。

四、临床治疗

(一) 病例介绍

〔例1〕 瘧病痉挛发作

任×× 女性 27岁 工人 初诊日期为1964年9月1日。

〔问诊〕三个月前，患者因与同事意见不和发生争论。此后自觉胸堵，咽塞，头晕，随后昏倒，意识不清，四肢抽动，没有咬破舌和遗尿。经过一小时始清醒，发作停止后全身疼痛。平时头晕，入睡困难，不欲饮食。自此次发作后，每遇不愉快的事情就发病，发作的时间长短不一，由十数分钟至半小时左右。经××医院诊断为瘧病。长期服用镇静剂，但不能有效控制。

〔望诊〕精神不振，舌质淡红，舌尖红，苔微黄，舌颤。

〔闻诊〕懒言。

〔切诊〕脉左沉弦，右沉细。

〔辨证〕肝郁血虚，风阳上扰，肝风内动。

〔立法〕养血柔肝，潜阳熄风。方用养血熄风汤。

〔处方〕生石决明 24克 白蒺藜 10克 生地 15克
杭白芍 12克 女贞子 10克 当归 10克
首乌藤 15克 合欢皮 10克 炒山栀 6克
炒枣仁 15克 杭菊 10克 钩藤 10克
宣木瓜 10克 香稻芽 10克

按前方加减服药十二剂，患者精神愉快，自觉头脑清爽，睡眠安好，饮食增加。经过一年多的观察，瘧病未再发作。

〔例2〕情感暴发

王×× 女性 29岁 工人 初诊日期为1965年11月30日。

〔问诊〕患者一年前因生气曾出现四肢抽搐。发病前20天，因家里遗失东西而精神受刺激，突然多言乱语，语无伦次，时哭时笑，无目的地往外乱跑，有时全身颤抖，手足冰凉，呃逆嗳气，小便正常，大便干燥。

〔望诊〕精神紧张，面潮红，舌质红，舌苔白。

〔闻诊〕乱语，不能答问，不时痴笑。

〔切诊〕脉沉细弦。

〔辨证〕肝郁化火，邪扰神明。

〔立法〕解郁降火，宁神定志。方用甘麦大枣加味汤。

〔处方〕甘草6克 淮小麦30克 大枣十枚
元参10克 丹参10克 生地15克
黄连6克 黄芩6克 郁金10克
菖蒲6克 十香返生丹一九(分两次服)

二诊：1965年12月3日。按前方服药三剂，患者精神恢复正常，面带笑容，对答如流，手足已温。尚有肢颤，饮食睡眠正常，大便已通畅。

〔例3〕意识障碍

茹×× 女性 44岁 家庭妇女 初诊日期为1966年5月20日。

〔问诊〕三天前，患者因生气而突然意识丧失，全身抽搐，约半小时抽搐停止，但不住口地重复说“不行、不行”，声音颤抖，语言不利，行走时摇晃欲倒，手也颤抖，睡眠尚好，不进食。

〔望诊〕精神恍惚，行走需人扶持，舌质红，舌苔白。

〔闻诊〕不答问，只喃喃自语，无法令人听清。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证〕肝郁血虚，血不荣筋，心气耗散，神无所依。

〔立法〕解郁养血荣筋，养心敛气安神。方用解郁养心汤。

〔处方〕当 归 10克 白 薇 10克 次人参 3克

麦 冬 10克 五味子 6克 甘 草 6克

白头翁 10克 秦 皮 10克 马尾连 6克

炒黄柏 6克 钩 藤 10克 宣木瓜 10克

杭白芍 10克 葛 蒲 6克 三剂

药后精神恢复正常，抽搐未出现，言语正常，饮食睡眠均好。除自觉有时心悸，无其它不适感觉。前方加远志、石斛各 10 克继服。

〔例 4〕假性痴呆

郑×× 女性 26 岁 工人 初诊日期为 1965 年 4 月 16 日。

〔问诊〕一年前，患者产后因生气而突然哭笑无常，言语、行为都象小孩一样幼稚，对玩具很感兴趣，淘气，点火或放水玩，破坏东西，有人劝阻时，或调皮地笑，或放声大哭。平日胆小易恐惧，多疑，睡眠不好。前日去××医院诊断为癔病，患者认为是被管制，不敢再去那个医院，故转中医治疗。

〔望诊〕表情幼稚，舌质淡、少苔。

〔闻诊〕说话象小孩，自称六岁。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证〕血虚肝郁，心神不足。

〔立法〕养血补心，解郁醒神。方用补心丹和甘麦大枣汤。

〔处方〕熟地12克 丹参10克 元参10克
五味子6克 甘草6克 淮小麦30克
大枣十枚 炒枣仁24克 远志10克
石菖蒲6克 首乌藤15克 合欢皮10克
炒山栀6克

按前方服药八剂，精神好转，幼稚行为和动作没有出现，睡眠好，就诊时答问确切，仍胆小多疑。门诊治疗八次，计一个半月，恢复半日工作，观察一年，前病未犯。

〔例5〕癔病性瘫痪

刘× 女性 19岁 高中学生 初诊日期为1970年5月20日。

〔问诊〕患者两天来突然右腿不能站立，而被收住院。

两月前，患者曾两次与同学生气而下肢不能走路，几天后才恢复。患者系独生女，平素娇气任性，爱生气，一生气就不爱说话。有时胃脘痛，咽中如有物梗阻，此次犯病也伴有此种症状。

入院时检查，四肢脊柱无畸形，脑脊液、血常规均正常。右下肢不能活动，感觉迟钝，无病理反射。

〔望诊〕除感情不稳定外，精神无异常。舌质红，苔白稍腻。

〔闻诊〕语声正常。

〔切诊〕脉沉细弦。

〔辨证〕肝郁血虚，血不荣筋，络脉失和。

〔立法〕舒肝解郁，养血荣筋通络。方用养血荣筋汤。

〔处方〕白头翁 10克 秦皮 10克 黄连 3克
炒黄柏 6克 当归 10克 杭芍 12克
生白术 6克 茯苓 12克 甘草 3克
柴胡 6克 桑枝 15克 木瓜 10克
丝瓜络 6克 三剂

二诊：药后右下肢已能屈伸，感觉也较正常。按前方继续服药三剂。三诊时已能站立并慢慢在室内行走。

〔例 6〕癔病性失音

张×× 女性 42岁 家庭妇女 初诊日期为1965年12月28日。

〔问诊〕前天因邻居一人病死，患者心情悲恸，当日一夜未睡，精神变得呆板。自昨日失语，问她哪里不舒服，以手拍胸。两天未饮食。

〔望诊〕神志清醒，舌质淡红，舌苔黄。

〔闻诊〕不能发音，以手势代语言。

〔切诊〕脉沉弦。

〔辨证〕气郁痰结，痰阻廉泉。

〔立法〕解郁化痰，开窍发声。方用十味温胆汤加减。

〔处方〕化橘红 6克 法半夏 6克 茯苓 12克
竹茹 10克 枳壳 6克 郁金 6克
菖蒲 10克 远志 10克 合欢皮 10克
栝蒌 15克 木蝴蝶 10克 两剂

二诊：1965年12月30日。按前方服第一剂药即入睡，醒后即能说话，饮食均正常。

〔例 7〕癔症性失明

刘×× 男性 26岁 工人 初诊日期为1963年7月19日。

〔问诊〕患者平素主观任性，纪律性不强。前几天因与车间组长争吵，其后精神失常，两眼发直，不说话，不进饮食，不睡，外出奔走。自前天两眼所见只有盘子大小，周围什么也看不见。自觉头昏，胸闷气憋。经××医院诊断为癔病。

〔望诊〕两目直视，行走需人扶持，瞳孔缩小，对光反应迟钝。舌质红，舌苔白腻。

〔闻诊〕不欲说话。

〔切诊〕脉沉弦。

〔辨证〕暴怒伤肝，肝脉郁滞，目系不通，遂致暴盲。

〔立法〕平肝明目。方用泻肝明目汤。

〔处方〕生石决明 24克 白蒺藜 10克 龙胆草 6克
炒山栀 6克 生地 10克 当归 10克
川芎 6克 青箱子 10克 杭菊花 10克

二诊：1963年7月22日。按前方服药两剂，眼睛看东西已清楚，头昏、胸憋症状已消失。

〔例8〕癔病性耳聋

张× 男性 37岁 干部 初诊日期为1966年2月10日。

〔问诊〕患者平时性情急躁，易发脾气。三周前因工作着急，突然两耳暴聋，不闻大小声音。其后更加急躁。大便2~3日一行，较干燥。饮食睡眠均正常。经××医院检查，内、外耳无异常，经治无效而转院治疗。

〔望诊〕精神一般，舌质红，舌苔黄厚较腻。

〔闻诊〕 答问语音高。

〔切诊〕 脉弦有力。

〔辨证〕 暴怒伤肝，肝火上逆，上犯清空，耳窍闭塞。

〔立法〕 平肝泻火，宣通清窍。方用龙胆泻肝汤。

〔处方〕 龙胆草 10克 炒山栀 6克 黄 芩 10克

生 地 10克 当 归 10克 柴 胡 6克

甘 草 3克 木 通 3克 泽 泻 10克

车前子 10克 川 军 6克 杭菊花 10克

二诊：服药一剂即能闻声音，三剂可听到一般声音。今日自行就诊，能正确答问。但感听力不够聪慧，两耳尚有发闷感觉。按前方继服药三剂。三诊时听力完全恢复正常。

〔例 9〕 植物神经机能障碍

杨×× 女性 19岁 工人 初诊日期为 1962年 8月25日。

〔问诊〕 本年4月7日，患者因怒后啼哭进食，食后呕吐不止，四天不能进食。此后呃逆频繁，呃逆时全身上耸，迄今已四个多月。并感胸闷胁痛。现仅能进稀食，进干食噎塞不能下咽。食后胃脘痛，吐白沫，咽中如有球状物梗塞，气出不畅。活动时头晕目眩，常因呃逆妨碍睡眠。

〔望诊〕 面色黄，呃逆时全身抽动，两肩上耸；舌质淡，苔薄黄。

〔闻诊〕 呃逆声连续不断。

〔切诊〕 脉左沉滑，右弦细。

〔辨证〕 肝气上逆，胃降失和。

〔立法〕 平肝降逆和胃。方用旋复代赭石汤合启膈散。

〔处方〕 旋覆花 10克 代赭石 15克 法半夏 6克

生甘地 3克 陈 皮 6克 云茯苓 12克
 砂 仁 5克 藿 梗 6克 郁 金 6克
 菖 蒲 6克 荷 蒂 十个 枳 壳 6克
 淡竹茹 10克 白人参 5克

二诊：1962年9月7日。按前方服药九剂，呃逆减少，其势已缓，但未全止；咽喉阻塞气憋都显著减轻，自觉胸中舒畅，已能进干食，胃脘已不痛。舌质淡，苔薄白。脉沉细弦。

〔处方〕清半夏 12克 黄 芩 10克 川黄连 3克
 生 姜 5克 淡干姜 1.5克 枇杷叶 10克
 杏仁泥 10克 柿 蒂 10克 紫苏子 6克
 苏梗叶各 6克 炙甘草 5克 老刀豆 12克
 白 芍 12克 沉香末 5克(分冲)

按前方服药六剂，呃逆已止。

〔随访〕1963年11月29日。治疗后一年多，前症未犯。

〔例 10〕瘧病“附体体验”

于×× 女性 32岁 农民 初诊日期为1962年4月12日。

〔问诊〕一年前，患者因女儿病故十分悲伤，常到村外女儿墓前痛哭。一天痛哭之后突然打个寒战，即失去知觉，自称有狐仙附体讲话，过后数伸欠即清醒，对狐仙“附体”时所说的话已不能记忆。此后经常在集体劳动时发作。有些青年人及儿童学她发病时所说的话嘲笑她，有人说她故意装神弄鬼，爱人也对她不满。曾在公社医院用针灸治疗，未能控制发作。

〔望诊〕精神一般，舌质淡，苔白少，舌颤明显。

〔闻诊〕能述说病情体验。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证〕心肝血虚，神不守舍，舍空邪气乘之。

〔立法〕养血补心安神。方用安魂汤。

〔处方〕熟地12克 当归10克 白芍12克

干桑椹10克 麦冬10克 五味子6克

甘草3克 远志10克 柏子仁10克

朱砂末1.5克(分冲) 琥珀末1.5克(分冲)

二诊：1962年4月19日。按前方服药后，几日未再发病，昨日仅有寒战，但觉头一昏即过。舌脉同前，前方加炙首乌15克，继服。

(二)治疗体会

根据瘵病临床表现的多样性，它在中医书籍中有多种病名，如肝风、脏躁、梅核气、奔豚、暴瘵、暴瘵、暴盲、暴聋、呃逆、呕吐、祟惑等等。本病的诱发因素皆与情志有关，而其中以怒为多见。怒为肝之志，肝主怒，反过来怒又伤肝。怒既为本病的诱因，为什么临床表现的症状却又不一样呢？这是由于每个人的个性特点、躯体状况即阴阳、气血的偏盛偏衰、病机的转化各有不同。如平素阴血偏虚的人，遇怒则肝阳上亢，肝风内动，多表现痉挛、猝然倒地。如平素血虚，遇怒伤肝，肝血被劫，血不荣筋，筋失血养，则表现肢瘫不能站立。如平素肝气偏盛，遇怒则气郁痰结，表现为梅核气，咽中如有物塞，咯之不出，咽之不下。如肝气聚于腹中，则发为奔豚，故气从少腹上冲至咽喉，发作时腹剧痛，气憋欲死，发作过后如常人。心主喜，其声笑；肺主

悲，其声哭；若肝郁化火，与心火合邪，心火盛则笑，火盛刑金，故表现哭笑失常。若肝郁痰结，痰阻廉泉；或悲哀恻哀损伤肺气，皆可表现暴瘖失声。若暴怒伤肝，肝血暴伤，睛失血养，则暴盲，表现突然视物不见，或视野范围缩小。胆经经脉绕耳，下络于肝，若暴怒伤肝化火，肝火循经上壅于耳，则表现突然暴聋，耳不闻声。若肝气横逆犯胃，胃失和降，则表现为呃逆不绝，或呕吐不止。若怒气扰肝，肝因邪气所扰，魂不守舍，则表现突然神智不清，如邪所惑，谓之祟惑。

以上各症，根据临床四诊合参，予以辨证论治，均能取得较好的效果。

五、小儿瘵病治验

（一）病例介绍

聂×× 女性 10岁 小学生 初诊日期为1964年3月8日。

〔问诊〕一个月前患儿受惊，当天夜里睡眠不稳，次日即精神不振，自觉头痛，晚上一夜未睡，无故哭泣，哭时全身抽搐，半小时后始停止。此后精神呆板，沉默不语，头向下倾，不肯上仰，表现焦虑恐惧，睡后出现阵阵瘵疾。经儿童医院检查，认为是精神受刺激所引起，建议精神科治疗，精神科又以儿童而拒绝治疗。后转我院就诊。

〔望诊〕头向下低，嘴紧撮，舌质淡红，舌尖红，舌苔白。

〔闻诊〕不语，无法听其声音。

〔切诊〕脉滑数。

〔辨证〕肝热受惊，惊则气乱，神不守舍。

〔立法〕平肝清热，镇惊安神。方用清热镇惊汤。

〔处方〕生石决明 15克 白蒺藜 6克 龙胆草 3克

炒山栀 3克 柴胡 2克 麦冬 6克

朱茯神 6克 连翘 6克 生草 2克

木通 1.5克 黄连 2克 钩藤 6克

薄荷 3克 三剂

二诊：1964年3月11日。服药后精神好转，低头噤嘴现象已少，夜眠安稳，饮食增加，从昨日未哭泣，仍有时恐惧，舌脉同前。前方加琥珀抱龙丸，每次一丸随药服。

经治疗后，症状消失，至本年3月19日恢复学习。

（二）病例分析：将本例附于癇病之后，在于证明儿童也可发生癇病，其表现与成年人一样。中医认为此病属于儿科惊风的范畴。一般来说，单纯外惊不足以引起小儿发病，必素有肝热之内因，外惊仅是诱因。故选用清热镇惊汤加生石决明、白蒺藜以平肝熄风；用胆草、山栀、柴胡泻肝热为主；连翘、麦冬清金制木；黄连泻心火；朱茯神安神定志；钩藤熄风，薄荷为小儿治惊必用之品。药后诸症皆效。此证在中医儿科为常见病，疗效也较好。

第三节 强迫性神经官能症

本病是以强迫症状为主的一种神经官能症。多在一定的精神因素作用下发病，患者病前多具有胆小拘谨、刻板固执、虽勤恳踏实但缺乏主动性、创造性和自信心等个性特点；或病前有躯体衰弱、过度疲劳等情况。

一、病因病机

中医认为，人精神活动中的谋虑、决断是由肝和胆主管的。肝为将军之官，主谋虑，胆为中正之官，主决断。所谓谋虑，是人们对待事物的一种分析思考过程，但仅有谋虑尚不能见诸于行动，还需要有决断才能去执行，只有肝胆二者功能正常协调时始能完成，如其中有一方面的功能失调，就不能很好地完成这一功能上的配合。若肝盛、胆虚，则表现为多虑而犹疑不决，产生强迫性的盲目多谋虑，但却得不出肯定的决断。临床上所见强迫性思维和强迫性行为的患者，多属于此种病机所造成。若肝胆俱虚，则患者表现对正常事物、环境产生不可理解的恐惧感，恐怖症多属于此病机。总之，强迫性神经官能症的病机多为肝胆功能失调。

二、临床表现

强迫症状是指一种反复出现、自知为不合理但又无法摆脱的观念、情绪和行为。病人常因此而感到痛苦，所以往往伴有情绪焦虑和忧郁。其临床表现主要有三种形式。

（一）强迫观念

病人的思想常为一些毫无意义的想法所纠缠，虽明知这些想法不对，却又无法摆脱和难以克制。病人经常想些缺乏意义的问题，比如一个人为什么长两只手；一加一为什么等于二等等。病人有时怀疑自己做过的事没有做好，如洗完脸又担心没有洗干净，锁完门又怀疑没有锁上，虽反复检查仍不放心；或自己虽没做坏事，却怀疑自己被别人当做坏人而心中忐忑不安。也有的病人在接触事物时有相反的观念出

现，如母亲抱着心爱的孩子站在凉台上时，出现把孩子扔到楼下去的想法。

（二）强迫情绪（又称恐怖症）

患者对某些物品、事物或环境产生不必要的恐怖感，但却无法控制，如怕上高，怕经过广场，怕细菌，怕得癌，怕灰尘，怕火，怕水，怕尖锐利器刀剪等。

（三）强迫行为

所谓强迫行为即病人明知没有必要而又不可克制的行为。如走路时数脚步，数路旁的电线杆或树木，数商店的玻璃窗，也可有疾病恐怖症，反复地洗衣、洗手等行为。常与强迫观念同时存在。

有些强迫性病人因怕被别人知道后讥笑，经常强行克制自己的行为，故而在一般情况下不易被人察觉出来。

以上的强迫症状并不全都在同一个病人身上出现，大多数病人仅出现其中某些症状。

三、诊断与鉴别诊断

强迫性神经官能症的临床诊断，主要以各种强迫性质的临床表现为依据。其次，强迫症的病人自知力完整，一般不发生严重危害行动，也是诊断依据的一条。另外，强迫症的症状往往在傍晚、入睡、疲劳等情况下出现，而在聚精会神地工作或早晨起床时消失。

本病应与精神分裂症相区别。精神分裂症的强迫现象，其内容多半是荒谬的和不可理解的，常找不到明显的精神刺激因素。精神分裂症患者的情感淡漠，精神活动内向，生活懒散，自知力缺乏，孤僻，敏感，多疑等，均与本病不同，

区别。

四、临床治疗

(一) 病例介绍

〔例1〕强迫恐惧

——王×× 男性 28岁 干部 初诊日期为1964年9月2日。

〔问诊〕四年前，患者因爱人患白血病死亡，精神受刺激较重，又兼病时负债较多，因此，产生强迫恐惧。一次本单位丢失物资，患者即想到自己负债多，别人一定会怀疑是自己偷盗的，便想尽一切办法证明自己没有偷盗，终日惊慌失措，坐立不安。周围人看到他这种异常的表现，真的引起了怀疑。当保卫科找其谈话时更加恐惧，未能说明情况。后来同事们才发现他精神不正常。患者走在人群中或乘坐公共车时，总把两手摆在别人都能看见的位置，手不敢接近衣袋，唯恐别人说自己拿了别人的东西。见陌生人精神紧张，怕别人怀疑自己有问题。入睡前强迫观念更重且不能控制，每夜仅睡3~4小时。昼日头疼，怕接触人。精神紧张时面红，手颤，发音有困难，自觉脊背及四肢发软，好象缩成一团。平时怕脏爱洗手。经××医院诊断为强迫性神经官能症。

〔望诊〕精神紧张，表情恐惧，两目无神，舌质淡，尖红，苔薄白。

〔闻诊〕言语不自然，尚能诉说病情。

〔切诊〕脉弦细。

〔辨证〕忧思伤心，阴血暗损，肝失血养，则令人恐。

〔立法〕养血柔肝，补心强神。方用补心汤加减。

〔处方〕 生熟地各 10克 当 归 10克 白 芍 12克
 合 欢 皮 10克 丹 参 10克 元 参 10克
 党 参 10克 首乌藤 15克 五味子 5克
 甘 草 5克 朱麦冬 10克 炒枣仁 15克
 远 志 10克 石菖蒲 6克

治疗两月余，至 1964 年 11 月 17 日，按前方加减服药 40 剂，强迫症状消失，睡眠安好，精神充沛，面部有喜悦表情。为了巩固疗效，改服补心丹，每次一丸。

〔随访〕 1965 年 2 月 27 日。患者以兴奋的心情述说病已痊愈，已参加工作。

〔例 2〕 强迫性小便频数

于×× 女性 38 岁 干部 初诊日期为 1962 年 11 月 12 日。

〔问诊〕 患者于 1950 年国庆节观看礼花时，因强忍小便时间过久，以致昏倒，经抢救才苏醒。从此小便排出困难，但尿意频繁，随时可有不自觉的小便遗出，因而产生强迫性小便频数。患者平时在家无任何感觉，小便也正常。但每当外出或乘坐公共汽车时即欲小便，每到一站必须下车找厕所。如急迫时常因精神紧张而昏倒遗尿，因此不能工作。经过很多医院，均诊断为强迫性神经官能症，但经长期治疗无明显效果。

〔望诊〕 精神正常，舌质淡红、少苔。

〔闻诊〕 语言正常。

〔切诊〕 脉沉细滑。

〔辨证〕 强力忍尿则伤肾，肾主恐，恐则气下，甚则昏厥尿自遗。

〔立法〕补肾益气。方用补肾益气汤。

〔处方〕熟地 15克 山药 15克 茯苓 12克
煅龙骨 15克 菟丝子 10克 益智仁 10克
沙苑蒺藜 10克 桑螵蛸 12克 黄芪 15克
生白术 10克 远志 10克 菖蒲 6克

按上方服药十剂，强迫小便现象已得到控制，遗尿昏厥未再出现。按前方加减服药三十余剂，强迫症状已不明显而参加工作。

〔例3〕强迫恐惧

仇×× 男性 24岁 工人 初诊日期为1960年5月17日。

〔问诊〕患者十四年来害怕见熟人。最初见熟人，产生恐惧，精神紧张，面红发热，手颤出汗，说话口吃，不知所措；欲小便，但小便又不能排出。逐渐发展到不见人小便也困难，但总有强迫欲小便，又害怕小便。思想不能集中，强迫观念不能控制，因此影响工作和行动，终日不敢外出见人。睡眠易醒。经××医院精神科诊断为强迫性神经官能症。

〔望诊〕精神紧张，舌质红，苔白，舌颤。

〔闻诊〕语言不自然。

〔切诊〕脉沉弦。

〔辨证〕肾阴虚，心肾失交。

〔立法〕滋肾阴，交通心肾。方用交泰汤。

〔处方〕生地 12克 女贞子 15克 当归 10克
白芍 10克 五味子 6克 甘草 6克
丹参 10克 元参 10克 炒枣仁 15克

麦冬10克 远志10克 菖蒲6克

药后强迫症状明显减轻，逐渐能适应环境，虽有欲小便现象，但能控制。

〔例4〕强迫恐惧

杨×× 女性 37岁 技术员 初诊日期为1963年7月8日。

〔问诊〕患者已往身体尚属健康。五年前，患者怀第四胎在三个多月时自然流产，经××医院检查，康瓦氏试验阴性，医生怀疑患者有先天性梅毒。患者当时精神紧张，此后即产生强迫性怕脏观念，不敢与人接触，终日带口罩不肯摘掉。两手经常泡在肥皂水内，或用漂白粉洗手（致两手皮肤脱落），两手不敢接触任何物体。室内不允许别人进入。一天有人摸过她的房门，她就大哭起来，然后用肥皂水刷洗多次仍不放心。衣服一天换几次，刚换上的衣服，就感被污染了，马上脱下来放在水里洗。因此，不敢外出，不能参加工作。每次去医院需经爱人多次动员。患者想尽一切办法防止外界污染，不乘车，不进候诊室。经××医院诊断为强迫性神经官能症。

〔望诊〕精神紧张，戴加厚大口罩，手戴白色手套，两手抬举（为避免与物体接触）。经动员后摘下口罩，舌质淡，舌苔白少。

〔闻诊〕语声低，不欲多言。

〔切诊〕脉沉细。

〔辨证〕肝主谋虑，以防外侮，肝血虚则妄谋多虑。

〔立法〕养血柔肝，解虑。方用益胆汤。

〔处方〕当归10克 杭芍12克 生地10克

何首乌 15克 炒山栀 6克 合欢皮 10克

干桑椹 10克 女贞子 10克 百 合 10克

远 志 10克 菖 蒲 6克

按前方服药十二剂，已能自行就诊。口罩手套已摘除，但仍有强迫性洗手，将挂号证装在塑料口袋内（便于刷洗），不敢进候诊室。经治两个月，服药四十剂，强迫症状已能控制。可乘坐公共汽车外出购买东西。

〔例 5〕强迫怀疑

程×× 男性 47岁 干部 初诊日期为1966年3月21日。

〔问诊〕病起于劳累后又遇生气，一个多月来患者产生严重的强迫观念，自己不能控制。每天上班时，总觉得忘带了什么东西，几次返回察看。下班时明知抽屉已锁好，但总不放心，必须几次检查才能走去。洗澡时摘下手表，洗完又不敢拿自己的表，唯恐别人说是偷的。在这种情况下胆怯，出汗，夜眠多梦易醒，昼日头晕，有时头痛。经××医院诊断为强迫性神经官能症。

〔望诊〕舌体胀大，舌质淡红，舌苔白。

〔闻诊〕言语正常。

〔切诊〕脉弦。

〔辨证〕肝主谋虑，胆主决断，肝胆失调，多谋而不决。

〔立法〕平肝益胆。方用平肝益胆汤。

〔处方〕珍珠母 24克 丹 参 10克 元 参 10克

朱寸冬 10克 远 志 10克 菖 蒲 6克

五味子 6克 甘 草 6克 炒山栀 6克

滁 菊 10克 竹 茹 10克

至1966年4月2日，按前方服药十二剂，强迫症状基本消失，精神愉快。

〔例6〕强迫性对立思想和意向

李×× 男性 32岁 未婚 文艺工作者 初诊日期为1964年4月16日。

〔问诊〕患者性素孤僻，心胸狭窄。1952年在音乐学院学习时因患神经衰弱，曾休学三个月。1954年毕业后参加工作，每遇劳累或精神受刺激即头痛、失眠。1957年感染肺结核，因不能胜任工作自行退职。1960年做肺后下叶切除手术。手术经过尚好，一个月出院。出院后精神症状加重，失眠，整日头昏沉不清，记忆力衰退。1961年出现强迫性症状，没有原因地想打人，或者打自己。有时想把自己的手指和舌头割掉。脑子里昼夜在画三角图案。一天吃饭时将饭碗摔掉，此后每到吃饭时就精神紧张，不敢端碗。经××医院精神科诊断为强迫性神经官能症，经长期治疗症状无好转，故转院治疗。

〔望诊〕舌质淡红，舌体胀大，舌边有齿痕，舌苔白。

〔闻诊〕语言正常，答问有条理。

〔切诊〕脉弦搏指。

〔辨证〕肝主谋虑，胆主决断，肝盛胆虚，致妄谋而无断。

〔立法〕泻肝益胆。方用泻肝益胆2号。

〔处方〕生石决明 24克 代赭石 15克 龙胆草 6克
炒山栀 6克 黄芩 6克 竹茹 10克
姜半夏 10克 枳壳 6克 杭芍 12克

远志 10克 石菖蒲 6克 夜交藤 15克
炒枣仁 15克

二诊：1964年4月24日。按前方加减服药八剂，强迫症状基本控制，自觉心情舒畅，已能做些家务劳动，睡眠一般。舌质淡红，苔薄白，脉弦细滑。改用养阴柔肝清心法。

〔处方〕珍珠母 24克 生地 15克 杭芍 12克
朱麦冬 10克 丹参 10克 元参 10克
炒枣仁 15克 远志 10克 石菖蒲 6克
五味子 6克 黄连 3克 甘草 5克
合欢皮 10克 炒山栀 6克 莲子心 3克

三诊：1964年6月9日。按前方服药十五剂，强迫症状已消失，精神恢复正常，能够适应环境，能裁衣缝衣，做较细致的工作，爱好音乐，现已恢复练习。

（二）治疗体会

在多年的临床实践中，笔者认为绝大多数强迫性神经官能症患者为虚证。这是根据中医学的理论并经过临床反复实践而证实的。如强迫性恐惧症，古人认为恐惧的病机有二：一为“肝虚则善恐，如人将捕之”。一为“肾在志为恐，肾虚则恐惧不安”。二者在临床所见，多为舌淡或舌红无苔，脉多以沉细为主，皆为阴血虚的见证。经过养肝或补肾的方法治疗以转化病机，肝血得养，肾阴得济，恐惧自失，从而消除症状。再如强迫观念，其病机为肝胆失调。“肝为将军之官，谋虑出焉”。“胆为中正之官，决断出焉”。在正常精神活动中，二者互相配合，既有对事物的深谋远虑，又能相应地作出正确的判断与决定。若肝胆失调，肝失去正常的深谋远虑能力，而形成病理状态的妄谋多虑，胆虚失去应有的判

断和决定的能力，所以表现为妄谋多虑而无决断。在这种情况下，应该以平肝益胆的方法治疗。平肝之目的，在于控制无为的妄谋多虑；益胆之目的，在于使胆气足而增强其决断的能力，从而达到恢复肝胆正常的功能活动和消除强迫观念的目的。

参 考 文 献

1. 《灵枢·本神篇》
2. 《灵枢·平人绝谷篇》
3. 《灵枢·本脏篇》
4. 《灵枢·海论篇》
5. 《灵枢·经脉篇》
6. 《难经·二十八难》
7. 《素问·五脏生成篇》
8. 《丹溪心法》
9. 《三因极一·病症方论》
10. 《伤寒论》
11. 《本草纲目》
12. 《温病条辨》
13. 《灵枢·通天论》
14. 《灵枢·癫狂篇》
15. 《中藏经》
16. 《千金方》
17. 《医学入门》
18. 《石室秘笈》
19. 《景岳金书》
20. 《济生方》
21. 《医学纲目》
22. 《诸病源候论》
23. 《医学准绳六要》

24. 《素问·宝命全形论》
25. 《素问·汤液醪醴论》
26. 《太素》
27. 《素问·举痛论》
28. 《素问·阴阳应象大论》
29. 《灵枢·师传篇》
30. 《儒门事亲》
31. 《医宗金鉴》
32. 《中国医学大辞典》
33. 《肘后方》
34. 《巢氏病源》
35. 《名医类案》
36. 《素问·上古天真论》
37. 《医学正传》
38. 《证治准绳》
39. 《素问·奇病论》
40. 《医林改错》
41. 《素问·灵兰秘典论》
42. 《素问·生气通天论》
43. 《金匱要略方论》
44. 《精神病学讲义》
45. 《实用内科学》
46. 《北京市中医治疗记实》
47. 《中医临床验案选录》
48. 《精神病的临床与防治》
49. 《内科疾病鉴别诊断学》

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=实用中医精神病学

作者=陈家扬

页数=408

S S 号=10536867

出版日期=1985年08月第1版